

神经与精神

黄泰康 主编

疾病



中国医药科技出版社

疑难病诊治方药丛书

神经与精神疾病

黄泰康 主编

中国医药科技出版社

登记证号：(京) 075 号

图书在版编目 (CIP) 数据

疑难病诊治方药丛书：神经与精神疾病/黄泰康主编. - 北京：
中国医药科技出版社，1999.2

ISBN 7-5067-1983-5

I. 疑… II. 黄… III. ①神经系统疾病-验方②精神病-验
方 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 02196 号

中国医药科技出版社 出版
(北京海淀区文慧园北路甲 22 号)
(邮政编码 100088)

天津宝坻第二印刷厂 印刷
全国各地新华书店 经销

开本 850×1168 1/32 印张 10.875

字数 265 千字 印数 1-4000

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

定价：20.00 元

内 容 提 要

《疑难病诊治方药丛书》是由著名中医药专家编写的一套系统介绍百余种疑难病治疗方法的丛书，由 12 个分册组成。

《神经与精神疾病》分册论述脑出血、蛛网膜下腔出血、脑梗死、短暂性脑缺血发作、震颤麻痹、老年期痴呆、偏头痛、急性感染性多发性神经炎、癫痫、精神分裂症、耳源性眩晕、流行性乙型脑炎等 12 类疾病的病因、辨证要点、辨证分型，介绍治法方药、单方验方、中成药、饮食疗法、医案医话及现代报道。并以“方药选介”为重点，共收约 400 方，旨在提供组方明确、用法清楚、疗效可靠、有临床参考价值的方药。详述方药的组成、适应症、用法用量、临床应用、药理研究及资料来源。

本书内容丰富，实用性强。可供临床医生、药师，药物开发、研究人员，高等医药院校师生及广大中医药爱好者阅读参考。

编写人员名单

主 编 黄泰康

副 主 编 马继周 鲍正飞 蒋光祖

编写人员 朱小纾 王荣娣 赵陆华

季建敏 孙 扬 胥 云

前 言

人类自古至今都在经受着各种疾病的折磨，有些疾病，目前还没有十分有效的方法来医治，特别是一些疑难的慢性病。再者，由于化学药品等毒副作用较大，人们普遍都愿从大自然中寻找治疗的方法和药品，国外也纷纷向中国寻求中医中药。因此，中医药走向世界并得到普及的可能将会越来越大。

国内外中医药研究，自 80 年代以来，已进入到一个飞速发展的时代。世界各国学者相继来中国学习中医药，在此大好形势下，为我们几千年的传统医药学精华能适应科技时代发展的需要，使其发扬光大，就有必要加强中医药对疑难病症的治疗，并使中药生产加工技术更为现代化，重点对中药研究中的化学、药理及中药地道药材资源的引种开发等一系列问题进行系统研究探讨和总结，从而建立一个新兴的中医药系统工程学。

《疑难病诊治方药丛书》由 12 个分册组成：《泌尿与生殖系统疾病》《外科疾病》《神经与精神疾病》《呼吸系统疾病》《心血管疾病》《肿瘤与血液疾病》《消化系统疾病》《内分泌与代谢疾病》《儿科疾病》《妇科疾病》《五官科疾病》《皮肤科疾病》。书中收集的方剂许多是久经验证、疗效可靠的著名方剂，可以为临床工作带来方便，并为新药开发提供思路。这套丛书是中药系统工程中研究中药有效方剂与药效的一部分。

在“辨证施治”中，有辨证要点及辨证分型，这给医院病区管理病床的医生以一定的帮助。

本套书的重点内容是“方药选介”，特别是方剂的选介。其中有分型治疗的方剂、常用方选、单方验方、中成药、食疗药膳、各家医案、现代报道，共收载各类有效方剂约 4000 首，有不少是名家的验方、验案，有很高的使用和研究价值，是新药开发的重要依据。

书中有些方剂中的动物药涉及国家野生药材资源保护条例，属野生药材资源保护范畴。为保持方剂原貌，予以保留，在临床上应用替代品。

我们将以此套书献给中西医结合临床各科医生，中药开发、研究人员，中医药管理工作者和广大的中医师、药剂师等，作为工作或研究参考用书。亦适于广大中医药爱好者使用。

由于水平有限，书中存在不妥之处，恳请广大读者不吝指正。

黄泰康

1998年12月

目 录

脑出血	(1)
蛛网膜下腔出血	(36)
脑梗死（包括脑栓塞）	(48)
短暂性脑缺血发作	(85)
震颤麻痹	(98)
老年期痴呆	(113)
偏头痛	(148)
急性感染性多发性神经炎	(192)
癫痫	(213)
精神分裂症	(264)
耳源性眩晕	(296)
流行性乙型脑炎	(316)

脑 出 血

脑出血是指脑实质出血而言，约70%~80%的脑出血是由于高血压动脉硬化、脑血管破裂所致。以50岁左右高血压病患者发病最多。脑出血患者中80%发生于大脑半球，20%发生于脑干和小脑。通常在情绪激动、过度兴奋、使劲排便、用力过度或脑力活动过度紧张时发病，少数则于休息或睡眠中发生。冬、春季节发病较多。脑出血占脑卒中的10%~30%左右，据报道脑出血的死亡率在40%~60%，而存活者中大约70%留有不同程度的残疾。因此脑出血是一急、重的脑血管疾病，对患者的生命及生存质量构成重大的影响。

本病发病突然，以昏迷、肢体瘫痪、口眼歪斜、语言不利等为主要临床表现。中医学中有关“中风”、“类中风”、“偏枯”、“大厥”、“薄厥”等记载与本病相似。如《素问·生气通天论篇》云：“阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。”《素问·调经论篇》云：“血之与气，并走于上，则为大厥，厥则暴死，气复返则生，不返则死。”并对其症状和诱发因素作了较详细的描述。历史上对该病的病因病机及其治法，意见并不一致，唐宋以前主要以“外风”学说为主，多以“内虚邪中”立论，治疗上多采用疏风祛邪、扶助正气的方药；唐宋以后，特别是金元时代，突出以“内风”立论，其中刘河间力主“心火暴甚”，李东垣认为“正气自虚”，朱丹溪主张“湿热生痰”。王履提出“真中”、“类中”。直到明代张景岳提出本病“非风”，乃因“内伤积

损”造成，才有了比较正确的认识。而脑出血作为一个病列入中医药文献，只是近几十年来的事。

一、病因病机

中医学认为本病发病虽十分突然，但其形成却是一个较为长期的过程，病因主要由于精血亏耗，肝风内动，心火暴甚，痰、瘀相兼上扰清空。

（一）精血亏耗 素禀不足，加之后天不知颐养，或用脑过度，或入房太甚，致精血暗亏，不能荣养脑络；脑络脆弱，遇有扰动，则破裂出血，发为是疾。《景岳全书·非风》：“本皆内伤积损颓败而然。”

（二）情志所伤 五志过极，皆能化火，心火暴盛；或素体阴虚，水不涵木，复因情志所伤，肝阳暴亢，引动心火，风火相煽，气血上逆，心神昏冒，遂卒倒无知。正如《素问玄机原病式》所言：“多因喜怒思悲恐之五志有所过极而卒中者，由五志过极，皆为热甚故也。”

（三）饮食不节 嗜酒肥甘，饥饱失宜，或形盛气弱，中气亏虚，脾失健运，聚湿生痰，痰郁化热，阻滞经络，蒙蔽清窍；或肝阳素旺，横逆犯脾，脾失健运，内生痰浊；或肝火内炽炼液为痰，以致肝风夹杂痰火，横窜经络，蒙蔽清窍，突然昏仆，喎僻不遂。此即《丹溪心法·中风》所谓：“湿土生痰，痰生热，热生风也。”以及《临证指南医案·中风》所云：“风木过动，中土受戕，不能御其所胜……饮食变痰……或风阳上僭，痰火阻窍，神志不清。”

（四）寒邪侵袭 本病与气候相关，冬春季节发病者甚多，与卒寒侵袭，腠理闭郁，肝之疏泄失常，气血逆乱，奔走于上有关。

总之，本病之发生，病机虽较为复杂，但归纳起来总因体虚

正损（精、气不足）的基础上为情志不节、饮食不慎、卒寒侵袭等所扰动，导致心火炽盛、肝阳暴张、虚风上旋，气血痰浊奔涌于上，神明无主，脑络破损，血溢于脑，于是猝然昏迷，或一蹶不醒。风、火、痰、瘀、气（逆）、正虚此六者在一定条件下互相影响、相互作用，致成本病。

二、辨证施治

（一）辨证要点

脑出血可分为急性期、恢复期和后遗症期，根据其不同表现，辨证施治。历史上因为对本病之病机认识欠清，故有按症状多少、病情轻重将本病分为“中络”、“中经”、“中脏”、“中腑”，或合称“中经络”、“中脏腑”来辨治，但对当今中医临床来讲似乎已不适合了。因为它们都是建立在“外风中人”的不同层次上分型的，如继续延用，则将忽略了本病“血证（脑）”、脑中蓄血的实质，与本病的治疗产生矛盾，宜以分期分型治疗为妥。本病虽为本虚标实，而急性期却突出表现为邪实。当然也有因正气不支而致元气暴脱者。到恢复期及后遗症期，则以正气虚损为主，显露出肝肾阴虚（或肾精不足）、元气亏损的本象，不可不辨。但痰瘀阻络，风火虽平而未靖，更难以遽除，故宜耐心治疗。

（二）辨证分型

1. 风火上扰清窍型

平素多有眩晕、麻木之症，情志相激病势突变，神志恍惚、迷蒙，半身不遂而肢体强劲拘急，或伴语言不利，便干便秘。舌质红绛，舌苔黄腻而干，脉弦大滑数。

2. 痰热内闭心窍型（阳闭）

起病急骤，神昏、昏愦、鼻鼾痰鸣，面赤身热，牙关紧闭，躁扰不宁，痰涎上涌，肢体强硬拘急，频繁抽搐，项强呕吐，二便不通。舌质红绛，舌苔褐黄干腻，脉弦滑数。

3. 痰湿阻络、蒙蔽心神型（阴闭）

素体多是阳虚湿痰内蕴，病发剧烈头痛，头晕呕吐，面色苍白，突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，半身不遂，两手握固，筋脉拘急，静卧不烦，四肢不温，痰涎壅盛，鼻鼾唇暗，大便秘结，小便潴留，舌质黯淡，舌苔白腻，脉象沉滑。

4. 元气败脱、心神散乱型（脱证）

突然昏仆，不省人事，频繁呕吐，肢体瘫软，手撒肢冷，冷汗淋漓，气息微弱，二便自遗，面青舌痿。舌质暗红，苔白腻，脉沉缓或沉微。

5. 气虚血瘀、脑络不通型

半身不遂，口舌歪斜，言语謇涩或不语，偏身麻木，面色㿔白，气短乏力，口角流涎，自汗心悸，大便溏薄，手足肿胀。舌质暗淡，舌苔薄白或白腻，脉沉细、细缓或细弦。

6. 肝风未靖、阴虚络阻型

半身不遂，口舌歪斜，舌强言謇或不语，偏身麻木，烦躁失眠，眩晕耳鸣，手足心热。舌质红绛或暗红，少苔或无苔，脉细弦或细弦数。

前四型多见于本病急性期，即发病之后1~2周左右，而恢复期及后遗症期则以后两型为多。

（三）治法方药

治疗要点：本病发病甚急，死亡率高，急性期宜积极救治，“顾命”为先，以留人治病。一般而言，急性期标实为著，宜祛邪为急；稳定后标实已缓，则补虚为要。但是在急性期发生脱证，亦宜大剂峻补。另外，治疗中宜突出一个“祛瘀”的原则，毕竟本病为“血溢”成瘀。

1. 分型治疗

（1）风火上扰清窍型 清肝熄风，化痰通络。镇肝熄风汤加减：煅龙骨 15g，煅牡蛎 15g，代赭石 30g，龟板 15g（均先煎），

(5) 气虚血瘀、脑络不通型 益气化瘀，活血通络。补阳还五汤加味：黄芪 30~60g，桃仁 10g，红花 6g，生地黄 10g，当归 12g，川芎 10g，赤芍 15g，地龙 12g，丹参 15g，稀莪草 15g。加全蝎、乌梢蛇、川牛膝、桑枝、地鳖虫、川断等可增加通络之力；如小便失禁，可加桑寄生、桑螵蛸、山萸肉、肉桂、益智仁、五味子补肾收涩之品；下肢瘫软无力甚者，加狗脊、桑寄生、杜仲等补肾壮筋之物；上肢偏废者，加桂枝、姜黄以通络；如患肢手足肿甚者，可加茯苓、泽泻、苡仁、防己淡渗利湿。

(6) 肝风未靖、阴虚络阻型 滋阴熄风，活血通络。地黄饮子去补阳之品，增平肝熄风药物：地黄 15g，麦冬 12g，石斛 10g，山萸肉 10g，桑叶 10g，白蒺藜 12g，钩藤 15g，丹参 12g，丹皮 10g，赤芍 12g，稀莪草 15g。兼见语言不利者，加郁金、石菖蒲、远志以祛痰利窍；兼见口眼喎斜者，加白附子、全蝎、僵蚕等以祛风通络；肢体麻木者，加陈皮、半夏、茯苓、胆南星以理气燥湿而祛风痰；大便秘结者，加火麻仁、郁李仁、肉苁蓉、玄参润肠通便。

2. 方药选介

本病在“中风”中病死率最高，而“中风”又为古之“四大证”之一，因此从古至今的医家无不对此予以特别重视，方药甚多。

①大秦苳汤

组成：秦苳 90g，甘草 60g，川芎 60g，当归 60g，白芍 60g，细辛 15g，川羌活、防风、黄芩各 30g，石膏 60g，白芷 30g，白术 30g，生地黄 30g，熟地黄 30g，白茯苓 30g，川独活 60g。

适应症：“中风”外无六经之形证，内无便溺之阻隔，手足不能运动，舌强不语，属血弱不能养筋者。

用法用量：上 16 味，锉。每服 30g，水煎，去滓温服，不拘时。如遇天阴，加生姜 7~8 片；心下痞，加枳实 3g。

资料来源：《备急千金要方》卷八

④大活络丹

组成：白花蛇、乌梢蛇、威灵仙、两头尖（俱酒浸）、草乌、天麻（煨）、全蝎（去毒）、首乌（黑豆水浸）、龟板（炙）、麻黄、贯仲、炙草、羌活、官桂、藿香、乌药、黄连、熟地、大黄（蒸）、木香、沉香各 60g，细辛、赤芍、没药（去油，另研）、丁香、乳香（去油，另研）、僵蚕、天南星（姜制）、青皮、骨碎补、白蔻、安息香（酒熬）、黑附子（制）、黄芩（蒸）、茯苓、香附（酒浸，焙）、元参、白术各 30g，防风 75g，葛根、虎胫骨（炙，以牛胫骨代）、当归各 45g，血竭（另研）21g，地龙（炙）、犀角、麝香（另研）、松脂各 15g，牛黄（另研）、龙脑（另研）各 4.5g，人参 90g。

适应症：“中风”瘫痪，痿痹痰厥，拘挛疼痛，痢疽流注，跌扑损伤，小儿惊痫，妇人停经。

用法用量：上药 50 味，为末，蜜丸，如桂圆核大，金箔为衣。陈酒送下。

临床应用：本方祛风活血，化痰通络，兼有扶正之功，广泛用于“中风”瘫痪、语言不利诸证，作为常用成药。但宜根据辨证，配用其他成药，如阴虚者宜合用杞菊地黄丸等。

使用注意：本品偏于辛温，可用菊花煎汁送服。

资料来源：《兰台轨范》卷一引《圣济》

⑤三化汤

组成：厚朴、大黄、枳实、羌活各等分。

适应症：中风，外有六经之形证，内有便溺之阻格。

用法用量：上药锉为末。每服 9g，用水 600ml，煎至 300ml，分两次服之，不拘时候。以微利为度。

临床应用：本方历代多用之，对“中风”肝风内动，肝阳痰火兼腑实者尤宜。当今临床用于脑出血急性期，认为对降低颅内

压有一定作用。

使用注意：闭证可用，脱证不宜。

资料来源：《素问病机气宜保命集》卷中

⑥地黄饮子

组成：熟干地黄（焙）、巴戟天（去心）、山茱萸（炒）、肉苁蓉（酒浸，切，焙）、附子（炮裂，去皮、脐）、石斛（去根）、五味子（炒）、桂（去粗皮）、白茯苓（去黑皮）各 30g，麦门冬（去心，焙）、远志（去心）、菖蒲各 15g。

适应症：瘖痱。下元虚衰，虚阳上浮，痰浊上泛，舌强不能言，足废不能用。现用于“中风”后遗症、各种脊髓病变之偏枯、失语属于精虚痰实者，亦可用于全身性瘙痒症。

用法用量：加生姜、大枣、薄荷，水煎服，用量按原方比例酌情增减。（原方为末，每服 9g，水 300ml，生姜 5 片，枣 1 枚，薄荷 2.4g，煎至 200ml，不计时候。）

临床应用：本方是当今临床治疗脑卒中的常用方之一，有较确切的疗效，特别是去附子、肉桂后，用于脑卒中（包括脑出血）属于阴虚络阻、痰邪壅塞者。亦用于本病的脱证，有大补肾元，回阳固脱的作用。

使用注意：阳虚不明显者可去附子、肉桂。

药理研究：以大鼠为实验对象，给本方煎剂喂养 1 个月，考察本方对中枢神经系统神经递质的影响和内分泌变化。结果发现地黄饮子煎剂喂养的大鼠下丘脑-垂体-肾上腺皮质的功能显著增强。这为该方治疗脑卒中收效良好提供了部分药理学依据。

资料来源：刘河间《医学六书》

⑦指迷茯苓丸

组成：茯苓 30g，枳壳（麸炒，去瓢）15g，半夏 60g，风化朴硝 7.5g。

适应症：中脘停痰，臂痛难举，或四肢浮肿，脉沉细。现用

晕，至于跌仆，昏不知人，移时始醒，或醒后不能复原，精神短少，或肢体痿废，或成偏枯，其脉弦长有力。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：此方为治疗脑卒中最常用方剂之一，在急性期多以此方化裁，变化而成的方剂也很多；因此方多为治疗之第一法，待肝风平息之后，则以他方施治，故临床上没有用此方作为固定方来全程治疗本病以统计疗效的报道。临证时可作加减，心中热甚者，加生石膏30g；痰多者，加胆星6g；尺脉重按虚者，加熟地黄24g，茺莢肉15g；大便不实者，去龟版、赭石，加赤石脂30g。

使用注意：忌食肥甘油腻之品。

资料来源：《医学衷中参西录》上册。

⑩建瓴汤

组成：生怀山药30g，怀牛膝30g，生赭石24g（轧细），生龙骨18g（捣细），生牡蛎18g（捣细），生怀地黄18g，生杭芍12g，柏子仁12g。

适应症：肝阳上亢，头目眩晕，耳鸣目胀，心悸健忘，烦躁不宁，舌强语言不利，口眼歪斜，半身麻木不遂，脉弦长而硬。

用法用量：磨取铁锈浓水，煎上药服。每日1剂，2次分服。

临床应用：肝阳亢旺者，尚宜加天麻、钩藤、桑叶；大便秘结者可加生大黄、芒硝；兼气虚者可加生黄芪。

使用注意：忌生冷油腻之品。

资料来源：《医学衷中参西录》中册

⑪补阳还五汤

组成：黄芪120g（生），归尾6g，赤芍4.5g，地龙3g（去土），川芎3g，桃仁3g，红花3g。

适应症：“中风”恢复期或后遗症，是否可用急性期（特别

是脑出血)尚待观察。正气亏虚,脉络瘀阻,半身不遂,口眼喎斜,语言蹇涩,口角流涎,大便干燥,小便频数,或遗尿不禁,舌苔白,脉缓。现代用于脑血管意外后遗症、小儿麻痹后遗症,及由其他原因引起的半身瘫痪、截瘫,属气虚血瘀者。

用法用量:水煎服。初得半身不遂,依本方加防风3g,服4~5剂后去之;如已病三两个月,前医遵古方用寒凉药过多,加附子12~15g;如用散风药过多,加党参10~15g。

临床应用:本方为治疗脑卒中最常用处方之一,有较好的疗效。施杞等人报道过以本方为主的益气化瘀法治疗颅内血肿(硬膜下血肿及脑内血肿)效果满意(上海中医药杂志,1983;(1):6)。对脑血栓等治疗亦有卓效(孙康泰,新中医,1988;(11):6;陈澄远,陕西中医,1988;(1):22)。

使用注意:肝阳、痰热重者本方不宜。

药理研究:1)对血液流变学的影响 “中风”患者血液具有“粘、浓、凝、聚”的倾向(指缺血性中风,笔者注),运用本方后,能增加血小板内环磷酸腺苷的含量,抑制血小板聚集和释放反应,抑制和溶解血栓,以改善微循环,促进侧支循环(浙江中医杂志,1986;(3):110)。2)对心、脑血管系统的药理作用 补阳还五汤静脉注射,有缓慢、持久的降压作用,对麻醉家兔能显著地增强心肌收缩幅度,反映心肌耗氧量的心肌张力时间指数显著降低,心肌营养性血流量明显增加(中药通报,1987;(2):51)。3)对皮下和脑内血肿吸收过程的影响 以兔皮下血肿和脑内血肿模型进行补中益气汤的实验研究,发现该方有促进血肿吸收的作用,用药后血管血流量增加,局部微循环障碍得以改善,巨噬细胞吞噬功能活跃,导致血肿明显较对照组缩小(上海中医药杂志,1985;(1):45)。4)对免疫功能的影响 补阳还五汤能使免疫功能低下小鼠的免疫器官重量增加,提高单核巨噬细胞吞噬功能,从而表明本方具有增强机体免疫功能的药理学

基础（陕西中医，1986；10：446）。5）对脑水肿自由基的作用本方可减少脑水肿时 SOD 的降低，减轻氧自由基对脑细胞、血脑屏障的损害（中国中西医结合杂志，1992；（9）：538）。

资料来源：《医林改错》卷下

⑫牵正散

组成：白附子、僵蚕、全蝎（去毒）各等分。

适应症：中风面瘫，口眼喎斜，面肌抽动。

用法用量：上药均生用，共为细末。每服 3g，热酒调下，不拘时候。

临床应用：本方最常用于感受风寒之后的面神经炎（Bell 面瘫），有许多报道。亦可以本方加味，如生川乌、生草乌、生半夏、威灵仙、全蝎、白及、陈皮、白僵蚕，制成粉末，每次用 15g（5 钱）和姜汁为糊，外敷患处，一昼夜换药 1 次。治疗 33 例，29 例完全治愈，2 例基本治愈，2 例无效（此 2 例病程超过两年以上）（哈尔滨中医，1965；（4~5））。

使用注意：忌吹风、沐雨、受寒。

资料来源：《杨氏家藏方》卷一

⑬天麻钩藤饮

组成：天麻 9g，钩藤（后下）12g，生石决明（先煎）18g，山栀 9g，黄芩 9g，川牛膝 12g，杜仲 9g，益母草 9g，桑寄生 9g，夜交藤 9g，朱茯神 9g。

适应症：肝经有热，肝阳偏亢，头痛头胀，耳鸣目眩，少寐多梦；或半身不遂，口眼喎斜，震颤、失眠，舌红，脉弦数。现用于高血压病。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：脑卒中肝阳亢旺者均可用此方加减，尤其发病后血压偏高者多用之，引申而来的新方也较多。

使用注意：忌生冷肥甘之物。

药理研究：对正常及高血压狗条件反射及血压的影响 本方200%水煎剂，在每条犬每日80ml，给药10～22日的剂量下，对高级神经活动处于正常状态的犬，不发生影响；但当高级神经活动发生障碍时，有一定的调整作用；对正常犬没有降压效果，对高血压犬则有一定的降压作用。从实验结果看，天麻钩藤饮既有降压作用，又有调节高级神经活动的作用，这为本方用于某些类型高血压病的疗效提供了部分药理学基础（中医药研究参考，1975；（9）：25）

资料来源：《杂病证治新义》

⑭羚角钩藤汤

组成：羚羊角5g（先煎），霜桑叶6g，川贝12g，鲜生地15g，双钩藤9g，滁菊花9g，茯神9g，生白芍9g，生甘草2g，淡竹茹15g（鲜刮，与羚羊角先煎代水）。

适应症：肝经热盛，热极动风。症见高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥，甚至神昏，舌质绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数。亦用于肝阳上亢、头痛、头晕、震颤、孕妇子痫。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：多用于脑溢血属阳闭者，可与牛黄清心丸同用。

使用注意：脱证不宜本方。

药理研究：降压、镇静作用明显，并有解热、抑菌、解毒、抗炎及抗惊厥作用，既可用于高血压等病，又可用于感染性疾病所致的高热惊厥（马有度，医方新解，重庆出版社，1982年）。

资料来源：《重订通俗伤寒论》

⑮三生饮

组成：南星（生用）30g，木香7.5g，川乌（生，去皮）、附子（生，去皮）各15g。

适应症：卒中，昏不知人，口眼喎斜，半身不遂，痰气上壅，咽喉作声，或六脉沉伏，或指下浮盛；兼治痰厥气厥，及气

意味着有扩血管和强心作用；血压逐步平稳上升，没有较大反复，休克缓解时间短；具有血管活性药物所没有的优点，能增加机体抵抗力，调动内在积极因素，推动全身血液循环，使休克缓解（新医药杂志，1977；（11）：20）。

资料来源：《重订严氏济生方》

①涤痰汤

组成：南星（姜制）、半夏（汤洗七次）各 2.5g，枳实（麸炒）、茯苓（去皮）各 6g，橘红 4.5g，石菖蒲、人参各 3g，竹茹 2.1g，甘草 1.5g。

适应症：“中风”，痰迷心窍，舌强不能言。

用法用量：上作一眼。用水 400ml，加生姜 5 片，煎至 200ml，食后服。

临床应用：本方有豁痰开窍之功，用于“中风”痰闭。痰热重者加川连、黄芩；便秘者加生大黄、芒硝。

使用注意：痰热重、体实者宜去人参。

资料来源：《奇效良方》卷一

②人参再造丸

组成：蕲蛇（酒炙）120g，龟板（炙）30g，玄参（去芦）30g，麻黄 60g，香附（炙）30g，山甲（珠）60g，天竺黄 30g，白芷 60g，地龙肉 15g，大黄（炙）60g，威灵仙 75g，熟地 60g，羌活 30g，姜黄 60g，乌药 30g，首乌（炙）60g，茯苓 60g，葛根 75g，细辛 30g，草豆蔻 60g，紫豆蔻 60g，藿香 60g，赤芍 30g，黑附片 30g，虎骨（炙，以牛骨代）30g，杭菊 24g，川芎 60g，青皮（炒）30g，僵蚕（炒）30g，白术（炒）30g，黄芪 60g，天麻 60g，黄连 60g，骨碎补 30g，全蝎 75g，白附子（炙）60g，防风 60g，草薢 60g，桑寄生 75g，党参（去芦）30g，沉香 30g，肉桂（去粗皮）60g，松香（炙）15g，没药（炙）30g，乳香（炙）30g，血竭花 24g，山羊血 15g，母丁香 30g，甘草

60g, 当归 60g。

适应症：“中风”中痰，口眼喎斜，言语不清，手足拘挛，左瘫右痪，半身不遂。

用法用量：以上 50 味，共研细粉，过筛。再兑入麝香 9g，牛黄 10.5g，朱砂粉 30g，犀角粉 24g，高丽参粉 60g，冰片 10.5g。混合均匀，研细，炼蜜为丸，每丸重 9g，金衣 16 开，蜡皮封固。每服 1 丸，日服 2 次，温开水送下。

临床应用：本方主要用于“中风”恢复期、后遗症期，可用菊花茶送服，以减燥性。

资料来源：《北京市中药成方选集》

①星牌华佗再造丸

组成：保密处方，未公开。

适应症：瘀血或痰湿闭阻经络之中风瘫痪，拘挛麻木，口眼歪斜，言语不清。

用法用量：口服，1 日 2~3 次，每次 8g。连服 10 天，停药 1 天，30 天为 1 疗程，可连服 3 个疗程。若有效果，可继续服用直至痊愈。预防量，每日 2 次，每次 4g。

临床应用：本处方为著名中医药专家冉小峰先生提供的历经近 200 年中医临床应用的祖传秘方。经国内 14 个医学科研单位协作，证明对脑血管疾病（脑动脉硬化引起的出血性“中风”、脑血栓形成及脑栓塞引起的缺血性“中风”）及“中风”后遗症；及冠心病、心绞痛具有独特的疗效。治疗脑血管疾病总有效率达 94.24%；治疗心血管疾病的总有效率为 93.24%。并有预防上述疾病作用。

药理研究：改善人体血液流变性，对血流受阻的血管有疏通作用，可预防血栓形成及溶解血栓。华佗再造丸对脑血管意外所引起的出血性“中风”及脑血栓所引起的缺血性“中风”具有双向治疗作用，既可止出血又可通血脉。

资料来源：粤卫药准字（85）第 A15~066 号。

②中风回春片（丸）

组成：丹参、忍冬藤、金钱草、白花蛇、红花、当归、蜈蚣、地龙等。

适应症：“中风”及“中风”后遗症。

用法用量：制成浓缩丸，每服 2g，1 日 3 次。

临床应用：卫剑琴等报道，以中风回春片治疗“中风”及“中风”后遗症 129 例，有效率在 85% 以上。

资料来源：卫剑琴，等．中成药研究，1986；（7）：19。

③佛手潜阳汤

组成：岷当归 15g，生龙骨 20g，怀牛膝 20~30g，生地 15g，川芎 6g，龟板 15g，菊花 9g，生石决明 15g，钩藤 12g，茺蔚子 9g，生牡蛎 20g，甘草 5g。

适应症：“中风”之肝阳暴亢，风火上扰证。

用法用量：水煎服。

临床应用：燥扰便结者加生大黄 5g，目赤头痛甚者加龙胆草 9g。

资料来源：夏永潮等，140 例中风病临床疗效分析，北京中医学院学报，1990；13（4）：17。

④佛手益气活血汤

组成：岷当归 30~100g，川芎 12g，黄芪 15g，赤芍 10g，水蛭 9g，伸筋草 15g，甘草 5g。

适应症：半身不遂、麻木，口舌歪斜等属于气虚血瘀“中风”者。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：便溏加白术 12g；智力低下者加枸杞子 12g，黄精 20g，白芷 9g。

资料来源：夏永潮等，140 例中风病临床疗效分析，北京中

医学院学报, 1990; 13 (4): 17。

②佛手二陈汤

组成: 岷当归 30g, 川芎 9g, 半夏 12g, 茯苓 10g, 陈皮 9g, 菊花 9g, 钩藤 9g, 甘草 5g。

适应症: “中风”属风痰瘀血痹阻脉络者。

用法用量: 水煎服。每日 1 剂, 2 次分服。

临床应用: 语言不清加菖蒲 15g; 颈项强直加葛根 12g。

资料来源: 夏永潮等, 140 例中风病临床疗效分析, 北京中医学院学报, 1990; 13 (4): 18。

④佛手育阴汤

组成: 岷当归 30g, 川芎 9g, 熟地 12g, 白芍 12g, 麦冬 15g, 元参 15g, 菊花 9g, 钩藤 9g, 麻仁 15g, 甘草 5g。

适应症: “中风”属阴虚风动者。

用法用量: 水煎服。每日 1 剂, 2 次分服。

临床应用: 便干加郁李仁 30g; 心烦不寐加黄连 7g。

资料来源: 夏永潮等, 140 例中风病临床疗效分析, 北京中医学院学报, 1990; 13 (4): 18。

⑤佛手通腑化痰汤

组成: 岷当归 30g, 川芎 9g, 半夏 12g, 茯苓 15g, 陈皮 9g, 竹沥 30g, 大黄 5g, 芒硝 5g, 桃仁 9g, 甘草 5g。

适应症: “中风”属痰热腑实, 风痰上扰者。

用法用量: 水煎服。每日 1 剂, 2 次分服。

临床应用: 头晕目胀加茺蔚子 10g; 身热苔黄加黄芩 9g。

资料来源: 夏永潮等, 140 例中风临床疗效分析, 北京中医学院学报, 1990; 13 (4): 18。

⑥佛手熄风汤

组成: 岷当归 15g, 川芎 9g, 羚羊角粉 5g (冲服), 菊花 9g, 钩藤 15g, 白芍 20g, 怀牛膝 20~30g, 代赭石 20g, 生地

15g, 桑叶 9g, 甘草 5g。

适应症：“中风”属风火上扰清窍者。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：夏永潮等于 1984 年 1 月至 1989 年 3 月，对 140 例“中风”急性期、恢复期、后遗症期患者，进行了以岷当归为主的佛手散系列处方（以上六个佛手散辨证方剂）的临床研究。病人中脑血栓形成 89 例，多发性脑梗塞 7 例，腔隙卒中 3 例，脑栓塞 2 例，脑出血 38 例，小脑出血 1 例。结果：急性期 63 例中治愈 22 例，显效 24 例，有效 17 例，总有效率 100%；加上恢复期、后遗症期者共 140 例，显效以上共 70 例（占 50%），总有效率 97.1%。邪实者，岷当归用量不宜超过 15g；正虚病例，则可用至 60~100g。本方加减法：痰浊盛者加竹沥 30g；肝火引动心火，心烦舌烂者加黄连 9g，连翘 15g。

药理研究：岷当归含 104 种化学成分，具有镇静止痉、镇痛、安神、增强机体对缺氧的耐受力、抑菌消炎、抗辐射、增强免疫、抗凝解聚等药理作用。

资料来源：夏永潮等，140 例中风病临床疗效分析，北京中医学院学报，1990；13（4）：18。

⑦加减防风通圣散方

组成：防风、荆芥、麻黄、薄荷、大黄、芒硝、赤芍、归须、川芎、栀子、连翘、黄芩、甘草、滑石、石膏、寒水石、天竺黄。

适应症：中风闭证。

用法用量：水煎服。和入安宫牛黄丸 1 丸，竹沥 150ml，能吞咽者少量频灌，不能吞咽者则鼻饲给药。

临床应用：何炎燊（广东）主任医师方。何氏认为“冬地育阴，介属潜阳，只可防治大厥未发之前，或用于闭开厥回，风火渐戢之后。（闭证）此时标证急，急当治标……迅折风火上腾之

威，使清空诸窍无使浊痰壮火蒙蔽，乃暂药之权衡也。……泄可去闭……不仅可挽救垂危，更可减轻后遗症，以利康复。”畅下之后，多汗出漉漉然，则壅壅塞得通，两三日间，恶候渐退，神识渐清。此时炉烟虽熄，恐灰中有火，勿畏虚投补，仍需清火息风为治。

使用注意：有脱象表现者忌用本方。

资料来源：史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：10～12。

②镇肝益阴汤

组成：生石膏 30g，生石决明 30g，黛蛤粉 30g，胆草 9g，天竺黄 9g，九节菖蒲 9g，旋覆花 9g，代赭石 9g，知母 9g，黄柏 9g，牛膝 9g，川郁金 9g，竹茹 12g，滑石 12g，磁石 12g，安宫牛黄丸 1 粒（化入），羚羊角粉 0.6g，犀角粉 0.6g（无犀角以广角代）冲服。

适应症：脑卒中闭证。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：如突然昏仆，脉沉弦而缓者，必然四肢不温，面色苍白，此气血郁闭之象，可先用苏合香丸开之，或于方中去安宫牛黄丸，加入苏合香丸。如服后脉转滑数，面转红润，再去苏合香丸，改用安宫牛黄丸。其余随证加减。

使用注意：脱象出现时即宜停用。

资料来源：史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：20～21。

③固脱保元汤

组成：黄芪 30g，党参 30g，熟地 30g，山茱萸 18～30g，桂圆肉 18～30g，山药 30g，枸杞子 15g，茯神 12g，枣仁 12g，白术 10g，生龙骨 12～30g，生牡蛎 12～30g，甘草 3g。

适应症：脑卒中脱证，五绝中仅出现肝、脾、肾三绝者。即

出现眼合、手撒、遗尿三症，尚属可救。

用法用量：煎服或鼻饲。

临床应用：王季儒（天津）主任医师以此方和镇肝益阴汤加减分别救治脑溢血闭证和脱证，具有一定效果。

使用注意：闭证本方不宜。

资料来源：史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：23。

③加味犀角地黄汤

组成：犀角、生地、丹皮、生白芍、阿胶、连翘心、黄芩、夏枯草、牛膝、菖蒲、麝香。

适应症：气血并走于上，上冲于脑，血热妄行，出于经络，面色潮红，神志昏蒙，脉象弦数。亦即脑溢血急性期。

用法用量：煎服或药汁鼻饲。

临床应用：本方为陕西刘茂甫教授所创立，认为急则治标，脑出血急性期必须以凉血止血为当务之急。

使用注意：不可用于脱证，对内闭外脱者宜加参附汤。

资料来源：史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：42。

④旱田黄龙饮

组成：旱莲草 15g，田七 6g（研末冲服），蒲黄 10g（生、炒各半，布包煎），地龙 12g，野菊花 15g，茜草 10g，毛冬青 100g（先煎），川牛膝 15g，丝瓜络 20g，红花 3g，生地 12g，丹参 15g。

适应症：脑血栓与脑溢血并存的复合性“中风”，或单纯的脑出血，或脑梗塞。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：本方为桂林蒋日兴主任医师验方。蒋氏通过大量的临床实践，发现脑出血和脑梗塞并非截然相反而单独存在的疾

病，两者之间均有共同的病理基础，两者可同时或先后存在于同一个病人身上，成为复合性“中风”。历代中医文献缺乏这种记载，此方治疗复合性中风，效果满意。治单纯脑出血，尚须加入止血药；治单纯脑血栓，须再加入化瘀通络之品。

使用注意：忌过食肥甘厚味。

资料来源：史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：86～88。

③马氏高屋建瓴汤

组成：生大黄 15～30g，元明粉 10～20g，枳实 10g，川牛膝 15g，代赭石 30g（打碎），生地 40g，黑山栀 15g，生石决 40g，生珠母 50g，磁石 50g。

适应症：“中风”昏迷。

用法用量：灌肠与鼻饲同时并用，灌入本方水煎药液。

临床应用：苏州马云翔主任军医认为本证乃“血之与气并走于上”之大厥，在发病 2 日以内急通大便，救治成功的机会较大。应用本方如所下的数量不多，第二三天连续通导，直至苏醒为止。马氏该验方，特别重视大黄的降逆作用。

使用注意：大黄后下，煎煮时间不宜长。

资料来源：史宇广等，当代名医临证·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：164～165。

③脑溢血方

组成：桑寄生 15g，元参 15g，生石膏 30g，海螵蛸 10g，胆星 10g，钩藤 15g，生蒲黄 10g，茜草根 15g，地龙 10g，夏枯草 15g，小蓟 20g，犀角粉 0.1g，羚羊粉 0.2g，血竭粉 0.5g（后 3 味共研细末分冲）。

适应症：脑溢血急性期。症见猝然昏仆，神志不清，二便失禁，呕吐抽搐，半身不遂，或体温增高，头面汗出，呼吸困难，瞳孔初期缩小，后扩大，两侧不等，甚则角膜反射消失。脉弦

烈等用该药颈动脉注射，治疗脑溢血 10 例，脑血栓形成 19 例，脑栓塞 1 例，总有效率达 96.7%。

资料来源：汤克仁等，山东中医杂志，1987；10：32。李果烈等，上海中医药杂志，1987；(5)：26。

三、单方验方

(一) 水蛭粉：每服 2~3g，日服 2 次（王合森等，中西医结合杂志，1990；(11)：694）。

(二) 安宫牛黄丸：每次 1 丸，日服 2~4 次（《温病条辨》）。

(三) 局方至宝丹：每次 1 丸，日服 2~4 次（《局方》）。

(四) 苏合香丸：每次 1 丸，日服 2~4 次（《局方》）。

(五) 云南白药：先服保险子，然后每服 1g，1 日 3~4 次（张笑平，中医急诊学，湖南科技出版社，1990）。

(六) 大黄粉：2~3g/次，每日 2 次（郭桃美，当代中医验方精选，上海科学技术出版社，1990）。

四、中成药

脑血康

治疗脑出血的成药尚不多，疗效较好的是中国中医研究院西苑医院等单位研制的脑血康口服液。

组成：水蛭等提取物。

功效：活血化瘀，破血消癥。

主治：脑出血急性期及恢复期。

用法用量：每次 1 支，每日 3 次口服或鼻饲灌服。

临床应用：西苑医院神经科 1980~1985 年期间治疗高血压脑出血 306 例，其中脑血康口服液治疗 180 例，西药治疗 66 例及手术治疗 60 例作为对照组。均于病程 1~7 天（平均 3 天）开始治疗。结果脑血康组治愈 107 例（59.4%），显效 38 例

(21.1%), 好转 17 例 (9.4%), 无效 18 例 (10.0%), 总有效率达 90.0%; 而西药组治愈 31 例 (46.9%), 显效 13 例 (19.7%), 好转 10 例 (15.2%), 无效 12 例 (18.2%), 总有效率 81.8%; 手术组治愈 18 例 (30.0%), 显效 19 例 (31.6%), 好转 13 例 (21.7%), 无效 10 例 (16.7%), 总有效率 83.3%。可以认为脑血康口服液治疗脑出血有很好的疗效。

方义解释: 脑出血为血溢脑络之外, 造成脑中瘀血证。水蛭破血逐瘀, “化瘀血而不伤新血” (《本经》), 正合本病之治则。味简力专, 收效迅速。

药理研究: 脑血康口服液能增强吞噬细胞功能, 促进血肿吸收; 加速纤维蛋白溶解; 改善微循环; 降压; 抑制血小板聚集并降低血浆 TXB₂ 含量, 有抗血栓、溶血栓作用。

资料来源: 谢道珍等, 中西医结合杂志, 1988; 8 (6): 341~343。

五、饮食疗法

脑出血大多由高血压病及动脉硬化发展而来, 故应注重控制过多地摄入钠盐及脂类食物, 饮食清淡, 忌肥甘厚味。饮食方如下, 主要用于预防和治疗高血压病及动脉硬化。

(一) 海蜇皮 30g, 荸荠 500g, 用水煮汤饮 (吴大真, 疑难病证良方妙法, 中国医药科技出版社, 1991)。

(二) 玉米须 60g, 煎水 600ml, 分 3 次服 (同 (一))。

(三) 枸杞菜 500g, 鲜桑椹 120g, 煎汁饮 (叶橘泉, 食物中药与便方, 江苏科学技术出版社, 1980)。

(四) 水芹菜 500g, 黑枣 250g。用水煮熟吃; 既防治高血压病, 又对治疗高血脂有益 (同 (三))。

(五) 昆布 120g, 绿豆 90g, 红糖 90g; 用水煮熟, 经常吃。防治疾病同四方 (同 (三))。

(六) 香蕉 500g, 黑芝麻 15g, 用香蕉蘸黑芝麻吃, 1 日吃完; 对高血压、脑出血(轻型)大便秘结者有效(窦国祥, 饮食治疗指南, 江苏科学技术出版社, 1981)。

(七) 牡蛎肉 90g, 决明子 30g。用水煮烂吃, 对脑卒中伴便秘者有效(同(六))。

(八) 竹沥汁 30ml, 姜汁或鲜石菖蒲汁 2ml, 灌服; 对脑出血昏迷痰浊壅盛者有效(何绍奇, 现代中医内科学, 中国医药科技出版社, 1991)。

六、医案医话

(一) 张琪医案——脑出血痰热内阻、腑实不通案

刘某, 男, 46 岁, 工人。1970 年 4 月 14 日初诊: 有高血压病史。于 1 周前突然昏迷跌倒, 继而出现右侧上下肢瘫痪。经某医院诊断为脑内囊出血。病人意识不清, 口眼向左歪斜, 牙关紧闭, 右侧瞳孔散大, 高热持续不退。血压 22.7/13.3kPa, 病理反射阳性。虽用多种抗生素, 其热不退。1970 年 4 月 14 日请中医会诊。病情如下:

病人昏不知人, 右侧肢体瘫痪, 口角歪斜, 面颊赤, 唇干, 胸部烦热, 牙关紧闭, 喉中痰声曳锯, 呼吸气粗, 双手紧握, 大便 7 日未行, 遗尿, 小便赤涩, 腹部拒按, 发热不退。舌红苔黄燥, 脉象滑数有力。病属“中腑”, 痰热内阻, 腑实不通。投以化痰清热, 开窍通腑泻浊之剂。处方: 半夏 15g, 橘红 15g, 麦冬 20g, 玄参 20g, 生地 25g, 川连 10g, 黄芩 15g, 郁金 15g, 菖蒲 15g, 大黄 10g, 菊花 20g (后下), 蒺藜 20g, 甘草 10g。

4 月 17 日二诊: 服前方 2 剂, 体温降至 37.2℃, 病人意识稍清, 但仍处于半昏迷状态, 可对话一两句, 烦热之象大减, 牙关已开, 大便仍未行, 小便已知。舌苔厚而干, 脉弦滑有力。此痰热及内结之实热稍减, 清窍见利, 但大便未通, 以前方增减,

加芒硝以软坚通便。处方：大黄 15g，芒硝 15g（冲），橘红 15g，枳实 15g，郁金 15g，川连 10g，黄芩 15g，菊花 15g（后下），玄参 20g，生地 20g，麦冬 20g，蒺藜 20g。

4月20日三诊：服药2剂，大便下行3次，量较多，坚硬成块，意识逐渐转清，已经能对话，烦热已除。舌质鲜红，苔白干。体温36.4℃，喉部痰声已减，从证候可知腑实已通，痰热得清，清窍已开，续以前法治之。处方：半夏 15g，胆星 15g，橘红 15g，茯苓 15g，菖蒲 15g，郁金 15g，玄参 20g，甘草 7.5g，川连 10g，黄芩 15g，大黄 7.5g，生地 20g，麦冬 20g。

4月27日四诊：服药3剂，舌强已明显好转，吞咽稍呛，右侧半身偏瘫。舌质红，苔已退，脉弦滑。宜清热养血活络。处方：秦艽 15g，羌活 10g，独活 15g，防风 10g，川芎 15g，白芷 15g，黄芩 15g，生地 20g，生石膏 40g，当归 20g，白芍 20g，苍术 15g，茯苓 15g。

5月3日五诊：服前方5剂，诸症悉减，尤以患侧肢体功能恢复明显，血压20/13.3kPa，舌、脉同前。继服前方。

5月15日六诊：服药6剂，肢体活动明显恢复，可扶杖下地走几十步，上肢稍能抬起，仍用上方加地龙 15g。

病人续服前方20余剂后，肢体功能基本恢复，可以自己料理生活（史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：132～134）。

（二）王季儒医案——脑出血内闭外脱案

郝某，女，74岁，住院号7806178。1978年9月7日入院。

患者入院前两天，突然出现心慌、胸闷、恶心，曾呕吐两次，为胃内容物，吐时大汗淋漓，四肢发挺。持续两小时后，症状缓解，而左半身无力，尚能活动。语无伦次。大便两次，为稀便，小便正常。经用强心药及健胃药，症状好转。今晨发现左侧偏瘫，而来院就诊。既往无高血压史，1976年曾出现过心房纤

颤。症见：体温 36.7°C ，血压 $24/16\text{kPa}$ ，神志朦胧，答非所问，口角右歪，左鼻唇沟及左眼裂变浅，闭合欠佳，两眼闭不能睁，瞳孔等大等圆，对光反射尚好，牙关紧闭，颈有抵抗感，两肺呼吸音清晰，心率 84 次/分钟，肺动脉区可闻及收缩期杂音 II 级。左侧肢体呈弛缓性瘫痪，肌张力下降，感沉迟钝，左侧膝腱反射亢进。脉弦滑。西医诊断“脑栓塞”。

该患者年逾古稀，家务操劳，阴虚于内，肝阳妄动，煽动肝风，故卒然四肢强直，牙关紧闭，口歪。此所谓“诸暴强直，皆属于风”；肝阳上犯心包，则心慌烦躁，语无伦次；犯胃则胸闷呕吐。且热能生痰，肝风挟痰横窜络道，故半身不遂。眼不能睁亦经络闭阻而为上眼睑麻痹。治以育阴潜阳，清热豁痰，佐以芳香开窍。生海蛤 30g，生牡蛎 15g，生龙骨 15g，杭菊花 10g，清半夏 10g，陈皮 5g，茯神 12g，天竺黄 9g，石菖蒲 9g，知母 9g，黄柏 9g，郁金 9g，十香丹 1 粒（化服）。

同时用脉通液 500ml 静脉点滴，及抗感染等治疗，并氧气吸入。

入院后，当天下午发现尿失禁，第二天上午嗜睡，神志半清，两侧瞳孔小，反射弱，颈有抵抗感，尿失禁。血压 $20/13.3\text{kPa}$ ，心率 84 次/分钟，左侧肌张力增强，至下午深度昏迷，病情加重。

9 月 9 日，体温 37.4°C ，深度昏迷，眼合，遗尿，颈有抵抗感，牙关紧，瞳孔左大于右，反射微弱，脉弦滑无力。已成中脏腑之闭脱兼见。腰穿脑脊液鲜血样，颅压高。停用脉通液，改用降颅压、止血剂。中药以镇肝息风、清热凉血、醒脑开窍，稍事固脱止血之法：生石决明 30g，生龙骨 20g，生牡蛎 20g，天竺黄 9g，菖蒲 9g，磁石 15g，全蝎 5g，钩藤 10g，牛膝 10g，丹皮 9g，杭菊 12g，生地 20g，鲜茅根 30g，血余炭 9g，党参 15g，广角粉 1g（冲），安宫牛黄丸 1 粒（化入）。鼻饲。

9月10日，体温 37.4°C ，血压 $14.7/9.3\text{kPa}$ ，昨天下午及夜间吐咖啡样物2次，潜血（++++），颈略抵抗，瞳孔左大于右，夜间多汗。症见眼合，口开，遗尿，舌质红绛，舌苔略呈黄黑色，脉转虚大，沉取似无。听诊：两肺呼吸音粗，有湿啰音，腹隆起，肠鸣音减弱。左侧肢体肌张力下降，痛觉消失。

患者眼合、口开、遗尿，是五绝中已现其三，且汗出颇多，脉虚大无根，是阳气有外越之象，正气有暴脱之险，急宜改弦更张，用强心固脱，补气止血法。炙黄芪 24g ，党参 20g ，熟地 20g ，生地炭 15g ，生龙骨 20g ，生牡蛎 20g ，枸杞子 15g ，菟丝子 15g ，茯神 12g ，菖蒲 9g ，天竺黄 9g ，山茱萸 12g ，三七粉 3g ，白及粉 3g （分2次冲服）。

9月11日，患者于凌晨半点出现抽搐5分钟，后呼吸表浅，时伴潮式呼吸，至1时半又抽1次，血压 $14.7/9.3\text{kPa}$ ，体温 37.6°C ，病情继续恶化，除有心肝肾三绝外，又加呼吸表浅及抽搐，是虚风内动，随时有厥脱之险。仍以强心补肾，益气固脱。党参 15g ，麦冬 15g ，五味子 5g ，菟丝子 12g ，枸杞子 12g ，杭芍 12g ，桂圆肉 5g ，生龙骨 20g ，生牡蛎 20g ，梔子 10g ，丹皮 10g ，生地 20g ，三七粉、白及粉各 3g （冲入）。

9月12日，药后脉转滑数，是虚脱之象已得控制，口开已合，今早又抽4次。体温 37.8°C ，血压 $18.1/13.3\text{kPa}$ ，昏迷虽然未减，而脉则大有转机，且血压回升，当舍证从脉，改用镇肝息风，清热祛痰，稍加固正之本。生石决明 30g ，胆草 9g ，生地 15g ，僵蚕 9g ，生龙骨 20g ，生牡蛎 20g ，知母 9g ，地龙 9g ，丹皮 9g ，忍冬藤 15g ，生石膏 24g ，竹茹 15g ，杭芍 15g ，梔子 9g ，天竺黄 9g ，菖蒲 9g ，党参 20g ，羚羊角粉 0.6g （分冲），安宫牛黄丸1粒。

9月13日，仍深度昏迷，肌肤转灼热，脉转疾数，偶有间歇，呼吸平稳，右肺有少许啰音，舌质干乏津，眼睑偶有抽

动，但抽搐已减，血压 24/14.8kPa。患者血压逐渐回升，脉转数疾而促，虽昏迷未减，而呼吸平稳，喉有痰声，肌肤灼热，舌干乏津，痰热虽然炽张，正气已有来复之渐，再以祛邪扶正，虚实兼顾，以清热镇肝，养阴固正。生石膏 30g，石决明 30g，天竺黄 9g，菖蒲 9g，知母 9g，黄柏 9g，竹茹 12g，党参 20g，黛蛤粉 30g，甘草 3g，竹沥水 30g（兑入），安宫牛黄丸 1 丸（代入）。

9 月 14 日，烧退，体温 37.2℃，呼吸平稳，喉有痰声，两侧瞳孔等大，反射迟钝，脉象亦较缓和，因多日无大便，原方加火麻仁 15g。

9 月 15 日，夜间有时睁眼，右手亦偶有活动，呼吸平稳，痰减少，呼之有意识反应，脉弦滑。自 9 月 8 日起已昏迷 8 天，今日稍清醒，原方每日 1 剂。

9 月 18 日，神志较清，能唤醒，有时领会语义，可简单回答问题，唯吐字不清，自言有饥饿感，血压 20/14.8kPa，脉缓和，再予育阴柔肝，豁痰通络。生石决 30g，生龙骨 20g，杭菊花 9g，天竺黄 9g，菖蒲 9g，郁金 9g，知母 9g，黄柏 9g，竹茹 12g，生地 15g，桑寄生 30g，威灵仙 9g，清半夏 9g，瓜蒌 30g，黛蛤粉 30g，竹沥水 30g（兑入），十香丹 1 粒（化入）。

9 月 19 日，取出鼻饲管。大便 1 次如柏油样便，潜血（++++），自病后 10 天无大便，其潜血是病中曾有上消化道出血之故。以后即按此方稍事增减，至 11 月 13 日步行出院（史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：24~28）。

七、现代报道

（一）历史上有相当长的一个时期认为脑卒中的本质是外风侵袭人体的经络、脏腑，故在“中风”的理论影响下有了“中经

络”、“中脏腑”的分类。以后又倡内风（或类风）说，认为“中风”是机体功能失调导致气逆、血涌、肝阳化风，挟痰邪为患，治疗脑出血也不离平肝或清肝、化痰、息风、降气等治法（李富生等，上海中医药杂志，1990；（10）：32）。

（二）自本世纪对脑卒中的病理有了较明确认识以来，认识到脑出血的根本病机即脑中络破血溢，造成脑部瘀血证。由于病势凶险，对进行活血化瘀治疗脑出血的构想近年来才应用于临床，但尚未被广泛接受。活血止血法是现代治疗脑出血的一个新进展。实践证明，如脑出血得不到控制，脑微循环障碍，会导致脑水肿进行性加重，复苏即成问题。如何才能有效地控制出血、改善脑部微循环障碍，实为脑出血治疗成败的一大关键。一些学者认为，古代文献限于当时条件，对脑出血这一层缺少认识，本病一旦确诊，应立即用凉血止血法，以解决主要矛盾。选用频率最高的方剂是犀角地黄汤（犀角、生地黄、赤芍、丹皮），在此基础上酌加潜镇息风、化痰降逆药物。近年来，鉴于凉血止血治疗本病的疗效还有待提高，不少学者提出应用活血止血法即“以行为止”的方法来治疗脑出血，不仅有应用活血兼止血药物的方剂，如前节提到的“旱田黄龙饮”等；也有纯用活血化瘀方如桃红四物汤；也有用破血药者，如中研院用脑血康口服液（有的单位用水蛭粉），唐山工人医院的郭凤鲁、司志国等重用乳香、没药、三棱、莪术、桃仁、牛膝；更有一些学者应用活血化瘀静脉制剂，如丹参注射液、川芎嗪注射液、毛冬青注射液、当归注射液、血府逐瘀注射液等，早期或待病情略平稳后即予足量应用，取得了令人欣喜的疗效，而且用药便利。活血化瘀方药及其制剂有利于迅速止血，减轻颅内血肿形成或加速血肿吸收，改善脑微循环，对抗脑出血时大量释放的自由基，从而减轻脑水肿，防止由脑疝形成所致的脑干缺血，对于减轻病情及减轻后遗症，均有显著的作用，而不致加重出血（王合森等，中西医结合杂志，

1990; (11): 694。张存志等, 新中医, 1992; (7): 33。何绍奇, 现代中医内科学, 中国医药科技出版社, 1991)。

这方面有许多成功的经验, 如上海高血压研究所曾用复方丹参注射液静脉点滴治疗有意识障碍的脑出血 36 例, 其中昏迷 17 例, 嗜睡朦胧 19 例, 存活率 27.9%。福建省泉州市人民医院吴端源用丹参注射液治疗急性脑出血患者 20 例, 并与 20 例 6-氨基己酸治疗组作对照, 用时将丹参注射液 8 支溶于 5% 葡萄糖溶液 500ml 中静脉点滴, 每日 1 次, 7 天为 1 疗程。结果丹参注射液组痊愈 8 例、显效 5 例、有效 3 例、死亡 4 例; 6-氨基己酸组痊愈 5 例、显效 5 例、有效 3 例、死亡 7 例。河北陈启俊等报道, 以上法 (丹参剂量大到 60ml) 治疗 42 例, 仅 2 例死亡, 效果甚佳 (对照组 38 例以西药治疗, 死亡 8 例), 显效率及有效率均优于对照组 ($P < 0.01$ 及 $P < 0.05$) (王合森等, 中西医结合杂志, 1990; (11): 694)。

(三) 关于脑出血治疗中应用活血药的安全性以及是否应该应用止血药问题, 一直是临床医师应用活血类药物治疗脑出血所关心的焦点。有资料证明, 除了血液病 (如白血病、再生障碍性贫血、原发性血小板减少性紫癜、血友病、恶性贫血等) 以及由肝病引起的脑出血外, 大多数脑出血的病理基础是脑内小动脉变性及动脉瘤, 与凝血机制障碍无明确关系。有人证明在脑出血发病后 6 小时内进行的脑血管造影中, 从未观察到造影剂从破裂的血管外溢; 用同位素标记的红细胞注入脑出血患者的静脉, 在血肿内未能发现放射性标记的红细胞; 用 CT 观察也证实, 6 小时后血肿不再扩大。因此, 脑出血急性期止血不再是“首要问题”。血压的理想控制, 即可防止再出血。急性期的首要任务是在于解除血肿对周围组织的压迫, 缓解以至消除血肿周围不能代偿的组织水肿, 以便改善神经组织的缺血、缺氧和坏死。活血药对此有很好的作用, 所以活血化瘀方药治疗脑出血会不会加重出血及

(或)引起再出血不必过多考虑。再者,活血化瘀药物对凝血机制具有双向调节作用,也为其治疗脑出血提供了一个有力的佐证 (Ojemann GR, et al. Neuro 1975; (23): 220. Kanno T, et al. J. Neurosurg 1984; (61): 1091。王楠等,上海中医药杂志, 1985; (1): 45。李富生,上海中医药杂志, 1990; (10): 32)。

八、主要参考资料

1. 王合森等,脑出血急性期的活血化瘀治疗研究概况,中西医结合杂志, 1990; 10 (11): 694~696
2. 陈启俊等,活血化瘀法治疗老年急性期出血性脑血管病 42 例报告,实用中西医结合杂志, 1991; 4 (2): 80-81
3. 李富生等,中风的研究进展,上海中医药杂志, 1990; (10) 32-35
4. 王楠等,益气化瘀法治疗皮下和脑内血肿的实验性研究,上海中医药杂志, 1985; (1): 45
5. 秦芝芃等,高血压动脉硬化性脑出血 55 例的临床与病理分析,中国神经精神疾病杂志, 1980; (6): 200
6. 何绍奇,现代中医内科学,北京:中国医药科技出版社, 1991: 435~437
7. 黄泰康等,中药方剂现代研究大典,科学出版社, 1996

之地”。故脑中络脉畸形或患有动脉瘤等，造成局部对血液压力承受能力薄弱，一遇扰动，便络破血溢，酿成是疾。

(二) 情志不节 七情太过，肝失调达，郁而化火，肝阳暴张，血随气逆，上扰清空，发为头痛或昏迷。《内经》云：“血之与气，并走于上，则为大厥。”

(三) 胃腑积热 阳明火炽，灼木生火，肝火上炎，风火相煽，迫血妄行；内扰神明，蓄血于髓腔，则为昏迷，或半身不遂，语言不利。

(四) 痰热内扰 肝旺侮脾，健运失司，聚湿生痰，郁久化热，痰热上扰清空，神明被扰，脑络瘀滞。

本病发病迅速，证情险恶。不论初起病因为何，根本病机是脑络受损，血溢于蛛网膜下腔，同时引起脑实质内血流量锐减，脑血管痉挛，脑实质可以大片缺血坏死，故不论血溢络外、还是气血不通造成脑之坏死，均是瘀血；瘀滞于脑中，扰乱神机，脏腑功能失调，则又有内风、痰热之变。于是有头痛如劈、神志昏蒙、或半身不遂或言语失利，甚则内闭外脱，以至不救。

二、辨证施治

(一) 辨证要点

本病属血证，乃脑中蛛网膜下腔“蓄血”，同时脑实质又有缺血坏死，均是瘀血为患。但因体质各异，症有兼挟，病有轻重，临床所见证型多端，均须明辨。

(二) 辨证分型

1. 肝火头痛型

头痛剧烈，多位于巅顶、后枕和项部，有时放散到前额或眼部及全头部，急躁易怒，恶心呕吐，颈项强直，夜寐不安，面红目赤，便干溲黄。舌质红，苔薄黄或黄厚，脉弦数。

2. 胃热头痛型

头痛剧烈，以前额部疼痛为主，可向全头扩展，恶心呕吐，口臭口干，口舌生疮，渴喜饮冷，夜寐不宁，大便秘结，小便黄赤。舌红苔黄，脉滑数或弦大。

3. 痰热头痛型

剧烈头痛，恶心呕吐，口干不欲饮，口淡无味，腹胀纳呆，心烦不眠，大便数日不下。舌质红，苔黄厚腻，脉滑数，或弦滑数。

本病常有意识障碍、偏瘫、失语、抽搐，乃与脑出血、脑梗塞病机一致，可参见该二章辨证分型。

(三) 治法方药

蛛网膜下腔出血证属瘀血，故首当采用活血化瘀之法，但证以出血为急，又当以宁血止血为要。根据辨证，投以相应方药，有利于降火、凉血止血，苏醒神志，缓解头痛。

1. 分型治疗

(1) 肝火头痛型 清肝潜阳。龙胆泻肝汤加减：龙胆草 10g，炒栀子 6g，黄芩 10g，夏枯草 12g，菊花 10g，柴胡 6g，当归 12g，丹参 15g，赤芍 15g，葛根 15g，玄胡索 30g。嗜睡者，加九节菖蒲 12g，郁金 10g，远志 10g，化痰开窍；谵妄者加川黄连 6~10g，安宫牛黄丸 1 粒；肢体瘫痪者，加桑枝 30g，川牛膝 15g，地龙 15g，疏风通络；抽搐肢强者，加僵蚕 10g，全蝎 3 条，天麻 10g，钩藤 15g，息风止痉。

(2) 胃火头痛型 清胃泻火。泻心汤加减：黄连 10g，黄芩 6g，生大黄 5~10g，石膏 30g，知母 12g，牛膝 15g，当归 10g，丹皮 15g，茜草 12g，枳实 6~10g。呕吐甚者，加鲜竹沥水 10ml，姜汁 2ml 同服。

(3) 痰热头痛型 清热化痰宁痛。黄连温胆汤增删：黄连 10g，姜半夏 10g，橘红 6g，枳实 10g，胆南星 6g，全瓜蒌 15g，生大黄 6~10g，苍术 10g，蔓荆子 12g，赤芍 15g，丹参 12g。

12g, 大黄 10g。

适应症：蛛网膜下腔出血。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：卢桂梅将本病辨为痰浊、血瘀、痰迷心窍、肝阳上亢、肝阳暴亢、肝肾阴虚六型；同时认为证情错综复杂，往往不是一型独见，常为多型兼挟互见。故以清热祛瘀汤为主，灵活变通，随证加减治疗十数例，临床观察到在改善症状、缩短疗程、减少死亡及后遗症的发生方面，效果满意。

资料来源：卢桂梅，新中医，1989；(8)：44。

④龙胆白虎汤

组成：龙胆草、生石膏、知母、竹叶、瓜蒌、丹皮、生地、杭芍、大黄、朴硝。

适应症：蛛网膜下腔出血。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：林鸣鸾等治疗本病用龙胆白虎汤随证加减，连服 20 剂取得满意疗效。

资料来源：林鸣鸾等，中医杂志，1962；(5) 21。

⑤大承气汤

组成：大黄 12g (酒洗)，厚朴 15g (去皮)，枳实 12g (炙)，芒硝 9g。

适应症：阳明腑实证及上焦热盛的疾病。现多用于多种急腹症，高热及上焦急性出血，如蛛网膜下腔出血、脑出血等。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：王子耀治一神昏口噤，腹满坚实之本病患者以大承气汤合安宫牛黄丸溶化鼻饲，2 剂后神清，以后改用羚角钩藤汤、三甲复脉汤调理半月，治愈（新中医，1986；(10)：20）。崔振风治李某剧烈头痛旋即昏迷，半月未行大便，处方以菊花、赤芍、木瓜、葛根、生大黄、芒硝、炙甘草。两剂见效，又加

减治疗 18 剂，亦愈（河北中医，1988；（3）：23）。钟氏则以本方参入泻火凉血、平肝息风诸药之中，投以石决明、珍珠母、槐花、黄菊、赤白芍、桃仁、丹皮、黄芩、生军、元明粉（冲）、羚羊角、麻仁。3 剂神清，患者出院（徐立民等，浙江中医杂志，1962；（5）：21）。李和等治本病头痛如破，二便秘结，予平肝降逆，通便行血之剂，药用羚羊角、旋覆花、代赭石、生龙牡、清半夏、元明粉、郁李仁、川军、玄参、荷叶、牛膝、藜本等，随证加减（中医杂志，1958；（5）：330）。

资料来源：同临床应用项。

⑥桃核承气汤

组成：桃仁 50 个（去皮、尖），桂枝 6g（去皮），大黄 12g，甘草 6g（炙），芒硝 6g。

适应症：瘀热蓄于下焦，少腹急结，大便色黑，小便自利，甚则谵语烦渴，其人如狂，至夜发热，及血瘀经闭、痛经，产后恶露不下，脉沉实或涩。现用于蛛网膜下腔出血。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：谢权桂治本病突发剧烈头痛，喷射性呕吐，大便不通等，以本方加减，方用桃仁、红花、当归、赤芍、丹参、田七、乳香、木香、钩藤、大黄、栀子等随证加减获佳效。

资料来源：谢权桂，新中医，1978；（5）：30。

⑦清瘟败毒饮

组成：生石膏（大剂）180～240g（中剂）60～120g（小剂）24～36g，生地（大剂）18～30g（中剂）9～15g（小剂）6～13.5g，犀角（大剂）18～24g（中剂）9～12g（小剂）6～12g，川连（大剂）12～18g（中剂）6～12g（小剂）3～4.5g，生栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、鲜竹叶、甘草、丹皮各 3～6g。

适应症：温热疫毒及一切火热之证。气血两燔，高热狂躁，

心烦不眠，或神昏谵语，头痛如劈，大渴引饮，咽痛干呕，发斑吐血，舌绛唇焦，脉沉细而数，或沉数，或浮大而数。现用于流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、败血症及蛛网膜下腔出血等表现为气血两燔者。

用法用量：石膏先煎 10 余分钟后，再入余药同煎；犀角磨汁和服，或研末，或先煎兑入，分 2 次服。六脉沉细而数者用大剂；沉而数者用中剂；浮大而数者用小剂。

临床应用：相玉珍治疗本病 16 例，初期昏迷者用安宫牛黄丸、紫雪丹灌服或鼻饲；清醒后用本方（包括犀角地黄汤、白虎汤、清营汤等），结果治愈 10 例，好转 6 例。

资料来源：相玉珍，河北中医，1987；（6）：36。

⑧蛛网膜下腔出血昏迷方

组成：石菖蒲 10g，生蒲黄 10g，清半夏 10g，全蝎 10g，天麻 10g，钩藤 15g，胆星 10g，羚羊角粉 0.5g，琥珀粉 0.4g（后 2 味同研细末分冲）。

适应症：蛛网膜下腔出血。发病前常单侧头痛眩晕，剧烈头痛，呕吐继而昏迷，甚则二便失禁，沉睡不醒，抽搐，半身麻木或不仁，脉弦大或弦数。舌红苔垢。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：邢锡波验方，史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：119。

⑨蛛网膜下腔出血神清偏瘫方

组成：黄芪 30g，元参 15g，丹皮 10g，当归尾 10g，制乳香 10g，制没药 10g，川芎 8g，地龙 10g，磁石 15g，桃仁 10g，伸筋草 15g，鸡血藤 15g，血竭 0.6g，安息香 0.1g，麝香 0.04g（后 3 味同研细末分冲）。

适应症：蛛网膜下腔出血。神清后，仅见半身麻木不仁。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2～3 次分服。

资料来源：邢锡波验方，摘自史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：119)。

⑩其它方剂，如镇肝息风汤、犀角地黄汤、羚角钩藤汤、补阳还五汤、清开灵等亦为本病常用处方，详细内容参见脑出血及脑梗塞章。

三、单方验方

(一) 龙胆泻肝丸：每服 6g，日服 2～3 次。

(二) 芎菊上清丸：每服 6g，日服 2 次。

(三) 牛黄清心丸：每服 1 丸，日服 2 次。

(四) 安宫牛黄丸：每服 1 丸，日服 2 次。

(以上选自陈贵廷，等，实用中西医结合诊断治疗学，中国医药科技出版社，1991 年)

(五) 局方至宝丹：每服 1 丸，日服 2 次。

(六) 云南白药：先服止血保险子，然后每服 1g，日服 2～3 次。

(以上选自中华全国中医学会武汉分会，中医急症，湖北科学技术出版社，1986 年)。

其余可参照“脑出血”部分。

四、中成药

丹参注射液

来源：张存志等，河北中医，1987；(1)：6。新中医，1992；24(7)：33～34。

组成：丹参提取物。

功效：活血化瘀。

主治：各种瘀血证。近年来除用于缺血性脑卒中的治疗外，逐渐用于脑出血及蛛网膜下腔出血的急性期。

五、饮食疗法

(一) 干莲房 1 个，烧灰为末，温开水冲服。(郑启明，民间饮食疗法，广西人民出版社，1981)

(二) 藕汁、韭菜汁各一杯 蒸热 1 次服完。

(三) 韭菜汁、童便各半杯 煮热后服。

(以上选自中华全国中医学会武汉分会，中医急症，湖北科学技术出版社，1986)

(四) 萝卜汁 1 杯 1 次服完。(叶橘泉，食物中药与便方，江苏科技出版社，1980)。

以上各方内服，有利于本病止血。另外，饮食宜清淡，忌服动火之食品和药品，如姜、酒等。

六、医案医话

(一) 全示两医案

陈某，女，41 岁，住院号：764137。

患者平素血压偏高，常在 24~28/14.67~17.33kPa，并伴有头痛。近日意识欠清，逐渐转入昏迷。1976 年 7 月 29 日收住本院内科治疗。8 月 5 日中医诊治。检查：血压 17.33/10.67kPa，阵发性头痛，头晕，精神不振，呈嗜睡状态，两眼球胀痛，颈项强直，胸闷痛，心界稍扩张，但无杂音。7 月 30 日脑脊液检查呈粉红色，镜检可见大量红细胞。脉洪弦数，舌质红，苔白腻浮黄。西医诊断：蛛网膜下腔出血；中医辨证：阴虚阳亢，风火上扰，迫血妄行，属“中腑”的“阳闭”之候。治宜滋阴潜阳，凉血止血，息风解痉，佐以理气止痛。处方：羚羊钩藤汤合瓜蒌薤白汤加减。羚羊角粉 3g (另煎兑入)，钩藤 9g，大蓟炭 9g，小蓟炭 9g，瓜蒌 18g，黄芩 9g，薤白 12g，黄连 6g，知母 9g，生石膏 30 克，藕节炭 9g，防风 5g，生地 15g，菊花

9g, 阿胶 9g (烔化), 元参 24g, 甘草 3g, 三七粉 1.5g (吞)。2 剂, 水煎服。

二诊: 服上药后, 头痛减轻, 尿呈浅褐色, 在原方内加入滑石 18g (包煎)、竹茹 9g、栀子 9g。2 剂。

三诊: 头痛消失, 除有胃部不适外, 其他尚好。舌苔薄白, 脉现沉缓。用二诊方去石膏、知母, 加白术、枳实各 9g, 以恢复脾胃功能。

四诊: 上方连服 6 剂, 于 8 月 14 日脑症状完全消失, 即投以清热和胃之剂善后, 于 9 月 1 日痊愈出院。(史宇广等, 当代名医临证精华·中风专辑, 北京: 中医古籍出版社, 1992: 157~158)

(二) 吴翰香医话

蛛网膜下腔出血的治疗以止血为先务。昏迷不省人事, 用香窜开窍药来促其苏醒, 是不恰当的。实证, 采用凉血清火法, 可投《金匱要略》泻心汤加味: 大黄 3~10g, 黄连 3~10g, 黄芩 6~15g, 侧柏叶 30g, 生地黄 30g, 石决明 30g, 龙胆草 3~10g, 墨旱莲 9~15g。虚证, 可用固涩止血法, 可宗《医学衷中参西录》补络补管汤加味: 山萸肉 30g, 龙骨 30g, 牡蛎 30g, 参三七粉 6g (吞), 代赭石 30g, 仙鹤草 30g, 降香 6~10g, 阿胶 6~10g。临证须随症损益, 还须配合西医对症疗法, 取长补短, 积极挽救病人生命。(史宇广等, 当代名医临证精华·中风专辑, 北京: 中医古籍出版社, 1992: 1~8)

七、现代报道

(一) 蛛网膜下腔出血常继发于脑内动脉瘤及动静脉畸形等疾病。出血常反复发作, 导致死亡, 故欲根治, 宜进行手术修补。本病发病时常伴有脑血管痉挛, 铃木二郎报道 107 例动脉瘤引起本病的病例中, 血管痉挛有 36 例 (占 33.6%), 其中 25 例

脑梗死（包括脑栓塞）

脑梗死是指局部脑组织，包括神经细胞、胶质细胞和血管，因缺血、缺氧所致的坏死、软化。脑梗死包括动脉粥样硬化血栓形成性脑梗死和脑栓塞。由于中医学对脑栓塞及动脉硬化性脑梗死的治法相同，所以本文集中对动脉粥样硬化血栓形成性脑梗死进行论述。

动脉粥样硬化血栓形成性脑梗死（简称为动脉硬化性脑梗死）是供应脑部的动脉系统中的粥样硬化和血栓形成，使动脉管腔狭窄、闭塞，造成脑局部血流中断、缺血软化。临床常表现为偏瘫、失语等局灶性神经功能的缺失。动脉硬化性脑梗死约占脑卒中的 50%～60%（脑栓塞则占 15%～20%）。本病比其他脑卒中的病势略缓，常在数分钟或数小时，甚至 1～2 天达到高峰期。多数患者在睡眠中发病，约占半数的患者以往一年内有过短暂性脑缺血发作。多发生于 50 岁以上的人群，特别是老年人。

本病中医文献中称为“中风”、“偏枯”、“偏风”等，除部分重症患者有不同程度的意识障碍外，多数患者神志清楚，故属“中经络”范畴。

一、病因病机

本病的发生，多由于患者脏腑阴阳严重失调，气血运行失常，痰湿内盛，复因情志所伤，或恣酒饱食，或房室劳累，或外邪侵袭等诱发。

（一）内伤积损，精气虚衰 年迈力衰，肾气不固；或形体肥胖，气虚于中；或思虑烦劳太过；气血亏损，以致真气耗散，元气衰惫，复因调摄失度，气滞或气虚血瘀，神明不用，半身偏枯。《杂病源流犀烛·中风源流》云：“人至五六十岁，气血就衰，乃有中风之病，少壮无是也，然肥盛之人，或兼平素嗜欲太过，耗其精血，虽甚少壮，无奈形盛气衰，往往亦成中风”。

亦有素不养慎，恣情纵欲，房室不节，肾精暗耗；或曲运神机，忧愁思虑，心血亏损，从而造成肾水不足，肝失所涵；心血不足，而肝失濡养，肝阳偏亢，加之将息失宜，内风动越，脑窍被阻，而成卒中。此即《临证指南医案·中风》所称：“营液内耗，肝阳内风震动”，“肝血肾液内枯，阳扰风旋乘窍。”

（二）湿痰内生，阻滞气机 饥饱失宜，嗜食肥甘厚味，酒食无度，皆可损伤脾胃，湿滞酿痰；或劳倦忧思过度伤及脾气，或形盛气弱，中气不足，或脾胃素弱，中气亏损，或肝旺克脾，致脾失健运，津液内停，聚湿成痰。痰浊停滞于经络、脏腑之中，滞碍气机，气血流行失畅，遇有扰动，则可阻滞脑络，使脑失奉养，发为中风。《素问·通评虚实论》说：“仆击、偏枯……肥贵人则膏粱之疾也。”《临证指南医案·中风》也说：“平昔酒肉，助热动风为病。”

（三）情志所伤，气滞血瘀 长期精神紧张，脑力过用，或情绪纷扰，肝气郁滞，脑络行血不畅，血液内结于脑，发为卒中偏瘫之疾。

（四）正气不足，外风入中 年老体衰，或饮食不节，或劳役过度，或禀赋不足，或久病体弱，皆致正气不足，气血衰弱，营卫失调，腠理不密；加之冬春季节，寒风外袭，导致经脉收引，气血流行不畅，脑失奉养，亦为卒中。正如《类证治裁·中风》所云：“真中风虽从外中，亦由内虚招风”。

故内在素质欠强，痰浊内蕴是本，属于内因；情志扰动、风

头晕头痛，痰多，突然或逐渐出现半身不遂，肢体麻木，口眼歪斜，言语蹇涩（构音不清、失语），纳呆，可突然昏倒不省人事，牙关紧闭，或有痴呆，抽搐，失明（病侧单眼失明），大便秘结。舌体肿，舌质黯红，舌苔黄腻，脉弦滑或弦数。

3. 肝肾阴虚、肝阳上亢型

头晕头痛，口干耳鸣，少寐多梦，半身不遂，肢体麻木，言语蹇涩（构音障碍或失语），口眼歪斜，大便秘结。舌红少苔，脉弦或弦细数。

4. 气虚血瘀、脑失所养型

倦怠乏力，心慌气短，半身不遂，肢软无力，偏身麻木，口眼歪斜，口角流涎，言语蹇涩，手足肿胀，大便稀溏或秘结。舌质淡或紫黯，舌苔薄白或薄腻，脉细或涩。

椎-基底动脉系统动脉硬化性脑梗死

1. 肝肾阴虚、风痰上扰型

平时头晕，耳鸣目眩，少寐多梦，手足心热，腰酸腿软，烦躁易怒；突然眩晕发作，视物成双或视物不清，声音嘶哑，吞咽困难，呃逆呕吐，走路不稳，口眼歪斜，可有半身不遂或四肢瘫痪，也可出现昏睡或神志不清。舌质红或黯红，苔黄或黄腻，脉弦滑或弦细。

2. 脾虚湿盛、痰浊蒙窍型

平素头痛头晕，胸满痞闷，时欲呕吐，倦怠乏力，少食多寐；突然眩晕，恶心呕吐，视物成双或视物模糊，舌强语蹇，枕部疼痛，走路不稳，肢体麻木，或有半身不遂，饮食作呕。舌体肿、质黯，苔白腻或黄腻，脉弦滑或滑数。

本病之发生主要归为本虚标实，气血亏虚，肝肾阴虚，特别是肾阴虚，使肝失所养，肝阳易亢，气血逆乱为发病之基础；经情志不节、过劳等诱因诱发之后，气血瘀阻于脑络成为主要矛盾，而风（内风）、火、痰、湿亦为重要表现，此为标实。

(三) 治法方药

1. 分型治疗

颈内动脉系统动脉硬化性脑梗死

(1) 脉络空虚、脑络瘀阻型 养血活血、祛风通络，佐以清热。大秦苳汤加减：秦苳 12g，当归尾 12g，赤芍 12g，川芎 15g，生地 20g，熟地 20g，羌活 15g，川牛膝 15g，防风 6g，生石膏 30g（先煎），黄芩 12g，茯苓 12g。有头晕头痛、面红目赤等肝火旺盛者加山梔子 6g，夏枯草 12g，磁石 30g，以清肝潜阳；手足拘急则用全蝎 6g，蜈蚣 4 条，白僵蚕 15g，以息风止痉；言语不清则加石菖蒲 12g，广郁金 12g，以化痰利窍；大便秘结则加生大黄 5g（后下）通腑泄热。

(2) 风痰上扰、痰热腑实型 有两种分型：其一为平肝通络、化痰清腑。温胆汤合三化汤加减：半夏 10g，橘皮 12g，茯苓 15g，枳实 6g，姜竹茹 6g，厚朴 10g，生大黄 5g（后下），羌活 10g，川牛膝 15g，黄芩 12g，天竺黄 12g，甘草 6g。其二为平肝息风、豁痰开窍。羚角钩藤汤增删：羚羊角粉 2g（分冲），钩藤 18g，桑叶 10g，浙贝母 10g，姜竹茹 6g，菊花 10g，夏枯草 10g，生大黄 6g（后下），赤、白芍各 12g，生地 20g，丹参 20g，威灵仙 12g，茯苓 15g。

出现失明，则于上 2 方中分别加入菊花 10g，白蒺藜 12g，青箱子 12g，以清肝明目；昏迷时则加入郁金 12g，九节菖蒲 12g，天竺黄 12g，黄连 6g，以清热豁痰开窍。

(3) 肝肾阴虚、肝阳上亢型 滋肾养肝、息风通络。天麻钩藤饮加减：天麻 10g，钩藤 15g，生石决明 30g，山梔 6g，黄芩 6g，杜仲 12g，川牛膝 20g，桑寄生 12g，益母草 30g，夜交藤 18g，桑枝 30g，秦苳 12g，川芎 12g，丹参 30g。舌强言謇加石菖蒲 12g，郁金 12g，以开窍豁痰；便秘加生大黄 5g 或番泻叶 10g，泡水代茶饮，以通腑泄热。

（4）气虚血瘀、脑失所养型 益气活血，通络荣脑。补阳还五汤增减：生黄芪 30g，当归尾 12g，赤芍 12g，川芎 12g，桃仁 10g，红花 6g，川牛膝 18g，鸡血藤 30g，地龙 12g，全蝎 6g。言语蹇涩加石菖蒲 12g，广郁金 12g，化痰开窍；便秘加芒硝 12g，火麻仁 15g，通便行滞；手足肿胀加桂枝 6g，茯苓 30g，川萆薢 15g，利湿通络。

椎-基底动脉系统动脉硬化性脑梗死

（1）肝肾阴虚、风痰上扰型 滋阴潜降、平肝息风。镇肝息风汤加减：怀牛膝 30g，生龙骨 20g，生大白芍 18g，天冬 12g，玄参 12g，生地 18g，醋龟板 15g，代赭石 15g，生牡蛎 30g，杜仲 12g，姜竹茹 6g。痰浊壅盛、舌苔黄腻，则去龟板、白芍，加胆南星 12g，竹沥水 10g，天竺黄 12g，化痰清热；头痛加夏枯草 10g，菊花 12g，白芷 10g，清肝热，散风止痛；舌强言蹇则加石菖蒲、郁金豁痰开窍；肢体瘫痪加鸡血藤 30g，赤芍 12g，羌活 15g，丹参 30g 等，活血通络。

（2）脾虚湿盛、痰浊蒙窍型 燥湿豁痰，息风开窍。半夏白术天麻汤出入：法半夏 12g，天麻 10g，茯苓 30g，炒白术 15g，橘皮 6g，钩藤 20g，川芎 12g，郁金 12g，石菖蒲 12g，葛根 15g，生姜 12g。肢瘫明显者，加用丹参 30g，川牛膝 20g，羌活 12g，威灵仙 10g，活血通络；嗜睡或神志昏糊，可加苏合香丸温通开窍；痰郁化热，则加黄芩 10g，栀子 6g，黄连 6g，以助清热之力；神昏不醒，舌苔黄厚则可用牛黄清心丸或至宝丹辛凉开窍。

2. 方药选介

①王氏化痰通腑饮

组成：全瓜蒌 15～30g，胆南星 6～10g，生大黄 10～15g（后下），芒硝 10g（分冲）。

适应症：急性缺血性脑卒中（即脑梗死）属痰热腑实者。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：本方为北京中医学院王永炎教授经验方。认为急性缺血性脑卒中病人中，其中属痰热腑实风痰上扰者，占50.6%。这类病证，急性期多为本虚标实，而以标实为主。其病机，初为痰瘀互阻而中焦壅滞，升降失常，进而肝失疏泄，气郁化火，故发病后多从阳化，邪热风火充斥三焦，而致痰浊化热腑气不通。服至大便泻腑气通为度，不宜过量。然后再予清化痰热活络之剂。运用本法治疗158例，半个月内的总有效率为82.3%。

使用注意：大黄煎煮时间只可1~2分钟，稍久即失去通下之用。

资料来源：史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：122。

②通络活血汤

组成：生石决明30g，黛蛤粉30g，旋覆花9g，代赭石9g，桑寄生30g，威灵仙10g，地龙10g，生穿山甲9g，僵蚕9g，豨莶草12g，竹茹12g，鸡血藤20g，知母9g，黄柏9g，麝虫3g，全蝎3~5g。

适应症：脑卒中“中经络”实证（多为脑血栓形成之类）。平素有高血压史，素体健壮，或痰湿也盛，适值肝热风动，或因肝郁化热，灼津为痰，阻塞络道，乃至半身不遂，口眼歪斜，言语蹇涩，脉象弦滑而数。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：痰湿盛加清半夏10g，广皮6g，茯苓12g；言语不利加羚羊粉1g（分冲），九节菖蒲9g，天竺黄9g，川郁金9g；不语或饮水即呛，上4味再加天麻3g，白附子3g；脉数有力加生石膏30g，龙胆草9g，栀子9g；头重脚轻，加白蒺藜10g，钩藤12g（后下），杭菊花9g，龙胆草9g，牛膝9g，羚羊粉0.6g

（分冲）。

使用注意：饮食宜清淡，忌食油腻之品。

资料来源：天津王季儒验方，史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：16。

③通络益气汤

组成：黄芪 18～30g，党参 18～30g，鸡血藤 18～30g，桑寄生 30g，威灵仙 10g，豨莶草 12g，当归 9g，白术 9g，地龙 9g，僵蚕 9g，熟地 12g，杭芍 12g，全蝎 3g，白附子 2g。

适应症：脑卒中属“中经络”虚证者。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：头晕加生海蛤 30g，白蒺藜 10g，杭菊 10g，何首乌 10g，或加桑麻丸 30g（布包同煎）或加鹿角胶 9g（烊化）；腰膝无力加川断 12g，狗脊 12g，枸杞子 12g，虎骨 1g（研细冲服）；口干加石斛 12g，麦冬 12g，湿痰盛加清半夏 9g，广陈皮 6g，茯苓 12g，言语不利加九节菖蒲、巴戟天、山萸肉各 10g，远志 6g，天麻 3g，麦冬 10g，五味子 5g。

使用注意：痰热内壅者不宜服用本方。

资料来源：天津王季儒验方，史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：17。

④加減三甲复脉汤

组成：龟板 30g（先煎），鳖甲 30g（先煎），牡蛎 30g（先煎），生地 18g，麦冬 12g，甘草 9g，桂枝 3g，桃仁 9g，赤芍 9g，白芍 9g，天竺黄 9g，郁金 12g，淡竹沥 1 支（冲），僵蚕 9g，全蝎 3 只。

适应症：因各种类型心脏病引起的脑栓塞，除见口眼歪斜，言语蹇涩，半身不遂等脑卒中征象外，可兼见胸闷、心悸，尤以舌质红绛，脉细为本证特征。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：本方主要作用为滋阴活络，用于中风肝风痰热不明显者。若兼气虚，可加黄芪 30～60g；兼阳虚，可配入仙灵脾、巴戟天各 10g。

使用注意：脾胃虚弱者本方不宜多用。

资料来源：浙江陆芷青验方，史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：103～104。

⑤羚羊角骨汤

组成：羚羊角骨 25g，钩藤 15g，白芍 12g，地龙 12g，石决明 30g，天竺黄 10g，云苓 10g，杜仲 12g，牛膝 15g。

适应症：脑卒中偏瘫肝阳偏亢者。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：大便秘结者宜加生大黄 6g，川牛膝 12g；痰热甚者加川连 3g，黄芩 6g，胆星 10g。

使用注意：饮食宜清淡。

资料来源：广州邓铁涛验方，史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：194。

⑥桑钩温胆汤

组成：桑寄生 15g，钩藤 15g（后下），清半夏 9g，橘红 9g，茯苓 15g，竹茹 12g，炒枳壳 9g，甘草 6g。

适应症：脑卒中各期、各型。

用法用量：卒中先兆、卒中急性期、反复“中风”，均用煎剂，后遗症期用膏剂。

临床应用：北京赵金铎老中医以本方加减治疗各类脑卒中，收效甚佳，特别是对脑卒中急性期的疗效较好。各地赵老的弟子多运用此方治疗本病。

使用注意：同上方。

资料来源：北京赵金铎验方，史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：230～231。

⑦转舌丹

组成：石菖蒲 10g，郁金 10g，连翘 10g，炒栀子 10g，姜半夏 10g，茯苓 30g，青皮 10g，辽细辛 1.5g，牙皂 1.5g（微炒），胆星 1.5g，薄荷 10g，炒枳实 10g，大黄 10g。

适应症：脑卒中不语，半身不遂。

用法用量：上药煎成去渣，用竹沥油 20ml，姜汁 10ml，兑入煎液服之。

临床应用：各型脑梗死，只要伴有舌蹇语难，即可以本方或参考本方治疗，根据辨证可作加减。

使用注意：大黄宜后下，煎煮时间不宜过长。

资料来源：河南杨友鹤验方，史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：243。

⑧豨莶至阳汤

组成：九制豨莶草 50g，黄芪 15g，天南星 10g，白附子 10g，川附片 10g，川芎 5g，红花 5g，细辛 2.5g，防风 10g，牛膝 10g，僵蚕 5g，苏木 10g。

适应症：“中风”偏于阳虚者。证见突然口眼歪斜，皮肤麻木，言语失利，口角流涎，半身不遂，甚至突然晕厥，不省人事，目合口张，汗出肢冷，呼吸微弱等。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：北京任应秋先生认为阴虚和阳虚，乃为“中风”辨证的两大关键，分列豨莶至阳汤治疗“中风”偏阳虚者、豨莶至阴汤治疗“中风”偏阴虚者。

使用注意：阴虚者本方不宜。

资料来源：北京任应秋验方，邓禄清等，中风病的家庭康复，广州：华南理工大学出版社，1989：102。

⑨豨莶至阴汤

组成：制豨莶草 50g，干地黄 15g，盐知母 20g，当归 15g，

杞子 15g, 炒赤芍 20g, 龟板 20g, 牛膝 10g, 甘菊花 15g, 郁金 15g, 丹参 15g, 黄柏 5g。

适应症：“中风”偏阴虚者。证见头晕耳鸣，目眩少寐，突然舌强言蹇，口眼歪斜，半身不遂，两手握固，肢体强直，时或抽搐，面赤如妆，躁扰不宁，甚或突然昏迷，言语障碍，尿闭便秘等。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：任应秋先生认为，上述稀益至阳汤治疗阳虚，药取其气，气重在辛，佐以活血；而本方治疗阴虚，药取其味，味重在酸，重佐活血，这是二方临床应用之差异。

使用注意：阳虚、脾弱者本方不宜。

资料来源：北京任应秋验方，邓禄清等，中风病的家庭康复，广州：华南理工大学出版社，1989：103。

⑩ 中风Ⅱ号片

组成：当归、川芎、灵仙、桃仁、土元、茺蔚子各 30g，红花、丹参、全蝎各 10g，地龙、络石藤、伸筋草各 60g，鸡血藤、川牛膝各 100g，蜈蚣 10 条，白花蛇 2 条。

适应症：脑血栓形成，脑栓塞后遗症。

用法用量：研末制片，每片含药 0.5g；每次 6~8 片，每日 3 次，温开水送服。

临床应用：本方重在活血化瘀通络。偏肝阳亢旺者，宜以桑叶、钩藤各 15g，煎汤送服；偏气虚者，宜用生黄芪 30g 煎汤送服；偏阴虚者可与杞菊地黄丸 6g 同服。

资料来源：邓禄清等，中风病的家庭康复，广州：华南理工大学出版社，1989：103。

⑪ 五藤汤

组成：天仙藤 20g，鸡血藤、络石藤、忍冬藤、钩藤各 30g，当归 10g，川芎、红花各 5g，僵蚕 5g，桑枝 30g。

适应症：脑血管病后遗症。

用法用量：水煎服。或送服语言散Ⅰ号或Ⅱ号片（详下）。

资料来源：李秀林验方，邓禄清等，中风病的家庭康复，广州：华南理工大学出版社，1989：103。

⑫语言散Ⅰ号

组成：羚羊角、犀角各 10g，牛黄、麝香各 3g，僵蚕、蝉蜕、黄连各 30g，朱砂、琥珀各 30g，冰片 1.5g。

适应症：“中风”急性期完全性失语。

用法用量：制末，每次 3g，1 日 3 次，温开水送服。

临床应用：语言散Ⅰ～Ⅳ号宜辨证应用。

资料来源：李秀林验方，邓禄清等，中风病的家庭康复，广州：华南理工大学出版社，1989：103。

⑬语言散Ⅱ号

组成：珍珠粉、朱砂各 3g，海石、川贝、僵蚕、蝉蜕、胆南星、天竺黄、石菖蒲各 30g，琥珀 10g，牛黄、麝香各 1.5g。

适应症：“中风”发病一周后失语者。

用法用量：同语言散Ⅰ号。

资料来源：同语言散Ⅰ号。

⑭语言散Ⅲ号

组成：胆南星、天竹黄、海石、川贝、橘红、郁金各 30g，珍珠粉、朱砂各 3g，牛黄、麝香各 1.5g，琥珀 10g，僵蚕、石菖蒲、蝉蜕各 30g。

适应症：“中风”失语 3 个月以内者。

用法用量：同语言散Ⅰ号。

资料来源：同语言散Ⅰ号。

⑮语言散Ⅳ号

组成：全蝎、僵蚕、海石、川贝、蝉蜕各 30g，牛黄、麝香各 2g，珍珠粉、朱砂各 3g，琥珀 10g，胆南星、天竹黄、化橘

红、石菖蒲各 30g，蜈蚣 10 条，白花蛇 2 条。

适应症：“中风”失语半年之后者。

用法用量：同语言散 I 号。

资料来源：同语言散 I 号。

⑩王氏“中风”方

组成：龙胆草、夏枯草、怀牛膝、杜仲、桑寄生、石决明。

适应症：“中风”病。

用法用量：水煎服。

临床应用：脑栓塞重者重用丹参；脑溢血者酌加羚羊粉；头痛眩晕者加菊花、牡蛎、白芍；痰盛者加川贝、竹沥；口眼喎斜者加白附子、全虫；肝阳上亢者加天麻、钩藤、地龙；津伤者加沙参、天花粉、石斛；胃热者加竹茹；心慌者加麦冬；舌尖边红而脉数有力者重用龙胆草；舌红伴发热者加葛根；滋腻药多时酌加两味温性芳香化浊药，如白蔻、砂仁等。待脉缓而不亢时再考虑用北芪、党参等滋补培中。

使用注意：饮食宜清淡。

资料来源：王药雨验方，邓禄清等，中风病的家庭康复，广州：华南理工大学出版社，1989：105。

⑪起瘫煎

组成：全瓜蒌、半夏、黄芩、鸡血藤、大血藤、忍冬藤、络石藤、地龙、怀牛膝、丹参、大黄。

适应症：“中风”、“中经络”（多为脑梗死）风痰瘀血、痹阻脉络证。

用法用量：水煎服，每日 1~2 剂。

临床应用：肝风上旋、肝阳亢旺者，宜加桑叶、白蒺藜、钩藤；兼阴虚者，可加玄参、生地。

资料来源：张笑平，中医急症救治，长沙：湖南科学技术出版社，1991：150~151。

⑬活血Ⅱ号

组成：川芎、赤芍、红花、丹参、降香。

适应症：急性闭塞性脑血管病。

用法用量：制成静脉用注射液，每次 4～8ml 加入 5%～10% 葡萄糖溶液中滴注。

临床应用：静脉滴注本方治疗急性脑血管病 147 例，总有效率达 79.6%。

药理研究：本方可显著改善微循环，加速纤溶，改善血液流变多项指标。

资料来源：陈可冀等，中西医结合杂志，1985；5（2）：100。

⑭复方川芎注射液

组成：赤芍、丹参、当归、川芎。

适应症：缺血性脑卒中（脑梗死）。

用法用量：按制剂常规制成静脉用注射液，用量每次 2～4ml 加入 5%～10% 葡萄糖溶液中静滴。

临床应用：于忠甫等以本注射液治疗脑血栓和脑栓塞 400 例，总有效率达 94.5%。

药理研究：显著改善微循环，改善血液流变诸指标，有抗血栓作用。

资料来源：于忠甫，中西医结合杂志，1986；6（4）：324。

⑮通脉舒络液

组成：黄芪、川芎、丹参、赤芍。

适应症：脑血栓形成。

临床应用：张学文等以本方制成注射液静脉滴注，口服通脉舒络汤（黄芪、丹参、山楂、红花、川芎、地龙、川牛膝、桂枝），随证加减，治疗脑血栓形成 110 例，总有效率为 98.2%。

资料来源：张学文，新中医，1982；3：27。

①丹参注射液

组成：丹参提取物。

适应症：缺血性心、脑疾病；近年也用于出血性脑卒中。

用法用量：每支 2ml，含丹参 4g；一般每日用 4～16ml（静脉滴注）。

临床应用：上海中医学院以丹参注射液 8～16ml 加入 10% 葡萄糖中静脉点滴，治疗缺血性“中风”65 例，有效率为 87.2%。

药理研究：丹参有显著改善微循环作用，并改善血液流变诸指标，抗血小板聚集。

资料来源：上海中医学院，医学情况交流，1977；(1)：16。

②川芎嗪注射液

组成：川芎的成分之一——川芎嗪。

适应症：缺血性心、脑疾病。

用法用量：每支 2ml，含川芎嗪 40mg；每次 40～80mg，稀释于 5%～10% 葡萄糖注射液或生理盐水 250～500ml 中静滴，每日 1 次，10 日为 1 疗程，可连用 1～2 个疗程。

临床应用：北京 35 个单位用川芎嗪治疗急性缺血性脑卒中 545 例，有效率 89.7%。

药理研究：抗血小板聚集、扩张小动脉、改善微循环，可透过血脑屏障。

资料来源：李富生等，上海中医药杂志，1990；(10)：33。山东省立医院，实用药物手册，济南：山东科学技术出版社，1986：487。

③灯盏花注射液

组成：灯盏花（灯盏细辛）素。

适应症：缺血性心、脑疾病等。

用法用量：每支 10mg；每次用 10～20mg 加入 5%～10% 葡

萄糖注射液或生理盐水 250--500ml 中静滴。

临床应用：灯盏花协作组用该注射液治疗 469 例；顾选文等以之治疗 60 例，有效率分别为 98.3% 和 93.3%。

药理研究：灯盏花素能抑制血小板聚集及内凝血功能。

资料来源：王荪等，中草药，1983；（1）：33；顾选文等，中成药研究，1979；（4）：17。

②脉络宁注射液

组成：玄参、牛膝等药物的提取物。

适应症：血栓闭塞性脉管炎，动脉硬化性闭塞症，脑血栓形成及后遗症，多发性大动脉炎，四肢急性动脉栓塞症，糖尿病坏疽，静脉血栓形成及血栓性静脉炎等。

用法用量：成人每次 10ml 或 20ml（1~2 支）加入 5% 或 10% 葡萄糖水 250~500ml 内静滴，每日 1 次，10~14 天为一疗程；可使用 3~4 个疗程，每个疗程之间可间隔 5~7 天，重症患者必要时可连续使用 2 个疗程。

临床应用：近年来全国各地对脉络宁治疗急性脑血栓形成、脑栓塞及其后遗症进行了大样本验证；佟慕新等的研究提示，用脉络宁和低分子右旋糖酐静滴，近期有效率分别为 88.5% 和 87.1%；刘朝霞等以脉络宁 20~30ml 加入 10% 葡萄糖或生理盐水中静滴，每日一次，15 天为一疗程，连用 1~3 疗程，对照组用低分子右旋糖酐加维脑路通 400mg 或复方丹参液 14~16ml 加入 10% 葡萄糖中静滴，疗程相同，结果脉络宁组有效率明显高于对照组（ χ^2 检验， $P<0.05$ ）。

药理研究：扩张血管、改善微循环、增加血流量及抗凝血、溶血栓等。

资料来源：佟慕新等，江苏中医杂志 1987；（1）：61；刘朝霞等，实用中西医结合杂志，1992；（5）：144。

②⑤ 偏瘫康复胶丸

组成：白花蛇、蜈蚣、马钱子、水蛭、川芎。

适应症：中风偏瘫。

资料来源：赵振兴，河北中医，1988；(1)：5。

②⑥ 抗瘫灵汤

组成：水蛭、木香、乌梢蛇、全蝎、鸡血藤、地鳖虫、地龙、丹参、忍冬藤、钩藤、黄芪。

适应症：中风偏瘫。

资料来源：董俊峰，山西中医，1988；(6)：26。

②⑦ 消栓汤

组成：丹参、川牛膝、大黄、川芎、葛根、桃仁、红花、赤芍、地龙、僵蚕、天竺黄、胆星。

适应症：脑血栓形成。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：俞大毛等以本方治疗脑血栓形成68例，总有效率83.8%。

资料来源：俞大毛，浙江中医杂志，1987；(10)：441。

②⑧ 脑脉丸

组成：黄芪、水蛭、人参、珍珠、川芎、丹参、龟板、寄生、葛根、杜仲、首乌、黄精、石菖蒲、胆星、海藻、黄连、白附子、葛花、灵芝、青皮、冰片、白花蛇。

适应症：脑梗死。

用法用量：研末制成水丸，每服10g，1日3次。

临床应用：靳照礼等用脑脉丸治疗脑血体形成169例；同时还用上方加减，治疗缺血性中风665例，有效率均在85%以上。

资料来源：靳照礼等，新中医，1989；(1)：28。

②⑨ 中风散2号

组成：当归、川芎、灵仙、桃仁、土元、茺蔚子各30g，红

丹参。肢体麻木困痛加秦艽、川木瓜、白附子。瘫痪无力加桑寄生、枸杞子、何首乌。

资料来源：眩晕中风证治，引自段苦寒，中医方剂小辞典，海口：三环出版社，1991：369。

②治“中风”血虚方

组成：辽沙参、柏子仁、鸡血藤、沙枣仁、地龙各 30g，川芎、红花、薤白、全蝎、桃仁各 10g，蜈蚣 3 条，朱砂 1.2g，琥珀 3g，远志 12g，当归身 15g。

适应症：“中风”之血虚痹阻型，昏迷仆倒，口眼歪斜，言语不清，心慌失眠，肢体麻木、无力或半身不遂。脉细弱或结代，舌淡、苔薄白。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：眩晕中风证治，引自段苦寒，中医方剂小辞典，海口：三环出版社，1991：370。

③川芎注射液

组成：赤芍丹参当归川芎

适应症：脑梗死脑栓塞。

用法用量：按注射剂制备常规制成静脉用注射液，用量每次 2~4ml 加入 5%~10% 葡萄糖溶液中静滴。

临床应用：治疗脑梗死、脑栓塞 400 例；总有效率达 94.5%。药理研究结果提示本方能显著改善微循环，改善血液流变诸指标，有抗血栓作用。

资料来源：于忠甫，复方川芎注射液治疗脑梗塞、脑栓塞 400 例，中西医结合杂志，1986；6（4）：324。

④加味黄连解毒汤

组成：黄芩、黄连、黄柏、焦栀子、当归、川芎各 12g，全蝎 10g，炙甘草 6g。

适应症：脑梗死。

用法用量：水煎服，每日1剂，15天为1疗程。

临床应用：治疗脑梗死50例中，男29例，女21例；年龄40~70岁；病程1个月至2年。结果：痊愈32例，显效9例，好转5例，无效4例，总有效率为92%。

资料来源：彭世桥等，加味黄连解毒汤治疗脑梗死50例报告，现代中医，1992；5（1）：23。

⑤加减生脉液

组成：人参、麦冬、黄芪、附子等。

适应症：老年性气虚综合征或老年性疾病，如动脉硬化症、脑梗死、老年性痴呆等脑血管疾病。

用法用量：水煎，每日1剂，分2次服或上药制成口服液，常规服用。

药理研究：

本方能显著降低含氧灌注心肌和缺氧心肌MDA的含量，与维生素E类似。对缺氧心肌过氧化脂质含量也具有显著降低作用。能非常显著地降低缺氧后再给氧灌注心肌的MDA含量。使高龄鼠肝过氧化脂质含量显著降低（ $P < 0.05$ ），使高龄鼠肝脏心脏SOD活性显著增高（ $P < 0.05$ ）。本方还具有增高心肌 Na^+ ， K^+ -ATP酶的活性。^[1]

又通过①对小鼠脑缺氧、缺血后再灌注损伤的影响（对正常小鼠脑过氧化脂质含量的影响；对脑缺氧小鼠脑过氧化脂质含量的影响；对脑缺氧后再灌注小鼠脑过氧化脂质含量的影响）；②对老化相关酶活性的影响〔对小鼠脑、肝脏单胺氧化酶（MAO-B）活性的影响；对豚鼠脑、骨 Na^+ ， K^+ -ATP酶活性的影响〕的实验，结果表明：本方对KCN诱发小鼠脑缺氧所致脑MDA含量增高具有降低作用。能显著抑制MAO-B的活性，有可能通过对MAO-B活性抑制，使单胺类神经递质水平升高，从而调整某些退化的生理功能和行为。对肝脏MAO-B活性的

抑制作用不明显，表明其不影响肝脏对体内某些有害的单胺类物质的解毒功能。^[2]

资料来源：

[1] 周敏等，生脉散加味对离体大鼠心肌缺氧、缺氧后再灌注损伤的影响，中药药理与临床，1988；4（3）：19。

[2] 周敏等，加减生脉液抗衰老的药理研究Ⅱ：对小鼠脑缺氧、缺血后再灌注损伤的影响，中药药理与临床，1989；5（5）：27。

③⑥大黄廑虫丸

组成：大黄 75g（蒸），黄芩 60g，甘草 90g，桃仁 200g，杏仁 200g，芍药 120g，干地黄 300g，干漆 30g，虻虫 200g，水蛭 100 枚，蛭螭 200g，廑虫 100g。

适应症：虚劳内有干血，形体羸瘦，腹满不能饮食，肌肤甲错，两目黯黑；亦治妇女经闭，腹中有块，或胁下微积刺痛。

用法用量：上 12 味，研末，炼蜜和丸，如小豆大。用酒送下 5 丸，1 日 3 次。

临床应用：大黄廑虫丸加减治疗脑梗死，应用本方（大黄 9～30g，廑虫、杏仁各 12g，桃仁、赤芍、牛膝各 15g，黄芩、虻虫、干漆、地龙、蛭螭各 10g，水蛭、干生地各 20g）阴虚者可加石斛、玉竹、玄参等；睡眠差者可加黄芪、党参、当归等；肝阳偏亢者加天麻、钩藤，石决明等。颅内压明显升高者，用 20% 甘露醇适当脱水，合并感染者加用抗生素。治疗脑梗死 34 例，男 26 例，女 8 例；年龄 40～50 岁 2 例，50～60 岁 12 例，60～70 岁 17 例，70～80 岁 3 例，年龄最小 46 岁，最大 74 岁。中经络 29 例，中脏腑 5 例。结果：临床治愈 25 例（73.5%），显效 6 例（17.6%），有效 2 例（5.8%），无效 1 例（2.94%）；总有效率为 97%。^[1]

药理研究：

37.65 ± 13.46 分钟, 两组之间无差异 ($P > 0.05$)。④对血脂的影响: 对照组与空白组比较, 总胆固醇、甘油三酯有显著性差异; 实验组的总胆固醇、甘油三酯低于对照组。对血液流变学的影响: 对照组血浆比粘度 (RPV)、血沉 (ESR) 较空白组高, 实验组与对照组各项指标之间无差异。⑤对抗小白鼠常压缺氧的生存时间虽有所延长, 但与对照组的差异不明显。^[2]

2. 对大鼠血液流变学的影响 将大黄、麝香、水蛭、桃仁、生地、白芍、甘草等 14 味中药粉碎成粗颗粒, 用 50% 的乙醇浸提, 每次浸泡 24 小时, 共提 2 次, 待浸液挥去乙醇, 配成 1g/ml 浓度。观察本方对大鼠血液流变性的影响。①对大鼠血栓形成的影响: 将大鼠麻醉后, 分离左处静脉和右颈总动脉。关闭血液置 6cm 长且称过重量的 4 号手术丝线于其右总颈动脉和左外静脉中。由股静脉给药 (7g/kg), 对照组给等量生理盐水。5 分钟后开放血液, 开放 20 分钟中断血流, 迅速取出丝线称重, 总重量减去丝线重即为血栓湿重, 并计算抑制率。②对 ADP 诱导血小板聚集的影响: 将大鼠麻醉后, 颈总动脉取血, 3.8% 枸橼酸钠抗凝, 不同速率离心分离出富血小板血浆 (PRP)、贫血小板血浆 (PPP), 用 PPP 稀释 PRP, 将 PRP 于两只血小板聚集仪的测量杯中, 分别加入 0.2mol/L 磷酸缓冲液、1g/ml 药液 10 μ l, 温育 3~6 分钟, 按此法, 用 ADP (1 μ mol/L) 诱导血小板聚集, 测定其程度, 记录 5 分钟曲线变化。另将大鼠随机分成 2 组, 给药组与对照组分别每日给药 13g/kg (灌胃) 和等量生理盐水, 连续 4 天, 于第 4 天灌胃后 1 小时颈总动脉取血, 同体外实验法制备 PPP 和 PRP 进行测定观察。③对血液粘度、红细胞压积和红细胞电泳的影响: 取大鼠随机分成血瘀模型给药组、血瘀模型对照组和正常对照组。前两组分别给药 13g/kg (灌胃) 和等容量的自来水 (灌胃), 连续 4 天。正常对照组大鼠麻醉后, 颈总动脉取血 5ml, 血样分置 2 支离心管中, 其中 1 支加少量肝

素抗凝。制备全血、血浆和血清血样。分别观察全血、血浆和血清比粘度，红细胞压积，10个红细胞的电泳时间。模型对照组及给药组于第4天皮下注射肾上腺素0.08ml/100g，共2次，间隔4小时，于第1次注射后2小时，将大鼠浸入冰水中5分钟，然后停食，于次晨进行实验检测，方法同正常对照组大鼠。结果提示本方能明显抑制大鼠的实验性血栓形成和血小板聚集功能，能明显缩短“血瘀”模型大鼠的红细胞电泳时间，使全血、血浆、血清和纤维蛋白原比粘度以及红细胞压积呈降低趋势。^[3]

3. 对大鼠实验性血栓及体外血小板聚集性的影响 取大黄廑虫丸以95%乙醇浸泡过夜。水浴回流提取，过滤，重复提取2次，合并滤液，置旋转蒸发器上减压回收乙醇。提取物加定量蒸馏水振摇，置水浴锅上蒸发，挥尽乙醇，最后用蒸馏水调至1ml含1g原生药，置冰箱保存，试验时用蒸馏水稀释成所需浓度。①大黄廑虫丸醇提取液对实验性血栓重量的影响。②大黄廑虫丸醇提取液对大鼠血小板聚集的影响。③大黄廑虫丸醇提液有效解聚作用。大黄廑虫丸酒精提取液能抑制ADP诱导大鼠血小板的聚集，其作用与剂量呈依赖关系；并能使聚集后的血小板逐渐解聚，有效解聚率与药物剂量呈正相关。大黄廑虫丸酒精提取液还能抑制大鼠实验性血栓的形成，血栓重量较对照组显著减少。^[4]

4. 对腹腔³²P标记血块吸收的影响 实验制成带P标记的血块大鼠10只，分成给药组及对照组，给药组用12%本方混悬液灌胃，每天2次，连灌7天，结果提示本方有促进腹腔血块吸收的作用。^[5]

5. 对大白鼠体外血栓形成的影响 取大白鼠20只，随机分为2组，给药组用36%本方混悬液，按100g体重1.5ml比例灌胃，4小时后取大白鼠腹主动脉血1ml，立即置入旋转杯内，恒速旋转，同时记录血栓形成时间和特异性血栓形成时间，10分钟后停止旋转，测量血栓比度及湿干重量。结果表明：本方可使

血栓重量明显减轻,但对特异性血栓形成作用不明显,说明本方抑制血栓形成的作用,主要是影响血栓形成的强度,对其速度则无明显影响。^[5]

6. 对实验性肝损伤的保护作用 用四氯化碳、乙醇综合法造成大鼠慢性肝损伤,用四氯化碳造成急性肝损伤。活杀后进行①生化测定:活杀取血制备血清,用改良赖氏法测定谷丙转氨酶(SGPT),用醋酸纤维薄膜电泳法测定乳酸脱氢酶同工酶(LDH₅)和血清蛋白。取肝右叶,分别制备匀浆,用改良Bergman和Loxley法测定羟脯氨酸,用荧光探针菲啉溴红法测定RNA和AND。②病理检查:取肝左叶,处理后观察一般病理改变和胶原纤维的分布情况。观察本方对实验性肝损伤的保护作用,结果:①大黄廑虫丸给药组LDH₅和SGPT降低,血清蛋白回升, γ 球蛋白下降,肝胶原明显减少,病理改变减轻,提示大黄廑虫丸对实验性慢性肝损伤有保护作用。②大黄廑虫丸对用四氯化碳造成的急性肝损伤无明显保护作用。^[6]

7. 对大鼠肠粘连模型的影响 实验以夹伤制成大鼠肠粘连模型,术后第2天灌服本方12%混悬液0.5ml/(100g·d)2次,持续7~12天,或分别于术后第2、7、21天开始给药7天(剂量同上),均可使动物肠粘连形成的程度明显减轻,并可使实验动物的肠蠕动呈缓和而持久的增强。^[7]

8. 抗动脉粥样硬化 实验选用朝鲜种鹌鹑48只,体重 87.5 ± 2.3 g,先普饲1周,分为2批。第一批分为对照组、给药组、阳性对照组,均喂高脂饮食,后两组用大黄廑虫丸(每天1丸)和烟酸肌醇酯(2.5mg/100g,日1次)。观察45天。第2批将上述对照组继续普饲,再分对照组、给药组和阳性对照组,喂养60天,处理动物。结果提示本方有明显降血脂作用,但对血清HDLc参数的影响,给药组与对照组无甚差异。大黄廑虫丸组动物脉粥样硬化斑块面积明显减少,并使粥样硬化斑块消退加

快。^[8]

资料来源：

[1] 孟庆年，大黄廬虫丸加减治疗脑梗塞 34 例，云南中医杂志，1993，14（6）：6。

[2] 黄焱明等，大黄廬虫丸对动物瘀血证、常年缺氧、高脂血症作用的探讨，实用中西医结合杂志，1989，2（5）：25。

[3] 刘青云等，大黄廬虫丸对大鼠血液流变性的影响，安徽中医学院学报，1991，19（2）：58。

[4] 佟丽等，大黄廬虫丸对大鼠实验性血栓及体外血小板聚集性的影响，中药药理与临床，1991，7（4）：5。

[5] 邱培伦，大黄廬虫丸防治肠粘连作用机制的研究，西安医学院学报，1981；（2）：263

[6] 邱培伦，大黄廬虫丸对实验性肝损伤的保护作用，中西医结合杂志，1998；8（11）：668。

[7] 邱培伦，大黄廬虫丸防治肠粘连的实验研究和临床观察，实用外科杂志，1981；（3）：117。

[8] 张殿增等，大黄廬虫丸抗动脉粥样硬化的实验研究，实用中西医结合杂志，1982；5（3）：135。

⑦桃红四物汤

组成：熟地黄、白芍药、当归、川芎、桃仁、红花。

适应症：脑梗死。

用法用量：水煎服。

临床应用：应用本方加味：桃仁 15g，红花 15g，当归 20g，生地 20g，赤芍 20g，川芎 25g，葛根 15g，水蛭 10g，黄芪 50g。每日 1 剂，水煎分 3 次服。治疗脑梗死 32 例，男 24 例，女 8 例；年龄 45～75 岁；病程 3 天至 8 个月。结果：痊愈（偏瘫、失语等神经系统症状和体征基本恢复正常）10 例；显效（偏瘫、失语等神经系统症状和体征明显恢复，可独立步行，患肢肌力恢

④通络消滞汤

组成：黄芪 30g，黄精 15g，知母 10g，川芎 10g，丹参 15g，当归 15g，鸡血藤 15g，何首乌 15g，僵蚕 10g，赤芍 12g，甘草 6g。

适应症：脑梗死。

用法用量：水煎，每日 1 剂，日服 2 次。

药理研究：以临床有缺血性脑血管病的症状（排除 TIA）及相应神经系统检查之定位指征，诊断为脑梗死的患者 40 例，男 34 例，女 6 例；年龄 28～72 岁，病程 10 天至 15 年。服药前，均以 XN-3 型血液粘度细胞电泳自动计时仪测定全血比粘度、血浆比粘度、血红细胞电泳时间、血小板电泳时间、红细胞压积各项指标。并同时测定血胆固醇、 β 脂蛋白，甘油三脂，部分病人行脑血流图及眼底检查，单独服用通络消滞汤，连续服药 1 个月，然后复查以上各项指标。服药后，能非常显著地降低全血比粘度、缩短血红细胞电泳时间、降低血胆固醇及 β 脂蛋白。其余指标也相应改善，具有统计学意义。推基底动脉缺血者，脑血流图改善率为 80%～88%，临床症状及体征，也相应好转。眼底检查，治疗前后改变不大。

资料来源：张慧芳等，通络消滞汤治疗脑梗塞对血液流变学及血脂影响的观察，山西医药杂志，1988；17（1）：22。

④通脉汤

组成：原缺。

适应症：脑梗死。

用法用量：口服，每日 1 剂，分 2 次服，连服 3 周。

药理研究：结果表明，通脉汤能明显降低脑梗死患者的全血粘度、血浆粘度及细胞沉降率，与治疗前相比差异显著（ $P < 0.01$ ），虽然细胞压积和纤维蛋白原含量亦有所降低，但经统计学处理差异不显著（ $P > 0.05$ ）。产生机制可能由于增加了红细

胞变形能力，改变了血浆成分及增加了红细胞和血小板表面电荷，从而阻止了红细胞和血小板的聚集和凝结。

资料来源：韩竹梅，通脉汤对脑梗塞患者血液流变学的影响，中医药学报，1992；（6）：17～18。

⑫芪黄蛭通汤

组成：生黄芪 60g，大黄 6g，水蛭 9g，三七 6g，当归 12g，路路通 15g，何首乌 30g。

适应症：脑梗死。

用法用量：水煎，每日 1 剂，分 2 次温服。

临床应用：腹胀便秘者大黄后下，并加枳实、厚朴各 10g，神昏不清者加石菖蒲 12g，远志 9g，郁金 15g；痰多者加贝母 10g，胆南星 12g，瓜蒌 20g；舌红少苔者加天冬 15g，熟地 24g。

资料来源：刘洪明，吉林中医药，1997；（2）：7。

⑬加味补阳还五汤

组成：黄芪 60g，红花、柴胡各 10g，茵陈 15g，桃仁、川芎、地龙、赤芍、当归各 10g。

适应症：脑血栓。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，早晚各 1 次。

资料来源：车宇光，辽宁中医杂志，1998；25（5）：208。

⑭通栓汤

组成：水蛭、当归各 12g，丹参、地龙各 15g，川芎、红药、赤芍各 10g，炙黄芪 50g。

适应症：脑血栓。

用法用量：水煎，每日 1 剂，分 2 次温服。

资料来源：梁改凤等，中医药研究，1997；13（2）：32。

三、单方验方

（一）牛黄清心丸，每次 1 丸，日服两次。用于本病有郁热、

肝阳旺者（《痘疹世医新法》）。

（二）竹沥水，每次 10～15ml，日服 3 次。用于本病痰盛者（《类证治裁》）。

（三）草决明 60g，煎汤代茶。用于风痰上扰而腑实者。（《千金方》）。

（四）野菊花 30g，煎汤服。适于肝旺者（《食鉴本草》）。

（五）防风 90g，天南星 90g，炙甘草 30g。为粗末，每服 12g，水煎去滓服用于风中经络，半身不遂。（《澹寮集验方》）。

（六）桔梗 30g（半生半熟），诃子 49 个（半生半炮），甘草 6g（半生半炙）。为细末，每服 21g，用煎熟童便 300ml，调服。治中风失音不语（《本草权度》）。

（七）豨薟草不拘多少，酒拌九蒸九晒，蜜丸服。治中风诸症（《医方集解》）。

其余验方，与“脑出血”部分互参。

四、中成药

脑梗死专病中成药渐趋增多，除口服剂型外，尚有许多静脉剂型，在本章常用方选中作过一些介绍。本节重点介绍吉林省抚松制药厂为主研制的、国家卫生部 1990 年批准的治疗脑血栓（缺血性中风）及其后遗症的最新首选药物——豨薟通栓丸。

组成：胆南星、冰片、当归、豨薟草、天麻、半夏、红花、三七、麝香等。

功效：活血、祛风、化痰，舒筋活络，醒脑开窍。

主治：脑梗死（缺血性“中风”），证见肢体麻木、半身不遂、口眼歪斜、左瘫右痪、语言障碍等。一般多用于该病急性期、恢复期。

用法用量：每丸 9g，口服每次 1 丸，1 日 3 次，温开水送服。

使用注意：服本药后，极少数病例可能出现嗜睡，面部发热，头痛等症状。持续服药可逐渐消失。孕妇及出血性中风（脑出血）急性期禁用。

临床应用：经长春白求恩医科大学三院、江苏省人民医院脑血管病康复分院、沈阳红十字会医院等脑血管临床研究单位的307例临床试验证明，对脑血栓的临床总有效率为96.7%，治愈显效率为81.4%，比对照组环扁桃酯（抗栓丸）胶囊的显效率63.3%高差异显著。该药见效快，无毒副作用，临床患者经头部CT检查证明，用药后病灶明显缩小或消失。

方义解释：缺血性“中风”乃因瘀血阻滞脑络而然，其表现肝阳偏旺、痰热内郁、经络不通最为多见，久病亦有肝肾不足的一面。本方以稀莪为主药，强筋健骨、祛风通络，并有温和的降压作用；辅以当归、红花、三七活血化瘀、消栓通络；麝香、冰片辛窜通窍醒神，兼能鼓动气血，有助通络；天麻平肝潜阳，平息内风；胆南星、半夏清化痰热。诸药同用，起到扶元振颓、通经活络、消栓行瘀的作用。

药理研究：具有显著的抗血栓形成作用。能显著降低血栓重量和全血粘度，增强红细胞的变形能力，抑制血小板聚集，扩张血管，改善微循环。

五、饮食疗法

饮食宜清淡，多食芹菜、海带等清肝通络、化痰去浊之品，不宜饮酒及多食辛辣厚味。与脑出血一章可相互参用。另下列药膳方可选用：

（一）紫菜羹 紫菜 15g，海米 10g，盐少许，煮羹常服。有益阴、活血、化痰的作用。（叶橘泉，食物中药与便方，江苏科技出版社，1980）

（二）黑木耳羹 黑木耳 30g，莲子少许，煮烂后服。有益

阴活血，培补元气的作用。（窦国祥，饮食治疗指南，江苏科技出版社，1981）

六、医案医话

（一）王永炎医案——风痰上扰、痰热腑实案

杨某，男，53岁。以左侧偏瘫四天而入院。入院查：意识清楚，血压20/12kPa，有左侧偏瘫，偏身麻木，口舌歪斜，左上肢肌力0°，左下肢肌力Ⅱ°，属重偏瘫。左侧肌张力高，左侧腱反射亢进，并可引出病理反射。腰穿脑脊液无色透明，初压18.67kPa；西医诊断为脑血栓形成，定位于颈内动脉系统；另患有慢性胃炎。诊查：左半身不遂，左偏身麻木，思睡，意识朦胧已有日半。口舌歪斜，头晕，大便4日未解，痰白粘不易咯出。舌质淡红，舌苔黄厚腻，脉象弦滑，偏瘫侧脉大有力。

辨证：证属中风中腑，后转为中经，风痰上扰，痰热腑实。

治法：先拟化痰通腑、平肝息风为治。处方：生大黄10g（后下），芒硝6g（分冲），全瓜蒌30g，黄芩10g，半夏10g，钩藤30g，菊花10g，竹沥水30g（分冲），生甘草3g。

二诊：服药2剂，大便已通，黄腻苔渐化，头晕稍有减轻，偏瘫亦轻，肌力左上肢由0°升至Ⅰ°，左下肢Ⅱ°升至Ⅲ°。改用平肝化痰加入活血通络之品。处方：钩藤30g，菊花10g，全瓜蒌30g，黄芩10g，半夏10g，陈皮6g，赤芍10g，草红花10g，桑枝30g。

三诊：上方药服6剂后，左上下肢肌力恢复至Ⅳ°，有人搀扶可以锻炼走路，左偏身麻木也明显好转。继服上方药10剂后，基本痊愈，出院。门诊随诊半月，已能半日工作，又治1个月后，恢复全日工作。（董建华，中国现代名中医医案精华，北京：北京出版社，1990：1888）

（二）朱进忠医案——痰蒙心窍、痴呆不语案

张某，男，53岁。饮酒之后突然脑血栓形成，已5个多月，某院治疗后，虽然偏瘫明显改善，但仍痴呆不语，亲疏不知，不知饥饱，伸舌偏歪。审之，除以上诸症外，舌苔白腻，脉弦。综合脉证，诊为痰蒙心窍。治以化痰开窍息风。处方：竹沥10g，生姜5片，半夏10g，钩藤15g，全蝎6g，附子1g，连翘10g。

服药3剂，痴呆之状稍有改善，有时能知饥饱。某医云：可否加竹沥为20g？余云：痰为阴类，非温不化，竹沥大寒，故不可多用。继服9剂，记忆力明显恢复，并能说一些简单话语，又服10剂，愈。（史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：184）

七、现代报道

近年来中医界治疗脑卒中、特别是脑梗塞重视应用通腑泻下和活血化瘀两种治法。

（一）据临床观察统计，在大宗脑梗死病例中，急性期患有便秘者达到50%～75%，许多学者推崇通腑泻下法治疗该病，如京华王永炎即创制了化痰通腑饮（星萎承气汤），也有学者甚至认为“只要大便不稀，即可通腑”，可见用之之频。据研究发现，泻下法可增加腹腔器官血流灌注，诱导性地抑制上部器官组织充血、出血，降低血压和颅内压，并能改善微循环障碍、抗休克。高血压脑病、脑出血病人头痛呕吐，以及并发的脑水肿、颅内压增高引起烦躁昏迷，泻下药通过排便，丢失体液，使有效血容量减少，体液再分配，降低血压，抑制脑微血管通透性和脆性，改善脑水肿，因而显效。缺血性脑卒中（脑梗死）病人脑组织水肿，胃肠道运动处于抑制状态，肠内发酵，腐败过程加剧，机体在强烈应激时交感-肾上腺髓质兴奋，病人往往有一派面红口臭、腹胀便结、苔黄脉数实热症状。苦寒泻下使病人热象缓

八、主要参考资料

1. 孙孝洪, 中医治疗学原理, 成都: 四川科学技术出版社, 1990
2. 何绍奇, 现代中医内科学, 北京: 中国医药科技出版社, 1991
3. 陈贵廷等, 实用中西医结合诊断治疗学, 北京: 中国医药科技出版社, 1991
4. 陈达仁等, 中国神经精神疾病杂志, 1991; 17 (增刊): 30~31
5. 史荫绵等, 解放军医学杂志, 1979; (4): 98
6. 黄泰康等, 中药方剂现代研究大典, 科学出版社, 1996

附一 混合性脑卒中

混合性脑卒中是指患者同时或先后出现不同部位的脑部病灶, 如脑出血与脑梗死并存, 或蛛网膜下腔出血合并脑梗死。此类病变多有共同的病理基础, 如在脑动脉粥样硬化、高血压病的基础上, 遇有诱因, 致使脑中某动脉破裂, 造成脑出血, 而该动脉远端所营养的区域缺血或另侧脑动脉痉挛, 均可导致脑梗死。症状表现可较繁复。但就中医而言, 均是瘀阻脑络, 皆可采用活血化瘀治法, 这方面可参考前述脑出血、蛛网膜下腔出血及脑梗死章方药; 由于脑中病损较大, 区域较广, 脑之功能影响甚大, 可有神志昏糊、昏愤, 目不认人, 思维迟钝等痰邪阻窍的见证, 可用涤痰汤或导痰汤加减; 若见身体痿弱, 不能站立或步履, 宜以地黄饮子加减, 方药不予另列。

附二 腔隙性脑梗死

与急性大块性脑缺血性梗死不同, 腔隙性脑梗死是慢性脑血管病变, 其梗死的特点是部位深——多位于基底节区及脑干, 梗死小——直径一般不超过 1cm, 数目多——由于上述区域多条脑细小动脉闭塞而成, 病灶新旧不一, 由于被组织细胞所吞噬, 梗

死区形如蜂窝样。病灶多位于相对静区，可不出现明显的偏瘫、偏盲及言语笨涩，而表现为高血压、头晕、头痛、肢体活动不灵便（肌张力高）、麻木、性格改变或智力低下等，多属中医肝肾阴虚、风阳上扰证。方药宜着重滋养肝肾、平肝息风、活血通络，方用地黄饮子、杞菊地黄丸、镇肝息风汤、天麻钩藤饮，桃红四物汤（方药详见“脑出血”“脑梗死”相应部分）。如见痴呆，可用涤痰汤和通窍活血汤加减。

短暂性脑缺血发作

短暂性脑缺血发作（TIA）是颈内动脉或椎-基底动脉系统的短暂性血液供给不足，临床上表现为可逆的、突然发生的数分钟至数小时的局灶性神经功能缺失，常在24小时内完全恢复，但可反复发作；常作为完全性脑卒中的早期预报。故早期预防、诊断和治疗短暂性脑缺血发作，在防治急性脑血管病工作中成为一个十分重要的环节。本病在中医学中属“中风先兆”、“小中风”、“眩晕”范畴。明代龚廷贤云：“论中风者，俱有先兆之证，凡人如觉拇指及次指麻木不仁，或手足少力，或肌肉蠕动，三年内必有大风之至。”即类似于此。

一、病因病机

中医学认为本病与肝肾不足、劳倦内伤、情志郁结关系密切。

（一）肝肾不足 素体肝肾不足，又加不知颐养，房室太过，或因它病损及肝肾，致使肝肾早亏，肝阳亢旺，内风易起，脑络不畅，发为是疾。

（二）劳倦内伤 脾元虚弱，复又饮食不节，或长期过劳、思虑太过，重伤中气，气虚血弱，不能荣脑；脾气既虚，运化失健，痰湿内生；更因脾虚升降失司，清气不升，浊气不降，痰浊内阻脑络，俾气机不畅，气滞血瘀于脑，亦生是病。

（三）情志郁结 肝主疏泄，气行血行，气郁血停。长期情

志不遂，肝气郁结，气滞导致血瘀，着于经脉之内，血行失畅；更因大怒或焦虑，气郁化火上扰，灼于脑络，致一时络窄血瘀，气血不得相续，也成此病。

总之，本病之作主要与肝、肾、脾三脏有关；标为风、火、痰、气（滞），气血一时瘀阻；本为肝肾不足，气血衰少；诸多因素相互作用，使得阴阳失衡，脑中脉络失和，血菟于上，发成该病。

二、辨证施治

（一）辨证要点

本病主要病理在于脑络一时性阻滞，脑失所养，神机失用。然宜明辨虚实，治方不爽。以虚证表现为主者，尚宜辨气虚、阴虚抑或肾精不足；以实证表现为主者，宜分肝风、痰浊、气滞、血瘀。一般而言发作时肝阳偏旺、肝风内扰者，虽有阴虚仍当平肝熄风为先；气虚显著者，虽见瘀痰内阻之象也当补气升清为主；病缓之后则宜从本图治。

（二）辨证分型

颈内动脉系统短暂性脑缺血发作

1. 气血瘀阻、脑络空虚型

头晕头痛，偏侧肢体麻木、乏力，或轻度半身不遂，口眼喎斜，或言语謇涩（构音困难或失语），对侧单眼一过性黑蒙。舌质暗，苔薄黄，脉弦或弦细。

2. 气虚血滞、脑失奉养型

气短疲惫，偏侧肢体乏力、麻木不仁，或见轻度半身不遂，口眼歪斜，舌强言謇（构音困难或失语）。舌紫或淡胖，苔薄，脉细或弦细。

3. 阴虚阳亢、脑络受扰型

头晕头痛，口干耳鸣，腰酸膝软，少眠多梦，健忘，神思迟

滞，突感半身无力、麻木不仁，或有轻度麻木不仁，口眼歪斜，大便偏干。舌红少苔，脉弦或弦数。

椎——基底动脉系统短暂性脑缺血发作

1. 肾阴不足、肝阳亢旺型

素有头昏头晕，耳鸣性躁，视物昏花，腰膝痿弱，失眠梦扰，口干咽燥，或有五心烦热，突发眩晕，走路不稳，言语蹇涩，吞咽不利，也可兼见肢体乏力或偏瘫，脉弦。

2. 痰浊内蕴、风痰上扰型

头晕头重，目眩耳鸣，胸脘痞闷，恶心欲吐，声音嘶哑或言謇不利，吞咽作呛，行走不稳或猝然倒地，可见到后头疼痛及偏瘫。苔黄腻或白腻，脉弦或滑。

(三) 治法方药

本病不论何证，均具有脑络不畅，脑失奉养的一面，故辨证施治之同时应注意着眼于疏通脑络。

1. 分型治疗

颈内动脉系统短暂性脑缺血发作

(1) 气血瘀阻、脑络空虚型 行气活身、养血荣脑。血府逐瘀汤加减：桃仁 12g，红花 10g，当归 15g，赤芍 10g，地黄 15g，川芎 6g，柴胡 6g，枳壳 6g，川牛膝 15g，决明子 30g。有言语不利者加九节菖蒲 12g，郁金 6g，以解语开窍；痰多加竹茹 6g，竹沥 15ml，以清化痰热。

(2) 气虚血滞、脑失奉养型 益气活血、通窍养元。补阳还五汤增删：生黄芪 40g，当归 10g，赤芍 12g，川芎 12g，桂枝 12g，桃仁 10g，红花 6g，全蝎 3g，地龙 12g。便溏可去桃仁，加炒白术 15g，淮山药 12g，健脾益气。

(3) 阴虚阳亢、脑络受扰型 滋肾养肝、息风通络。一贯煎加减：沙参 12g，麦冬 12g，生地 20g，当归 15g，川牛膝 15g，枸杞子 12g，桑枝 30g，生石决明 30g，豨莶草 15g，火麻仁 10g。

椎-基底动脉系统短暂性脑缺血发作

(1) 肾阴不足、肝阳亢旺型 滋阴潜阳、清肝熄风。杞菊地黄汤加味。天麻 10g, 钩藤 20g, 甘菊花 10g, 黄芩 10g, 夏枯草 15g, 枸杞子 12g, 干地黄 15g, 山萸肉 10g, 淮山药 15g, 茯苓 10g, 泽泻 12g, 丹皮 6g。治瘫者尚可加桑枝 30g, 威灵仙 12g, 丹参 30g, 以养血疏络。

(2) 痰浊内蕴、风痰上扰型 健脾豁痰、平肝息风。半夏白术天麻汤出入: 天麻 10g, 姜半夏 12g, 炒白术 15g, 陈皮 6g, 茯苓 12g, 竹茹 6g, 夏枯草 10g, 白菊花 6g, 桑叶 10g, 怀牛膝 15g, 枳实 10g, 葛根 30g。苔浊腻宜去夏枯草、菊花、竹茹, 加白芷 12g, 佩兰 6g, 石菖蒲 10g, 以芳香化浊, 化痰醒胃。

2. 方药选介

①二丹饮

组成: 丹参 30g, 丹皮 12g, 川芎 9g, 赤芍 15g, 红花 9g, 夏枯草 30g, 川牛膝 30g, 钩藤 15g (后下), 豨莶草 15g, 珍珠母 30g。

适应症: “中风”先兆。

用法用量: 水煎服。

临床应用: 高灌风等以本方治疗观察 236 例“中风”先兆患者。发病最长者 3 年, 最短者 3 个月。予服中药, 观察脑血流图、血脂 3 项、血压下降情况及症状改善程度。服药前脑血流图显示, 患者的波幅均值低于正常, 流入时间延长, 主峰角增大, 流入速度低, 血管阻力增加, 服药后均有显著性改善; 并有降血脂作用, 显效 156 例 (占 66.1%), 好转 65 例 (27.5%)。高血压者血压均下降 15~20mmHg, 达到安全幅度, 总有效率 90%。加减法: 头痛 眩晕、眼花重者加天麻 10g, 茺蔚子 15g; 面红目赤, 烦躁易怒者, 加龙胆草 6g, 白薇 6g; 项背强, 口角流涎者加葛根 15g, 半夏 9g, 竹茹 9g, 地龙 9g。

归、白芍、怀牛膝、元参、钩藤、地龙、珍珠母。

适应症：由肝肾阴虚、肝阳化风所致的“中风”先兆及“中风”病。

用法用量：水煎服。

临床应用：本方柔肝熄风、滋养肝肾，用于颈椎病椎基底动脉系统缺血性 TIA 及高血压病多年、颈内动脉系统 TIA、肝阳偏旺者效果较好。

资料来源：《医话医论荟要》方，引自段古寒，中医方剂小辞典，海口：三环出版社，1991：378。

⑤平肝潜阳汤

组成：珍珠母 30g，生牡蛎 30g，生槐米 15g，豨莶草 15g，夏枯草 12g，牛膝 9g，赤芍 9g。

适应症：缺血性脑卒中先兆。证见面色发红，头脑胀痛，目赤口苦，急躁易怒，手足颤抖，尿黄赤。舌红，苔薄黄或黄干，脉弦数。

用法用量：水煎服。

临床应用：见益肾养阴汤项。

使用注意：阳虚者忌用本方。

资料来源：张鹤年，上海中医药杂志，1990；(5)：16。

⑥化痰通络汤

组成：陈胆星 9g，法半夏 9g，石菖蒲 9g，丹参 9g，天麻 9g。

适应症：缺血性脑卒中先兆。证见眩晕头重，胸脘痞闷，纳呆多寐，时有意识模糊，肢体麻木，痰多，或见下肢（一侧）浮肿。舌红胖大，或有齿痕脉弦滑或濡数。

用法用量：水煎服。

临床应用：见益肾养阴汤项。

使用注意：忌食肥甘厚味。

资料来源：张鹤年，上海中医药杂志，1990；5：16。

⑦益肾养阴汤

组成：干地黄 12g，麦冬 12g，玄参 12g，石斛 9g，女贞子 9g，肉苁蓉 9g，菟丝子 9g。

适应症：缺血性脑卒中先兆。证见头晕目花，脛软乏力，肢体麻木，气短心悸。舌质嫩，脉细尺弱。

用法用量：水煎服。

临床应用：上海张鹤年以平肝潜阳汤、化痰通络汤及益肾养阴汤治疗缺血性脑卒中先兆 230 例，与阿司匹林组（阿司匹林 0.3g，每周 4 次，并加用对症处理西药）61 例对照，均以一个月为一疗程；同时检测血液流变学指标，以治疗后症状、体征及血液流变学指标变化输入电脑；以达“安全”为度，未达“安全”者续用第二个疗程。结果，中药组第一疗程末达“安全”者 96 例（41.7%），第二疗程末达“安全”者 109 例（47.7%）第三疗程末达“安全”者 22 例（9.6%），第四疗程末达“安全”者 3 例（1.3%），经 5 年随访无一例发生卒中；西药阿司匹林组第一疗程末 9 例（14.8%）达“安全”，第二疗程末 17 例（27.9%）达“安全”，第三疗程末 11 例（18%）达“安全”，第四疗程末 15 例（24.6%）达“安全”，第五疗程末 6 例（9.9%）达“安全”，经 5 年随访有 3 例发生脑卒中。认为中药防治组达“安全”者快于对照组（ $P < 0.05$ ），且效果较优。

使用注意：痰湿重者本方不宜。

资料来源：张鹤年，上海中医药杂志，1990；（5）：16～17。

⑧杞菊地黄丸

组成：熟地黄、山萸肉、炒山药、丹皮、茯苓、泽泻、枸杞子、菊花。

适应症：肝肾不足，头昏目眩，视力减退，目涩、羞明、流泪、手足一过性麻木或失用。可用于 TIA 属于阴虚阳亢者。

用法用量：研末为蜜丸，每服 6～9g，日 2～3 次，淡盐汤送服。亦可改为水煎剂，2 次分服。

临床应用：本方由六味地黄丸加杞、菊而来，具有养肝熄风、定眩明目之功。治疗 TIA 宜加当归、白芍、丹参养血活血荣脑；兼气虚而肝阳偏亢不甚者，可加西洋参、生黄芪、炙升麻益气以行血；肝阳亢旺者，则宜加桑叶、钩藤、夏枯草平肝熄风。丸剂多作为 TIA 消失后巩固疗效用。

使用注意：忌肥甘厚味及动风之食物。

药理研究：应用¹³¹I 标记醋碘苯酸钠测定大白鼠肾功能，观察到六味地黄汤（本方主要部分）对肾血管双侧狭窄的实验性肾性高血压有明显的改善肾功能、降低血压和降低死亡率的作用。说明六味地黄汤能促进已有循环障碍的肾脏的排泄功能，但其原理尚待研究。同时发现六味地黄汤对正常大白鼠无降压作用（中华内科杂志，1964；1）。

资料来源：《医级》

其他方药，如华佗再造丸、豨莶通栓丸以及地黄饮子、补阳还五汤等活血化瘀治疗脑卒中之品，均可用于治疗短暂性脑缺血发作，唯剂量宜减至 1/3～1/2，亦可采用活血化瘀的静脉制剂，可参见“脑出血”、“脑梗死”相应内容。

⑨红丹汤

组成：红花 10g，丹参 30g，生山楂 30g。

适应症：短暂性脑缺血发作。

用法用量：水煎，每日 1 次，2 次分服。

临床应用：治疗短暂性脑缺血发作 32 例，男 20 例，女 12 例；年龄 42～63 岁，平均 52.5 岁。结果：随访期间未再次发作者 19 例；发作次数明显减少见症状减轻者 8 例；发作间隔延长者 1 例；脑血栓形成者 4 例。

资料来源：敬学恩，中药活血化瘀疗法治疗短暂性脑缺血发

与“脑梗死”有关内容可互参。

六、医案医话

(一) 郭维一医案——颈内动脉系统 TIA。

张某，男，55岁。1986年6月10日诊。患者素有心脏病，今日上午开会时，突感左半身活动不灵，上下肢厥胀，活动受限，心慌气短，头昏头闷，时而欲吐，口干不饮，自服心宝等药无效。查血压 16/11.47kPa，心率 83 次/分钟，律不齐。舌质暗淡，苔心微腻，脉沉濡而涩。证属“中风”先兆，痰瘀阻络。投“中风”先兆基本方加味：丹参 30g，白芥子 3g，水蛭 3g（粉剂分冲），葛根 10g，西洋参 6g（另炖），竹茹 10g，枳实 10g，陈皮 10g，半夏 10g，茯苓 10g，远志 10g，天花粉 10g，鸡血藤 15g，甘草 3g。

1 剂后患肢活动灵活，3 剂后诸恙悉除。守方略加减，间日服 1 剂，继进 5 剂后停用，追访两年余上症未发。（史宇广等，当代名医临证精华·中风专辑，北京：中医古籍出版社，1992：263）

(二) 樊蓓医案——椎-基底动脉系统 TIA

王某某，女，56岁，1992年3月11日初诊。头晕频发1年余，多为夜间平卧时或起床时发生，有时头晕持续3~6小时，每周发作1~2次。发作前先有双耳闭气、呕吐，畏光、畏声，发作后一如常人。曾住某脑科医院作 TCD 等检查，诊断为椎基底动脉系统 TIA，予西比林、阿司匹林、脑通等内服，症状控制；但遇有疲劳、紧张，症状往往复作。本次发作较重，清晨起床时头晕，行走不稳，跌仆于地，伴语言蹇塞、表达吃力，头皮麻木，耳鸣目花，心烦怕声，肢体活动尚可。苔薄白，舌淡红，有齿痕，脉细弦，血压 24/14kPa。此乃属肝肾亏虚、中气亦馁，血不荣脑，经络气血暂时不得接续而然，治当培补肝肾、益气养血，濡络荣脑：杜仲 12g，天麻 10g，怀牛膝 15g，桑寄生 12g，

熟地 12g, 山萸肉 6g, 丹参 30g, 川芎 10g, 生黄芪 30g, 枳壳 10g, 薏仁 2g (后下), 甘草 3g。

1992年3月17日二诊: 今日血压 22/15kPa。头晕改善, 夜间已可平卧, 原方去薏仁加升麻 6g 以助黄芪益气升清之力。

1992年3月24日三诊: 服药后头麻、头昏、眼前发黑均未再发生, 渐可起床, 近几日未再发头晕。血液流变学检查由治前的高粘(综合异常值 85.60)降至基本正常(综合异常值 41.40, 低于中风警告值 70.00)。苔薄, 舌淡红, 脉细濡。予原方加豨莶草 15g 续服, 20剂后血压 20/12kPa, 症状完全消失, 感到“从来没有过的头脑清楚”。嘱常服天麻杜仲丸、杞菊地黄丸。随访 1 年, 头晕、耳鸣等未再复发。

按: TIA 虽多因动脉硬化, 血液运行不畅, 遇有诱因, 导致微血栓形成而然, 是乃为血瘀的一面, 治疗理当活血化瘀; 然其病无虚不成, 临床上多可见其在气虚、或阴虚、或肾元不足等基础上发生, 故宜重视补虚培元的应用。补法可巩固 TIA 治疗的临床疗效, 也起到预防 TIA 的作用。就活血化瘀法而言, 因本病未有象脑梗死那样大的血栓形成, 脑的神经功能障碍不大且不持久, 宜养血活血法为好, 峻烈、量大的活血或破血药易伤气耗血; 如用之, 也只宜暂用, 似不宜久服。积极治疗 TIA, 可以预防脑梗死、脑出血的发生。

七、现代报道

(一) 以短程抗凝治疗 TIA 10 例, 均为短期内频繁发作且病较重者。先用肝素 12500u 加入 10% 葡萄糖注射液 100ml 静脉滴注(每分钟 8~12 滴), 每 8 小时 1 次, 同时服用新抗凝片(Sintrom) 8~12mg。并根据凝血时间(三管法)调整肝素用量, 于 24~48h 后继续用新抗凝片。以后每日或隔日测定凝血酶原时间及活动度, 以调整新抗凝片的维持量, 新抗凝片维持量为每日 2mg/日, 于 TIA 控制后再继续数日(15 日左右)后停药。再观

察数日出院。10例患者及时应用抗凝治疗后，均在24h内控制发作。随访8例，有1例于14个月发生脑血栓，有2例分别于41个月、46个月TIA各发作1次。说明抗凝的近期疗效是肯定的（汤洪川，吉林医药，1983；4（2）：35）。

（二）中医辨证治疗TIA 18例，临床分为气虚血瘀和肝阳上亢两型，其中气虚血瘀型13例，肝阳上亢型5例，服药2个月，停药4个月观察疗效，其中显效10例，好转3例，无效3例（薛芳，中医杂志，1988；29（2）：33）。

（三）TIA的自然转归，以首次发病后1年为观察期，则自然痊愈、不再发作者占1/3；经常发作、症状刻板者占1/3；发展至脑卒中者占1/3，其中大多数为完全性脑梗死，少数为脑出血。以5年计，有TIA病史者中约25%~40%将发生严重的完全性脑卒中，较无发作者的发生率大10倍。故宜积极治疗，其意义不在于治疗其单次发作，而主要是预防其发展为完全性脑卒中。其发病机制与脑梗死有某些类似，也可以说是脑梗死的前奏，故宜活血化瘀治疗；由于其病情较脑梗死为轻，中药的剂量不必过大（林兆耆等，实用内科学（7版）北京：人民卫生出版社，1984：2544。陈贵廷等，实用中西医结合诊断治疗学，北京：中国医药科技出版社，1991：721）。

八、主要参考资料

1. 陈贵廷等，实用中西医结合诊断治疗学，北京：中国医药科技出版社，1991：721~724
2. 何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991
3. 林兆耆等，实用内科学（第7版），北京：人民卫生出版社，1984
4. 中华全国中医学会武汉分会，中医急症，湖北科学技术出版社，1986
5. 傅景华等，古代验方大全，北京：中医古籍出版社，1990
4. 黄泰康等，中药方剂现代研究大典，科学出版社，1996

脉失濡。

(一) 气血不足 素体气血不足，或后天不知调摄，患病过多，耗损气血，致使身体早衰，脑元变性，筋脉失濡，虚风内动。《素问》云：“掌受血而能摄，足受血而能步。”气血不足故筋脉强直难用，不住震颤。

(二) 肾精亏虚 “年过四十而阴气自半”，年高肾精亏损，及“久病穷必及肾”，亦使肾精虚耗，脑气不足，不能主宰动作，从而发为震颤。

(三) 肝气失疏 卒受七情惊恐，或情志不舒，肝气郁结，均使肝之疏泄失常，脑之功用不达，发为震颤。

(四) 痰热化风 老年抑郁，肝气不舒，横逆犯脾，脾虚生痰，痰郁而生热，热盛动风，则脑元失调，肢体颤动不已。

总之，气血不足、肾精亏损、脑元失养是本，痰热、肝郁是标；本病之发生，多为本虚标实。

二、辨证施治

(一) 辨证要点

本病患者多见于郁闷、忧虑之人，每遇情志抑郁或紧张激动而震颤加甚。气血亏虚则筋脉拘紧，又见少动、动作笨拙，脉多弦细；气郁生痰，故见多涎，面溢油腻，苔多见厚腻，脉弦而滑；久病及肾，精亏于下，而脑髓不足于上，则反应迟钝、神思不敏；久病多瘀，亦当细察，每见其舌有紫斑或而黑舌暗。震颤为主者，气郁为主；偏于筋挛者，气血当察；久病不愈，必兼顽痰、瘀血；肾精不足，亦当兼顾。

(二) 辨证分型

1. 气血不足，虚风内动型

手足震掉，筋脉拘紧，行步慌张，肢体乏力，头晕目花，神呆懒言，少气自汗，大便不爽，而色不华。舌胖而润，边有齿

痕，舌质暗淡或见瘀斑，脉细弱或缓而无力。

2. 肝郁血虚，痰热生风型

肢体颤抖，筋脉拘紧，情怀抑郁，或急躁易怒，胸闷脘痞，头晕涎滴，面溢油垢。舌红或淡红，苔黄或腻垢，脉弦滑或细弦。

3. 肾精耗损，筋脉失濡型

形体消瘦，头晕耳鸣，腰酸腿软，颤掉日久，步态拖沓，行走不稳，失眠健忘，便下难解。舌质暗红，苔少，脉弦细或细涩。

(三) 治法方药

1. 分型治疗

(1) 气血不足，虚风内动型 益气养血，活络息风。定振丸加减：生黄芪 30g，炒白术 15g，炙升麻 10g，生熟地各 12g，当归 12g，川芎 10g，丹参 30g，天麻 10g，钩藤 30g，全蝎 6g。气虚甚加党参 15g 或人参 6g，健脾益气；震颤甚加蜈蚣 4 条，息风定痉；便秘加火麻仁 15g，白术改生白术 30~60g，润肠健脾通便。

(2) 肝郁血虚，痰热生风型 开郁和血，清化痰热。涤痰汤出入：胆南星 10g，姜半夏 12g，橘皮 6g，茯苓 30g，枳壳 12g，竹茹 6g，玫瑰花 3g，川朴花 6g，柴胡 3g，白芍 30g，丹参 18g，钩藤 15g，甘草 6g。热甚加黄芩 6g，清热化痰；便秘加全瓜蒌、生大黄各 10g 行滞通腑；颤甚加木瓜、葛根各 30g，舒筋解痉息振。

(3) 肾精耗损，筋脉失濡型 补肾填精，柔筋通络。大定风珠增删：白芍 30g，干地黄 30g，山萸肉 10g，枸杞子 15g，阿胶 10g (烔)，龟板、鳖甲、牡蛎各 30g，五味子 6g，鸡子黄 2 枚 (后下)，丹参 30g，甘草 6g。颤甚加全蝎 10g，蜈蚣 4 条，息风止痛；心烦易怒，加连翘、郁金各 10g，清心除烦；痴呆健忘，

加石菖蒲 15g, 制首乌 12g, 补脑开窍; 失眠加酸枣仁 30g, 合欢花 6g, 养心解郁宁神。

2. 方药选介

①羚羊钩藤汤

组成: 羚羊角片 4.5g (先煎), 霜桑叶 6g, 京川贝 12g (去心), 鲜生地 15g, 双钩藤 9g (后入), 滁菊花 9g, 茯神 9g, 生白芍 9g, 生甘草 2.5g。

适应症: 肝风上扰, 头晕胀痛, 耳鸣心悸, 手足躁扰, 狂乱痉厥; 肝经热盛, 热极动风以及震颤麻痹见肌肉僵硬, 手足或下颌抖动等症。

用法用量: 用鲜竹茹 15g 同羚羊角片先煎, 然后入其他药同煎。

资料来源:《重订通俗伤寒论》

②一贯煎

组成: 北沙参 10g, 麦冬 10g, 当归 10g, 生地黄 30g, 杞子 12g, 川楝子 5g。

适应症: 肝肾阴虚, 肝气不舒, 胸脘胁痛, 暖气吞酸, 咽干口燥, 舌红少津, 脉弦细弱。用于震颤麻痹见肌肉僵硬, 活动迟缓, 口干少津, 舌红少苔, 脉来细数, 更见急躁易怒, 气郁则手足颤抖加甚。

用法用量: 水煎服。

临床应用: 燥热症状重者加川黄连 5g 同煎。

资料来源:《柳州医话》

③逍遥散

组成: 当归 (去苗, 锉, 微沙)、茯苓 (去皮, 白者)、芍药 (白)、白术、柴胡 (去苗) 各 30g, 甘草 (炙微赤) 15g。

适应症: 肝郁血虚, 五心烦热, 手足震颤, 屈伸不利, 两胁作痛, 神疲食少。舌质紫暗或多瘀斑, 或青筋暴露, 脉细弦。

用法用量：上为粗末。每服 6g，用水 300ml 加入生姜 3 片、薄荷少许同煎至 210ml，去滓热服，不拘时候。若为饮片煎服，上方剂量折成 1/3~1/2。

资料来源：《太平惠民和剂局方》

④归脾汤

组成：白术、当归、白茯苓、炙黄芪、龙眼肉、远志、酸枣仁（炒）各 3g，木香 1.5g，甘草（炙）0.9g，人参 3g。

适应症：心脾两虚，气血不足，面色苍白，精疲力弱，自汗畏寒，少气懒言，动作迟缓，舌质淡胖，苔薄白，或舌体有瘀点，脉沉细。

用法用量：上药加生姜、大枣，水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：《正体类要》

⑤皂砂导痰汤

组成：半夏 10g，橘红 10g，茯苓 15g，炙甘草 6g，煨皂角 1g，礞砂 1g，胆南星 2g。

适应症：胸闷昏眩，恶心，呕吐痰涎，肢麻震颤，手不能持物，甚或四肢不知痛痒，咳喘痰多，舌体肥大有齿痕，舌苔厚腻或白或黄，脉沉滑。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：尚炽昌，疑难病证名验方辑要，北京：华艺出版社，1990：622

⑥大定风珠

组成：生白芍 18g，阿胶 9g，生龟板 12g，干地黄 18g，麻仁、五味子各 6g，生牡蛎 12g，连心麦冬 18g，炙甘草 12g，鸡子黄 2 枚，鳖甲 12g。

适应症：素体阴虚，虚火内动，症见神倦嗜卧，颧红，口唇颤动，手足蠕动，足趾抽搐，舌下无苔，质绛，脉虚弱。

用法用量：除阿胶、鸡子黄外，余药水煎去渣，纳入阿胶烱化，再入鸡子黄，搅匀，温服。

资料来源：《温病条辨》

⑦补中益气汤

组成：黄芪、炙甘草各 1.5g，人参（去芦）0.9g，当归身 0.6g（酒焙干或晒干），橘皮（不去白）0.6～0.9g，升麻 0.6～0.9g，柴胡 0.6～0.9g，白术 0.9g。

适应症：头目眩晕，动则气短，懒言，肢颤头摇，纳减，乏力，畏寒肢冷，汗出，溲便失常，舌胖大，质淡红，苔薄白，脉沉无力或虽洪大、按之虚软。

用法用量：上药咬咀，都作一服。用水 300ml，煎至 150ml，去滓，空腹时稍热服。

资料来源：《脾胃论》卷中

⑧天王补心丹

组成：人参（去芦）、茯苓、玄参、丹参、桔梗、远志各 15g，当归（酒浸）、五味子、麦门冬（去心）、柏子仁、酸枣仁（炒）各 30g，生地黄 120g。

适应症：心肾不足，阴亏血少。心悸怔忡，头眩，心烦少寐，胸闷不畅、肢麻、气短，口咽干涩，睡则张口，舌红赤，苔薄或白或黄，脉沉虚无力，甚则雀啄、屋漏（心律不齐）。

用法用量：上为末，炼蜜为丸，朱砂 9～15g 为衣。每服 9g。亦作汤剂，剂量酌减。

资料来源：《校注妇人良方》

⑨摧肝丸

组成：胆南星、钩藤、黄连（酒炒）、滑石（水飞）、铁华粉各 30g，青黛 9g，炒僵蚕、朱砂（飞）各 15g，天麻（酒洗）60g，甘草 6g。

适应症：颤振。

用法用量：为末，以竹沥 250ml，姜汁少许，打糊为丸，绿豆大。每服 4.5g，食后及临卧茶水送下。

资料来源：《证治准绳》

⑩治震颤方

组成：生龙骨、生牡蛎各 18g，玳瑁、九节菖蒲各 6g，白蒺藜、滁菊花、钩藤、远志、佩兰叶、木瓜、荷叶各 10g，桑寄生 24g。

适应症：震颤（肝豆状核变性），亦可用于震颤麻痹证。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：《中医医案医话集锦》

⑪定振丸

组成：天麻、秦艽、全蝎、细辛、熟地黄、生地黄、当归、川芎、芍药、防风、荆芥、白术、黄芪、威灵仙。

适应症：震颤麻痹。

用法用量：改丸剂为水煎服，方中黄芪用量宜大，一般 50～100g 左右。

资料来源：《证治准绳》方，转引自何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991：456。

⑫益脑强神丸

组成：鹿角胶 50g，龟板胶 50g，燕菜 50g，西红花 50g，玳瑁 100g，麝香 4g，海马 50g，枸杞 100g，山萸肉 75g，桃仁 25g，熟地 70g，白首乌 100g，黄精 100g，石菖蒲 50g，豨莶草 100g，生槐米 100g（冬季装入牛胆中，至仲春取出，晒干），五味子 50g。

适应症：震颤麻痹之髓海不足型。头晕耳鸣，记忆不清，头摇肢颤，两目昏眩，溲便不利，昼则多睡，夜则多醒，重则神呆，啼笑反常，语无伦次，舌质淡红，体肥大，苔薄白，脉沉弦无力，或弦细而紧。

用法用量：上药研末，炼蜜为丸，每丸重 6g。每服 1 丸，日服 3 次，淡盐汤下。

资料来源：任继学，范国梁，江苏中医杂志，1982；（4）：11。

⑬化痰透脑丸

组成：制胆星 25g，天竺黄 100g，煨皂角 5g，麝香 4g，琥珀 50g，郁金 50g，清半夏 50g，蛇胆陈皮 50g，远志 100g，珍珠 10g，沉香 50g，石花菜 100g，海胆 50g。

适应症：震颤麻痹之痰涎壅滞型。胸闷昏眩，泛恶，呕吐痰涎，肢麻震颤，苔腻脉濡。

用法用量：共研细末，炼蜜为丸，每丸重约 6g；每次 1 丸，日服 3 次，白开水送下。

资料来源：任继学，范国梁，江苏中医杂志，1982；（4）：11。

⑭制动汤

组成：半夏 15g，代赭石 50g，钩藤 30g，白芍 25g，南星 15g，云茯苓 20g，香附 15g，青皮 15g，竹茹 15g，陈皮 20g。

适应症：震颤麻痹风痰上逆型。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：张洪恩，千家妙方。

⑮加减通窍活血汤

组成：桃仁、红花、赤芍、川芎、麝香、僵蚕、地龙、葛根。

适应症：震颤麻痹气滞血瘀型。肢体震颤，强直少动，屈伸不利，舌质紫暗，或有瘀斑，脉象细涩。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服

资料来源：罗练华，中医神经病学，成都：四川科学技术出版社，1985：117。

⑯震颤麻痹方

组成：丹参、珍珠母各 30g，白芍、茯苓各 15g，川芎、菊花、白蒺藜、麻仁、桂枝、丹皮、泽泻、山药、炒杏仁、赤白芍、苏子、化橘红、五味子、生熟地各 10g，牡蛎 20g，地龙 6g。

适应症：老年震颤麻痹。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：施继宗，北京中医，1983；(4)：13。

⑰加减大补阴丸

组成：生熟地、首乌、山萸肉、龟板、元参、羚羊角粉、钩藤、蕲蛇、潼白蒺藜、生牡蛎。

适应症：震颤麻痹肝肾阴虚型。多见于老年（60 岁以上），头目眩晕，耳鸣失眠多梦，腰酸膝软，肢体强硬，筋脉拘紧，抖动不已，大便干结。舌体偏瘦，舌质暗红、少苔，脉弦细或沉弦。

用法用量：水煎服。

临床应用：大便干结者加大黄、火麻仁、郁李仁；腰膝酸痛者加杜仲、桑寄生；筋脉拘紧者加木瓜、鸡血藤、伸筋草。

资料来源：李庚和，上海中医药杂志，1992；(2)：12～14。

⑱王氏震颤 I 方

组成：全瓜蒌 30g，胆南星 10g，竹沥 30g，钩藤 15g，天麻 10g，珍珠母 30g（先煎），丹参 15g，赤芍 10g，羚羊角 1.5g（分冲）。

适应症：震颤属痰热内盛、内风扰动者。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：王永炎验方，董建华，中国现代名中医医案精华，北京出版社，1990：1879。

三、单方验方

(一) 蝎蚣散：全蝎、蜈蚣等量，研细末。每服 3g，每日 3 服，温开水送下（朱良春，虫类药的临床应用，江苏科技出版社，1981）。

(二) 木瓜 15g，葛根 30g，磁石 30g，水煎服，每日 1 剂，两次分服（《外台秘要》）。

(三) 人参、白术、黄芪各 3g，白茯苓、炙甘草、陈皮各 3g。水煎服（《医编》参术汤）。

(四) 松节 30g，乳香 30g，木瓜若干。以松节、乳香炒焦为末，木瓜煎酒下（《赛金丹》筋骨拘挛方）。

(五) 牙皂、木香各等分，水煎服（《保元方》手足拘挛立效方）。

四、中成药

治疗本病尚缺乏专病中成药。一般可从培元息风定振人手，选用益气聪明丸、杞菊地黄丸及天麻杜仲丸等。

杞菊地黄丸

来源：《医级》卷八

组成：生地、山茱萸、茯苓、山药、丹皮、泽泻、枸杞子、菊花。

功效：滋肾养肝，佐以清肝息风。

主治：肝肾不足兼见虚风内动或风热上乘诸症。震颤麻痹多有肝肾不足、脑失奉养见证，兼见震颤、肌肉僵硬、行动不灵，亦为本药适应症。

用法用量：上药研末，炼蜜为丸。每服 6～9g，温开水送下。

临床应用：震颤频率快、幅度大者可配合煅龙骨、煅牡蛎、

鳖甲、龟板；大便干结难解，舌质偏红者，宜加全瓜蒌、玄参、怀牛膝；面赤眵多、小便黄赤者，可加龙胆草、夏枯草、黄芩。制丸服。

方义解释：内风震颤多由肝肾不足，虚风内动而然。本方乃补阴代表方六味地黄丸加枸杞、菊花而成。方中以地黄滋阴补肾，填精益髓而生血；山萸肉、枸杞子温补肝肾，收敛精气；山药健脾，固精缩尿；以泽泻泻肾火，丹皮泻肝火，茯苓渗脾湿，菊花清肝熄风，正合病机。

五、饮食疗法

本病忌食辛辣诸品，如辣椒、姜、蒜等；饮食宜清淡。饮食疗法如下，有一定效果。

(一) 羊脑 1 副、龙眼肉 15g。先将羊脑用开水烫过，除去羊脑表面薄膜，同龙眼肉炖熟吃。每周 1~2 次（《穷乡便方》）。

(二) 核桃肉 15~30g。每日生吃，不拘时间（叶橘泉，食物中药与便方，江苏科技出版社，1980 年）。

(三) 甘草 30g，小麦 60g，大枣 15 枚。用水 4 碗，煎成 1 碗，分早晚两次服（《一效集》）。

(四) 小麦 30g，红枣 10 枚，龙眼肉 15g。水煎连汤吃（《春脚集》）。

(五) 鸡蛋黄 3 只。取金银首饰一件，用开水烫去油污后，放在蛋黄内，加水将蛋黄炖熟，吃蛋黄并饮汤（《绛囊撮要》）。

(六) 金针菜（黄花菜）60g，木耳 15g。用水 750ml 煮成 250ml，以白糖调服。据经验，金针菜、木耳可减轻忧郁，对减轻震颤有益（叶橘泉，食物中药与便方，江苏科技出版社，1980）。

六、医案医话

(一) 王永炎医案——痰热风动震颤案

赵某，男，59岁。主诉：3年前发现双手震颤，尔后逐年加重，入院时查双手震颤属静止型，幅度中等，写字可见明显震颤线条，影响工作、生活，生活自理亦感吃力。

诊查：双手震颤始动时间2.5秒，拐弯时间2.5秒。兼有头晕眠差，心胸闷痛，汗多。舌质暗，有瘀点，舌苔根部黄腻，脉弦细滑。

辨证：以气阴不足而气虚生痰，阴虚生热，痰热内盛以致内风动越，证属痰热风动。

治法：治以清化痰热，养血活血为法。

处方：全瓜蒌30g，胆南星10g，竹沥30g，钩藤15g，天麻10g，珍珠母30g（先煎）丹参15g，赤芍10g。

另选用羚羊粉1.5g，随汤药分两次冲服。

经治疗半月，出院时震颤幅度变小，程度变轻，可以自控，写字前后对照明显好转，生活可以自理，始动时间缩短为1.6秒，拐弯时间缩短为1.8秒。治疗前后两次脑电图对比，治疗前 α 波指数为28%，而治疗后 α 波指数为52%，前后对照 α 波指数有明显提高。本例疗效判为临床治愈。出院后门诊随访半年，病情稳定。（董建华，中国现代名中医医案精华，北京出版社，1990：1879～1880）

(二) 侯力娜医案——气血虚弱、筋失濡养案

某男，50岁。四肢发僵，不自主颤动，行走困难一年。伴左手麻木，握物不稳，写字困难。在外院神经科诊为“帕金森病”，服左旋多巴、安坦等药治疗，因副反应不能耐受，遂停药，于1982年8月转来中医治疗。检查：神情呆滞，缺少表情，动作缓慢。四肢肌张力增高，伴不自主震颤，左手如搓丸样。走路起步慢，呈小步慌张步态，联合运动少。脉弦细，舌质暗淡，苔薄白。中医属“震掉”，“痉证”。肝藏血、主筋，肝肾阴虚，肝

血不足，筋脉失于濡养，虚风内动，筋脉拘急。治以益气养血、柔筋息风之法。药用人参粉、当归、白术、广木香、龙眼肉、党参、赤白芍、海螵蛸、茯苓、木瓜、炙甘草。

加减调服，病情逐渐减轻，3个月后，四肢不自主震颤消失，除左上肢肌张力稍高外余均正常，走路恢复常态，两手自然摆动。改配丸药调服。（侯力娜等，中医治疗神经系统疑难病的初步探讨，北京中医学院学报，1984；4：27）

七、现代报道

本病是中枢神经系统退变性病变，与衰老有一定关系。补气血、填肾精能够抗衰老业已为世人接受，对改变脑功能退化（以器质性改变为基础的）确有作用（陈克忠，中西医结合杂志，1986年特集：134～138）；另一方面，也宜重视解郁、清肝、化痰、化瘀治标，特别是化瘀，对改善本病震颤、僵直有较大作用。陈可冀等应用大剂量黄芪治本病有效，可资进一步研究、推广。本病属顽证，疗程宜长，药量宜足（任继学等，江苏中医，1982；（4）：11。陈可冀，中西医结合杂志，1986年特集：24～29）

八、主要参考资料

1. 陈贵廷等，实用中西医结合诊断治疗学，北京：中国医药科技出版社，1991
2. 任继学等，江苏中医，1982；（4）：11
3. 董建华，中国现代名中医医案精华，北京出版社，1990
4. 章连等，中西医结合杂志，1987；7（8）：447
5. 黄泰康等，中药方剂现代研究大典，科学出版社，1996

一、病因病机

(一) 精气亏虚 老年期痴呆均发生于花甲之后，精气亏虚，此乃发病之本。经云：“年过四十，阴气自半”，更兼不识颐养，房室太过，肾精重亏，脑气空虚，思维、记忆不锐。

亦有肾阴不足于下，肝阳偏旺者，热扰神明，导致神昏而愤；肾阳不足，脾气亦羸者，脾肾虚寒，脑气为之迟钝，成为神思不敏。

(二) 痰蒙神明 素嗜肥甘厚腻，脾气失司，痰浊由生，郁久化热，痰热扰及神明；或痰浊凝聚，阻滞脑络，血流郁滞，痰瘀交互为患，脑气为之壅塞，亦发为本病。

总之，本病的病位在脑，涉及肾、心、脾、肝；其病理性质是本虚标实；以精气亏虚为本，痰、瘀、风、火为标，终致脑络不利、髓海失养，灵机失用。

三、辨证施治

(一) 辨证要点

本病必须为老年期或老年前期逐渐发病，以灵机失用为基本点。本病宜辨虚实施治，虚者神呆疲惫、行动迟缓、腰酸膝软、肢体麻木、发枯齿摇、纳少尿频；实者头重如裹、头晕耳鸣、手足心热、烦躁不寐、面红耳赤、口苦纳呆；治疗当予分辨。亦有虚实相杂者，则宜辨虚实多少，扶正与祛邪按比例投之。

(二) 辨证分型

1. 心肾失交型

遇事善忘，智能减退，腰酸腿软，或有遗精，头晕耳鸣，或手足心热，心烦失眠。苔薄白，舌质红，脉细数。

2. 痰瘀闭阻型

遇事善忘，智能减退，语言迟缓，神思欠敏，表情呆钝，或

头重如裹。舌苔白腻，脉滑；或舌上有瘀点，脉细涩。

3. 痰热扰心型

善忘颠倒，智力减退，烦躁不眠，胸脘满闷，面红耳赤，痰多色黄，口苦纳呆。舌质偏红，舌苔黄腻，脉滑数。

4. 肝肾不足型

善忘迟钝，智力减退，头目眩晕，耳鸣，失眠多梦，腰膝酸软，肢体麻木，动作笨拙，舌体偏瘦。舌质暗红，少苔，脉细数。

5. 脾肾亏虚型

善忘迟钝，智能减退，精神痿软，行动迟缓，倦怠乏力，纳少便溏，腰膝酸软，或见畏寒。舌淡暗，苔薄白，脉细弱。

6. 髓海空虚型

善忘迟钝，智能减退，形体衰惫，精神呆滞，气短乏力，腰膝酸软，足酸，发枯，齿摇，纳少，尿频。舌质淡，两尺脉沉细而弱。

(三) 治法方药

1. 分型治疗

①心肾失交型 交通心肾。用心肾两交汤或六味地黄丸加减：生地 12g，山萸肉 10g，山药 15g，川连 3g，肉桂 1g（后下），远志 12g，枣仁 30g，石菖蒲 30g，郁金 10g。腰酸甚可加桑寄生 10g，杜仲 10g，补肾强脊；耳鸣、头晕，加磁石 30g（先煎），桑叶 10g，白蒺藜 10g，以平肝息风。

②痰瘀闭阻型 涤痰化瘀。予洗心汤、寿星丸加减：党参 10g，姜半夏 12g，陈皮 10g，枳壳 6g，制南星 12g，远志 6g，石菖蒲 30g，川朴 6g，丹参 30g，赤芍 12g，白矾 10g，郁金 15g。痰盛加竹茹 6g，茯苓 30g，桂枝 10g，化痰和中；瘀重加桃仁 12g，红花 6g，麝香 0.1g（分冲），化瘀通窍。

③痰热扰心型 化痰清热，宁心安神。宜清心滚痰丸、菖蒲

郁金汤出入：石菖蒲 30g，郁金 15g，川连 5g，黄芩 10g，胆星 12g，白矾 10g，天竺黄 12g，竹茹 6g，枳实 6g。便秘宜加生大黄 6g（后下）、风化硝 12g（分冲），泄热通腑；神昏而昧，宜加牛黄清心丸化服，以清心开窍。

④肝肾不足型 滋补肝肾，健脑益智。方选杞菊地黄丸加减：生地 15g，首乌 15g，山萸肉 6g，枸杞子 12g，女贞子 12g，桑寄生 12g，赤芍 12g，丹参 15g，郁金 12g，石菖蒲 12g，远志 6g。虚风内动者，加龟板 30g，龙骨 30g，牡蛎 30g（均先煎），白芍 30g，鸡子黄一枚，以养肝息风；肝阳偏旺者，加决明子 15g，楮实子 12g，桑叶 10g，清肝息风。

⑤脾肾亏虚型 健脾补肾。方用还少丹增删：熟地 15g，山药 15g，黄芪 30g，党参 15g，枸杞 12g，牛膝 12g，楮实子 15g，巴戟天 12g，肉苁蓉 15g，小茴香 3g，远志 10g，石菖蒲 15g。虚寒甚者可加附片 6~10g，肉桂 2g（后下），温阳除寒。

⑥髓海空虚型 填精补髓，健脑益智。方宜河车大造丸、右归丸出入：紫河车 15g，熟地黄 30g，鹿角胶 10g（烊），龟板胶 10g（烊），黄精 30g，首乌 15g，山萸肉 10g，菟丝子 12g，菖蒲 30g，远志 10g，丹参 15g。形体衰惫甚者，可加仙灵脾 30g，巴戟天 10g，海狗肾 10g，黄狗肾 10g，温肾填精；脑萎缩甚者，尚可加赤芍 15g，白人参 10g，益气养血，活血荣脑；神思不敏，视昏听渺者，可加麝香 0.1g，马钱子粉 0.1g，通窍醒神，分冲，有一定帮助。

2. 方药选介

①肾虚瘀阻痴呆方

组成：熟地 15g，龟板 15g（先煎），山萸肉 15g，桃仁 10g，红花 10g，丹参 15g，川芎 10g，石菖蒲 10g，郁金 10g，赤芍 10g，黄精 20g，何首乌 15g，枸杞子 15g，楮实子 15g。

适应症：老年期痴呆及老年性精神障碍，善忘，甚则不识家

用。

临床应用：陈家扬应用本方治疗老年期痴呆及精神病，通过30余年临床实践，取得了令人振奋的疗效。

资料来源：陈家扬，实用中医精神病学，北京：北京出版社，1985：347～349。

④补肾益脑汤

组成：首乌、山茱萸、枸杞、菟丝子、山药、赤芍、丹参、菖蒲、郁金、远志。

适应症：“中风”痴呆病，即脑血管性痴呆。

用法用量：水煎服，每日1剂，分早晚服用，连服2个月为1疗程。

临床应用：北京中医学院东直门医院神经内科以本方加减治疗20例“中风”痴呆病患者，以积分法判定疗效，结果：显效13例（65%），有效6例（30%），无效1例（5%），总有效率为95%。治疗后脑电图、血脂等指标均有不同程度的改善。

药理研究：首乌含卵磷脂，经药理实验发现能骤减神经的时值，促进神经兴奋，丹参能改善微循环，使脑中ATP含量明显增多，有利于能量代谢和氧效应的调节。

资料来源：袁应坚等，中风·痴呆病的初步研究，全国首届中医脑病学术研讨会资料集，北京：1991。

⑤清心醒神汤

组成：黄连、栀子、生地、竹茹、元参、麦冬、黄芩。

适应症：多发性脑梗死性痴呆属心火亢盛、痰热内扰者，心烦易怒，情绪急躁，健忘失眠，头部胀痛，面红耳赤，大便干、小便黄，严重者见谵语神昏。舌质红，舌苔黄厚腻，脉滑或数。

用法用量：水煎服，每日1剂，2次分服，服用1～3周。

临床应用：中日友好医院对中医治疗多发性脑梗死痴呆进行了探索，分4型施治，分别应用清心醒神汤、滋阴平肝汤、益气

通瘀汤及补髓益智汤治疗，18例中10例痴呆症状有所改善，改善率55.6%。

资料来源：傅仁杰等，中医杂志，1991；(4)：24～25。

⑥滋阴平肝汤

组成：生地、白芍、元参、决明子、天麻、钩藤、川楝子、龙骨、牡蛎。

适应症：多发性脑梗死痴呆属肝肾阴虚、肝阳上亢者，头晕目眩，视物不明，咽干口苦，健忘失眠，肢体震颤抖动或伴麻木，舌体歪斜。舌质瘦红，苔少而干，脉细或数。

用法用量：水煎服，每日1剂，2次分服，服用1～3周。

临床应用：见清心醒神汤项。

资料来源：傅仁杰等，中医杂志，1991；(4)：24～25。

⑦益气通瘀汤

组成：黄芪、党参、人参、丹参、赤芍、当归、川芎。

适应症：多发性脑梗死痴呆属气虚血瘀者，多遗有肢体偏瘫痿废，兼见神识呆滞，面色无华，身倦乏力，言少不利。舌质淡或暗，舌苔薄白，脉细弱。

用法用量：水煎服，每日1剂，2次分服，服用1～3周。

临床应用：见清心醒神汤项。

药理研究：人参等益气药可改善大脑兴奋-抑制过程，提高思维的灵敏性，并有抗疲劳作用。丹参、赤芍、当归、川芎等活血通窍药物可改善大脑循环，提高大脑缺血区的血供量及氧供量，丹参尚能使脑中ATP增多，因此对改善大脑机能有一定作用。

使用注意：痰热、肝阳旺者，宜先清化痰热、平肝息风，然后再予本方。

资料来源：傅仁杰等，中医杂志，1991；(4)：24～25。

⑧补髓益智汤

组成：枸杞子、山萸肉、熟地、何首乌、菟丝子、茯神、桂圆肉、巴戟天、石菖蒲。

适应症：多发性脑梗死痴呆属髓海不足者，高龄久病，体态衰老，表情呆滞，耳鸣，视物不清，发枯，动作迟缓，二便失司。舌质淡，舌苔白，脉沉细。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服，服用1~3周。

临床应用：见清心醒神汤项。

药理研究：枸杞、山萸肉、熟地、何首乌、菟丝子、巴戟天等均有抗衰老作用。

资料来源：傅仁杰等，中医杂志，1991；(4)：24~25。

⑨益气化痰醒脑汤

组成：党参30g，黄芪60g，丹参20g，川芎、桃仁各10g，地龙15g，红花5g，天竺黄、菖蒲、远志各6g，鹿角霜15g。

适应症：老年性痴呆。

用法用量：水煎服，每日1剂，早晚分服。

临床应用：本方为南京市中医院谢昌仁主任医师经验方，曾以其治疗老年性痴呆获效。

药理研究：参照益气通瘀汤项。

资料来源：何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991：500。

⑩桃仁复苏汤

组成：桃仁10g，生大黄10g，桂枝10g，朱砂1.5g，菖蒲10g，远志10g，蜈蚣2条，龙骨、牡蛎各30g（先煎），玄明粉10g（冲服），甘草6g。

适应症：老年性痴呆。

用法用量：水煎服，每日1剂，2次分服。

临床应用：本方为刘寿康经验方，刘氏曾以其治疗70岁以

上老年性痴呆患者 2 例，收效较佳。

使用注意：服用本方必须是老人体质壮实，大便秘结者；对体虚者不可浪投。

资料来源：何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991：500。

⑩益气补肾宁心汤

组成：党参、黄芪、生地、熟地、茯苓、山萸肉、枣仁、泽泻、龙骨各 10g，山药 15g，龟板 30g，远志 5g，五味子 3g。

适应症：老年性痴呆及早老性痴呆心肾气虚证，神呆神疲，心悸易惊，傻哭傻笑，善忘不识家人，气短无力行动，目光呆滞，重听耳聋。舌质淡，苔薄白，脉弱。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，连服 2~3 个月，以后可改服金匱肾气丸合安神定志丸。

临床应用：痴呆甚者可酌加石菖蒲、远志、茯苓、麝香之属，有血瘀见证者，宜重用丹参、川芎。

资料来源：何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991：500。

⑪桑女三甲汤

组成：桑寄生、女贞子各 20g，白芍、天冬、生地各 15g，龙骨、牡蛎、龟板各 30g。

适应症：脑血管性痴呆早期。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：本方为罗忠彪验方，据罗氏报告，本方治疗脑血管性痴呆早期，颇有效验。

资料来源：何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991：499。

⑫养阴益肾汤

组成：枸杞子、制首乌、玉竹、女贞子、麦冬、灵芝、石菖

蒲、赤芍、郁金各 10g，川芎 12g，丹参 15g，菊花 6g。

适应症：脑动脉硬化痴呆早期。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，早晚分服，连服半年以上。

临床应用：本方为梁炜验方，梁氏等以其加减治疗脑动脉硬化痴呆早期患者 30 例，结果基本痊愈 5 例，显效 12 例，好转 11 例，无效仅 2 例。其加减法为：血脂高，痰浊甚者，加泽泻、生山楂、胆南星、姜半夏、白矾；肢体麻木，加桃仁、红花；高血压，性急易怒，加天麻、钩藤、石决明；懒言短气，神疲乏力，加黄芪、党参；肢体运动障碍（步态不稳，肢体震颤），加全蝎、地龙、蜈蚣、僵蚕。

资料来源：何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991：499～500。

⑭肾精不足汤

组成：生龙骨、炙龟板、远志、菖蒲、巴戟天、肉苁蓉、补骨脂、熟地黄。

适应症：老年期痴呆及精神障碍，脑海空虚，智能障碍或低下，包括理解力、计算力、分析能力、综合能力、批判力、创造力等，尤以记忆障碍为最显著，精神呆板。舌质淡，脉细弱。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，2 次分服。或制成合剂服用。

临床应用：偏阴虚者，宜加山萸肉、枸杞子；偏阳虚者可加仙灵脾、仙茅；肾精虚甚者加何首乌、紫河车。

资料来源：陈家扬，实用中医精神病学，北京：北京出版社，1985：91。

⑮益气聪明汤

组成：生黄芪 15g，太子参 15g，蔓荆子 10g，赤芍、白芍各 10g，升麻 4.5g，黄柏 6g，炙甘草 4.5g，葛根 15g。

适应症：老年脑动脉硬化症所致的眩晕、头痛、健忘等症，

亦可用于老年期痴呆。

用法用量：水煎服，每日1剂，早晚分服。或按原方剂量做成冲剂4包，每天冲服2包（上午8～10时，下午2～3时各服1包），连服3个月。

临床应用：益气聪明汤原为元代李东垣创制，后世多用之治疗眩晕、耳鸣等症。上海金寿山先生在临床上常用之治疗老年动脉硬化或衰老所致的高级神经功能障碍。上海中医学院等以30例老年脑动脉硬化症病人为观察对象，随机分为两组，用双盲法分别给予中药冲剂（益气聪明汤）和安慰剂，经3个月的临床观察，分析有关指标发现：1) 指向记忆和联想学习记忆活动水平呈上升趋势。2) 图象自由回忆和无意义图形再认记忆活动水平有上升趋势。3) 人像特点联系回忆、记忆活动无上升趋势变化，且有所下降。认为本方对老年脑动脉硬化症患者高级神经功能活动障碍（主要表现在记忆力衰退）有一定改善作用。

药理研究：益气聪明汤对脑供血状况有改善作用，能降低血脂水平，增加红细胞压积并使红细胞电泳加快；能使脑神经递质变化，cAMP水平提高。

资料来源：张铭等，上海中医药杂志，1991；(5)：41～43。

⑩康宝

组成：蜂王浆、刺五加、淫羊藿、黄精、枸杞子、熟地、黄芪、山楂、马钱子碱（微量）。

适应症：老年脾肾两虚、高级神经功能衰退，头晕失眠，倦怠健忘。

用法用量：制成口服液，每次10～15ml，每日3次，6～8周为1疗程。

临床应用：中国中医研究院西苑医院进行了本方的临床研究。药后患者食量增加，睡眠、体力、视力、听力、图形记忆、性功能等均有改善，肺通气功能流速高峰显著增加，血浆粘度比

增高者显著下降，体外淋巴细胞摄取 ^3H -TdR 显著增加。

药理研究：1) 调节中枢神经系统：抑制小鼠中枢神经，与戊巴比妥钠有一定协同作用；2) 提高机体适应能力：可显著延长小鼠负重游泳时间及减压、常压缺氧条件下的生存时间，并显著降低氧耗量，增加存活率；3) 对内分泌系统作用：可显著增加大鼠血清睾酮（雄性）和雌二醇（雌性）水平，并可使氢化考的松所致肾上腺皮质耗竭小鼠在低温下的死亡数显著减少，体重增加，肾上腺无萎缩；4) 促进免疫功能：可显著增加特异性抗体、溶血素和凝集素的效价，促进小鼠腹腔巨噬细胞吞噬率和吞噬指数，并可对抗地塞米松对机体免疫功能的抑制，即既能促进又能调节机体免疫功能。故本方有较好的抗衰老作用。

资料来源：陈可冀，抗衰老中药学，北京：中医古籍出版社，1989：28～34。

⑯青春宝

组成：人参、天门冬、麦门冬、地黄等。

适应症：老年体弱，气血两虚，记忆力减退等脑机能衰退。

用法用量：制成口服液，每次 10ml，1 日两次；或制成片剂，每次 1.5g，1 日两次口服。

临床应用：有自觉精神旺盛，精力充沛，记忆、思维等提高的作用。

药理研究：可明显地延长小鼠及果蝇的平均寿命；明显减少小鼠脊髓神经细胞中脂褐质含量，尤以雄性为著；并可抗辐射。

使用注意：阴虚火旺或肝阳偏旺者慎用。

资料来源：陈可冀，抗衰老中药学，北京：中医古籍出版社，1989：31～32。

⑰还精煎

组成：地黄、潼蒺藜、锁阳、菟丝子、何首乌、牛膝、菊花、石菖蒲等 18 味中药。

适应症：老年肾精亏损，肝肾阴虚，记忆力等高级神经功能减退或痴呆。

用法用量：制成口服液，每次 10ml，每日 2 次。疗程 1 年。

临床应用：上海龙华医院等观察 45~76 岁中老年人，疗程 1 年，药后大脑功能有显著改善，近视力、远视力提高，并有调节免疫作用。

药理研究：还精煎能明显地抑制中老年大、小鼠 MAO 活性，降低大鼠脑皮质 NE 的水平，使之接近青年大鼠水平；可纠正下丘脑-垂体-性腺-胸腺轴各个层次不同环节的老年性改变；延长小鼠和蚕蛾的平均生存率；对动物免疫机能的紊乱有调节作用；对肝、肾、肺、骨骼的老化也有改善作用。

资料来源：陈可冀，抗衰老中药学，北京：中医古籍出版社，1989：32~33。

⑬五子衍宗液

组成：菟丝子、枸杞子、五味子、覆盆子、车前子。

适应症：老年肾虚，脑功能及性功能减退，亦治久无生育，精子稀少。

用法用量：原为水泛丸，每服 6g，日服 2 次；现制成口服液（每支含生药 6g），每日 2 支，疗程为 5 周。

临床应用：北京医科大学对本方进行了临床研究，结果显示：本方可使老年肾虚衰老症状的总积分值下降（ $P < 0.01$ ），红细胞中超氧化物歧化酶（SOD）活力回升（ $P < 0.01$ ），血浆过氧化脂质（LPO）含量下降；血浆睾酮（T）含量上升（ $P < 0.01$ ），雌二醇（ E_2 ）与 T 比值下降（ $P < 0.01$ ）。而糖水安慰剂组治疗前后均无明显变化。提示减少自由基中毒损伤，增强抗氧化酶活力及调节体内性激素水平，可能是五子衍宗液治疗老年肾虚、延缓衰老（包括脑衰老）的主要作用机制之一。

资料来源：王学美等，中国中西医结合杂志，1992；12

(1): 23~25。

②还少丹胶囊

组成：熟地黄、山药、牛膝、枸杞子、山茱萸、茯苓、远志、五味子、楮实、小茴香、巴戟天、肉苁蓉、石菖蒲。

适应症：老年衰老及肾阳虚证，包括老年脑功能衰退、痴呆。

用法用量：原为水泛丸，现制成胶囊，每粒含生药 4g。每服 6~9 粒，每日 3 次。疗程为 3 个月。

临床应用：成都中医学院附属医院等对 309 例中老年肾虚患者，以不同剂量进行为期 1.5~3 个月治疗，并与还少丹水泛丸及安慰剂以单盲或双盲法进行对比观察。结果：还少丹胶囊大、小剂量组（Ⅰ、Ⅱ组），还少丹水泛丸大、小剂量组（Ⅲ、Ⅳ组）及胶囊小剂量短疗程组（Ⅴ组）治疗前后症状记分比较，均有显著性差异（ $P<0.001$ ， <0.01 ），而安慰剂组治疗前后差异无显著性意义。Ⅰ~Ⅳ组的近视力、握力、心理衰老、瞬时记忆记分治疗后均有明显改善（ $P<0.05$ ）；血清过氧化脂质、肾上腺皮质激素、超氧化物歧化酶、细胞免疫功能等，治疗后均有改善，与安慰剂组比较 $P<0.05$ ，胶囊组与水泛丸组比较差异不显著（ $P<0.05$ ），说明这两种剂型均有抗衰老、补肾、改善脑功能的作用。因胶囊较水泛丸更易吸收、副作用更少，故以胶囊剂较优。

药理研究：动物实验证明，还少丹胶囊具有抗衰老和治疗肾阳虚证等作用。

资料来源：杜辛等，中国中西医结合杂志，1992；12（1）：20~22。

③春回胶囊

组成：补骨脂、仙灵脾、蛇床子、人参、鹿茸、玉竹、山楂等 11 味中药。

适应症：老年肾气虚衰，记忆力等脑功能减退，头晕耳鸣。

用法用量：制成胶囊，每次2~4粒，每日2次，6个月为1疗程。

临床应用：中国中医研究院广安门医院对春回胶囊进行了大宗临床研究。药后“春回”组肾虚见证显著减轻，精神、体力、耐寒力、睡眠和性功能改善，疲劳感及感冒频率减少，少数人黑发新生，老年斑消失，优于对照组。经检查，心、肾功能、听力、智能（记忆广度、短暂记忆、划销试验）、精细动作均显著高于药前，肺通气功能亦改善；改善性功能，药后性激素水平趋于正常；显著增高血浆cAMP水平，及cAMP/cGMP比值，淋巴细胞转化率和对PHA诱导的应答能力；显著降低血清LPO的生成和MAO活力，降低甘油三脂、增高HDL值。

药理研究：延长老年小鼠和鹌鹑的平均寿命；明显延长小鼠在常压缺氧时的生存时间；明显降低14和24月龄大鼠的心肝组织的LPO量和脑组织的MAO活性，显著增加中枢神经系统NE和DA水平。

资料来源：陈可冀，抗衰老中药学，北京：中医古籍出版社，1989：31。

②补肾健脑片

组成：旱莲草150g，桑叶9g，豨莶草16.5g，黑芝麻60g，当归9g，金银花7.5g，何首乌96g，怀牛膝9g，天麻9g，金樱子36g，菊花4.5g。

适应症：脑动脉硬化症，脑功能障碍及神经衰弱症候群，头痛、头晕、头昏脑胀、失眠、多梦、耳鸣、眼花、记忆力衰退等。

用法用量：制成片剂，每次4片，每日3次。

资料来源：高辉远等，蒲辅周医案。

又通过①对小鼠脑缺氧、缺血后再灌注损伤的影响（对正常小鼠脑过氧化脂质含量的影响；对脑缺氧小鼠脑过氧化脂质含量的影响；对脑缺氧后再灌注小鼠脑过氧化脂质含量的影响）；②对老化相关酶活性的影响〔对小鼠脑、肝脏单胺氧化酶（MAO-B）活性的影响；对豚鼠脑、骨 Na^+ , K^+ -ATP 酶活性的影响〕的实验，结果表明：本方对 KCN 诱发小鼠脑缺氧所致脑 MDA 含量增高具有降低作用。能显著抑制 MAO-B 的活性，有可能通过对 MAO-B 活性抑制，使单胺类神经递质水平升高，从而调整某些退化的生理功能和行为。对肝脏 MAO-B 活性的抑制作用不明显，表明其不影响肝脏对体内某些有害的单胺类物质的解毒功能。^[2]

资料来源：

[1] 周敏等，生脉散加味对离体大鼠心肌缺氧、缺血后再灌注损伤的影响，中药药理与临床，1988；4（3）：19。

[2] 周敏等，加减生脉液抗衰老的药理研究Ⅱ：对小鼠脑缺氧、缺血后再灌注损伤的影响，中药药理与临床，1989；5（5）：27。

⑤益智灵

组成：太子参 30g，天冬 10g，熟地 20g，川芎 6g，炙远志 6g，制胆星 10g 等。

适应症：老年痴呆。

用法用量：上药制成口服液，含生药 2g/ml，早晚各 1 次空腹服，每次 30ml。1 个月为 1 疗程，最长不超过 4 个疗程。

临床应用：治疗老年痴呆 51 例，其中男性 31 例，女性 20 例；年龄最小 49 岁，最大 87 岁；病程 13 天至年；其中高血压 31 例，脑卒中 30 例，脑动脉硬化 28 例，心脏疾患 17 例。治疗前原服用复方降压片和心痛定以降血压和治疗心脏疾患者，逐渐减量，1 个月内完全停用。同时进行脑力训练，以激发患者志

男 8 例, 女 6 例; 年龄 52~75 岁; 多发性梗塞性痴呆 17 例, 男 9 例, 女 8 例; 年龄 50~70 岁。疗效标准: 治愈: 主要症状基本恢复, 神志清楚, 定向健全, 答问切题, 生活能自理。有效: 主要精神症状有所减轻或部分消失, 生活基本自理, 回答问题基本正确, 但反应迟钝, 智力或人格仍有部分障碍。无效: 病情无明显改善或继续发展。结果: 老年性痴呆 14 例中, 痊愈 1 例, 有效 10 例, 无效 3 例。多发性梗塞性痴呆 17 例, 有效 12 例, 无效 5 例, 总有效率为 74.2%^[1]。

实验研究:

药化研究:

对本方药味所含微量元素进行了分析, 方中人参为吉林产, 麦冬为四川产, 五味子为东北产, 结果表明: 三味药中铁含量最高; 尤其是五味子铁、锰含量最高, 铜、铬含量也较高。麦冬中含镍较丰富。还发现生药部位及产地不同, 其微量元素含量也有差异^[2]。

药理研究:

(1) 增加冠脉流量, 改善心肌供血的作用 麻醉狗在位心, 分离左旋支, 通过 MF-27 型电磁流量计测定分钟流量, 生脉液 0.5ml/kg, 使流量峰值平均增加 $33.2\% \pm 6.0\%$, 与对照组比较, 两者差异显著 ($P < 0.001$), 说明本品能有效地增加狗冠脉流量。生脉注射液亦能使大鼠离体心脏灌流量明显增加, 可由正常的 7.15 ± 0.64 增至 $9.57 \pm 1.78\text{ml/min}$ ^[3]。

为了进一步了解生脉液改善缺血性心肌的作用, 又有实验观察了生脉液对急性心肌梗塞犬缺血区的返回血流及心内膜下区灌注压的影响, 结果 14 只犬在结扎冠脉前降支后 30 分钟时, 左心室收缩期峰压平均降低 $3.5 \pm 0.67\text{kPa}$ ($26 \pm 5.0\text{mmHg}$) ($P < 0.01$); 左心室舒张末期压平均升高 $0.73 \pm 0.17\text{kPa}$ ($5.5 \pm 1.3\text{mmHg}$) ($P < 0.01$); 给药后左心室舒张末期压较给药前明显

降低 ($P < 0.05$), 心内膜下区灌注压在用药后明显升高 ($P < 0.05$), 左心室舒张末期压降低与临床所见一致。临床报道, 生脉散可使急性心肌梗塞患者 $a\%$ 减少 ($a\%$ 是反映左心室顺应性舒张末期压力状态的一项重要指标)。左心室舒张末期压降低, 使心内膜下区灌注压升高, 能改善急性缺血区心肌血流量, 从而改善氧的利用, 推测生脉液可能改善缺血区的营养血流^[3]。

(2) 对大鼠离体心肌缺氧、缺氧后再灌注损伤的影响应用生脉散加味 (人参、五味子、麦冬、黄芪、附子), 按 Langendoff 法制备大鼠离体心脏, 用含氧 KHB 液和乏氧 KHB 液分别灌注, 结果: 加味生脉液能显著降低含氧灌注心肌 MDA 含量, 对缺氧心肌过氧化脂质含量也有显著降低作用, 并能非常显著地降低缺氧后再给氧心肌的 MDA 的含量^[4]。

(3) 对实验性心肌梗塞修复作用的影响 用结扎家兔冠状动脉前降支方法及用大白鼠腹腔注射脑垂体后叶素方法造成心肌梗塞的动物模型。实验组家兔耳静脉注射、大白鼠腹腔注射生脉散, 其用量按 2.5g (人参) / 50kg 体重计算, 用生理盐水稀释。对照组用以上相应给药方法给与等量的生理盐水, 家兔治疗 48 小时, 大白鼠治疗 72 小时, 分别腹腔注射 $^3\text{H} - \text{TdR} 300 \sim 350 \mu\text{Ci}/\text{只}$ 和 $1 \mu\text{Ci}/\text{g}$ 体重, 标记 4 小时, 取心脏进行病理组织处理, 用浸膜法涂布 1: 1.5 稀释的核-4 乳胶; 分别曝光 30 天 (家兔) 及 8 天 (大白鼠), 经显影、定影、染色后进行病理观察和计算细胞核标记率。实验结果: ①家兔梗塞心肌组织的病理变化: 实验组心肌呈点片状坏死灶, 周围炎性反应已吸收, 有大量成纤维细胞增生。对照组心肌呈大片状坏死灶, 周围有明显的炎性反应, 轻度的肉芽组织增生。放射自显影结果: 实验组细胞核标记率为 16%, 对照组细胞核标记率为 4.2%, 标记的细胞核大部分是成纤维细胞核, 偶见标记的心肌细胞核。②大白鼠损伤心肌组织的病理变化: 实验组坏死灶周围有大量成纤维细胞增生,

而对照组坏死灶周围有大量炎细胞浸润。放射自显影结果：实验组平均标记率为 32.8%，对照组平均标记率为 13.8%。两组标记率经统计学处理差异显著 ($P < 0.05$)。另外采用高速放射自显影曝光 24 小时结果，实验组标记率为 30.1%，对照组标记率为 13.8%，两种放射自显影方法所得结果相一致。有关家兔心肌梗塞恢复过程，陶氏等曾有报道，家兔心肌梗塞发生后 5 天内为急性坏死的进展期，5 天后进到修复期。本组实验结果治疗组家兔和大白鼠心肌梗塞后的第 2 天、第 3 天已进入修复期，而对照组仍处于炎性反应期。这一结果可以表明生脉散有促进损伤心肌 DNA 合成，加速损伤心肌的修复作用^[5]。

(4) 对损伤心肌细胞乳酸脱氢酶及心肌细胞超微结构的影响

选用北京第四制药厂生产的生脉散注射液，运用体外培养心肌细胞的方法，观察中药生脉散注射液对阿霉素引起心肌细胞损伤时，心肌细胞内乳酸脱氢酶释放及超微结构的影响。实验结果：证明生脉注射液 30、100、300ml/L，对阿霉素 1mg/L 作用 4 小时引起的培养心肌细胞乳酸脱氢酶释放没有影响；对其引起的心肌细胞超微结构损伤也无改善作用，表明生脉注射液对阿霉素引起的心肌损害的保护作用，可能是在整体情况下产生的^[6]。

(5) 对小鼠耐缺氧及对家兔急性心肌缺血的影响 小鼠腹腔注射生脉注射液（酒沉物）1g、2g/kg，家兔耳静脉注射 1g、2g/kg。观察指标：①耐缺氧作用：分别按文献常规方法及腹腔注射异丙肾上腺素法。②对家兔急性心肌缺血的影响：用垂体后叶素法，观察 S-T 段移位变化、心率和心律变化。③对家兔体温的影响。④急性毒性测定。实验结果表明：①两种耐缺氧实验皆显示本方具有显著的提高小鼠耐缺氧能力的作用。②能对抗垂体后叶素引起的家兔 S-T 段变化和心律失常，对心率减慢无明显影响。③对正常家兔体温无降低作用，对致热家兔体温升高具有显著降低作用。④急性毒性试验结果显示本药的 LD_{50} 为 6.08

$\pm 0.56\text{g/kg}^{[7]}$ 。

(6) 调节血压改善微循环 ①对血压的影响：在对狗急性失血休克实验中观察到，股动脉放血至血压下降到 2.7kPa (20mmHg) 时，给生脉注射液后，血压平均升高 $7.9 \pm 1.8\text{kPa}$ ($59.0 \pm 13.5\text{mmHg}$) ($P < 0.001$)。家兔放血至血压降至 4kPa (30mmHg) 时，给生脉散后血压上升至 10.9kPa (82mmHg)，1 小时后仍维持在 8kPa (60mmHg)。②对微循环的影响：a. 对实验性心源性休克家兔肠系膜微循环的影响。实验结果表明，生脉散组动物微循环障碍程度明显低于对照组，死亡率也相应低于对照组。用橄榄油静注造成家兔急性心功能不全，生脉散预先给药组存活率为 75% ，而对照组为 12.5% ，两组差异显著 ($P < 0.05$)，认为主要作用为加强心肌收缩力及改善微循环^[8]。b. 对大分子右旋糖酐所致微循环障碍的影响。生脉注射液 (10ml 中含生药人参 1g ，麦冬 3g ，五味子 1.5g)、大分子右旋糖酐 (HMWD) 分子量为 $600 \sim 800\text{kDa}$ 。将大鼠随机分为①生脉散 + HMWD 组：尾静脉注射生脉注射液 0.4ml/g 体重；②生理盐水 + HMWD 组：尾静脉注射同剂量的生理盐水；③对照组。以上每组又分为两组，在给药给水 5 分钟后，一组尾静脉注射 10% HMWD $0.3\text{ml}/100\text{g}$ 体重，24 小时内生脉散 + HMWD 组的死亡率为 36.8% ，生理盐水 + HMWD 组的死亡率为 72.2% ， $P < 0.01$ 。另一组尾静脉注射 10% HMWD $0.2\text{ml}/100\text{g}$ 体重，观察给 HMWD 1、4、8、12 小时的血液流变性指标。大鼠从腹主动脉取血，按梁氏法用玻璃毛细管粘度计测定全血比粘度、血浆比粘度。用 SDZ-1 型红细胞粘度计时器在恒温 25°C ，电压 40V 的条件下，测定 10 个红细胞，每个红细胞泳动 $165\mu\text{m}$ 所需要的时间为红细胞电泳时间。用 L × J64-01 型离心机 (半径为 15.9cm)，3000 转/分钟，离心 30 分钟，所得值为红细胞压积。结果大鼠尾静脉注射大分子右旋糖酐后，全血比粘度，红细胞压

积明显增加,提示血流缓慢。红细胞电泳时间延长,表示红细胞聚集性增强。生脉散可使全血比粘度,血球压积明显降低,在4小时后变化最为显著($P < 0.001$),红细胞电泳时间明显缩短($P < 0.001$),表明生脉注射液对HMWD所致微循环障碍有保护作用^[9]。

(7) 对体外血栓形成及凝血系统功能的影响 ①体外血栓形成:雄性家兔1.5~2.0kg,分为生理盐水及生脉注射液(每支2ml,每1ml含生药红参0.1g,麦冬0.312g,北五味子0.156g)组。静脉注射,剂量均为2ml/kg,于注射前和注射后2小时分别取血,按李承珠等报道的方法进行实验。生脉注射液静脉注射2小时后,可使体外血栓形成时间明显延长,血栓重量(湿重)明显减轻,血栓长度缩短,表明生脉注射液有抑制体外血栓形成的作用。②对凝血系统功能的影响:雄性家兔静脉注射生脉散注射液,剂量同前,于注射前和注射后2小时分别取血,按Quick一步法测定凝血酶原时间。结果生脉注射液对正常血浆凝血酶原时间及凝血酶原消耗时间均明显延长,即对外源性凝血系统及内源性凝血系统均有明显抑制作用,表明生脉注射液的抗凝血作用较强。生脉散注射液并能使血浆纤维蛋白含量减少($P < 0.05$),优球蛋白溶解时间,凝血酶时间有一定程度延长,说明纤维蛋白原降解产物增多,而纤维蛋白原降解产物有明显抗凝作用^[10]。

(8) 对衰老代谢产物及老化相关酶活性的影响 ①对小鼠肝脏过氧化脂质含量的影响:按TBA-MDA反应比色测定肝丙二醛含量,Lowry法测定肝蛋白质含量。结果:加味生脉散使老龄鼠肝过氧化脂质含量显著降低。②对小鼠心、肝超氧化物歧化酶的影响:用0.1mol/LMEDTA和-0.05mol/L磷酸缓冲液(pH7.8)制备20%小鼠心、肝匀浆,采用核黄素-NBT法测SOD活性,Lowry法测酶液蛋白含量,结果:加味生脉液可显著增高老龄小鼠心、肝SOD活性。③对豚鼠心肌 Na^+ 、 K^+ -

ATP 酶活性的影响：取豚鼠心室肌，Matsuiand Schwartz 法制备 Na^+ , K^+ - ATP 酶，Harry 法测定无机磷；Lowry 法测定酶蛋白含量，结果：加味生脉液具有增高心肌酶活性作用，对调整老年心肌功能有意义^[4]。

(9) 对老年大鼠肝脏组织化学成分的影响 将健康的 18 个月龄的 Wistar 大白鼠 22 只随机分为 2 组，雌雄各半。对照组每日给予 10ml/kg 生理盐水灌胃。给药组每日给予 10ml/kg 生脉口服液（每 1ml 含生药 0.55g）灌胃。2 组动物连续灌胃 3 周。给药前测定动物的体重和体力，给药后每周测定 1 次。经 t 检验进行统计学处理。①应用自行设计的抑柱法测定动物的体力情况，将大鼠放于纱布包裹的木棍上，待其抓牢后提起，使之悬空，用秒表计算时间，直到大鼠因不能坚持而掉落为止。测定 3 次取其平均值。②给药 3 周后，将动物断头处死，取出肝脏，处理后观察肝脏组织化学成分的变化。结果表明：①生脉口服液对老年大鼠体重没有明显影响 ($P > 0.05$)，但体力明显增强，两组相比有显著差异 ($P < 0.05$)；给药组动物给药前后体力亦有显著差异 ($P < 0.05$)。②生脉口服液能提高老年大鼠肝脏内琥珀酸脱氢酶的活性，增加肝脏内核糖核酸和糖原的含量。③生脉口服液对老年大鼠肝脏内乳酸脱氢酶和单胺氧化酶没有影响^[11]。

(10) 对大鼠红细胞 2, 3 - DPG 的影响 选用雌性大白鼠，体重 150~200g，将动物随机分为 4 组：生脉散缺氧组；生理盐水缺氧组；生脉散非缺氧组；生理盐水非缺氧组。生脉散的两组动物每天尾静脉注射生脉散注射液（每 10ml 中含红人参 1g，麦冬 3g，五味子 1.5g）0.5ml/100g 体重，连续给药 4 天。生理盐水两组动物每天尾静脉注射生理盐水 0.5ml/100g 体重，连续 4 天。缺氧组的两组动物在第 4 天给药或给生理盐水之后 30 分钟放入体积 10000ml 的恒压缺氧装置中，其负压恒定在 53~60kPa (400~450mmHg) 的条件下缺氧 8 小时。非缺氧组的两组动物

在第4天给药或给生理盐水30分钟后禁食、禁水2小时。经上述处理后的4组动物皆在乙醚麻醉下腹主动脉取血，肝素抗凝，进行2,3-DPG测定。生理盐水缺氧组全血红细胞和血红蛋白的2,3-DPG浓度皆明显高于生理盐水非缺氧组 ($0.001 < P < 0.05$)；而生脉散两组的2,3-DPG含量与生理盐水非缺氧组相比则全血、红细胞及血红蛋白的2,3-DPG浓度皆明显增加 ($P < 0.001$)。从血气分析的结果可看出生脉散缺氧组的pH、 PO_2 及 SO_2 皆高于而 PCO_2 则低于生理盐水缺氧组。而非缺氧组两组之间血气分析无明显差异。结果表明：生脉散可以增加正常人血红蛋白2,3-DPG浓度，从而具有降低血氧亲和力的作用。还可使2,3-DPG高于正常者下降，即具有“双向调节”作用^[12]。

(11) 对小鼠脾虚证模型及大鼠免疫功能等的影响 按《中华人民共和国药典》(1985年版)规定品种配方，分别制成生脉饮袋泡剂水提液及煎剂溶液。进行实验：①对大黄所致小鼠“脾虚证”模型的影响；②对小鼠腹腔巨噬细胞吞噬鸡血球的影响；③对炎症反应的影响；④对大鼠体内白细胞游走的影响；⑤镇痛作用；⑥对幼小小鼠体重、器官重量的影响。结果表明：小剂量生脉饮袋泡剂治疗大黄所致“脾虚”模型小鼠，可见体重迅速恢复，但剂量过大效果反差，这可能与本方溶出物甚多，加重胃肠负担而致腹泻加剧有关。另外还能明显抑制角叉菜胶和蛋清所致的大鼠足肿胀，表明其对早期炎症具有较强的抗炎活性。由于切除肾上腺后抗炎作用消失，提出其抗炎作用与激活肾上腺皮质功能有关。本方能增强吞噬细胞的吞噬功能，而对白细胞游走无影响，能明显抑制醋酸所致小鼠扭态的反应^[13]。

(12) 对老龄大鼠中暑的预防作用 取党参50g，麦冬35g，五味子15g。用蒸馏水配成10%冲剂。选择15~18月龄纯种健康Wistar大鼠，体重270~470g，雌雄不拘，实验动物置于

沉液混合。小鼠腹腔注射，生脉Ⅰ号 1.0g/kg，生脉Ⅱ号 0.8g/kg，生脉Ⅲ号 1.3g/kg。大鼠静脉注射，剂量同上。观察指标：①急性毒②对小鼠耐缺氧与耗氧量的影响；③对小鼠耐寒冷的影响；④对大鼠急性心肌缺血和心律失常的影响（垂体后叶素法）。结果表明：①尾静脉注射 LD₅₀分别为生脉Ⅰ号 20.1g/kg，Ⅱ号 15.3g/kg，Ⅲ号 25.3g/kg。②三种生脉液皆能显著提高小鼠耐缺氧能力，降低耗氧量。③三种生脉液均使小鼠寒冷条件下死亡率降低，但统计无显著性差异。④三种生脉液均对大鼠急性心肌缺血具有保护作用^[17]。

资料来源：

[1] 邱森山等，生脉饮治疗老年呆病，中药药理与临床，1993；9（3）：4

[2] 李荣谱等，生脉散生药成分中微量元素的测定，中成药研究，1986；（8）：17

[3] 陶静仪等，黄精、生脉液扩冠等作用的实验研究，陕西新医药，1981；（3）：56

[4] 周敏等，生脉散加味对离体大鼠心肌缺氧、缺氧后再灌注损伤的影响，中药药理与临床，1988；4（3）：19

[5] 李亚民等，生脉散对实验性心肌梗塞修复作用的影响，中西医结合杂志，1985；5（6）：346

[6] 蔡青，生脉注射液对损伤心肌细胞乳酸脱氢酶及心肌细胞超微结构的影响，中西医结合杂志，1991；（5）：286

[7] 白音夫等，生脉注射液酒沉物的药理作用，中草药，1986；17（12）：18

[8] 赵连根等，生脉注射液对急性心功能不全的预防作用，天津医药，1974；（9）：449

[9] 宋崇顺等，生脉散对大分子右旋糖酐所致微循环障碍和弥漫性血管内凝血的影响，辽宁中医，1984；（12）：36

[10] 许青媛等, 生脉注射液对家兔体外血栓形成及凝血系统功能的影响, 中西医结合杂志, 1986; 6 (7): 428

[11] 张国玺等, 生脉口服液对老年大鼠肝脏组织化学成份的影响, 中西医结合杂志, 1987; 7 (8): 481

[12] 宋崇顺等, 生脉散对红细胞 2, 3-二磷酸甘油酸作用的初步研究, 中药药理与临床, 1986; 2 (1): 25

[13] 徐嘉红等, 生脉饮的药理作用初步研究, 中药药理与临床, 1989; 5 (6): 12

[14] 林凤如等, 生脉散对老龄大鼠中暑的预防作用, 中西医结合杂志, 1989; 9 (8): 485

[15] 欧阳卓志等, 两种生脉饮口服液的药理学研究, 中成药研究, 1988; (2): 30

[16] 王红兵等, 生脉饮口服液对大鼠心输出量的影响, 中成药研究, 1990; 12 (12): 26

[17] 李增晞等, 三种生脉注射液药理作用的研究, 中草药, 1984; 15 (7): 24

⑦益肾化癥降浊汤

组成: 山萸肉、菟丝子、益智仁、郁金、胆南星、远志、石菖蒲各 10g, 紫河车 3g (炒黄研末冲服), 水蛭 6g, 生山楂 20g。

适应症: 老年性痴呆。

用法用量: 兼肝阳偏亢者, 加天麻 10g, 生石决明 20g; 兼阳虚者, 加仙灵脾 10g, 肉桂 5g; 兼阴虚者, 加百合、女贞子各 15g; 兼肝郁者, 加香附、佛手各 10g。水煎每日 1 剂, 分 2 次服, 30 天为 1 疗程。

临床应用: 治疗老年性痴呆 48 例中, 男 28 例, 女 20 例; 年龄最小 50 岁, 最大 87 岁。主要症状基本恢复, 神志清醒, 定向健全, 回答问题正确, 反应灵敏, 生活自理, 能进行一般社会活动为显效, 共 21 例; 主要精神症状有所减轻或部分消失, 生

活基本自理，回答问题基本正确，但反应迟钝，智力与人格仍有部分障碍为有效，共 23 例；主要症状无改变，或病情有发展，生活不能自理，回答问题不正确，神志痴呆为无效，共 4 例；总有效率为 91.6%。

资料来源：李维华，自拟益肾化浊降浊汤治老年性痴呆 48 例，浙江中医杂志，1993；28（12）：549

②益脑冲剂

组成：黄精、何首乌、黄芪、葛根等。

适应症：老年人认知功能减退。

用法用量：上药制成冲剂，每小包 15g（相当含生药 24.5g），每日 2 次，每次 2 小包，温开水冲服。连续服用 2 个月。

临床应用：选择具有初中或初中以上文化程度、无严重心、肺、肝、肾等疾病的中老年人，经 WMS 测定记忆商值（MQ） ≤ 100 分者 27 例，随机分成益脑冲剂组及脑复康对照组（用药每日 3 次，每次 2 片，连续服用 2 个月），观察 WMS，血浆过氧化脂质（LPO）、肝功能（SGPT）、血尿常规和心电图。结果，据韦氏记忆量表（WMS）检测，益脑冲剂对 WMS 各项目量表分值均不同程度地提高，表明该冲剂能明显促进中老年人认知功能。该冲剂还能使血浆 LPO 量下降。临床表明，益脑冲剂能明显改善患者衰老的自觉症状，优于脑复康。

资料来源：龚康敏等，益脑冲剂对老年人认知功能减退和血 LPO 影响的初步观察，安徽中医学院学报，1992；11（3）：49。

③孔圣枕中丹

组成：炙龟板 15g，生龙骨 30g，石菖蒲 10g，远志 10g。

适应症：老年性痴呆。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，30 天为 1 疗程，酌情治疗 1～3 个疗程。

临床应用：心脾两虚型合用归脾汤、益气聪明汤；肾精虚衰型合用左归丸；气郁痰凝型合用逍遥散、涤痰汤；痰郁化火合用黄连温胆汤、《景岳全书》服蛮煎；肾虚血瘀型合血府逐瘀汤。

资料来源：孔繁林等，山西中药，1998；(1)：10。

⑩醒脑汤

组成：淫羊藿 20g，巴戟天 20g，肉苁蓉 20g，熟地黄 30g，女贞子 20g，益智仁 20g，远志 12g，石菖蒲 12g，龟板 30g，鹿角胶 20g，何首乌 15g，枸杞子 20g。

适应症：老年性痴呆。

用法用量：龟板打碎先煎，鹿角胶烊化冲服，每日 1 剂，水煎服。随症化裁，连续治疗 2 个月。

资料来源：陈运明，广西中医药，1997；20 (2)：28。

⑪呆聪汤

组成：人参、水蛭、何首乌、葛根、黄芪、知母、锁阳、生地黄、川芎、淫羊藿、菟丝子等。

适应症：老年痴呆。

用法用量：先将人参、水蛭粉碎过筛装入大号胶囊（每料 0.5g），每次 4 粒，早晚各 1 次，其余药物以冷水 800ml 浸泡 2 小时，然后以文火连煎 3 遍，合计 400ml，早晚 2 次分服。每日 1 剂，每周 5 剂，休息 2 天，服药 40 剂（8 周）观察疗程。

资料来源：阎乐法，山东中医杂志，1997；16 (11)：499。

三、单方验方

(一) 甘草 10g，小麦 30g，红枣 15 枚，煎服。治老年期痴呆，精神恍惚、悲伤欲哭、睡眠不安、烦躁等。（尚焱昌，疑难病证名验方辑要，华艺出版社，1990）

(二) 生大黄 6g，决明子 12g。水煎或泡服。

(三) 丹参 30g，桃仁 10g，红花 6g。煎服。

元素 Zn、Cu 均下降，Zn/Cu 增高。瞬时记忆力、记忆广度显著增进。肺功能改善。维生素 E 组则 LPO、头发微量元素和记忆力与寿桃丸组相似，余项无明显改变。

方义解释：本方为宫廷秘方。主要药物益智仁补肾温阳，增智延年；枸杞、生地、天冬补肾填精；当归养血活血。综合言之，本方主要功用为补肾温阳、活血荣元，从而达到健脑作用。

药理研究：寿桃丸不同剂量组均能延长鹤鹑的平均寿命，作用与维生素 E 相似。且寿桃丸具有明显的清除超氧自由基和羟自由基作用，并具有多种单味药协同作用。

五、饮食疗法

宜常吃核桃仁、花生仁、芝麻、蜂王浆、花粉一类补肾健脑、抗衰老的食物；也宜常吃既降血脂又降血糖的食物，如大蒜、洋葱、山楂、蘑菇、绿豆等。饮食不宜过饱，经常饱食的老年人易患本病。长期大量饮酒会直接损伤脑细胞，形成脑萎缩而成本病，故宜戒酒。间断以生大黄或决明子泡水饮服，保持大便通畅对改善或预防本病有益。

药膳也有一定作用：

(一) 白首乌片 30g，红枣 10 枚，大麦片 200g，熬成药粥，每日 1 次（樊莛验方）。

(二) 百合 30g，黑木耳 15g，煮熟常服（樊莛验方）。

(三) 河鱼（草鱼）1 条，姜 3 片、葱白 1 根，煮汤，不拘时服（樊莛验方）。

(四) 羊脑 1 副，龙眼肉 15g，炖熟吃，每周 1~2 次（《穷乡便方》）。

(五) 黑母鸡 1 只，蛇 1 条，去杂洗净，炖烂吃，常服（市售某营养液主要配方）。

(六) 核桃仁 15~30g，每日生吃，不拘时间。（叶橘泉，食

重复而荒谬，有时久久面壁而立，不言不动，有时则傻笑不能自制，饮食不知饥饱。原会弹琵琶，现在连“上海”二字也不知何意，并出现向人讨债等荒谬行为。诊见患者面部表情淡漠，行动语言迟钝，偶吐少量涎沫，面颊虚浮无华，脉濡缓，舌淡胖，苔薄白腻，经云：“重阴者癫”。忧愁思虑损伤心脾，心脾不足则气血生化无源，心失所养，而神明之机不健，虽有吐涎沫，痰湿决非主因。治病求本，当予解郁理气，斡旋中焦气机以生气血。处方：炙黄芪 12g，当归 9g，陈皮 6g，白术 9g，茯苓 9g，佛手花 6g，厚朴花 6g，广木香 9g，淡干姜 3g，丹参 12g，石菖蒲 9g，越鞠丸 9g（包煎），姜竹茹 9g。

服 7 剂无效。追问病史，患者多年来怕冷，且有多尿、滑精等症。此为肾阳不足，脾失温煦，湿从内生。法当温肾以健脾，所谓“离照当空而阴霾自散”也。处方：炙黄芪 12g，党参 12g，黑附块 12g，淡干姜 3g，白术 9g，石菖蒲 9g，陈皮 6g，姜半夏 9g，益智仁 12g，淮山药 12g，越鞠丸 12g（包煎）。

连服 10 剂，诸症明显好转，家属要求以丸代汤。即用附桂八味丸、人参健脾丸、越鞠丸等交替服用，每日 12g，都用丹参、石菖蒲代茶吞服。半年后语言行动一如常人，未再复发。（史宇广等，当代名医临证精华·癫痫狂专辑，北京：中医古籍出版社，1992：85~86）

七、现代报道

（一）老年期痴呆是由多种因素所形成的肾虚和痰瘀所致，肾虚是本，痰浊、瘀血为标。肾与大脑关系密切，《内经》云：“脑为髓之海”，肾主骨生髓，故肾气通于脑。肾虚患者多有脑功能减退，运用补肾法，可使脑功能得到改善。有学者以实验证实，补肾中药是通过调节“脑-垂体轴”而发挥治疗作用；对大脑发育不全的患儿，采用补肾法，可促使大脑发育，故补肾可以

补脑。既然补肾能补脑，肾虚则可致脑萎缩（老年性痴呆之脑萎缩，脑重减少 20%～30%，脑细胞减少可达 35%～45%；脑血管性痴呆也有脑实质的破坏、脑细胞的减少）。老年期痴呆是人体衰老在大脑方面的表现，肾虚又是引起衰老的主要原因，所以老年痴呆的病理中心是肾虚，补肾是重要治法之一（傅仁杰，中医杂志，1991；（2）：56。陈克忠，中西医结合杂志，1986 年特集 134～138）。

（二）老年期痴呆病程漫长，有长达 10 余年者。因此不可能一方到底，应据不同病情及其变化，耐心调治。据国外统计，阿尔采默病占不可逆痴呆的 80%，老年期痴呆有一部分是难以治愈的，明医家张景岳也认为“此证有可愈者，有不可愈者”。因此宜力争早期诊断早期治疗。如对中老年人或未老先衰者出现脑功能减退者即予补肾健脑治疗，会较病成之后治疗效果要显著，治疗也容易。因安眠镇静西药易诱发痴呆，故老年人宜慎用，这对预防本病也是有益的（何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991）。

八、主要参考资料

1. 何绍奇，现代中医内科学，北京：中国医药科技出版社，1991：497～500
2. 傅仁杰，中医杂志，1991；（2）：56
3. 陈可冀，抗衰老中药学，北京：中医古籍出版社，1989：28～34
4. 袁应坚等，中风·痴呆病的初步研究，全国首届中医脑病学术研讨会（北京）资料，1991
5. 黄泰康等，中药方剂现代研究大典，科学出版社，1996

偏 头 痛

偏头痛是一种反复发作的、主要由于神经元特别是下丘脑神经元功能失调而导致的血管舒缩紊乱性头痛。具有如下特征：每次发作的性质和过程基本相似，头痛位于一侧或双侧，伴有恶心、呕吐，或畏光、畏声、脸色苍白等症状，头痛持续4~72小时（未经治疗或治疗不力），中等到严重程度，头痛前可伴有视觉改变等先兆；间歇期基本正常，约半数患者有家族史。患病率国外为5%~10%，国内则0.6%~1.1%；本病约占所有头痛的1/4强，为神经内科主要病种之一。通常在青春期前后起病，历时长达数年甚至几十年，因而是一种常见而独特、顽固的疾病。

中医古籍对本病多有记载，《黄帝内经》有云：“人有病头痛以数岁不已……脑逆故令头痛。”《伤寒论》云：“干呕吐涎沫，头痛。”《三因极一病证方论》之头痛“上连风府眉角而痛”等均对此而言。病相当于中医历代文献中的“偏头痛”、“偏头风”、“额角上痛”、“头半边痛”、“头角痛”，但内容更为广泛，也包括中医所说的“正头痛”、“头风”、“脑风”等。

一、病因病机

本病多有遗传倾向，常于青春发育之时起病，乃提示素禀脑气不充，更加之气血不足，或肾元亏损，以及情志过激、劳作太过、风邪外袭或房室不节乃成其病。

（一）情志过激 患者具有一定的个性特征，如焦虑倾向和

易于忧虑、做事刻板、责任心过强和完美主义倾向，这使得他们比普通人更易发生情绪的波折。据观察，偏头痛发作大约有56%~72%是由于情绪紊乱所激发。情怀不畅，肝郁气结，郁而化火；或煽动肝阳，上亢化风，夹痰邪扰动清空，脑络气血瘀滞，不通则痛。“风气通于肝”，所以头风与肝的疏泄紊乱密切相关。

(二) 劳作太过 思虑用脑或体力疲劳，耗气伤阴。气虚则血滞，阴虚则阳亢，肝阳夹风兼夹血滞、痰饮为患，亦发为头痛。所谓“阳气者，烦劳则张”是也。“头痛巅疾，下虚上实”。

(三) 风邪外袭 风邪善行数变，极易上犯。约半数患者于气交之际发病，与风邪扰动相关。风邪袭表，客于头之络脉，营卫不和，血行郁滞，不通则痛。《素问》云：“风气循风府而上，则为脑风。”“新沐中风，则为首风。”《普济方》则说：“风邪伤于阳经，入于脑中，则令人头痛也。又有手三阳之脉，受风寒伏留而不去者名曰厥头痛。”

(四) 素体亏虚 素禀气血不足、肾元亏虚，加之不知颐养，耗伤太过，诸如房室不节、月事过多，均可使脑失奉养而发为头痛。所谓良性性交头痛，其发生率达0.2%~1.3%，与房事不节相关。另外，脾胃不和，内生痰湿，亦为发病重要因素之一。《医宗必读》：“气虚痛者，恶劳动，其脉大；血虚痛者，善惊惕，其脉芤。”《石室秘录》云：“夫脑痛者，因脑阴之虚，风得留之而不去。”故素体亏虚是本病发病之基础。

总之，偏头痛病位在脑，涉及肝、脾、肾等多个脏腑，肝郁化火、肝阳化风、风邪外袭、气血亏虚和肾元亏损、脑阴不足为本病的主要病理机转；而气滞、痰邪、瘀血阻滞清窍，脑络失畅，不通则痛为本病的具体表现。本病以内伤为主，外感风邪多为诱发因素，不伴发热，与热性头痛不同；亦不包括高血压病头痛，肝阳头痛在本病中不占主要地位；也不包括脑外伤所致的头

痛，创伤性病因在本病发病环节中不占比重。

二、辨证施治

(一) 辨证要点

1. 辨偏头痛之属外感或内伤 虽然偏头痛病因掺杂，见症繁多，病以内伤为主。但一般而言，因于外感者，常于气候骤变时发病，或于冬春，或于夏秋，或于阴雨之时，或栉风沐雨，伴有明显恶风（或畏寒、流涕），均有因可寻；因于内伤者，或因抑郁烦扰，或过于思虑，或远足疲惫、体力消耗，或房事太密、月事不调，亦有因可稽。气虚者脉大，血虚者面白，肾亏者腰膝酸软，肝阳者筋惕肢麻，气郁者胸胁胀满，痰浊者恶心头眩，瘀血者痛有定处、如锥如刺。本病多有兼证，临床当视何者为主治之。

2. 辨头痛所属经络：头为诸阳之会 手足三阳经均循头面，厥阴经亦上会于巅项。由于脏腑经络受邪之不同，头痛的部位各异，大抵太阳头痛，多在头之后部，下连于项；阳明头痛，多在前额部及眉棱等处；少阳头痛，多在头之两侧，并连及耳部；厥阴头痛，则在巅项部位、或连于目系。循经用药，亦是治疗的重要一环。

(二) 辨证分型

1. 瘀血阻滞型

头痛经久不愈，痛处固定不移，如锥如刺，甚则头痛如劈；或头之一侧可扪及暴起之经脉，头痛时面暗唇紫；舌有瘀斑、紫点，脉细或细涩；妇女常有痛经，经血中夹有血块。

2. 痰浊内蕴型

头痛昏蒙，思维迟钝，胸脘痞闷，纳呆呕恶，或吐痰涎。舌苔白腻或水滑，脉弦滑，亦可见脉濡；多见于肥胖之人。

3. 肝郁化火型

部痛用川芎、柴胡，前额头痛用白芷，眉棱骨痛用蔓荆子，巅顶痛用吴茱萸，因风而头痛且以巅顶为主者用藁本，满头痛用羌活、防风，头痛连及项背者用葛根。凡兼有大便不通、阳明腑实者，均宜选用适当的药物通腑，对于平息偏头痛的发作十分有益。

1. 分型治疗

(1) 瘀血阻滞型 活血化瘀，通窍止痛。通窍活血汤加减：桃仁 10g，红花 6~10g，川芎 15~30g，赤芍 15~30g，当归 10g，郁金 10g，葱白 10g，生姜 3g。有条件者可入麝香少许与药汁同服。痛甚加全蝎、蜈蚣、地龙通络止痛；夹寒可加细辛、桂枝温经止痛。

(2) 痰浊内蕴型 化痰降逆，通阳定痛。半夏白术天麻汤为主：炒白术 15g，天麻 6~10g，姜半夏 10g，陈皮 6g，茯苓 15g，枳实 6g。夹风者加白蒺藜、蔓荆子祛风止痛；夹热者加川连、竹茹、黄芩清化痰热；夹寒者加吴茱萸、生姜温阳止痛。

(3) 肝郁化火型 清肝解郁。丹栀逍遥散出入：柴胡 6g，赤白芍各 15g，青陈皮各 6g，郁金 10g，黄芩 10g，山栀子 6g，丹皮 10g，白术 6g，白蒺藜 12g。肝阳化风明显者，酌加桑叶、龙胆草、天麻、钩藤、石决明、磁石清肝息风；大便偏干可加入决明子、生大黄、芒硝通腑泄热。

(4) 外感风邪型 疏风和络，调和营卫。川芎茶调散增删：绿茶 10~30g，川芎 30g，羌活、荆芥、防风、细辛、薄荷各 6g，白芷 15g。偏寒者可加麻黄、桂枝、生姜发汗解表；偏热者加菊花、生石膏、苦丁茶疏风清热；偏湿者可用藁本、川朴、藿梗化湿解表，或苡仁、淡竹叶、六一散渗湿于下。

(5) 气血不足型 两益气血，上荣脑髓。八珍汤加减：党参 12g，黄芪 15g，炒白术 10g，茯苓 10g，当归 10g，川芎 15g，白芍 12g，熟地黄 10g。偏于气虚者尚可加炙升麻、柴胡以助补气升清；偏于血虚则宜详查失血之因，加用塞流之品；然后加阿

胶、艾叶补血。

(6) 肾虚脑弱型 补肾填精，益脑缓痛。大补元煎出入：熟地黄 15g，淮山药 12g，山萸肉 10g，枸杞子 10g，人参 3g，当归 12g，杜仲 12g。偏肾阴虚者，宜合女贞子、墨旱莲、白芍、龟板；偏肾阳虚者，可用巴戟天、仙灵脾、附子、肉桂。

2. 方药选介

①救脑汤

组成：辛夷 9g，川芎 30g，细辛 3g，当归 30g，蔓荆子 6g。

适应症：头痛连脑，双目赤红，如破如裂。

用法用量：每日 1 剂，水煎取汁，分早晚服。

临床应用：本方自清代至今备受医家推崇，临床奏效较捷，近年王育辉氏以之治疗偏头痛取得佳效。

使用注意：本方以辛散药为主，剂量偏大，体虚者宜慎用；对胃有一定刺激性，可在饭后服用。

药理研究：方中川芎、当归等可显著降低血小板聚集率，并减少其分泌反应，从而抑制 5-HT，减缓和控制偏头痛发作。

资料来源：王育辉，云南中医杂志，1983；4（2）：15。

②桃红四物汤

组成：熟地黄、白芍药、当归、川芎、桃仁、红花。

适应症：瘀血腰痛；妇人月经来时，血多有块，色紫粘稠，内有瘀血者；近年用于瘀血头痛。

用法用量：配剂量后每日 1 剂，水煎取汤液分服。

临床应用：陈宝田认为慢性头痛（大多为偏头痛）的共同病因是风、瘀血和血虚，以疏风活血养血为治疗大法，临床上分 5 型论治，均以桃红四物汤加味：风寒型合麻黄附子细辛汤；风热型加黄芩、生石膏、防风、白芷；痰湿型合二陈汤；肝肾阴虚型合杞菊地黄汤；瘀血型加鸡血藤、羌独活、白芷等。在已报告的 147 例中，治愈 65 例，显效 53 例，显效以上共 118 例，占

80.3%，好转 19 例，总有效率 93.2%。在大样本辨证分型的基础上，陈氏又创制具有消风、散瘀、祛湿、速止头痛作用的正天丸。由川芎、当归、白芍、生地、桃仁、红花、防风、羌活、独活、细辛、钩藤、白芷、泽泻、附子等组成，经广州中医学院等 4 家科研、医疗单位 350 例的临床验证，其治愈率达 33%，总有效率 98%，疗效显著优于天麻对照组。

使用注意：本方为活血药组成，月经量多者慎用；本方及衍生方正天丸均对胃粘膜有刺激作用，脾胃虚弱者慎服。

药理研究：多数活血药物均具有抑制血小板聚集的作用，可降低血浆中 5-HT 含量，从而阻抑偏头痛的发生。以本方为主的正天丸尚具有镇痛、镇静作用，可扩张脑血管、增加脑血流量，改善微循环及降低血压；分子生物学研究揭示其能够促进心、肾、胸腺、肾上腺等核糖核酸的合成。本方对脑血管舒张和收缩具有双向调节作用。

资料来源：王永炎等，北京中医学院学报，1992；15（1）：5。

③血府逐瘀汤

组成：当归、生地各 9g，桃仁 12g，红花 9g，枳壳、赤芍各 6g，柴胡 3g，甘草 3g，桔梗 4.5g，川芎 4.5g，牛膝 10g。

适应症：上焦瘀血，头痛胸痛，胸闷呃逆，失眠不寐，心悸怔忡，瘀血发热，舌质暗红，边有瘀斑或暗点，唇暗或两目暗黑，脉涩或弦紧；妇人血瘀经闭不行，痛经，肌肤甲错，日晡潮热；以及眼科云雾移睛。青盲等目疾。现用于高血压、精神分裂症、脑震荡后遗症、性功能低下、更年期综合征、顽固性头痛等属于瘀血内阻，日久不愈者。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，两次分服。

临床应用：血府逐瘀汤治疗偏头痛临床应用很多。郭士彬、吴启富等用本方治疗 226 例，基本治愈 97 例，显效 90 例，有效

72 例（内蒙古中医药，1987；6（3）：12，中级医刊，1990；25（1）：56）刘选清报道以本方治疗 55 例，痊愈 38 例，好转 15 例，无效 2 例（陕西中医，1983；4（2）：11），可见治疗效果是令人满意的。

使用注意：月经量多者慎用。

药理研究：1）改善微循环，抗休克：对微循环作用的观察表明，消化道给药后，能显著改善由高分子右旋糖酐造成的大鼠急性微循环障碍，并可防止由于微循环紊乱而致的血压急剧下降。证明有活血化瘀，改善微循环，增加组织器官血流灌注量的效应（中成药研究，1988；（7）：29）。2）凝血作用与抗凝作用：本方静脉制剂在试管内有缩短复钙时间、凝血酶原和凝血酶凝固时间；对血小板有解聚作用，并能复活肝脏清除能力（浙江中医杂志，1981；（10）：428）。

资料来源：王清任《医林改错》卷上

④罗止园偏头痛方

组成：菊花 9g，霜桑叶 9g，黄芩 6g，薄荷 6g，苦丁茶 7.5g，连翘 12g，夏枯草 12g，藁本 6g，白芷 6g，荷叶边半个，鲜茅根 12g。

适应症：急性偏头痛和三叉神经痛，发作时一侧头痛剧烈，太阳穴有热感，舌质红，脉浮数。肝经风火上攻诸阳之会。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：本方治疗受热或热病后发生的偏头痛较合适，当代名医岳美中对本方推崇备至，临床经验丰富，今人亦有淑其道者（《岳美中医案集》）。

使用注意：脾虚胃弱者慎服。

药理研究：菊花、白芷有抗血小板聚集作用，连翘有一定镇痛作用。

资料来源：《止园医话》

⑤谈野翁方

组成：白芷 30g，川芎、川乌、甘草各 15g。

适应症：偏头痛发作期。

用法用量：混合均匀，取 1 半炒黄，与另 1 半生者分别轧细，各过 90~120 目筛，然后和匀并分成 10 包。每日 2 次，每次 1 包，痛甚则临时加服，24 小时内不得超过 4 包。以茶叶、薄荷各 3g，水 200ml 煮沸取汁送下。发作频繁者，痛止后继续服本方 1 周。

临床应用：李正东以本方治疗偏头痛 130 例，治愈 84 例，占 64.6%，显著好转 25 例，占 19.2%，好转 21 例，占 16.2%，近期疗效较好。

使用注意：服药期间宜忌劳累过度、气恼以及烟、酒刺激食物。阴虚火旺体质者慎用。

药理研究：川芎、白芷可抑制血小板聚集，减低血液中 5-HT 含量，控制偏头痛发作；川乌有一定镇痛作用。

资料来源：李正东，浙江中医杂志，1983；(6)：252。

⑥川芎茶调散

组成：薄荷叶（不见火）240g，川芎、荆芥（去梗）各 120g，香附子（炒）250g（别本作细辛去芦 30g），防风（去芦）45g，白芷、羌活、甘草（炙）各 60g。

适应症：风邪头痛，或偏或正，或巅顶作痛，作止无时，或见恶寒，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮者。

用法用量：上药研为细末，每服 6g，食后用茶清调下。

临床应用：本方可通治各经头痛，临床上视头痛所在经络，可加重归本经药量。如川芎善治少阳经头痛（头顶两侧痛），羌活善治太阳经头痛（后脑、前额痛），白芷善治阳明经头痛（眉棱、额骨痛）。可灵活用之。

使用注意：本方主要用于风寒偏甚之头痛，风热著者宜加菊

花、连翘。

药理研究：川芎、羌活、白芷可对抗血小板聚集造成的 5-HT 释放增加，阻抑偏头痛的发作，细辛有镇痛作用。

资料来源：《太平惠民和剂局方》卷二

⑦川芎散

组成：川芎、细辛、羌活、槐花、石膏、香附子、炙甘草各 15g，荆芥、薄荷、茵陈、防风（去叉）、菊花各 30g。

适应症：偏正头疼。

用法用量：上 12 味，为末。每服 6g，食后用茶清调下，1 日 3 次。

临床应用：本方疏风、清热、止痛，多用于偏头痛之属风热型者，根据各部位头痛可加用引经之品，如前额痛可加白芷，巅顶痛加吴萸，后枕及项痛加葛根，两颞痛加柴胡，可增强疗效。

使用注意：服药期间，忌食动风发物。

药理研究：川芎、羌活、菊花可抗血小板聚集，抑止偏头痛。细辛有镇痛作用。

资料来源：《卫生宝鉴》卷九

⑧本事方川芎散

组成：川芎（洗）、柴胡（去苗）各 30g，半夏曲、炙甘草、甘菊、细辛（去叶）、人参（去芦）、前胡（去苗，洗）、防风（去叉股）各 15g。

适应症：偏头痛肝胃不和、兼风热上壅。

用法用量：为粗末，每服 12g，用水 150ml，加生姜 4 片。薄荷 5 叶（3g），同煎至 100ml，去渣温服。

临床应用：现今临床治疗偏头痛属肝胃不和、风热上壅，一般均去前胡、人参，而可酌加川连、吴萸、桑叶、白蒺藜。

使用注意：服药期间，宜注意情志调摄；并忌食生、冷、油腻之品。

臑。

资料来源：张仲景《伤寒论》

⑪调中益气汤

组成：黄芪 3g，人参（去芦头，有嗽者去之）、甘草、苍术各 1.5g，柴胡、橘皮（如腹中气不得运转，更加 3g）、升麻各 0.6g，木香 0.3~0.6g。

适应症：肠胃虚弱，湿阻气滞，脘腹胀满，不思饮食，身体倦怠，大便泄泻，肢节烦疼者，亦用于气虚之偏头痛。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分用。

临床应用：偏头痛之发作，气血不足为本，气虚为主者可用本方治疗。李永才以本方治疗 36 例。治愈率为 77.8%。

使用注意：体实者本方不宜；服药期间宜忌生冷油腻之食品。

资料来源：李永才，吉林中医药，1986；（5）：1。

⑫羌活胜湿汤

组成：羌活、独活各 3g，藁本、防风、甘草（炙）、川芎各 1.5g，蔓荆子 0.9g。

适应症：风湿在表，头痛项强，腰背重痛，身尽痛，难以转侧，恶寒发热，脉浮。

用法用量：上药咬咀，都作 1 服。用水 300ml，煎至 150ml，去滓，食后大温服。

临床应用：头痛甚时川芎量宜加大至 15~30g；湿甚加白术 10g、防己 6~10g；风甚加白芷 10g、羌活加至 6~10g。

使用注意：体虚多汗宜加生黄芪固表。

资料来源：李杲《内外伤辨》卷中

⑬天麻钩藤饮

组成：天麻 9g，钩藤（后下）12g，生石决明（先煎）18g，山栀 9g，黄芩 9g，川牛膝 12g，杜仲 9g，益母草 9g，桑寄生

9g, 夜交藤 9g, 朱茯神 9g。

适应症：肝经有热，肝阳偏亢，头胀头痛，耳鸣目眩，少寐多梦；或半身不遂，口眼喎斜，舌红，脉弦数。现也有用于高血压病，偏头痛。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：本方亦偏头痛临床最常用方之一，可加各经头痛之引经药，如少阳经用柴胡、川芎，太阳经用羌活、葛根，阳明经用白芷，厥阴经用吴茱萸；头痛甚者可加玄胡索以活血定痛。

使用注意：肝阳不旺者不宜用之。

药理研究：对正常及高血压狗条件反射及血压的影响：本方 200% 水煎剂，在每条犬每日 80ml，给药 10～22 日的剂量下，对高级神经活动处于正常状态的犬，不发生影响；但当高级神经活动发生障碍时，有一定的调整作用；对正常犬没有降压作用，对高血压犬有一定的降压效果。从实验结果看来，天麻钩藤饮既有降压作用，又有调节高级神经活动的作用（中医药研究参考 1975；(9)：25～26）。偏头痛无论发作期或间歇期，都存在着一定的高级神经活动的功能紊乱，本方治之有一定效果。

资料来源：《杂病证治新义》

⑭镇肝息风汤

组成：怀牛膝 30g，生赭石 30g（轧细），生龙骨 15g（捣碎），生牡蛎 15g（捣碎），生龟板（捣碎）15g，生杭芍 15g，玄参 15g，天冬 15g，川楝子 6g（捣碎），生麦芽 6g，茵陈 6g，甘草 4.5g。

适应症：肝阳上亢，肝风内动，头目眩晕，或脑中时常作疼发热，或目胀耳鸣，或心中烦热，或时常噎气，或类中风偏枯。亦用于偏头痛。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：彭敏以本方治疗偏头痛，按随机原则，分为治疗

组 70 例，口服汤药，每日 1 剂，浓煎分 3 次服；对照组 62 例，口服阿斯匹林、苯巴比妥、谷维素，每日 3 次。两组均以 15 天为 1 疗程，治疗期间停用其它药物。治疗结果：治疗组近期治愈 23 例，占 32.9%，有效 41 例，总有效率 91.4%；对照组治愈 6 例，占 9.7%，有效 49 例，总有效率为 88.7%。两组治疗疗效有显著差异。

资料来源：《医学衷中参西录》

⑮清震汤

组成：黄芩 2.4g，防风 1.8g，羌活 1.2g，甘草 0.6g，川芎 1.8g，蔓荆子 1.8g，当归、荆芥各 2.4g，半夏、柴胡、天麻各 2.1g，细辛、独活、白芷、藁本各 0.9g，石膏 3g。

适应症：正头痛。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：本方剂量较小，宜据偏头痛部位或归属经络，加重归某经（或部位）之药，如太阳经（后头部及项枕部）重用羌活；阳明经（前额及眉棱骨部）宜重用白芷；少阳经（两侧头部）宜重用川芎、柴胡；厥阴经（头顶部）宜加用吴萸，并重用藁本。

使用注意：脾胃虚弱者饭后服之，忌外出冒风沐雨。

药理研究：川芎、当归等有一定抗血小板聚集作用，抑制 5-HT 释放，达到减抑偏头痛的作用。

资料来源：《嵩崖尊生》卷六

⑯麻黄附子细辛汤

组成：麻黄 6g（去节），细辛 3g，炮附子 3g。

适应症：素体阳虚，外感风寒，畏寒无汗，鼻塞头痛，苔白，脉细。

用法用量：上 3 味，用水 600ml，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取 300ml，去滓，分 2 次温服。

热，火动风生，风火上扰清窍所致。以头痛Ⅱ号方治疗45例，结果治愈27例，显效5例，显效以上共32例，占71%；随访半年至6年，远期疗效为痊愈17例，显效12例，显效以上共29例，占64.4%。

使用注意：忌食生冷油腻之品。

资料来源：王池卿，中级医刊，1981；10：25。

②平肝解痉汤

组成：川芎、桑叶、菊花、磁石、石决明、代赭石、白芍、白芷、牛膝、柴胡、神曲。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：汪文强认为本病多由情志失和，肝失条达，郁而化火，肝风内动，或木火伤阴，肝失濡养，或肾水不足，水不涵木，肝阳上亢，导致气血逆乱，瘀阻脑络，上扰清空而发病。以本方随症加减，治疗偏头痛162例，痊愈65例，占40.1%，好转87例，总有效率为93.8%。

使用注意：服用本方时宜注意情态调摄，不宜冒风沐雨。

资料来源：汪文强，实用中西医结合杂志，1991；（8）：470。

②芎牛汤

组成：川芎30g，牛膝60g，羌蔚子15g，制香附10g，滁菊花10g，桂枝6g，生甘草6g，双钩藤15g（后下）。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：姚意才根据北京中医学院董建华教授的经验，即川芎、牛膝药对治疗血管神经性头痛，剂量通常是1：2，可通上达下，调和升降，平肝祛风、通络止痛。经加味后组成本方，治疗偏头痛31例，结果近期治愈13例，好转16例，认为对典

型偏头痛者疗效较好，普通偏头痛疗效稍差。

使用注意：月经多者慎用。

资料来源：姚意才，中医杂志，1985；(1)：59。

②养血平肝汤

组成：当归、白芍、川芎、生地、旋复花、代赭石、木瓜、香附、生石膏、生甘草。

适应症：内伤头痛。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：关幼波认为内伤头痛常虚实夹杂，气郁血虚、阴方痰瘀交错。其病机主要是虚、滞、痰、瘀。本方对血管性头痛尤其效果良好。

使用注意：不宜过食生冷、油腻之品。

资料来源：关幼波等，广西中医药，1981；(4)：9。

④乔氏加味川芎散

组成：川芎30g，石兰20g，菊花10g，僵蚕15g，柴胡10g，钩藤20g，夜交藤18g，白芷10g。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服，10天为1疗程，最长2疗程。

临床应用：乔玉槐以许凌《东医宝鉴》之川芎散加味而成本方。以之治疗偏头痛78例，结果显效26例，有效45例，总有效率为91.03%，而对照组25例，以心得安20mg，1日3次，治疗20天，无显效病例，仅有效9例，总有效率仅36%，两组有效率之比有非常显著的差异($P < 0.001$)。治疗组39例脑血流图异常者治后15例恢复正常，而对照组8例脑血流图异常者无1例恢复正常。

使用注意：月经量多者慎用；脾胃虚弱者宜饭后服。

资料来源：乔玉槐等，中西医结合杂志，1990；10(4)：

235。

㊟化瘀止痛汤

组成：当归、桃仁、红花、丹参、川芎、细辛、白芷、藁本、蜈蚣、龙骨、牡蛎、黄芪、生地。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：朴志贤等认为头痛终因久病邪气入络，气血运行不畅，脉络瘀阻所致，治以上法较为合适。经1~4周连续观察，所治97例中，临床治愈37例，显效25例，显效以上共62例，占63.5%，好转29例，无效6例，总有效率93.8%。作者报告本方止痛效果迅速，在91例有效病例中连续服用6剂药见效者58例，占有效病例的63.7%。多数病例在10剂内获效。

使用注意：月经量多者慎服。

资料来源：朴志贤等，吉林中医药，1991；(5)：14。

㊟复方地甲猬虫汤

组成：地龙15g，穿山甲21g，刺猬皮、地鳖虫、九香虫各18g，蜣螂虫24g，虻虫15g，蝉蜕18g，露蜂房12g，僵蚕24g，当归30g，川芎18g，鸡血藤24g，木香18g，青皮15g。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：高文武以本方治疗偏头痛240例，218例（占90.8%）基本治愈，好转12例，无效10例，总有效率95.8%。随访1~3年，仅24例复发，若按1年不复发为治愈，其实际治愈率也在80%以上。药重279g，量大药猛，不同一般。

使用注意：脾胃虚弱者及月经量多者本方不宜。

资料来源：高文武，中西医结合杂志，1988；8（11）：653。

㊟头痛糖浆

组成：当归、白芍、川芎、熟地、夏枯草、钩藤、珍珠母、

鸡血藤、细辛、刺蒺藜、菊花、桑枝、秦艽。

适应症：偏头痛。

临床应用：李清渠等以本方加适量白糖及水 1000ml 煎煮，浓缩至 100ml，每次 50ml，日服两次。治疗 65 例，治愈 42 例，显效 9 例，显效以上共 51 例，占 78.5%，有效 9 例，无效 5 例，总有效率 91.1%。

使用注意：不宜过食生冷油腻之品。

资料来源：李清渠等，武汉医学，1983；7（1）：35。

⑳三生散

组成：生草乌、南星、生白附子、葱、姜适量。

适应症：头痛。

用法用量：打烂后取少许外敷头痛处。

临床应用：外敷时间宜掌握，一般不宜超过 4 小时，否则局部起泡。

使用注意：忌外出吹风。

资料来源：鄢生浩，四川中医，1988；6（8）：32。

㉑白石散

组成：白芷、川芎、生石膏各适量。

适应症：风热型偏头痛。

用法用量：研细末，外敷神阙穴。

临床应用：可与内服中药配合应用。

使用注意：勿食生冷之品。

资料来源：周永辉，浙江中医杂志，1990；25（5）198。

㉒头痛塞鼻散

组成：川芎、白芷、远志、冰片各适量。

适应症：偏头痛。

用法用量：研末塞鼻。

临床应用：可与内服方药配合应用，亦可独用。

使用注意：药物保存须密闭，若气泄则无效。

资料来源：吴震西，中医杂志，1982；(2)：68。

⑪复方羊角冲剂

组成：羊角、川芎、白芷、川乌。

适应症：偏头痛、紧张性头痛及神经痛。

用法用量：每次1袋(8g)，每日2~3次冲服。

临床应用：广泛用于各型偏头痛，止痛效果较好。

使用注意：忌生冷之品。

资料来源：山东省立医院编，实用药物手册，人民卫生出版社，1982。

⑫程氏蒸薰方

组成：川芎15g，晚蚕砂30g，僵蚕20~30只，香白芷15g。

适应症：头痛。

用法用量：将中药放入砂锅内，加水1000ml，煎至600ml，用厚纸将砂锅口糊封，并视头痛部位大小，盖纸中心开一孔，令患者将头痛部位对准该孔，全头痛者，头部对准砂锅口（两目紧闭或用手巾包扎），上面覆盖一块大方手巾罩住头部，以热药气熏蒸，每日1剂，每日两次，每次熏蒸10~15分钟。

临床应用：程爵棠以《张氏医通》外熏方加白芷创立本方。治疗头痛39例，痊愈29例，有效10例，有效率达100%，病程在数月至10年以上不等。

使用注意：偏于外感者加入葱、生姜各15g更好。

资料来源：程爵棠，浙江中医杂志，1981；19(9)：39。

⑬三生散

组成：生草乌、天南星、生白附子各30g，葱白7个生姜40g。

适应症：偏头痛。

用法用量：诸药研末调匀，用一层纱布包好，放入锅内隔水

蒸，热敷痛处，勿敷眼部。

临床应用：本组 43 例偏头痛中，男 12 例，女 31 例；年龄最小 19 岁，最大 42 岁；病程最短半年，最长 17 年。全部病例血压、头颈部、神经系统及眼底检查均正常。结果：24 小时内痛止者 40 例，2~3 天痛止者 3 例；随访 2 年内无复发者 31 例，占 72.1%。

资料来源：鄢声浩，三生散外治偏头痛 43 例，四川中医，1988；(8)：33。

④川芎汤

组成：川芎 30~60g，细辛 5~10g，蔓荆子 10~15g，葛根 10~15g。

适应症：偏头痛。

用法用量：每日 1 剂，水煎早晚分服。

临床应用：所治偏头痛 50 例中，男 10 例，女 40 例；年龄最小 4 岁，最大 70 岁；病程长者 15 年，短者 5 日；限于一侧者 29 例，双侧者 11 例，全头痛者 10 例。治疗结果：服药后头痛消失，脑血流图恢复正常者 44 例，病情好转者 5 例，无效者 1 例。治愈后 1 年内复发 1 次者 5 例，复发过 2 次者 3 例。复发者服用本方仍有效。

资料来源：王胜利，大剂量川芎治疗偏头痛 50 例，中医函授通讯，1993；(4)：44。

⑤川芎定痛饮

组成：川芎、钩藤、菊花、白蒺藜、苈苈仁、白蒺、半夏、赤芍、川牛膝。

适应症：偏头痛。

用法用量：本方重用川芎，每剂在 15g 以上。每日 1 剂，水煎服。头痛缓解再进 3~6 剂。若兼头晕目眩者加生石决明、珍珠母、生牡蛎；跳痛重，舌质紫而瘀斑多者加水蛭、鬼见羽、桃

⑦头风散

组成：白芷 75g，川芎 30g，炙川乌 30g，生甘草 30g，天麻 30g。

适应症：肌紧张性头痛。

用法用量：诸药研细，每次 3g，每日 2 次，1 个月为 1 疗程。兼肝火盛者以龙胆泻肝汤加石决明 30g 煎汤送服；胃火盛者玉女煎送服；肾阴亏虚者六味地黄汤送服。无明显兼证者以细茶一撮，薄荷 1.5g，泡水送服。

临床应用：所治肌紧张性头痛 50 例，男 22 例，女 28 例；年龄在 21～54 岁；病程 2～15 年。疗效标准：疼痛消失，1 年无复发者为治愈；疼痛减轻一半以上，疗效巩固 1 年以上者为好转；治疗后疼痛无减轻或反增加者为无效。结果：治愈 25 例（50%），好转 19 例（38%），无效 6 例（12%）。

资料来源：张家驹，头风散为主治疗肌紧张性头痛 50 例，中医杂志，1986；27（8）：580。

⑧头痛散

组成：天麻 12g，当归尾 12g，白菊花 12g，白芷 12g，川芎 12g，丹参 12g，红花 10g，桃仁 6g，生地 10g，茯苓 12g，白芍 12g，蔓荆子 12g。

适应症：偏头痛。

用法用量：每日 1 剂，水煎服。

临床应用：所治偏头痛 62 例中，男 28 例，女 34 例；年龄 14～67 岁。结果：痊愈且追踪 1 年半无复发 24 例，显效 28 例，有效 10 例。

资料来源：陈维国，头痛散治疗偏头痛 62 例，四川中医，1986；4（9）：41

⑨头痛煎

组成：川芎 15g，羌活 12g，细辛 3g，白芷 15g，赤芍 15g，

元胡 10g, 三七粉 6g。

适应症：血管性头痛。

用法用量：水煎服，每日 1 剂（冲服）。如风热加桑叶、薄荷；痰湿重加半夏、桔梗、竹茹；肝旺加天麻、钩藤、菊花。

临床应用：所治血管性头痛 51 例，男 18 例，女 33 例；年龄 15~66 岁。疗效标准：缓解：头痛发作消失，数周或数月未犯；好转：头痛发作程度减轻，频率减少；无效：头痛发作未减少。结果：缓解 12 例，好转 38 例，无效 1 例；总有效率为 98%。

资料来源：徐启刚等，头痛煎剂治疗血管性头痛 51 例分析，中医杂志，1986；27（2）：114。

④ 加味血府逐瘀汤

组成：当归、生地、桃仁、红花、枳壳、柴胡、川芎、牛膝、桔梗、细辛、桂枝、黄芪。

适应症：偏头痛。

用法用量：前额痛甚加白芷，后枕痛甚者加羌活，头顶痛甚者加藁本。每日 1 剂，水煎 300ml，分早、晚 2 次分服。连续服药 20~30 剂。

临床应用：治疗偏头痛 57 例中，男 21 例，女 36 例；就诊年龄 17~53 岁，发病年龄 7~45 岁；病程 2~27 年。疗效标准：基本控制：自服药始观察期限已超过治疗前最长间歇期 10 倍以上，在整个观察期内头痛未再发作或偶有轻微发作，但不影响工作。显效：自服药始观察期限已超过治疗前最长间歇期 5 倍以上或偶有轻微发作，但不影响工作，或观察期已超过治疗前最长间歇期的 10 倍以上，发作时头痛明显减轻，时间缩短，呕吐症状消失，发作次数减少 50% 以上。有效：服药期间及停药后，发作次数减少或头痛减轻，时间缩短，恶心呕吐症状减轻或消失。无效：症状无改善或仅在服药期间症状稍有改善。结果：基本控

制 21 例 (36.8%), 显效 23 例 (40.4%), 有效 5 例 (8.8%), 无效 8 例 (14.1%), 总有效率为 85.9%。开始出现疗效的服药剂数为 3~20 剂, 平均服药 7 剂时出现疗效。共服药最少者 7 剂, 最多者 60 剂, 未发现毒副作用, 有效患者的观察期均为最长间歇期的 5~10 倍, 平均 12 个月零 8 天。

资料来源: 吴启富, 加味血府逐瘀汤治疗偏头痛 57 例的疗效分析, 中级医刊, 1990; 25 (1): 56。

④加减散

组成: 柴胡 10g, 黄芩 10~15g, 川芎 15~30g, 白芷 10~15g, 赤、白芍各 15~30g, 薄荷 30~50g (后下), 全蝎 3~6g, 僵蚕 10g, 牛膝 30~60g, 细辛 3~10g, 生甘草 6g。

适应症: 偏头痛。

用法用量: 水煎服, 每日 1 剂, 半月为 1 疗程, 治疗期间停用其他药物。

临床应用: 治疗偏头痛 60 例, 均为门诊患者, 男 6 例, 女 54 例; 年龄 21~57 岁; 病程 1 个月至 27 年; 本组患者均有典型的单侧或双侧偏头痛症状, 并经检查后排除脑外伤、肿瘤、高血压、动脉炎、鼻窦炎等疾患。结果: 治愈 (症状消失, 脑血流图基本正常, 随访半年未复发) 25 例; 显效 (头痛明显减轻, 脑血流图好转, 随访半年病情稳定) 18 例; 好转 (头痛减轻, 发作次数减少) 13 例; 总有效率为 93.4%。服药期间均无不良反应。

资料来源: 牛兴东, 加减散治疗偏头痛 60 例疗效观察, 内蒙古中医药, 1992; 11 (4): 8。

④芎牛汤

组成: 川芎 30g, 牛膝 60g, 羌活 15g, 制香附 10g, 滁菊花 10g, 桂枝 6g, 生甘草 6g, 双钩藤 15g (后下)。

适应症: 偏头痛。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：共治偏头痛 31 例，结果：近期治愈（服 12 剂头痛停止）共 13 例，好转（12 剂内头痛缓解）16 例，无效 2 例。

资料来源：姚意才，“芎牛汤”治疗偏头痛 31 例，中医杂志，1985；26（1）：59。

④芎芷细辛汤

组成：川芎 30～50g，白芷 15g，细辛 8～15g，全蝎 10g，蜈蚣 20 条。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：治疗偏头痛 186 例中，男 66 例，女 120 例；年龄 15～60 岁；病程 6 个月至 25 年。结果：治疗 20 天以内，头痛及主要兼症消失，1 年无复发者为近期治愈，共 164 例，占 88.1%；头痛明显减轻，发作次数减少者为有效，共 13 例，占 7.0%；病情无明显改善者为无效，共 9 例，占 4.9%；总有效率为 95.1%。

资料来源：赵广安，自拟芎芷细辛汤治疗偏头痛 186 例，吉林中医，1993；（2）：13。

④芎辛汤

组成：川芎、细辛、白芷、延胡索、牛蒡子、法半夏等。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，10 天为 1 疗程。

临床应用：本组治疗偏头痛 101 例中，男性 41 例，女性 60 例；年龄 16 至 69 岁；病程为 2 个月至 60 年。诊断标准：①头痛反复发作，病程在 2 个月以上（排除青光眼、鼻窦炎、神经官能症等引起头痛和紧张性头痛以及颅内占位性病变，脑血管畸形而致的头痛）。②头痛突然发作，呈跳痛、胀痛、刺痛、抽痛，部位多为一侧前额、太阳穴、后枕部及头顶部。痛前多伴眼前闪

光，轻度视野缺损、发作时伴头晕、头汗出、四肢发凉，甚则恶心、呕吐；③头痛持续数小时至数天不等，可以自行缓解而不留后遗症，伴无痛间歇期，其间犹如常人。疗效标准：①显效：头痛及伴随症状基本消失，或偶有轻微头痛，持续时间缩短；②有效：头痛发作次数减少，程度减轻，持续时间缩短；③无效：头痛及其它症状经服药 10 天后仍无明显改善者。结果：显效 55 例，有效 39 例，无效 7 例，总有效率 93.1%。

资料来源：周超凡等，加味芎辛汤治疗偏头痛 101 分析报告，实用中医内科杂志，1989；3（1）：16

④定痛饮

组成：全蝎 6g（研细末分吞），川芎 15g，钩藤 30g（后下），天麻 15g，菊花 15g，川牛膝 15g，赤芍 15g，白芍 30g，菖蒲 6g，葛根 20g，生石决明 25g。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。头痛缓解后，当再服 3～6 剂，以固疗效。

临床应用：治疗偏头痛 100 例，1988 年 4 月据《临床疾病诊断治愈好转标准》明确诊断为偏头痛，其中男 37 例，女 63 例，年龄最大 62 岁，最小 12 岁，病程 4 个月至 21 年。症状特点有：反复发作的病史，每次持续数 10 分钟，或数小时、数天，发作时一侧或双侧，自颞部、眼眶或前额逐渐扩展，为搏动样跳痛、胀痛、牵痛、针刺样痛，并伴有呕吐、恶心。有的病人发作前有眼前闪光，发黑、畏光等先兆，舌红有瘀点，舌下静脉迂曲，脉弦。疗效判定为：治愈二头痛及兼症完全消失，停药半年至一年内未见复发。好转：头痛兼证基本消失，停药一年有复发，但发作次数减少，疼痛程度减轻。无效：治疗后疼痛症状无好转。结果：治愈 41 例，好转 56 例，无效 3 例，总有效率为 97%。

资料来源：赵培基等，定痛饮治疗偏头痛 100 例临床观察，实用中医内科杂志，1992；6（4）：174。

④防风通圣散

组成：防风、川芎、当归、芍药、大黄、薄荷叶、麻黄、连翘、芒消各 15g，石膏、黄芩、桔梗各 30g，滑石 90g，甘草 60g，荆芥、白术、栀子各 7.5g。

适应症：偏正头痛，苔腻微黄，脉数。

用法用量：上药为末。每服 6g，用水 200ml，加生姜 3 片，煎至 120ml，温服，涎滞者，加半夏 15g（姜制）。

临床应用：应用本方丸剂，每次 6g，每日 2 次，口服。治疗偏头痛 15 例，结果：8 例 2 个月未发作，3 例发作明显减少，1 例发作减少一半，有效率 80%。服药 1~2 个月后分别检验：服药后 1 个月，对 ADP 诱导的最大聚集率平均数由 64.33% 下降至 59.67%，均差为 46.7%，经统计学处理，有明显差异（ $P < 0.05$ ）。服药 2 个月后下降至 58.1%，均差为 6.23，有显著意义（ $P < 0.01$ ）。服药后 1 个月及 2 个月对诱导剂肾上腺素最大聚集率平均数由 62.16% 分别下降至 54.13% 及 46.48%，均差值为 8.03 及 15.68%，亦有显著意义^[1]。

药理研究：1. 降胆固醇作用 将防风通圣丸研碎，蒸馏水浸泡 24 小时，取上清液配成 50% 的药液。进行实验。①灌胃给药对小鼠血清胆固醇的影响；②皮下注射给药对小鼠血清胆固醇的影响；③腹腔注射蛋黄乳液对小鼠肝脏中胆固醇的影响。结果表明用本方浸液灌胃给药（0.12g/g 体重），可使用蛋黄乳液造型的小鼠血清胆固醇显著降低，皮下给药则无效，对肝脏胆固醇无影响。因此推测本方可能是主要抑制了外源性胆固醇的吸收^[2]。

2. 抗血栓、抗心律失常和降压作用 取防风通圣丸经水溶化，醇提，以生理盐水配制而成。观察本方①对家兔体外血栓形

次持续数十分钟、数小时或数天。头痛部位限于一侧颞部、额部、眼眶部、顶部，为较强烈的搏动性跳痛、胀痛、钻锥样痛。可伴有出汗、呕吐、恶心、颜面苍白或颜面及眼结合膜充血等。结果：①近期疗效：基本治愈 218 例，占 90.8%（症状和体征完全消失，停药后 3~6 个月未再复发）；好转 12 例，占 5.0%（症状和体征基本消失，停药后 3 个月内有复发，但次数减少）；无效 10 例，占 4.2%。②远期疗效：对治愈的 218 例进行了 1~3 个年的随访，其中 194 例情况良好，只有 24 例复发。

资料来源：高文开，复方地甲猬虫汤治疗偏头痛型血管性头痛 240 例，中西医结合杂志，1988；8（11）：653。

④桃红四物汤

组成：熟地黄、白芍药、当归、川芎、桃仁、红花。

适应症：偏头痛。

用法用量：水煎，每日 1 剂，分早晚 2 次温服。

临床应用：应用本方：桃仁 10g，红花 8g，川芎 10g，当归 12g，生熟地各 15g，白芍 12g。水煎服，15~18 剂为 1 疗程。治疗偏头痛 63 例，男 23 例，女 40 例；病程 2 月至 14 年。结果：近期治愈 14 例，占 2.2%；显效 25 例，占 39.7%；好转 19 例，占 30.2%；无效 5 例，占 7.9%；总有效率 92.1%^[1]。

药理研究：对小白鼠耐缺氧及抗疲劳的影响 耐缺氧试验取 54 只纯种 NIH 小白鼠，游泳抗疲劳试验取 66 只纯种 NIH 小白鼠，分给药组与生理盐水对照组，分别记录因缺氧致死与被淹死的时间，比较组间差别。结果：给药组耐缺氧及游泳的试验的实验鼠死亡时间均明显长于对照组^[2]。

又取本方：桃仁、红花、熟地、白芍、当归、川芎。制成 200%煎剂备用。将小鼠随机分成对照组和用药组。对照组服生理盐水，服用量 0.2ml/g；用药组服 200%桃红四物汤煎剂，服用量 0.2ml/g。半小时后将每只小白鼠分别放入完全密闭的

500ml 的玻璃瓶内，瓶内放有钠石灰 15g，严密观察直至小白鼠死亡，准确计算出其存活时间。结果：用药组平均存活 59 分 3 秒，对照组平均存活 41 分 4 秒，用药组较对照组明显延长存活时间，延长率为 43.2%，两组统计学处理有显著差异 ($P < 0.05$)，表明桃红四物汤能提高小白鼠在缺氧情况下的耐受力^[3]。

资料来源：

[1] 潘北桂等，桃红四物汤治疗偏头痛 63 例疗效观察，中医杂志，1985；6 (6)：424。

[2] 张华等，桃红四物汤对小白鼠耐缺氧及抗疲劳试验报告，浙江中医杂志，1989；(5)：229。

[3] 朱广智等，桃红四物汤对小鼠耐氧的实验研究，中西医结合眼科，1992；10 (4)：195。

④通窍活血汤

组成：赤芍 3g，川芎 3g，桃仁 9g (研泥)，红枣 7 个 (去核)，红花 9g，老葱 3g (切碎)，鲜姜 9g (切碎)，麝香 0.15g (绢包)。

适应症：偏头痛。

用法用量：用黄酒 250ml，将前 7 味煎至 150ml，去滓，将麝香入酒内，再煎二沸，临睡服。

临床应用：应用本方加减：赤芍 20g，川芎 20g，桃仁 10g，红花 10g，生姜 15g，大枣 15g，白芷 15g，菊花 20g，蔓荆子 15g，葱白 3 根。黄酒适量为引。水煎服，每日 1 剂，连服 4～10 剂。治疗偏头痛 253 例，男 45 例，女 208 例；年龄 20～55 岁。结果：显效：头痛及伴随症状基本消失，或头痛偶有轻微发作，客观指标改善，共 206 例；好转：发作频度减少 50% 以上，疼痛减轻，共 26 例；无效：服药前后无变化，共 21 例；总有效率为 91.70%。

资料来源：庞润辉，通窍活血汤加减治疗偏头痛 253 例，实用中西医结合杂志，1992；5（11）：698。

⑤散偏汤

组成：川芎 20g，白芍 15g，郁李仁 3g，柴胡 3g，白芥子 3g，香附 6g，甘草 3g，白芷 1.5g。

适应症：头风，偏头痛。

用法用量：每日 1 剂，分 2 次水煎服。如肝火偏旺，加菊花 9g，钩藤 9g，天麻 9g；寒湿加附片 6g，干姜 6g；血瘀甚加赤芍 15g，红花 9g，归尾 9g。

临床应用：治疗头风，偏头痛 50 例中，女 34 例，男 16 例；病程均在 1 年以上。结果：治愈（症状完全消失，恢复日常工作）30 例，占 60%；基本治愈（症状基本消失，但劳累或恼怒之后，仍有轻度发作，不影响日常工作）16 例，占 32%；好转（症状好转，仍有反复，次数减少）2 例，占 4%；总有效率为 96%^[1]。

又用本方：白芍 15g，川芎 30g，郁杏仁、甘草、柴胡各 3g，白芥子 9g，香附 6g，白芷 1.5g。如素体虚弱者，加太子参、黄芪各 30g，当归 15g；肝胆热象明显者，加黄芪 10g，生地 12g；痛剧者，加全蝎 6g，蜈蚣 1~3 条。水煎服，每日 1 剂。治疗偏头痛 39 例，均按《实用内科学》偏头痛的诊断标准诊断。其中男性 5 例，女性 34 例；年龄最大者 53 岁，最小者 15 岁；病程最长者 5 年，最短者 1 个月。结果：治愈（临床症状消失，随访 1 年以上未复发）37 例；好转（临床症状消失，半年内复发）2 例；总有效率为 100%。轻者服药 1~2 剂，重者 3~5 剂^[2]。

资料来源：

[1] 李文海，散偏汤治疗头风 50 例疗效观察，贵阳中医学院学报，1984；（4）：19。

[2] 李连仲等, 散偏汤治疗偏头痛, 浙江中医杂志, 1991; (12): 543。

⑤越鞠丸

组成: 川芎 15g, 香附 12g, 神曲 10g, 栀子 10g, 苍术 10g。

适应症: 偏头痛。

用法用量: 每日 1 剂, 水煎, 分早、晚服。

临床应用: 治疗偏头痛 50 例, 男 12 例, 女 38 例; 年龄 15~67 岁; 病程 3 天至 10 余年; 头痛多呈周期性、反复发作性。结果: 服药后头痛消失, 脑血流图恢复正常 45 例, 病情好转者 5 例。

资料来源: 于书本等, 越鞠丸加味治疗偏头痛 50 例, 山东中医杂志, 1991; 10 (6): 19。

⑥疏潜汤

组成: 菊花、川芎各 20g, 珍珠母 30g, 蔓荆子 15g, 天麻 10g, 全蝎、薄荷、露蜂房各 6g, 细辛、朱砂各 3g。

适应症: 偏头痛。

用法用量: 武火煎 15 分钟, 日 1 剂, 分 2 次服, 小儿酌减。头胀痛加石决明; 掣痛加蜈蚣 1 条; 锥刺痛加桃仁、红花; 闪电样痛加防风、地龙; 疼痛部位不定或蚁行感加防风、僵蚕; 烘热痛加牛膝、生石膏; 血管跳动样痛加杭芍、牛膝; 伴脑鸣加荷叶、磁石, 伴耳鸣加磁石、蝉蜕; 伴眩晕加白蒺藜; 伴失眠加炒枣仁, 心悸心烦加山栀、龙骨; 鼻塞加辛夷、苍耳子; 伴恶心呕吐加胆星、半夏; 若吐涎沫再加吴萸、生姜; 眼球胀憋加草决明、密蒙花; 口眼歪斜加僵蚕、白附子; 头痛以额角颞部为主加白芷; 痛连巅顶加藁本; 痛达脑后加羌活; 气虚加黄芪; 血虚加当归。10 剂为 1 疗程。

临床应用: 共治偏头痛 120 例, 结果: 服药 10 剂, 头痛消失, 随访 1 年以上未发作者为治愈, 共 45 例; 服药 10 剂或 10

适应症：偏头痛。

用法用量：面白唇淡、脉沉细者加党参、熟地、黄芪；颈痛加葛根；舌淡红加钩藤、天竺黄；舌质紫暗加丹参、红花；失眠加琥珀、远志。水煎服，每日1剂，15天为1疗程。病程好转再进20剂。

临床应用：治偏头痛86例中，男23例，女63例；年龄18~64岁；病程3个月至16年。结果：治愈占60.6%，有效占32.5%；总有效率为93.1%。

资料来源：周继武等，通窍镇痛汤治疗偏头痛86例，四川中医，1993；11（5）：30。

⑤ 芎菊汤

组成：菊花60g、川芎、葛根、川牛膝、合欢皮、夜交藤、炒枣仁各30g，防风、白芷、白芥子各15g，蝉蜕10g，甘草6g。

适应症：顽固性偏头痛。

用法用量：水煎服。每日1剂，7天为1疗程，疗程间休息1~2天。

资料来源：王东明等，山东中医药大学学报，1997；21（3）：196。

⑥ 清肝熄风汤

组成：淡黄芩、黑山栀、川芎、白芷、蔓荆子、白菊花、柴胡各10g，生白芍12g，夏枯草、双钩藤（后下）各15g。

适应症：偏头痛。

用法用量：每日1剂，水煎2次，共取汁500ml，分2次温服。10天为1个疗程。

临床应用：夜寐不安者加夜交藤、茯神；胸脘痞满、纳食不馨者加炒枳实、焦山曲；痛有定处，如锥刺之者加桃仁、红花、赤芍；久痛入络生风者加僵蚕、全蝎、蜈蚣。

资料来源：张正明等，江苏中医，1997；18（5）：17。

⑤ 芎归汤（方名为编者拟）

组成：川芎 15～30g，当归 15g，赤芍 12g，全蝎 15g，白芍 12g，青黛 10g，木瓜 12g，防风 10g，菊花 10g。

适应症：顽固性偏头痛。

用法用量：每日 1 剂，水煎服，10 天为 1 疗程，一般治疗 2～4 疗程。

临床应用：阴血不足加何首乌 15g，石斛 15g，肝气郁滞加香附 12g，肝阳上亢加生石决明 30g，生赭石 30g，遇寒加重加吴茱萸 6g，肝肾不足加生地 15g，女贞子 15g，后枕痛加羌活 10g，前额痛加白芷 10g，两太阳穴痛加柴胡 10g，眉棱骨痛加藁本 10g，巅顶痛加细辛 3g，吴茱萸 6g。

资料来源：张霞，山西中医，1998；14（2）：17。

三、单方验方

（一）外用方

1. 白附子 3g，葱白 15g。白附子研细末，与葱白捣成泥状，取黄豆大一粒，堆在小圆纸上，贴在痛侧太阳穴处，约 1 小时后取下。

2. 蓖麻同乳香、食盐捣，取黄豆大小块贴于太阳穴处。

3. 鹅不食草 30g、白芷 15g、冰片 1.5g，共研末备用。发作时用棉球蘸药粉少许塞鼻孔。

4. 葱适量，捣烂取汁，涂太阳穴处。除痛甚捷。

5. 朴硝少许吹鼻中；左痛吹右，右痛吹左。（以上均见吴大真等，难治病的良方妙法，中国医药科技出版社，1991）

（二）内服方

1. 制川草乌各 6g，白芷、僵蚕各 6g，生甘草 9g。研细末，分成 6 包，每日 1 包，分 3 次用绿茶送服。（王永炎等，北京中医学院学报，1992；15（1）：5）

2. 川芎、蔓荆子各 10g, 水煎服。(李泰, 河北中医, 1988; (5): 1)
3. 上茯苓 30~60g, 煎服。(袁曙光等, 河北中医, 1988; (6): 4)
4. 钩藤 30g, 全蝎 5g, 研末。每服 3g, 1 日 2~3 次。(孙刚, 江苏中医, 1988; 9 (4): 10)

四、中成药

近来中药治疗偏头痛有几个品种, 如正天丸、镇脑灵、复方羊角冲剂、当归素片、野木瓜片等, 也有用川芎嗪、复方丹参或丹参注射液以及清开灵注射液治疗偏头痛者。此处介绍散偏冲剂。

来源: 散偏冲剂处方原为清朝陈士铎《辨证录》所载的著名验方, 许多医家对此甚为推崇。南京医学院第一附属医院贝叔英主任医师和黄泰康副研究员等将散偏汤进行剂型改革, 研制了治偏痛冲剂。

组成: 川芎 30g, 白芍 15g, 白芥子 9g, 白芷 2.5g, 香附 6g, 柴胡 3g, 郁李仁 3g, 甘草 3g。

功效: 活血化瘀, 行气解郁, 疏风化痰。

主治: 偏头痛及其他各类头痛。

用法用量: 加辅剂制成冲剂, 每包 20g (含川芎 1g)。每日 2~3 次, 每次冲服 1 包。

临床应用: 用以此药治疗偏头痛 150 例, 结果显效 45 例 (占 30%), 进步 81 例, 无效 24 例, 总有效率 84%; 对照组 34 例, 口服安慰剂, 全部无效。制成冲剂, 服用较为方便。

方义解释: 方中主药川芎, 有疏风活血、通络之力, 辛香上行, 专治头痛巅疾; 配合白芍活血化瘀、酸敛柔肝, 与甘草同用则和络止痛力著, 同时防川芎量大散气太过; 配白芷则疏风止痛

力强；香附、柴胡及郁李仁清肝解郁行滞，白芥子化痰。综合诸药则活血行瘀、疏肝解郁、疏风化痰、柔络止痛，正合偏头痛之病机，对瘀血阻滞、痰浊内蕴、肝郁化火、外感风邪型及兼体虚者之偏头痛均有一定作用。

药理研究：动物实验提示该药能扩张脑血管，增加脑血流量，改善微循环，并有镇痛、镇静作用。

五、饮食疗法

忌食猪头肉、烧鹅、公鸡及牛奶、啤酒、巧克力及柑橘等诱发偏头痛的食品；生冷油腻之品亦当慎食。

药膳亦为治疗偏头痛的有效方法。

(一) 鳙鱼(大头鱼)头 1 只、生姜 30g、米酒 120g。将鱼头切块，用水适量，同放砂锅内煮熟，趁热吃完。

(二) 生姜片 90g，老葱头 30g，鲤鱼头两个，酒 60g。同糯米加水煮饭，1 次吃完。

(三) 猪脑 2 副，生姜汁 50ml，酒 60g。隔水蒸熟，1 次吃完。

(四) 生鱼 1 条，莲子 60g，鸡蛋 3 只。用水煮熟，以生盐调味吃。

(五) 向日葵仁 60g，母鸡 1 只。将鸡除去毛脏，同向日葵仁用水煮汤吃。

(六) 紫河车(胎盘) 1 个，川芎 30g。先将胎盘洗净煮熟，同川芎在新瓦上焙干，研为细末，每次服开水冲服，每日两次。(以上均引自郑启明，民间饮食疗法，广西人民出版社，1981)

六、医案医话

(一) 樊蓂医案——肝火上扰，脑络郁滞案

蔡某，男，56岁。以发作性双侧额颞部疼痛40年就诊。初时每1~2个月一发，近5年来几乎每周发作2~3次，甚至天天头痛。发时视力模糊，头痛如劈，有目痛、呕吐，甚至抱头恸哭，每次头痛持续6~48小时，常规止痛剂不起作用，因而常常需急诊处理，注射强力止痛剂。为治该病，患者多年来足迹遍布大半个中国，服过多种中西药物均未能控制病情发展。1991年3月来诊，视其情怀抑郁、面色黧黑，伴腰酸乏力，目胀而痛，苔薄舌淡红，脉弦数，断其必有瘀血郁滞脑络，然观其病势急骤、发作频繁，亦有肝火上扰、清空失靖之象。乃先予清肝泄火、活血通络折其病势，药用：桑叶10g，黄芩6g，夏枯草12g，白蒺藜10g，磁石30g（打），川芎15g，白芍12g，柴胡6g，山梔子6g，甘草3g。5剂后头痛发作频率减少，程度减轻，能够耐受；遂改以川芎20g，赤白芍各15g，郁金10g，僵蚕15g等养血柔肝、活血定痛之品巩固两月。随访1年半，头痛未再复发。治疗后患者的血小板聚集指数（最大聚集率）由治前的87%降至42.75%，血液流变学指标亦有多项改善。

(二) 张锡纯医案——头风害目案

[病者] 王某，年近五旬，高等检察厅科员。

[病名] 头风害目。

[原因] 处境不顺，兼办稿件劳碌，渐觉头疼，日寝加剧。服药无效，遂入省人民医院，住院日，头疼未减，转添目疼。

[症候] 越数日，两目生翳，视物不明，自言脑疼彻目，目疼彻脑，且时觉眩晕，难堪之情，莫可名状。

[诊断] 脉左部洪长有力，脉症合参，知系肝胆之火，挟气血上冲脑部，脑中血管因受冲激而膨胀，故作疼。目系连脑，脑

中血管膨胀不已，故目疼生翳，且眩晕也。因晓之曰，此系脑充血症也。深究病因，脑疼为目疼之根，而肝胆之火挟气血上冲，又为脑疼之根。

〔疗法〕当清火平气，引血下行，头疼愈而目疼生翳及眩晕，自不难调治矣。其目翳原系外障，须兼用外治之法，用磨翳药水1瓶，日点眼上5、6次，自能徐徐将翳尽消。

〔处方〕怀牛膝30g，生杭芍18g，生龙骨18g（打），生牡蛎18g（打），代赭石18（打），乌玄参12，川楝子12，龙胆草10，生甘草6，磨取铁锈浓水煎药。

附磨翳药水方：生炉甘石30g，硼砂18g，薄荷叶10g，蝉蜕10g（带全足，去翅土）。制法（略）。

〔效果〕服1剂，觉头目之疼顿减。又服两剂，其头疼目疼眩晕皆愈，视物亦较真。（何廉臣，重印全国名医验案类编，上海科学技术出版社，1959：45～46）

七、现代报道

（一）偏头痛以中医中药治疗往往有较好的疗效，一般而言，效果比单用西药为佳。应用多种方法多途径给药也是一大特点，不但止痛效果有所提高，而且复发率也减小，积累了丰富的经验。并应用现代医学检验方法，对偏头痛的疗因病机进行了探讨，在一定程度上发展了中医关于头痛的理论。10年来的报道中，治疗偏头痛的中药大致以“辛开、苦降、甘缓”为原则，据统计，以使用频数大小决定先后次序，则川芎、白芍、生地、当归、桃仁、红花、白芷、柴胡、半夏、茯苓、细辛、甘草等为治疗偏头痛的首选药物；并重视伍用风药、虫类药，川芎与细辛或牛膝同用也成为热点。治愈率一般40%～90%，总有效率80%～100%。从10年来410篇有关本病的临床研究资料看，多数医家着重于用中药控制偏头痛的频繁发作，疗程在1～15天，尤其

选用 5~10 天为多，都取得了一定效果；但从控制和预防偏头痛来考虑，则疗程宜更长些。（王永炎等，北京中医学院学报，1992；(1)：5~12）。

（二）很多学者以现代检验手段对偏头痛病机进行了研究。

1. 脑电图：有人对①32 例偏头痛者进行脑电图检查，其中 25 例异常，经治疗后 13 例病理没消失；②36 例中 29 例有不同程度的异常；③20 例中有 6 例异常。而正常人中仅可见 10% 的轻度异常率，故本病脑电图的异常率高于正常人。虽然有的学者所作的工作与此有些出入，但总的来说偏头痛患者存在脑水平的功能异常（脑 CT 大多无器质性病变的证据）。（中华医学会第二次全国脑电图与临床神经生理学术会议论文集，1989 年 10 月，南京）

2. 脑血流图：有资料表明，①66 例本病患者 54 例异常，治疗后 43 例恢复正常，揭示治疗后尚有 11/66 例（16.67%）异常；②46 例中 39 例异常，显示脑血管张力增加，两侧血容量不均衡，两侧波幅差明显（乔玉槐等，中西医结合杂志，1990；10(4) 235）。笔者的研究中，曾检查 1194 例偏头痛患者（均为发作间歇期检查脑血流图），发现共有 461 例（38.61%）异常，而正常或基本正常 733 例（61.39%），1 侧或两侧脑血管扩张者 28 例（2.35%），1 侧或两侧血管收缩者 204 例（17.09%）；两侧供血不平衡 85 例（7.12%）；血管紧张度增高 60 例（5.03%），血管张性减退占 88 例（7.37%）。

3. 甲皱微循环：有多篇报道。1 项 62 例的研究中，52 例异常，在治后复查的 26 例中各项指标均有明显改善。43 例本病患者甲皱微循环提示血液颜色暗红者增加（患者组为 37%，正常对照组为 16%），血液状态中线粒流出现率少，管袢清晰度差（患者组 60% 不清晰，正常组仅 8% 不清晰），管袢形态异常率增加，管袢排列不整齐，血流速度缓慢。另外 1 项 290 例的研究结

果也与此相似（张澍等，中华神经精神科杂志，1985；2：98）。

4. 血小板聚集率及血液流变学检查：自从 Hilton 和 Cumings 1971 年发现偏头痛患者的血小板功能异于正常人以来，国内外的大批学者对此进行了深入而持久的研究。结果发现，不论偏头痛发作时及缓解期，患者的血小板聚集和释放功能明显增强，具体表现为对二磷酸腺苷（ADP）、肾上腺素（ADR）、花生四烯酸、胶原等诱导剂诱导的血小板聚集性增高。这一理论较好地解释了偏头痛的主要发病过程，因而被广泛接受。Hanington 甚至提出偏头痛是一种原发性的血液病（血小板功能异常）。患者的血液流变学的改变也得到重视，有人发现在所测的全血比粘、血浆比粘、红细胞电泳、红细胞压积四项指标中，均提示不同程度的增高，尤其是后两项更为显著，表明与红细胞聚集性增高、血流粘滞有关，致使偏头痛患者脑部微循环灌注不良。又有人发现偏头痛病人的血浆粘度显著高于肌紧张性头痛和正常对照组；另外 1 组较大的样本（78 例）同时测定血小板聚集率和血液流变学，提示偏头痛患者的血小板对诱导剂过分反应，聚集率增高；血液流变学中血浆粘度及红细胞压积增高（Blau, Migraine, chapman and Hall: London, 1987）。

（三）我们知道，脑电图主要是检查脑电功能的，偏头痛患者脑电图异常率增加，提示其存在脑水平的功能异常；脑血流不论是发作期还是缓解期均有异常，提示了该病脑部经络存在气滞、血瘀；甲皱微循环的异常揭示了本病尚存在全身瘀血证表现；而全血的血小板聚集率不论是在发作期或缓解期的异常增高及血液流变学提示的患者血液浓、粘状态，均是中医血瘀证的有力证据。因此，偏头痛不论诱因和起始病机是什么，关键病机是经络、尤其是脑部经络的气滞血瘀；就整体而言，不论本病发作与否，偏头痛患者都存在瘀血证，当然这是指血流郁滞而言，与内结瘀血（血栓）及离经瘀血（出血性血肿等）有所不同。由于

本病以脑部瘀血为主要见证，可以出现灵机失用（脑的高级功能障碍等）、屡发损目，也可能较正常人更易患缺血性中风（内结瘀血，阻滞脑络）。这为临床运用活血化瘀法治疗偏头痛提供了依据。然而临床上以活血化瘀法结合传统的辨证论治方法来治疗本病似更为妥贴些，疗效也可更好一些。

八、主要参考资料

1. Silberstein, SD. MD. Advances in understanding the Pathophysiology of headache. Neurology, 1992; 42 (Suppl 2): 6~10
2. 戴瑞鸿等, 内科疾病诊断标准. 上海: 上海科技教育出版社, 1991: 412~414
3. 何绍奇等, 现代中医内科学. 北京: 中国医药科技出版社, 1991: 442
4. Blau JN. MD, Migraine, Chapman and Hall: London. 1987: 369~373
5. 张海洲, 中医治疗血管性头痛的进展与评价, 江苏中医, 1990; (7): 43~46
6. 王永炎等, 近十年中医药治疗头痛的临床研究述评, 北京中医学院学报, 1992; 15 (1): 5~12
7. 张澍等, 功能性及血管性头痛对甲皱微循环的影响, 中华神经精神科杂志, 1985; 18 (2): 98
8. 陈同慧等, 偏头痛与肌紧张头痛病人血小板活性和血液流变学的对比研究, 山东医药 1989; (6): 61
9. 吴钢等, 偏头痛患者血小板聚集功能及血液流变学变化的研究, 福建医药杂志 1989; 11 (4): 6~8
10. 黄泰康等, 中药方剂现代研究大典, 科学出版社, 1996

急性感染性多发性神经炎

急性感染性多发性神经炎，又称急性多发性神经根炎，即格林-巴利综合征，以渐进性、对称性和弛缓性肢体麻痹为其临床特点，病程早期可有不同程度的感觉障碍，严重者可伴有颅神经麻痹和呼吸肌麻痹。其病因很可能与某种感染（如病毒）及自身免疫反应有关；主要损害部位为脊神经根和脊神经，也可累及颅神经、脊髓和脑，主要病理是神经纤维水肿、瘀血、髓鞘和轴突坏死。其发病多数急骤、发展迅速，由轻到重常无明显过渡期，病死率曾高达30%，现已降至5%以下。伴有呼吸肌麻痹者为重型，最为险峻。临床予以及时抢救和治疗，多数患者可于数月到1年内完全康复，也有少数人留有后遗症。本病好发于夏秋两季。西医主要以糖皮质激素等治疗。

中医学认为，本病以肢体软瘫为特征，属“痿证”范畴，又可兼见痹证、痉证和厥证，临床应予明辨。《证治准绳·痿论》云：“痿者手足痿软而无力，百节缓纵而不收。”近年来中医治疗本病积累了相当的经验，病死率和致残率有所下降。

一、病因病机

中医学认为本病的原因是外感时邪、内外合邪及内伤本虚相互作用的结果，导致宗筋弛纵而成痿证。

（一）外感温热、湿毒 夏秋之交，冒暑劳作，感受温热邪毒或居地多湿，以水为事，湿毒浸淫，邪伤宗筋，肌肉濡渍不仁

以成痿证。《痿论》云：“有渐于湿，以水为事，居处相湿”、李东垣“湿热乘于肝肾”、“燥金受湿热之邪，绝寒水生化之源”等均指此类。

(二) 素体亏虚 素禀脾肾阳虚或肺肾气虚，卫气不足，易感受寒湿之邪或温热、湿毒之邪，内外合邪，宗筋不能束骨、利机关，而成痿证；邪盛正虚，外邪留连不去，耗损真元，甚则可见呼吸不继的肺肾阳虚危候。

总之，本病的病因病机主要是正气内虚感受外邪、或疫气袭人，着于宗筋，伤于肝、脾、肺、肾，俾肌肉弛纵、不仁，甚则肺肾阳虚而呼吸困难，以至败症叠现。

二、辨证施治

(一) 辨证要点

1. 本病以肢体瘫软为主证，夏秋两季发病较多，与感染温热疫毒或湿毒有关，因而以湿热浸淫型最为常见。脾肾阳虚，寒湿下注型可导致呼吸困难，甚则亡阴亡阳，宜特别注意。急性期乃起病之初，以实为主。

2. 待病势趋缓，进入恢复期，脾虚、肝肾两亏的虚证渐显，以虚为主，宜注意培元扶正。

(二) 辨证分型

1. 肺热伤阴型

初起咽痛，鼻塞流涕，或见发热，咳嗽少痰，突然肢体瘫痪(多先下肢乏力)，筋脉弛缓，麻木不仁，心烦口渴，皮肤干燥或手足汗出，小便短赤，大便秘结。舌质淡红或偏红，苔黄，脉数。

2. 湿热浸淫型

四肢困重无力，继则瘫软痿废或四肢麻木、酸痛，胸闷，或口眼歪斜，口渴不欲饮水，大便溏薄，小便短赤。舌胖质暗，苔

黄腻，脉弦滑。

3. 寒湿下注型

突然四肢瘫软不用，双下肢先瘫或下肢瘫痪严重，或肢体麻木，手足发凉，甚则冷汗频出，胸如束带，进而吞咽困难、呼吸无力，喉有痰涎，唇甲青紫，或瞬目不能。舌质淡，舌苔薄白，或舌紫苔腻，脉来沉迟或伏。

4. 脾气虚弱型

四肢瘫痪，下肢尤重，筋脉弛缓，手足肿胀，食少腹胀，肌肉握痛，病久则肌肉消瘦，面色萎黄不华，大便稀溏。舌质淡，苔薄白，脉细无力。

5. 肝肾两亏型

肢体瘫痪，筋脉弛缓，腰膝酸软，肢体麻木，有如蚁走、针刺，两目干涩，头晕耳鸣。舌红少苔，脉弦细数，或舌淡胖，脉迟或缓。

(三) 治法方药

本病虽有正虚的一面，但初病时病情进展，属急性期（大约1周左右时间），治疗宜解毒祛邪、防止亡阴亡阳为主；恢复期则外邪已衰，正损显露，宜以匡正扶元、起痿振颓为主。

1. 分型施治

(1) 肺热伤阴型 清热润肺，甘寒养阴。方用清燥救肺汤加减：桑叶 10g，北沙参 12g，炙枇杷叶 10g，生石膏 30g，桔梗 6g，杏仁 10g，银花 15g，连翘 15g，板蓝根 30g，芦根 30g。下肢瘫痪可酌加牛膝 15g，木瓜 12g；上肢瘫痪加羌活 6g，威灵仙 15g，桂枝 10g；麻木加赤芍 12g，川芎 20g，鸡血藤 30g；肢痛加炙乳香，炙没药各 10g；汗多加生黄芪 30g，生牡蛎 30g，浮小麦 45g；大便不畅加生大黄 6g（后下）。

(2) 湿热浸淫型 清热利湿，通络起痿。方选三妙丸增损：苍术 30g，黄柏 12g，怀牛膝 15g，生苡仁 12g，萆薢 12g，木瓜

12g, 茯苓 12g, 独活 6g, 桑枝 30g, 丹参 30g, 鸡血藤 30g。胸满痞闷加厚朴 10g, 枳壳 12g, 青皮 6g, 口眼歪斜加白附子 10g, 白僵蚕 15g, 全蝎 4g。

(3) 寒湿下注型 祛寒除湿, 温补脾肾。方用麻黄附子细辛汤合参术汤加减: 制附子 30g (先煎半小时), 麻黄 10g, 细辛 6g, 人参 10g, 白术 15g。寒湿重者加苍术 12g, 干姜 6g, 肢冷汗多去麻黄, 加黄芪 30~60g。

(4) 脾气虚弱型 益气健脾, 振颓起废。方选参苓白术散增删: 党参 15g, 黄芪 30g, 茯苓 15g, 白术 12g, 山药 15g, 陈皮 6g, 羌活 6g, 桂枝 10g, 威灵仙 12g, 木瓜 15g, 丹参 30g, 续断 15g。手足肿胀者加络石藤 15g, 川萆薢 12g, 伴阴虚有热则去羌活、桂枝, 加石斛 12g, 沙参 12g, 知母 6g。

(5) 肝肾两亏型 补益肝肾, 强筋健肌。偏阴虚者方选虎潜丸出入: 醋龟板 30g, 黄柏 10g, 知母 6g, 熟地 30g, 当归 12g, 生黄芪 30g, 阿胶 10g (烔化), 制首乌 12g, 赤芍 10g, 续断 10g, 桑寄生 12g, 杜仲 10g。偏阳虚(肾阳虚明显)者方用二仙汤合四物汤加减: 仙茅 12g, 仙灵脾 30g, 巴戟天 12g, 肉苁蓉 15g, 鹿角霜 20g, 当归 12g, 川芎 12g, 熟地 30g, 鸡血藤 15g, 黄芪 30g。有针刺、蚁走感加炙乳香、炙没药各 10g; 面色无华, 头晕心悸则重用黄芪, 另加党参 15g, 麦冬 10g; 肾阳不足, 寒自内生者, 可加制附片 12g, 肉桂 3g (后下), 补骨脂 12g。

2. 方药选介

①干颓汤

组成: 生黄芪 150g, 当归 30g, 甘枸杞 30g, 山萸肉 30g, 生乳香 9g, 生没药 9g, 鹿角胶 18g (捣碎)。

适应症: 肢体痿废或偏枯, 脉象极微细无力者。可以作为格林-巴利综合征恢复期治疗方剂。

用法用量: 水煎服。

临床应用：阴虚甚者，宜加生地黄、石斛；兼湿热未尽者，可合用苍术、苡仁、黄柏。

使用注意：格林-巴利综合征急性期湿热重者不宜应用本方。

药理研究：黄芪有良好的抗病毒作用，可以诱生干扰素，对病毒性疾病的治疗有益。鹿角胶、山萸肉、枸杞均为补肾药，具有补肾药的共性——增强下丘脑-垂体-肾上腺皮质、性腺、甲状腺等轴机能，有益于本病之恢复。

资料来源：《医学衷中参西录》

②补阳还五汤

组成：生黄芪 120g，当归尾 6g，赤芍 4.5g，地龙 3g，川芎 3g，桃仁 3g，红花 3g。

适应症：气虚血瘀证。证见肢体痿软无力，手足麻木不仁，肌肉瘦削，甚则肌肤甲错，小便频数，或遗尿不禁，舌质淡或有瘀点，脉涩不利。

用法用量：水煎服。

临床应用：本方主要应用于格林-巴利综合征恢复期，肌力差者，可酌加炙马钱子粉；遗尿不禁者，宜加益智仁、覆盆子、乌药。

使用注意：湿热重者不宜用本方。

药理研究：补阳还五汤可明显改善血瘀证患者的血液流变的“浓、粘、凝、聚”倾向；增加血小板内环磷酸腺苷的含量，从而抑制血小板聚集和释放反应；抑制和溶解血栓；改善微循环，促进侧枝循环（浙江中医杂志，1986；3：110）。补阳还五汤能使免疫功能低下小鼠的免疫器官重量增加，提高单核巨噬细胞吞噬功能，从而增强机体免疫功能（陕西中医，1986；10：466）。

资料来源：尚炽昌，疑难病证名验方辑要，北京：华艺出版社，1990：629。

③清燥救肺汤

组成：霜桑叶 9g，煅石膏 7.5g，甘草 3g，人参 2.1g，胡麻仁（炒，研）3g，阿胶 2.4g，麦门冬 3.6g，杏仁 2.1g，枇杷叶（去毛，蜜涂炙黄）1片。

适应症：肺热熏灼之痿证。肢体痿软不用，肌肉消瘦，皮肤干枯，心烦口渴，咳呛喉干，手足心热，小便短而热痛，舌红苔黄，脉细数。

用法用量：水煎服。

临床应用：气虚著者，宜加生黄芪 30～60g；燥热甚者，可加黄芩、知母、石斛；肌力差加炙马钱子粉。

使用注意：一般用于秋燥所致肺热痿证，用于急性期。

药理研究：桑叶有一定的抗病毒作用。

资料来源：《医门法律》卷四

④清燥汤

组成：酒黄柏 1g，苍术 3g，黄连 3g，猪苓 1g，泽泻 2g，茯苓 1g，黄芪 5g，人参 1g，白术 3g，陈皮 2g，当归身、升麻、柴胡、甘草各 1g，麦冬、生地黄、五味子各 1g，神曲 1g。

适应症：湿热成痿兼气阴两伤者。四肢瘫软或麻木，胸部束带感，全身沉重，精神倦怠，气短胸闷，汗出不畅，口渴不欲饮，舌苔白腻或薄黄腻，脉濡大或虚大。

用法用量：水煎服。药剂量可适当扩大。

临床应用：湿热浸淫，下肢弛纵不收，可加苡仁、萆薢；气虚甚者，黄芪宜加至 30～60g，生用。

使用注意：饮食忌肥甘油腻，宜食清淡之品。

药理研究：方中黄芪、人参具有提高机体免疫功能，促进抗体合成，加强白细胞诱生干扰素的能力；人参能增强下丘脑-垂体-肾上腺皮质功能，甘草具有类似肾上腺皮质激素的作用；黄连抑制病毒且可提高机体免疫功能。

适应症：格林-巴利综合征急性期。

用法用量：水煎服或鼻饲。

临床应用：梁氏以中药Ⅰ、Ⅱ方（针对急性期设Ⅰ方，恢复期设Ⅱ方）配合维生素、能量合剂及抗生素控制继发感染等，治疗本病80例，结果：好转74例，死亡6例，病死率7.5%；其中四肢麻痹有记录者60例中，肌力恢复时间为2~80日，治疗后3~8天开始恢复者45例。

使用注意：饮食宜清淡，忌肥甘厚味。

药理研究：附子能提高垂体-肾上腺皮质轴功能，甘草有类似肾上腺皮质激素作用，二者对格林-巴利综合征有缓解作用，可替代临床使用肾上腺皮质激素；附子有强心和改善循环，对抗本病可能造成的循环衰竭；黄芩、甘草有直接抗病毒作用。

资料来源：中级医刊，1979；8：21。

⑧梁氏Ⅱ方

组成：川断、牛膝、杜仲、苡仁各15g，桂枝、枸杞各5g，党参、知母、锁阳各10g，千年健7.5g。

适应症：格林-巴利综合征恢复期。

用法用量：水煎服。

临床应用：见梁氏Ⅰ方。

使用注意：本方不宜用于急性期。

资料来源：中级医刊，1979；(8)：21。

⑨复方马钱子汤Ⅰ号

组成：银花、板蓝根、大青叶各30~60g，黄芩、仙灵脾、寄生各15~30g，马钱子3~10g（将有毛的马钱子切成6~8片薄片，和其他中药放在一起加水浓煎，每剂煎两次，每次煎1小时，然后去滓喝汤，切勿浸泡后煎服，以进食后半至1小时服用为宜，不宜空腹服用），甘草10~30g。

适应症：格林-巴利综合征进展期。

用法用量：水煎服。一般用 3~5 剂，有兼证者随症加减。

临床应用：樊祥冲治疗格林-巴利综合征分进展期、恢复期论治，设相对应的复方马钱子汤 I 号和复方马钱子汤 II 号，治疗本病 417 例，其中 68 例加用激素，其余有继发感染者加抗生素，极重型采取气管切开和正压呼吸。结果：基本痊愈 241 例，好转 157 例，无效（均死亡）19 例，其中重型和极重型 230 例，死亡 19 例，病死率为 8.3%。

使用注意：马钱子剂量及炮制、煎煮法均应严格遵守，免出意外。

药理研究：银花、板蓝根、大青叶、黄芩具有较好的抗病毒作用；仙灵脾、寄生起免疫调节作用；甘草有抗病毒及类似糖皮质激素样作用；马钱子含土的宁碱，兴奋脊髓运动神经元，可提高骨骼肌紧张度。故本方能阻止病情进展。

资料来源：樊祥冲，江苏医药，1981；（10）：54。

⑩复方马钱子汤 II 号

组成：生马钱子切片 3~10g，桑寄生、仙灵脾、葛根各 15~30g，黄精、黄芪、枸杞子各 30~60g，甘草 10~20g。

适应症：原用于格林-巴利综合征恢复期，现也用于急性期。

用法用量：水煎服，必要时鼻饲。

临床应用：樊祥冲曾于 1981 年和 1986 年两次报道应用复方马钱子汤系列处方治疗大宗的本病患者，取得良效。前者已于复方马钱子汤 I 号方中详述，此处介绍后者。樊氏自 1972~1983 年共收治本病 771 例，男 464 例，女 307 例；年龄 10 个月~74 岁，其中 1~15 岁 428 例（占 55.5%）。急性或亚急性起病 725 例，慢性复发型 46 例。临床设治疗组 656 例，以复方马钱子汤 II 号为主中西医结合治疗；对照组 115 例，全部用西药治疗。治疗结果：治疗组痊愈 177 例，基本痊愈 212 例，好转 245 例，死亡 22 例，病死率 3.4%；对照组痊愈 3 例，基本痊愈 3 例，好

转 72 例，死亡 37 例，病死率 32.2%。经统计学处理，两组对比有显著差异 ($P < 0.01$)。

使用注意：马钱子有一定毒性，临床应用宜注意其剂量、用法，可参考复方马钱子汤 I 号。樊氏治疗本病，生马钱子一般每天用 3~9g，炮制者用 5~12g，入煎剂；虽未发现重中毒反应，但仍宜谨慎观察。

药理研究：马钱子含土的宁碱，可选择性地兴奋脊髓，提高骨骼肌张力；黄芪、黄精、仙灵脾可调节免疫机能，并有一定抗病毒作用；甘草具有类似糖皮质激素样作用，可阻抑本病炎症的进展。

资料来源：樊祥冲，中西医结合杂志，1986；6 (8)：492~493。

⑩黄芪桂枝五物汤加味方

组成：黄芪 30g，桂枝 10g，白芍 10g，生姜 10g，大枣 6 枚，杜仲 10g，牛膝 12g，制马钱子 0.6g (吞)。

适应症：气虚络阻之急性脊髓炎、格林-巴利综合征、重症肌无力、脑血管意外以及其他感染性脊髓病引起的肢体瘫痪、肢体麻木、自汗、小便失禁、舌苔薄润、脉缓涩。

用法用量：水煎服。

临床应用：肌力差者，加炙马钱子粉适量内服；小便失禁者加覆盆子、益智仁、桑螵蛸。

使用注意：格林-巴利综合征进展期湿热重者本方慎用；马钱子剂量不宜太大。

药理研究：黄芪、白芍调节免疫机能，诱发干扰素产生；桂枝、生姜有一定的抗病毒和发汗作用；马钱子能兴奋脊髓，增强肌肉张力。

资料来源：尚炽昌，疑难病证名验方辑要，北京：华龄出版社，1990：641。

⑫马钱汤

组成：生马钱子 5～6g（先煎 30 分钟），苍术 10g，川牛膝 15g，生苡仁 20～30g，木瓜 30g，细辛 3～4g，生甘草 10g。

适应症：格林-巴利综合征。

用法用量：水煎服。

临床应用：王逢民以本方为主辨证治疗格林-巴利综合征 13 例，收到满意疗效。湿热疫毒型可加络石藤 20g，徐长卿 15g，萆薢 15g，防己 12g；脾胃亏虚型加炙黄芪 30g，桂枝 8g，白术 10g，山药 15g。

使用注意：马钱子先煎可减毒性，宜煎透。

资料来源：王逢民，首届全国中医脑病学术研讨会资料集，北京：1991。

⑬清化活络方

组成：薏苡仁 30g，白术 10g，茯苓 12g，黄芪 10g，赤芍 15g，鸡血藤 30g，桑枝 30g，板蓝根 12g，忍冬藤 12g，六一散 12g（布包）。

适应症：格林-巴利综合征初期湿热阻络，筋脉弛缓致痿（瘫痪）。

用法用量：水煎服。

临床应用：王永炎以本方为主治疗格林-巴利综合征，配合糖皮质激素，成功地抢救了重症患者。

使用注意：饮食宜清淡，忌肥甘油腻之品。

药理研究：板蓝根、忍冬藤有良好的抗病毒作用。

资料来源：董建华，中国现代名中医医案精华，北京出版社，1990：1182。

⑭疗瘫健步灵

组成：鸡血藤 1000g，天麻、仙灵脾、黄芪各 500g，牛膝 120g，制南星、全蝎、僵蚕各 30g，蜈蚣 50 条，地龙 60g。

适应症：传染性多发性神经根炎，多发性神经炎，面神经麻痹等。

用法用量：将前6味植物中药加适量水，煮沸2小时，去渣留液，加热蒸发成流浸膏；再将后4味中药，碾碎过筛制成细粉。将此细粉掺入流浸膏内和匀，置于干燥箱内或自然干燥，取出制成粉剂备用。3岁以下每次0.5~1.0g，3~6岁每次1.0~1.5g，6~12岁每次1.5~2.0g；每日3次。

临床应用：湿热重者，可与二妙丸6g同服；肝肾不足者，宜与虎潜丸10g同用；气虚者，加服补中益气丸10g。

使用注意：饮食宜清淡。

资料来源：《中西医结合儿科试用新方》

⑮附子马钱散

组成：制附子90g，制马钱子1g。

适应症：传染性多发性神经根炎后遗症，婴儿麻痹后遗症。

用法用量：共研细末。3~6岁每次0.5~1.0g，6~9岁每次1.0~1.5g，9~12岁每次1.5~2.0g。每日3次，温开水送服。可与疗瘫健步灵同时服用。

临床应用：肌力弱、行走艰难者加虎潜丸10g；遗尿者可加服金匱肾气丸10g、缩泉丸6g。

使用注意：须遵守用药剂量。

药理研究：附子含有强心的成分；马钱子能兴奋脊髓，增强骨骼肌紧张度。

资料来源：《中西医结合儿科试用新方》

⑯二妙散

组成：炒黄柏、苍术（米泔浸炒）各等分。

适应症：湿热浸淫证。肢体瘫痪无力，或兼手足麻木、疼痛、肢体微肿，扪之微热，身重面黄，胸脘痞闷，口苦粘腻不爽。口渴不欲饮水，食欲不振，小便短赤。舌苔黄腻，脉滑数或

濡数。

用法用量：为末，每服 6g，水煎入姜汁调服。

临床应用：格林-巴利综合征急性期湿热之象较明显，许多医家均以本方为主治之，如前述吴敬农七味解毒汤、清燥汤含有本方，有一定效果。

使用注意：忌食肥甘厚味。

资料来源：《丹溪心法》

⑩三妙丸

组成：黄柏 120g，苍术 180g，川牛膝 60g。

适应症：湿热下注，两下肢瘫痪或麻木不仁，或有如火烙之热。

用法用量：黄柏酒拌略炒，苍术米泔水浸，焙干，川牛膝去芦。共为末，面糊为丸，如梧桐子大，每服 50～70 丸，空心姜、盐汤下。

临床应用：本方可用于格林-巴利综合征的急性期，宜酌加清热解毒之品，如板蓝根、蒲公英、银花等。

使用注意：忌肥甘油腻之品。

资料来源：《医学正传》

⑪虎潜丸

组成：黄柏（酒炒）250g，龟板（酒炙）120g，陈皮、知母（酒炒）、熟地黄、白芍药各 60g，锁阳 45g，炙虎骨 30g（以牛骨代），干姜 15g（一方加金箔 500g，一方用生地黄 60g）。

适应症：肝肾亏损证。病势缓慢，肢体逐渐瘫痪无力，腰脊酸软不举，久则骨肉瘦削，头晕耳鸣，潮热盗汗，手足心热，遗精早泄，舌红少苔或无苔，脉细数。

用法用量：为末，酒糊为丸或粥糊为丸。

临床应用：一般用于本病恢复期和后遗症期。

使用注意：格林-巴利综合征急性期慎用本方。

资料来源：《丹溪心法》

①振颓丸

组成：人参 60g，炒白术 60g，当归 53g，乳香、没药各 30g，全蜈蚣 5 条（不用炙，选大者），穿山甲 30g（蛤粉炒），炙马钱子 30g。

适应症：气虚血瘀证。肢体痿软无力，兼有肌肉痹木，搔之不知痛痒，或筋脉拘挛痹痛，关节屈伸不利，面色萎黄，神疲乏力，纳差便溏，舌淡苔白，脉软无力。

用法用量：共轧细过罗，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 6g，无灰温酒送下，日再服。

临床应用：一般用于本病恢复期或后遗症期，兼肝肾不足者，可加地黄 12g，山萸肉 10g，牛膝 12g，杜仲 15g。

使用注意：马钱子宜炙用。方法是先将马钱子去净毛，水煮 2~3 沸捞出，用刀将外皮皆刮净，浸热汤中，早晚各换汤 1 次，浸足 3 昼夜取出。再用香油煎至纯黑色，掰开视其中心微有黄意，火候即到。将马钱子捞出，温水洗数次，将油洗净；再入锅内以砂土炒之，土有油气，换土再炒，以油气尽净为度。

药理研究：马钱子的有效成分是土的宁（番木鳖碱），对脊髓有选择性兴奋作用，可提高骨骼肌的紧张度，临床上应用马钱子治疗本病已取得良效。

资料来源：《医学衷中参西录》

②河车大造丸

组成：紫河车 1 具，茯苓、龟板各 60g，炒黄柏、炙杜仲各 45g，牛膝、麦冬、天冬各 35g，生地 75g，党参 30g，砂仁 2g。

适应症：阴损及阳，阴阳俱虚者。肢体瘫痪无力，腰脊酸软不举，甚则骨肉瘦削，头晕目眩，自汗盗汗，气怯神疲，阳痿早泄，舌红少苔，脉虚弱。

用法用量：研末，蜜泛为丸；每服 6g，日 3 服，温水送下。

临床应用：本方补肾填精，兼以清热，治疗本病则多用于恢复期及后遗症期；气虚明显者，用黄芪 30g 煎汤送服本药。

使用注意：格林-巴利综合征急性期慎用。

药理研究：紫河车含有蛋白质、糖、钙、维生素、免疫因子及女性激素、助孕酮、类固醇激素、促性腺激素、促肾上腺皮质激素等，有强壮滋补作用。地黄亦可增强下丘脑-垂体-靶腺功能，使进康复。

资料来源：《扶寿精方》

②二妙散

组成：苍术、白术、黄柏各 10g，苡米 30g，木瓜 15g，黄芪 30g，茯苓 12g，半夏 12g，白蔻 10g，葛根 12g，升麻 6g，麦冬 12g，五味子 10g，生甘草 60g。

适应症：多发性神经炎急性期，症见身热不扬或发热恶寒，胸闷脘痞，四肢沉酸无力，进而瘫软痿废，小便短赤，大便秘结或泄泻，舌质黄腻脉滑或濡数。

临床应用：湿热重则酌加防风、素苳、萆薢、桑枝、泽泻等，减黄芪、麦冬、五味子量或不用；湿重而热不显者酌加桂枝、制附子、麻黄、细辛、黄芪可加大量至 60~120g；痰多加新竹沥；脾气不足加陈皮、焦三仙等。

服上方，病情稳定后，开始恢复，进入邪祛正衰阶段，症为食少腹胀，气短，面色浮面不华，消瘦，自汗盗汗，心烦，舌苔薄白或薄黄，脉细数，证属正气衰败，邪气留连。以大补元气、健脾和胃、兼祛残邪为治则，补中益气汤加味：人参 20g，黄芪 100g，当归 18g，白术 15g，陈皮 10g，砂仁 10g，升麻 6g，柴胡 6g，熟附子 10g，山药 30g，桂枝 10g，陈曲 15g，甘草 10g。加减：阴虚明显酌加鳖甲、黄精、麦冬、沙参、石斛；减桂、附量；肾气阳虚者加寸云、肉桂、山萸肉、鹿角片（霜）；血瘀者加川芎、赤芍、桃仁、红花、鸡血藤。

错》黄芪赤风汤)。

(八)羌活 1000g, 谷子 45g (水中取沉者), 捣筛为丸, 每服 9g, 日 3 服 (《外台秘要》热风瘫痪方)。

(九)金钗石斛 30g, 玄参 6g, 水煎服 (《辨证录》)。

(十)草薢、杜仲、苁蓉 (酒浸)、菟丝子 (酒浸) 各等分。以酒煮猪腰捣和为丸, 每服 10g, 空心温酒送服 (《奇效良方》金刚丸)。

四、中成药

格林-巴利综合征没有专病中成药, 可据证情酌选银黄口服液、大活络丹、人参再造丸、人参归脾丸、虎潜丸, 亦可选用中药清热解毒针剂“双黄连” (成分: 银花、黄连、连翘) 静脉点滴。此处介绍专治湿热痿证 (类似于本病急性期) 的古方四妙丸, 可参用。

来源:《成方便读》

组成: 苍术、炒黄柏、牛膝、苡苡仁各等分。

功效: 清热燥湿。

主治: 湿热下注之痿证。证见下肢痿弱无力, 小便黄赤, 大便溏解热臭。苔黄腻, 舌质红, 脉濡或数。

用法用量: 制成水丸, 每服 6~10g, 日服 2~3 次, 温开水或淡盐汤送下。

临床应用: 本方对湿热致痿的治疗较二妙丸、三妙丸力强。近年来各地对格林-巴利综合征急性期的治疗, 除应用专方外, 多在本方基础上辨证治疗, 取得了一定的疗效。

方义解释: 由于湿热疫毒侵袭, 浸淫经脉, 气血运行阻滞, 致成本病。“伤于湿者, 下先受之”, 故下肢痿软无力最多; 气血不荣经络, 则见不知痛痒, 肌肉痹木无知; 若湿阻络瘀, 亦见经络疼痛或麻木。方中以黄柏苦寒清热解毒、苍术苦温燥湿, 苡仁

392例,其中92例并用山莨菪碱30~50mg,加入10%葡萄糖500ml静脉滴注,每日1次,之后每4小时肌肉注射山莨菪碱10~30mg;或者用东莨菪碱3.0~4.5mg,加入10%葡萄糖500ml静脉滴注,每日1次,之后0.6~0.9mg维持,病情好转后减量乃至停药。西药组有效率为67.8%,病死率32.2%;中药组有效率为93.5%,病死率为6.4%;中西医综合治疗组有效率为98.7%,病死率为1.3%。马钱子汤组疗效优于西药组,中西医结合治疗组疗效又优于马钱子汤组。以在固定时间内肌力恢复达Ⅳ°进行统计,中西医结合综合治疗组和西药组及中药马钱子汤组相比均有显著差异($P<0.01$),加用莨菪类药治疗的92例与同期71例未用莨菪类药者相比疗效又有提高。在平均住院天数、气管切开后的平均拔管天数和正压呼吸天数等方面均有明显减少。认为以复方马钱子汤为主的中西医结合方法能较快地阻止病情的进展,甚至在短时间内改善病情。对有较严重呼吸肌麻痹的极重型病例,加用大剂量的莨菪类药治疗,往往使病情转危为安,避免或减少了气管切开,1978年以来本病病死率降至1.3%(樊祥冲,中西医结合杂志,1986;6(8):492)。

(三)近年中医治疗格林-巴利综合征较为突出的特点是马钱子制剂的应用。方法有散剂,也有生用或炙用入煎剂者;用量也突破了禁区,少者5g,大者12g,这在前代是不可想象的。马钱子制剂的应用确实提高了临床疗效,降低了病死率,但其治疗机制尚未完全阐明,宜作进一步探讨(刘毓麟等,中西医结合杂志,1984;4(12):754。萧佐桃等,中医杂病集成,湖南科学技术出版社,1991:394)。

八、主要参考资料

1. 樊祥冲, 中西医结合杂志, 1986; 6(8): 492
2. 刘毓麟等, 中西医结合杂志, 1984; 4(12): 754

癲 癇

癲癇是一种常见的、由不同原因导致的神经系统慢性发作性病患，是反复发作的神经元异常放电所致的暂时性发作性脑功能失调。可表现为运动、感觉、意识、行为和植物神经等功能的不同障碍，或兼而有之。常见的类型有大发作、小发作、局限性发作、精神运动性发作和癲癇持续状态等。临床表现与有关神经元的部位和神经元异常放电扩散的范围有关。

癲癇的发病率与患病率，各家报告不尽相同；一般而言，国外年发病率约 17.3/10 万～100/10 万，国内为 35/10 万；患病率欧美国家为 2‰～7‰，我国约 4.7‰。据国内流行病学资料，男性发病较多，男女之比约 1.7:1。发病的类型与表现和年龄有明显关系。本病至少有 40% 无原因可稽，属原发性癲癇；癲癇病人家属中的癲癇患病率为一般人口中癲癇患病率的 4～7.2 倍；初次发病多在 19 岁以前（60.6%）。癲癇对青少年生长发育有严重影响而且难以治愈。

本病临床上多表现为发作性肢体抽搐、几乎均有意识丧失、有时有精神异常，持续短暂并反复发作。属于中医学“痫证”、“癲证”范畴。

一、病因病机

本病的发生，主要责之心、肝、脾肾四脏脏气失调，引起一时性阴阳紊乱，气逆痰涌，火炎风动，蒙蔽清窍。

(一) 素体亏虚 心主血脉，由于用脑过度而伤心血，心血不足则神失所养；肾虚肝失所养，肝血不足；脾虚运化不健，精微不布，不能荣脑，均致脑之元神功能失调，发为癫痫。

(二) 痰浊内聚 饮食失调，脾气素虚则痰浊内聚，一旦七情失调，尤以骤然大惊、大恐、大怒为甚。惊则气乱，肝失条达而横逆，甚则抽搐，痰随气动，上冲于元神之府或蒙蔽心窍均可使神明丧失。恐则气下，精血不能随气上承，心神及元神之府失养而神明不用，水不涵木则导致肝风内生。大怒伤肝，怒则气上，肝气不舒，五志化火，若兼脾虚生痰，则痰火互结，火扰心，痰闭窍，痰火随气上冲于脑而抽搐神昏。

(三) 外感六淫 邪气干扰脏腑之气的平衡，轻者邪退而脏气渐平，重者或素来脏腑之气偏颇者，则邪虽退而气机仍不能和顺。肝失条达，脾失健运，痰浊遂生，肝气郁结则化火生风，风火痰上扰于脑则生癫痫。

(四) 瘀血内阻 跌仆、产伤损及脑部，瘀血内阻，血流不畅，脑气阻塞，神明失用，乃发抽搐。

另外，虫邪内生于脑，脑之神机因之阻滞，亦可发为癫痫。痰浊和气滞血瘀可相互影响，使癫痫之病机更趋复杂，痰瘀互结可使本病反复发作，难以根治。

二、辨证施治

(一) 辨证要点

1. 癫痫发作主要与心肝脾肾四脏有关。心主血、主神明，心血不足，心火亢旺，神不守舍则精神错乱，自言自语，无故游走。肝藏血性喜条达，肝血不足，肝风内动；或肝气郁结日久化热，挟痰上扰，蒙蔽清窍，均可发为痫证。肾主水藏精，肾阴虚，肝失所养，肝风挟痰，上扰清窍亦为痫证。脾主运化，脾虚运化失职，痰湿内聚，随气上逆，蒙于清窍，则痫证突发。外伤

瘀血，阻塞清空，阳气被郁，或瘀久化热，兼热灼痰凝，风痰气逆上扰亦可发病。临证之时宜辨识何者为主而治之。

2. 癲癇见证繁复，初、中期身体较为壮实，发作较频繁，以实证为主；久病精神困顿，疲软乏力，虽见抽搐，亦宜顾及体虚之一面，用药不宜单纯讨伐。

（二）辨证分型

1. 肝风痰浊型

发作前见头昏、眩晕、胸闷、乏力，情绪不稳，继而突然尖叫，昏仆倒地，不省人事，面色苍白，牙关紧闭，口吐白沫，两眼上翻，四肢抽搐，二便失禁，或见短暂意识丧失，双眼发呆，茫然所失，语句中断，持物落地。舌质淡红，苔腻，脉弦滑。

2. 肝火夹痰型

平素性情急躁，心烦失眠，口苦咽干，大便秘结，发时仆倒于地，不省人事，四肢抽搐，口吐涎沫。舌红苔黄，脉弦数。

3. 瘀血阻窍型

头部或有外伤史，或曾有脑卒中，头刺痛、常有定处，发时昏仆，肢体抽搐。舌质紫暗或有瘀斑，脉涩或紧。

4. 囊虫内扰型

曾有进食“米”猪（或牛）肉史，周身皮里膜外生有“痰核”（病理检查证实为囊虫），忽然头痛，神昏仆倒，口吐白沫，角弓反张，四肢抽搐。苔腻浊，脉弦或细。

5. 肝肾阴虚型

发作日久，腰膝酸软，头晕眼花，失眠多梦，记忆力差，心悸不宁，五心烦热，口干舌燥，大便干结。舌红少苔，脉细数。

6. 脾胃虚弱型

癇证久发，神疲乏力，面色无华，眩晕时作，食欲不振，恶心呕吐，大便溏泄。舌质淡，脉细濡。

7. 心血亏虚型

平素心悸气短，失眠梦扰，头晕健忘，口苦咽干，发时精神错乱或无故游走，喃喃自语，或欣快、发怒，不识他人。舌质淡，脉细数。

(三) 治法方药

癫痫的中药治疗，发作期宜予豁痰，开窍、醒神；缓解期（间歇期）宜辨证分型施治，发作频繁而体实者宜着重祛痰、息风、化痰、去虫、止搐；久病体弱则宜补虚为主，否则不易收效；若体虚邪实，则补虚与祛邪二法宜予相兼。

1. 分型治疗

(1) 肝风痰浊型 化痰息风，开窍定痫。定痫丸加减：天麻、胆南星、半夏、陈皮、麦冬各 10g，茯神、远志、菖蒲各 15g，白僵蚕 12g，全蝎 6g，琥珀 2g（冲服）。无津伤可去麦冬；痰涎难咯加全瓜蒌 30g，宽胸豁痰；痰涎清稀加干姜 5g，温化痰饮。

(2) 肝火夹痰型 清肝泻火，化痰开窍。龙胆泻肝汤合涤痰汤损益：龙胆草、黄芩、胆南星、枳实、半夏各 10g，茯神、远志、石菖蒲各 15g，白僵蚕 12g，钩藤 20g，全蝎 6g。便秘加生大黄 5g（后下）通腑泄热，痰粘加竹沥水 10ml（冲服）清热豁痰。

(3) 瘀血阻窍型 活血化瘀，息风止抽。通窍活血汤出入：赤芍 15g，川芎 12g，桃仁 10g，僵蚕 20g，全蝎 6g，天麻 10g，蜈蚣 4 条，丹参 20g。便干加生大黄 5g（后下）通腑；痰多加胆南星 12g，天竺黄 12g，以化痰清热。

(4) 囊虫内扰型 杀虫化痰，定痫止抽。验方化虫丸：槟榔 60g，雷丸、干漆各 30g，郁金 25g，枯矾 20g，白芥子 15g。共研末，炼蜜为丸，每丸重 5g，早晚各服 1 丸。可加入全蝎 60g，蜈蚣 15 条，以息风止痉。

(5) 肝肾阴虚型 滋肾养肝，潜阳息风。大定风珠汤加减：

生地 30g, 麦冬 12g, 阿胶 10g (烔化), 鸡子黄 1 只, 醋龟板 30g, 生牡蛎 20g, 醋鳖甲 30g, 白芍 15g, 五味子 10g, 火麻仁 10g。急躁心烦, 心肝火旺加龙胆草 10g, 灯芯草 3g, 以清火除烦; 食欲不振加焦山查、炒麦芽、神曲各 10g, 消食助运。

(6) 脾胃虚弱型 健脾益气, 和胃降逆。六君子汤加味: 党参 15g, 白术 12g, 茯苓 20g, 半夏 10g, 橘红 10g, 生龙牡各 30g, 钩藤 30g, 僵蚕 15g, 甘草 6g。痰多加石菖蒲 12g, 胆南星 12g, 远志 6g; 呕恶腹胀加枳壳 10g, 竹茹 6g, 和中理气。

(7) 心血亏虚型 养血安神, 平肝息风。酸枣仁汤合甘麦大枣汤增删: 酸枣仁 30g, 知母 10g, 茯神 30g, 当归 12g, 生地 30g, 党参 12g, 甘草 12g, 小麦 30g, 大枣 10 枚, 黄连 6g。抽搐者加全蝎 10g, 僵蚕 15g, 蜈蚣 4 条, 息风定搐; 大便秘者加生大黄 6g, 芒硝 10g (冲), 枳壳 10g 泄热通便, 以助息风。

2. 方药选介

①清热镇惊汤加减方

组成: 钩藤 12g, 朱砂 1g, 天竺黄 5g, 龙胆草 9g, 柴胡 7g, 木通 3g, 黄连 4g, 灯芯 2g, 竹叶 6g, 甘草 5g。

适应症: 阳痫证。多有头晕头痛、胸闷等先兆症状, 旋即昏倒, 不省人事, 面色先潮红、紫红, 继则青紫或苍白, 口唇青暗, 两目上视, 牙关紧闭, 颈项侧扭, 手足抽掣, 或喉中痰鸣, 或口吐涎沫, 或有类似猪羊叫声, 甚则二便自遗。可渐渐苏醒, 一如常人。舌质红, 苔白腻或黄腻, 脉弦数或弦滑。

用法用量: 水煎服。每日 1 剂, 2 次分服。

资料来源: 尚炽昌, 疑难病证名验方辑要, 北京: 华龄出版社, 1990: 572。

②五生丸

组成: 生南星、生半夏、生川乌、白附子、黑豆等量。

适应症: 阴痫证。证见面色黯晦萎黄, 手足清冷, 神志昏

愤，偃卧拘急，口吐涎沫，声音微小，或颤动，或抽搐，也有仅呆小无知，不闻不见，不语不动，1日数次至数十次频作者。舌质淡，苔白厚腻，脉沉细或沉迟。

用法用量：姜汁糊丸。每服3g，1日2次。

资料来源：尚炽昌，疑难病证名验方辑要，北京：华龄出版社。1990：572。

③龙胆泻肝汤

组成：龙胆草、生地黄、当归各1g，柴胡、泽泻各3g，车前子、木通各1.5g。（《医宗金鉴》方有黄芩、栀子、甘草）。

适应症：肝火痰热证。证见焦急郁怒，烦躁失眠，口苦咽干，咯痰胶稠，大便秘结，突然发作，昏仆抽搐、口吐涎沫，或有吼叫，舌质偏红，苔黄或黄腻，脉弦滑数。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

资料来源：《兰室秘藏》

④泻青丸

组成：当归、冰片、川芎、栀子、大黄（湿纸裹煨）、羌活、防风各等分。

适应症：肝火郁热，夜卧不安，易惊，抽搐，脉洪大者。

用法用量：为末，炼蜜为丸，芡实大，每服半丸至1丸，竹叶煎汤，用砂糖、温水化下。

资料来源：《小儿药证直诀》

⑤当归龙荟丸

组成：当归、龙胆草、栀子、黄连、黄柏、黄芩各30g，大黄、芦荟各15g，木香4.5，麝香2.5g。

适应症：肝胆实火而致的抽搐、惊悸、眩晕、胁痛、谵语发狂、便秘溲赤，或耳鸣耳聋等。

用法用量：为末，糊丸或蜜丸，每服6g。

资料来源：《丹溪心法》

⑥五癇丸

组成：天南星 30g（炮），乌蛇 30g（酒浸一宿，去皮、骨，焙干，称），朱砂 7.5g（另研），全蝎 6g（去毒），半夏 60g（汤浸 7 次），雄黄 4.5g（研），蜈蚣半条（去头、足、炙），白僵蚕 45g（炒，去丝、嘴），白附子 15g（炮），麝香 1g（另研），白矾 30g，皂角 120g（捶碎，用水 250ml，捣汁去滓，与白矾一处熬干为度，研）。

适应症：癲癇。

用法用量：上药为细末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服 30 丸，食后用生姜汤送下。

资料来源：《杨氏家藏方》卷二

⑦定癇丸

组成：明天麻、川贝母、姜汁炒半夏、蒸茯苓、茯神（去木蒸）各 30g，胆南星（九制者）、石菖蒲（杵碎取粉）、去尾全蝎（甘草水洗）、僵蚕（甘草水洗，去嘴，炒）、腐煮真琥珀（研）、灯草各 15g，洗陈皮（去白）、远志（去心、甘草水洗）各 21g，酒蒸丹参、去心麦冬各 60g，辰砂（研细、水飞）9g。

适应症：痰热内扰。男女小儿癇证，忽然发作，眩仆倒地，不省高下，甚则痰壅抽搐，目斜口歪，痰涎直流，叫喊作声。亦可用于癲证。

用法用量：用竹沥 100ml，姜汁 20ml，再用甘草 120g 熬膏，和药为丸，如弹子大，辰砂为衣。每服 6~9g，照五癇分引下：犬癇，杏仁 5 枚，煎汤化下；羊癇，薄荷 1g，煎汤化下；马癇，麦冬 6g，煎汤化下；牛癇，大枣 2 枚，煎汤化下；猪癇，黑豆 9g，煎汤化下。每日 2~3 次。

临床应用：西安医学院第一附属医院中医科报道，用定癇丸治疗 21 例癲癇，总有效率达 85.7%（中医杂志，1982；（6）：75）；胡氏报告用定癇丸加减改为水煎剂治疗癲癇，疗效也甚满

意（辽宁中医，1965；（1）：35）。

资料来源：《医学心悟》卷四

⑧白金丸

组成：白矾、郁金各等分。

适应症：痰迷心窍证。证见痰多烦躁，突然昏倒，口吐涎沫，神志不清，舌质淡苔白，脉滑。

用法用量：皂荚汁为丸。每服3～6g，每日1～2次。

临床应用：何炎燊等用本方加半夏、南星、石菖蒲等祛痰开窍之味治疗癫痫，收效理想。

资料来源：何炎燊等，中华内科杂志，1977；（5）：320。

⑨黄芪赤风汤

组成：黄芪60g（生），赤芍3g，防风3g。

适应症：原治诸疮诸病，或因病虚弱者；现亦用于癫痫气虚血瘀者。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：对于脑外伤形成瘢痕，或脑部炎症引起的粘连，在大脑皮层运动区（中央前回）产生刺激性病灶，或其他各种原因导致的脑部缺血、缺氧，致使癫痫发作。运用补气活血药为主（或佐以化痰药）治疗癫痫，可以改善脑血流循环，促进瘢痕吸收，粘连缓解，使皮层运动区停滞性病理性兴奋灶渐趋消失，从而癫痫停止发作。杨启茂等以本方治疗癫痫，收效理想（福建中医药，1964；（5）：27）。

资料来源：《医林改错》卷下

⑩左归丸

组成：熟地250g，山药120g（炒），枸杞子120g，山茱萸肉120g，川牛膝90g（酒洗，蒸熟，精滑者不用），菟丝子120g（制），鹿胶120g（敲碎，炒珠），龟胶120g（切碎，炒珠）。

适应症：肾精亏损证。证见癫痫发后，神思恍惚，面色晦

暗，头晕目眩，两眼干涩，健忘失眠，腰酸腿软，耳鸣便干。舌红苔少，脉细数。

用法用量：先将熟地蒸烂杵膏，加炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹时用滚汤或淡盐汤送下 100 丸。

资料来源：《景岳全书》卷五十一

⑪六君子汤

组成：人参（去芦）、甘草（炙）、白茯苓（去皮）、白术（去芦）、陈皮、半夏各等份。

适应症：脾虚痰盛证。证见痛证发作日久，神疲乏力，身体瘦弱，食欲不佳，眩晕时作，面色不华，大便溏薄，痰多恶心，或胸脘痞闷。舌质淡，苔白腻，脉濡滑或弦滑。

用法用量：上锉末，每服 9g，用水 150ml，煎至 100ml，不拘时服。

资料来源：《世医得效方》卷五

⑫滋阴宁神汤

组成：当归、川芎、白芍、熟地、人参、茯神、白术、远志各 3g，酸枣仁、甘草各 1.5g，黄连（酒炒）1.2g。

适应症：癲病属阴血虚损者。证见突然昏倒，不省人事，口禁目闭，抽搐吐沫。醒如常人，但头晕心悸，双目干涩，唇甲淡白，手足搐动，或月经前后发作频繁。舌质淡或舌尖红，苔薄白，脉细滑。

用法用量：上药加生姜，水煎，温服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：《医学入门》

⑬磁朱丸

组成：神曲 120g，磁石 60g，朱砂 30g。

适应症：心肾不交证。证见精神不安，心悸失眠，耳鸣耳聋，惊痫时作。

用法用量：上3味，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服3丸，日3服。

临床应用：尤洪范等以磁朱丸加味治疗癫痫取得满意效果（吉林中医药，1981；（2）：40）；清柯韵伯推崇磁朱丸为“治癫痫之要剂”（《删补名医方论》）。

资料来源：《备急千金要方》

⑭大补元煎

组成：人参少则用3~6g，多则用30~60g，山药（炒）6g，熟地少则用6~9g，多则用60~90g，杜仲6g，当归6~9g（若泄泻者去之），山茱萸3g（如畏酸吞酸者去之），枸杞6~9g，炙甘草3~6g。

适应症：气血大亏，肚肾不足，甚则精神失守，病证危剧。癫痫体质大虚者可用之。

用法用量：用水400ml，煎至280ml，空腹时温服。

资料来源：《景岳全书》

⑮星香二陈汤

组成：天南星、木香、陈皮、半夏、茯苓、紫石英、甘草、生姜。

适应症：风痰痫证。证见发作前夕头晕胸闷恶心欲呕，随即猝倒，不知人事，手足抽搐，角弓反张，两目上视，口眼牵引，喉出畜声，将醒之时，口吐白沫或流清涎，脉多滑大，舌苔白厚腻。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

资料来源：《简明中医内科学》

⑯赵氏痰痫验方

组成：青礞石10g，石决明12g，天麻6g，天竺黄10g，胆南星6g，钩藤3g，全蝎2.4g，僵蚕6g，代赭石10g，南红花5g，桃仁3g，法半夏15g。

适应症：癲癇痰浊内扰，肝风内动，瘀血阻窍证。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

资料来源：《赵心波儿科临床经验选编》

⑯赵氏惊癇验方

组成：石决明 12g，天麻 6g，蜈蚣 2条，广郁金 10g，南红花 5g，石菖蒲 6g，龙胆草 5g，神曲 10g，桑枝 10g，全蝎 3g，朱砂 1.2g（分冲）。

适应症：癲癇痰热蒙窍，肝风内动，每遇惊扰则发作癲癇者。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

资料来源：《赵心波儿科临床经验选编》

⑰赵氏癲癇小发作验方

组成：钩藤 5g，法半夏 3g，全蝎 1.5g，南红花 5g，桃仁 3g，天麻 6g，僵蚕 6g，生侧柏 10g，珍珠母 10g，煅牡蛎 10g，远志 6g。

适应症：癲癇小发作，常为楞神表现。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

资料来源：《赵心波儿科临床经验选编》

⑱医病无双丸

组成：南星 30g，半夏 30g（2味用白矾、皂角、生姜煎汤浸1日夜透，切片，随汤煮干，去矾、皂、姜不用），川芎 9g，归身（酒洗）、软石膏各 30g，天麻 21g，僵蚕 1.5g，生地黄（酒炒） 30g，荆芥穗 15g，辰砂 15g，川独活 15g，乌犀角 15g，白茯苓（去皮）、拣参各 30，远志（甘草水泡，去心）、麦冬（去心）、白术（去芦油）、陈皮（去白）各 15g，酸枣仁（炒） 15g，黄芩 9g，川黄连（去皮） 15g，白附子（煨）、珍珠、甘草各 9g，金箔 30片。

适应症：癇证。

用法用量：上为细末，用好酒打稀糊为丸，如梧桐子大，金箔为衣。每服 50 丸，空腹时用白汤送下。

资料来源：《寿世保元》

②定搐化风锭

组成：全蝎 20 只，桔梗 10g，黄连 10g，蝉蜕 15g，甘草 10g，防风 15g，羌活 15g，大黄 15g，僵蚕 15g，法半夏 15g，麻黄 3g。

适应症：痰热夹风之癫痫证。

用法用量：上药除全蝎外，共轧细面，再将全蝎混入，再轧过罗。每 300g 兑朱砂 30g，牛黄 5g，麝香 5g，冰片 10g，共研匀蜜为丸，重 3g；每服 1 至 2 丸，每日 2 次。

资料来源：《景岳全书·古方八阵》

②柴胡加龙骨牡蛎汤

组成：柴胡 12g，龙骨、黄芩、生姜、铅丹、人参、桂枝（去皮）、茯苓各 4.5g，半夏 6g，大黄 6g（切），牡蛎 4.5g（熬），大枣（擘）6 枚。

适应症：原用于伤寒往来寒热、胸胁苦满，烦躁惊狂不安，时有谵语，身重难以转侧；现用于癫痫、神经官能症、美尼尔氏综合征以及高血压病等见有胸满烦惊为主证者。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：岳美中教授生前认为癫痫为肝风所致。主张因势利导，以柔制刚，尤其对顽固性癫痫，宜用育阴潜阳法治疗，选用柴胡加龙骨牡蛎汤。陈华鹰，（柴胡加龙骨牡蛎汤医治作用的探讨，浙江中医杂志，1964；7（7）：20）、钱元龙（柴胡加龙则牡蛎汤临床运用的探讨，江苏中医，1965；（3）：4）、夏睿明（柴胡加龙骨牡蛎汤临床运用的体验，重庆医药，1977；（2）：14）以及日本尾台榕堂（《类聚方广义》）均将本方应用于癫痫，效果较确。日人中神琴溪（《生生堂治验》）也有以本方治癫痫病

的治险。日人相见氏统计 1969~1975 年 433 例癲病患者，其中 63% 有胸胁苦满和腹直肌挛缩的症状，结合癲病“休作有时”的特点，认为此类属柴胡汤证，结合癲病之风痰证治，应用柴胡加龙骨牡蛎汤正合病机。

资料来源：《伤寒论》

② 邢氏养阴镇癲方

组成：硫化铅、生赭石、生地、元参、生山药、牛黄、琥珀、羚羊粉、麝香、钩藤、胆南星、天麻、清半夏、全虫、天竺黄、蜈蚣。

适应症：癲病。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：《邢锡波医案选》

③ 绝癲汤

组成：煅礞石、天竺黄、天麻、陈胆星、法半夏、钩藤、桃仁、红花、生侧柏。

适应症：癲病。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

资料来源：张汤敏验方，癲病新疗法，北京化学工业出版社，1991。

④ 桂芍镇癲片

组成：柴胡、党参、甘草、半夏、桂枝、生姜、黄芩、芍药、大枣等。

适应症：癲病，大发作及小发作。

用法用量：成人 6 片/次，日 3 次，小儿酌减，单用本药或并用其他抗癲药。

临床应用：治疗顽固性癲病 36 例，服药 6~12 个月，总有效 16 例。本方对发作频度高者效果较差，以普遍性发作者较优，副作用较小。

例；无效 2 例。

资料来源：焦源，湖北中医杂志，1985；(1)：16。

③ 癫痫宁

组成：马蹄香、石菖蒲、甘松、牵牛子、千金子等。

适应症：癫痫。

用法用量：每片 300mg，口服 900mg（儿童 60～300mg），每日 3 次。连服 2 月，无效者停药，有效者继续服用。

临床应用：治疗 24 例，显效 1 例，有效 19 例，无效 2 例，未定疗效 2 例（不满 1 疗程）。脑电图观察 20 例，治疗后好转 17 例。

资料来源：张翼麟，云南中医杂志，1985；6（4）：16～18。

④ 雄黄停痫丸

组成：钩藤、制乳香各 25g，琥珀、天竺黄、天麻、全蝎、胆南星、郁金、黄连、木香各 19g，荆芥穗、明矾、甘草各 13g，珍珠、冰片各 2g，绿豆 200 粒。

适应症：癫痫。

用法用量：各药研细末，制成水丸如绿豆大，以雄黄 25g，朱砂 5g 研细末为衣；成人每次 4～6g，1 岁儿童 1～1.5g，随年龄体质增减药量，每日 2 次，温开水冲服；儿童以 1 月、成人以 3 月为 1 疗程。

临床应用：治疗癫痫 87 例，临床控制（服药 1 疗程，随访 1 年以上无发作）34 例，有效（服药期间及停药后尚有发作、但症状较轻、间隔时间延长）20 例，无效 33 例，总有效率 62%。认为停止发作后，须连续服药 100 天～1 年以上，以免复发。

资料来源：张洪海等，上海中医药杂志，1987；(10)：27～28。

⑤ 王氏癫痫丸

组成：巴豆霜 5g，杏仁 20g，赤石脂、代赭石各 50g。

适应症：癲癇。

用法用量：巴豆去壳并挤压去油，取渣制成巴豆霜，加入余药，共为细末，制成蜜丸如赤豆大。成人饭后服 3 粒/日 3 次。如无不良反应加至每次 5 粒，儿童酌减。发作频繁、间歇短者以 1 月为 1 疗程；发作次数少、间歇时间长者以 2 月为 1 疗程。

临床应用：324 例观察表明，治愈（症状完全消失，1 年以上无癲癇发作）247 例，好转 59 例，无效 18 例，总有效率 94.4%。

资料来源：王宗起，吉林中医药，1988；（1）：10。

④马南汤

组成：羚羊角、天南星、全蝎、地龙、菖蒲、半夏、僵蚕、皂角、天麻、柴胡、木耳、马钱子（冲服）。

适应症：癲癇。

用法用量：马钱子先用水煎 90 分钟，捞出去皮，用麻油炸至焦黄色，研面，装瓶。每服 3g，以上方其余药物煎汤冲服，每日 1 次。缓解期以上方制成散剂，一般服 3 个月左右。

临床应用：以本方治疗癲癇 40 例，结果：2 年以上未复发者 14 例，6 个月～2 年停止发作者 16 例，发作次数减少、间歇期延长，症状减轻者 8 例，无效 2 例，总有效率 95%。

使用注意：忌食绿豆、茶叶、荤腥油腻、生冷、辛辣。

资料来源：张家庆，四川中医，1988；6（2）：31。

⑤通脉愈癇丸

组成：赤芍、桃仁、川芎各 30g，丹参 90g，法半夏、生南星、煅礞石各 45g，石菖蒲 20g，肉桂 15g，当归、紫河车、黄芪、党参各 60g，天麻 50g。

适应症：脑外伤继发性癲癇。

用法用量：上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重 10g；每次 1 丸，1 日 3 次，姜汤送服，儿童酌减。1 月为 1 疗程。

(5%); 总有效率 95%。

资料来源: 张家庆, 马南汤治疗癫痫 40 例疗效观察, 山西中医, 1988; 4 (6): 14。

④马蝎散

组成: 马钱子 120g, 全蝎 40g, 广地龙 40g, 石菖蒲 40g, 制半夏 40g, 僵蚕 40g, 乳香 40g, 没药 40g, 生甘草 40g, 生绿豆 60g。

适应症: 癫痫。

用法用量: 先将马钱子与绿豆放在砂锅里加水煮, 视绿豆开花为度。弃绿豆取马钱子去皮切成薄片, 置烘箱内烘干, 研极细粉末。将乳香、没药放在新瓦片上煨去油脂冷后粉碎。其余药物均烘干粉碎过筛, 与马钱子粉、乳没粉混匀, 贮藏在棕色玻璃瓶中密封备用。3 岁以下小儿每日量 0.5g, 4~7 岁每日量 0.7~1.2g, 8~15 岁每日量 1.2~1.8g, 16 岁以上每日量 1.8~2.4g。最大剂量不超过 3g。每晚睡前半小时用黄酒冲服, 小儿可用温开水冲服。亦可将药粉装入空胶囊吞服。45 天为 1 疗程。服本方第 1 疗程时须同时服抗痉挛西药, 第 2 疗程开始减 1/2 量, 第 3 疗程减 2/3 量, 第 4 疗程停药西药。控制症状后仍需服本方至 1 年。

临床应用: 所治癫痫 40 例, 临床症状均符合癫痫症, 其中 34 例脑电图显示为癫痫, 12 例未见异常, 4 例未做脑电图。男 30 例, 女 10 例; 年龄最小 8 个月, 最大 35 岁; 病程最短 5 个月, 最长 32 年。结果: 临床控制 (各种类型的痫性发作症状已完全控制, 停药后 2 年以上不发, 或脑电图复查连续 2 次以上无痫性波) 14 例; 显效 (各类癫痫在 6 个月至 2 年内停止发作) 19 例; 有效 (发作次数明显减少, 间隙期延长, 发作时症状减轻, 或多种症状已控制 1 种) 6 例; 无效 (各类发作均无改善) 1 例。

资料来源：吴宝信，“马蝎散”治疗 40 例癲癇的疗效观察，上海中医药杂志，1986；(7)：32。

④止癇灵

组成：黄芪 10g，黄精 10g，柴胡 10g，三棱 6g，莪术 6g，丹参 15g，川芎 6g，二丑末 3g，青礞石 15g，菖蒲 10g，川连面 3g，黄芩 6g，蜈蚣 3g，生龙牡 15g，珍珠母 15g。

适应症：癲癇。

用法用量：上药制成冲剂，每袋相当于两剂中药剂量，每次 1/4 袋，每日 2 次。夜间发作者睡前服半袋，1 次顿服。

临床应用：57 例，服药最短 3 个月，最长者 2 年。结果：共治发作完全控制 23 例，发作控制 50% 以上 21 例，发作控制 30%～50% 7 例；总有效率为 89.4%。

资料来源：王允荣，止癇灵为主治疗小儿癲癇 57 例临床观察，中医杂志，1986；27 (3)：180。

④化癇止抽二号方

组成：青礞石 10g，地龙 6g，全蝎 6g，钩藤 6g，天麻 6g，胆南星 7.2g，二丑 15g，法半夏 5g，桃仁 5g，红花 5g，沉香 3g，生大黄 3g，人工牛黄 0.3g，白矾 8g。

适应症：癲癇。

用法用量：上药剂量配制汤剂，散剂，片剂均可。汤剂每日 1 剂，连服 1～3 个月后用散剂或片剂巩固疗效。周岁以内每次 1g，1～3 岁每次 1.5g，4～7 岁每次 2g，8～14 岁每次 2.5～3g，成年人酌情加量。每日服 3 次，严重者可增加到每日 4 次，白开水送服。服药初期可引起每日腹泻 2～3 次，约 1 周内转为正常。

临床应用：所治癲癇 75 例中，男 39 例，女 36 例，年龄 1～40 岁，病程 1～21 年。结果：治疗期间未用或减用抗癲癇西药，药后连续半年以上未发作，或维持原用抗癲癇西药量，治疗后连续半年以上未发作为显效，共 35 例；维持原抗癲癇西药量，

治疗后发作次数减少 50% 以上为好转，共 32 例；无效 9 例。

资料来源：朱文中等，化痫止抽二号方治疗 75 例癫痫小结，湖北中医杂志，1982；(5)：24。

⑬ 风引汤

组成：大黄、干姜、龙骨各 56g，桂枝 42g，甘草、牡蛎各 28g，寒水石、滑石、赤石脂、白石脂、紫石英、石膏各 84g。

适应症：癫痫、风瘫。突然仆卧倒地，筋脉拘急，两目上视，喉中痰鸣，神志不清，舌红苔黄腻，脉滑者。

用法用量：上十二味，杵末粗筛，以布囊盛之。每服 6～9g，用井花水 300ml，煮 3 沸，温服 100ml。

临床应用：应用本方水煎服，每日 1 剂。顽痰加礞石；食滞加建曲。治疗癫痫 100 例中，男 63 例，女 37 例；病程 1 年以下者 14 例，1～5 年 52 例，5 年以上 26 例，20 年以上 8 例。结果：停药后随访 2 年以上无复发为治愈，共 46 例；停药半年后复发，经服药又予控制者为显效，共 15 例；在服药期间或停药后发作次数减少，症状减轻者为有效，共 25 例；服药后病情未见改善者为无效，共 14 例。

资料来源：白炳森等，风引汤治疗癫痫 100 例临床小结，河北中医，1986；(4)：24。

⑭ 甘松汤

组成：甘松、凌霄花、附子、石菖蒲各 10g，代赭石 30g，藜芦 3g。

适应症：癫痫。

用法用量：每日 1 剂，水煎分 2 次服。

临床应用：本组 41 例中，男 22 例，女 19 例；年龄 1～61 岁，平均 22.3 岁；病程 1 个月至 20 年，平均 6.6 年；初发病在 20 岁以下者 20 例；病因属原发性的 34 例，继发性的 7 例。结果：17 例显效（发作完全控制，停发 6 个月以上），11 例有效

(发作次数明显减少，大小发作和多种发作中，一种发作控制，另一种发作虽未能完全控制，但次数减少)，13例无效（发作频率无明显改善）。

资料来源：曾广盛，甘松汤治疗癲癇 41 例疗效分析，浙江中医杂志，1981；(11)：521。

④⑤宁癲散

组成：蚤休、川郁金、白矾各 15g，广木香、制香附各 9g，辰砂 1.5g。

适应症：癲癇。

用法用量：上药共研细末，分 10 包，成人每天服 1 包，儿童减半。白天发作者上午服，夜晚发作者睡前服，连服 3 个月为 1 疗程。

临床应用：所治癲癇 40 例中，男 28 例，女 12 例；年龄最小 1 岁，最大 38 岁；病程最短 1 年，最长 10 年。各例每年平均大发作都在 5 次以上，用西药及其他中药而未能奏效者。结果：连续服药 3 个疗程者 28 例，随访 3 年，未再发病者为显效，共 23 例；偶有发作，但程度减轻者为有效，共 3 例；3 年内照常发病者为无效，共 2 例。连续服 2 个疗程者 12 例，显效 5 例，有效 3 例，无效 4 例。

资料来源：张盛融，“宁癲散”治疗癲癇 40 例疗效观察，安徽中医学院学报，1982；(2)：20。

④⑥宁癲散

组成：槟榔 30g，黑丑 30g，酒大黄 25g，制南星 120g，皂角 30g。

适应症：癲癇。

用法用量：上药共为细末，砂糖调拌，间歇期每日晨起空腹调服 1 次，成人每次 6g，小儿每次 3g，发作时人麝香少许，用姜汤送下，用量与间歇期同，疗程必须在 1 个月以上。

临床应用：共治疗 30 例，其中大发作者 9 例，小发作者 11 例，局限性发作者 3 例，精神运动性发作者 7 例。结果：追访 5 年以上未复发者 24 例，发作间歇时间延长，但在 1 年后复发，而继续服药才能控制者 5 例，1 例无明显效果。

资料来源：汤铁城，宁痫散治疗癫痫，中国医药学报，1989；4（6）：46。

④加味磁朱丸

组成：南星 100g，半夏 15g，磁石 10g，生赭石 100g，朱砂 100g，全虫 100g，蜈蚣 30 条，白芍 200g，神曲 200g，甘草 200g。

适应症：癫痫。

用法用量：上药共为细末，炼蜜为丸，每丸 15g。日服 3 次，每次 1 丸，铁锈水送服，小儿减半。疗程 90 天。一般需服药 90 天～半年。

临床应用：治疗癫痫 30 例中，男性 18 例，女性 12 例；年龄 2～40 岁；其中原发性 18 例，继发性 12 例。结果：经治疗停止发作半年以上者为痊愈，共 23 例；经治疗后发作次数减少，每次发作间隔 3 个月以上者为好转，共 4 例；经治疗后病情无变化者为无效，共 3 例。

资料来源：尤洪范，加味磁朱丸治疗癫痫，吉林中医，1981；（2）：47。

④加减温胆汤

组成：半夏、茯苓、竹茹、陈皮、枳壳、太子参、枣仁、远志、菖蒲、甘草。

适应症：癫痫及其精神障碍。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，30 天为 1 疗程。

临床应用：治疗各类精神障碍患者 132 例，男 103 例，女 29 例；年龄 15～73 岁。其中神经官能症 54 例，更年期综合征

38例，精神分裂症24例，脑动脉硬化性精神障碍16例。疗效判断：痊愈：病人自觉症状消失或明显减轻，稳定达3个月以上者；好转：病人自觉症状减轻，稳定达1个月以上者，不大于3个月；无效：病情无改变；复发：痊愈或好转病人，疗效不巩固，自觉症状复发者。结果：痊愈41例（31.1%）；好转74例（56.1%）；无效17例（12.8%）；复发22例，复发率为19.1%；总有效率为87.2%。

资料来源：陈发熙，加减温胆汤在精神医学中应用的体会——附132例分析，中级医刊，1987；22（12）：45。

④伏痫散冲剂

组成：杜仲、巴戟、钩藤、甘草各150g，白芍、远志、麦冬、天冬、黄芩、丹参各180g，长春花、田三七各120g，柴胡、竹茹、石菖蒲、郁金各160g，藏红花、人中白各50g，朱砂、琥珀各60g，全蝎、蜈蚣各20g，珠贝300g。

适应症：癫痫。

用法用量：除朱砂、琥珀、人中白外，把其余药物经水煮，去渣文火浓缩至500g，加入人中白经发酵后再加朱砂、琥珀粉末混匀，适当烘干。分装30包，每包约20g。治疗组每日1包，分3次服。服药后第5天始停服苯妥英钠等所有抗癫痫药。本组198例，分为治疗组和对照组，治疗组148例服用伏痫散冲剂，对照组50例口服苯妥英钠0.1g，每日3次。同时给服复合维生素B粉作安慰剂。每2周检测1次苯妥英钠血药浓度，把血药浓度控制在有效的范围内。

临床应用：疗效标准：控制：基本不发作。显效：发作减少 $\geq 76\%$ 。有效：发作减少51%~75%。效差：发作减少26%~50%。无效：发作减少 $< 25\%$ 。结果：治疗组总有效率为97.3%；对照组总有效率为70%。两组总有效率有非常显著性差异（ $P < 0.001$ ）。治疗组控制率为66.2%，而对照组为零。两

组在 10 年以上的疗效比较, 治疗组有效率为 96%, 对照组为 63.9%, 有非常显著性差异 ($P < 0.001$)。

资料来源: 肖裕光等, 伏痫散冲剂治疗癫痫 148 例, 新中医, 1992; (10): 42。

⑤全蝎韭糖汁

组成: 全蝎 1 只, 新鲜韭菜 250g, 红糖 50g。

适应症: 癫痫。

用法用量: 全蝎焙干研粉, 与韭菜混合揉汁, 汁中放红糖, 反复拌匀后入锅内蒸, 空腹 1 次服下。

临床应用: 治疗癫痫 110 例中, 男 62 例, 女 48 例; 年龄最小 10 岁以下, 最大 30 岁以上。设 60 例对照组, 采用苯妥英钠 0.1~0.2g, 每日 2~3 次, 部分病例使用硝基安定和鲁米那。疗效标准参照 1979 年青岛会议癫痫疗效评定标准。结果: 显效率达 78%, 有效率达 95%。与对照组疗效比较两组间存在显著性差异。

资料来源: 晏九银等, 全蝎韭糖汁治癫痫 110 例, 四川中医, 1991; 9 (11): 12。

⑤齐济除痫丸

组成: 干紫河车 1 具, 生晒参、水牛角浓缩粉、玳瑁各 45g, 菖蒲、僵蚕、全蝎、水蛭、地龙、胆星各 30g, 檀香、益智仁、硼砂各 15g, 蜈蚣 15 条。

适应症: 癫痫。

用法用量: 上药共研细粉, 以丹参 120g, 远志、桑椹, 神曲各 60g, 鲜猪苦胆 (或牛胆) 2 个, 水煎浓缩收膏, 合药粉制成黄豆大丸, 用朱砂、琥珀、人工牛黄各等分研粉挂丸衣。每次 6g, 每 8 小时服 1 次, 以生姜、大枣汤送下, 儿童酌减。女病人月经前 1 周内服药量增至每次 9g。单纯夜间发作者, 白天不用或少用, 而在下午 4~5 点和睡前各服 9g。

临床应用：治疗癲癇 476 例中，男 369 例，女 107 例，年龄 5~61 岁；病程 3~32 年。结果：近期痊愈：与治疗前发作间歇时间比较，延长 1 年以上未发作者，共 304 例，占 63.8%；好转：发作时症状比前减轻，间歇性明显延长，共 167 例，占 35.1%；无效：共 5 例，占 1.1%；总有效率 98.9%。

资料来源：张爱国，齐济除癇丸治疗癲癇 476 例，山东中医杂志，1992；11（6）：14。

⑤ 阴阳抗癇丸

组成：郁金、白矾、钩藤、僵蚕、栀子、胆南星各 50g，半夏、蜈蚣各 10g，生赭石、地龙、磁石、天竺黄各 100g，朱砂、皂角、广角各 20g，硼砂 800g，守宫 2000g。

适应症：癲癇。

用法用量：上药共研为末，炼蜜为丸，每丸重 7.5g。用于阳癇，每日 2~3 次，每次 1 丸，1 个月为 1 疗程。阴癇者，加炙马前子 50g。

临床应用：治疗癲癇 50 例中男 24 例，女 36 例；年龄在 1~50 岁；病程 1 个月至 6 年。疗效标准：治愈：停药后 1 年以上未发作者。好转：服药过程中发作次数减少，发作时间缩短，或大发作停止，小发作有。无效：服药过程中发作情况无改善者。结果：治愈 48 例，占 80%；好转 10 例，占 16.6%；无效 2 例；总有效率 96.7%。

资料来源：荀生茂，自拟“阴阳抗癇丸”治疗癲癇 60 例临床观察，内蒙古中医药，1989；（1）：5。

⑥ 克癇散

组成：酒大黄、全蝎、川芎各 30g，姜半夏 50g，礞石、沉香、海浮石各 35g，南星 42g，牵牛子（生熟各半）90g，建曲 240g，白花蛇 1 条。

适应症：癲癇。

用法用量：神昏不醒加石菖蒲、郁金、麝香；惊搐者加钩藤、天麻、磁石；火甚者加寒水石、紫石英、石膏；风痰加白附子；热痰加天竺黄。上药共为细末，瓶装备用，每晨7时以铁锈水100ml送服10g，发作期，每次服15g，1日3次，儿童酌减。

临床应用：治疗癫痫41例中，男23例，女18例；年龄6个月至53岁；病程1个月至25年。结果：服药后2年内不用其他药物而未见发作为临床治愈，共22例；发作频度减少20%以上，症状明显减轻为好转，共16例；症状无改善为无效，共3例；总有效率92.6%。

资料来源：任明等，中药治疗癫痫41例，陕西中医，1990；11（7）：294。

⑤抑痫丸

组成：天麻330g，全蝎330g，丹参90g，当归150g，硼砂100g，蜂蜜1000g。

适应症：癫痫。

用法用量：将前4味烘干，与硼砂共为细末，炼蜜制丸，朱砂为衣。每丸重9g，每次1丸，每日3次，连服半年为1疗程。

临床应用：本组癫痫128例中，男74例，女54例，年龄6~68岁；病程0.5~2年，脑电图异常者104例。结果：完全控制：服1~6个疗程未发作者66例，基本控制：服1~6个疗程，（每年发作1~2次者）44例，有效：发作次数较治疗前减1/2以上者14例。无效4例，总有效率96.87%。

资料来源：霍宗信等，抑痫丸治疗癫痫128例，山东中医杂志，1992；11（6）：15。

⑥抗痫片

组成：桃仁30g，赤芍15g，红花15g，川芎15g，半夏10g，香附15g，木通8g，苏子10g，青皮15g，甘草10g，陈皮15g，大腹皮10g，桑白皮15g。

适应症：儿童癲病。

用法用量：上药经加工制成片剂，每片 0.3g，每片含生药 1.5g。我们按 0.5 片/kg·次的剂量给药，1 日 3 次。

临床应用：观察组 100 例儿童癲病中，男 53 例，女 47 例；平均年龄 8.4 岁。对照组 40 例中，男 23 例，女 17 例；平均年龄 9.8 岁。观察组中全身性发作 80 例，其中强直阵挛性发作 59 例，肌阵挛 18 例，失神 3 例；部分性发作 20 例，其中植物神经性 13 例，局限运动性 7 例。对照组中全身性发作 32 例，其中强直阵挛性 26 例，肌阵挛 4 例，失神 2 例；部分性发作 8 例，其中植物神经性 6 例，局限运动性 2 例。两组年龄、病程、病型分布基本一致。两组病人均以 1983 年自贡会议关于小儿癲病临床分类和治疗的建议标准进行判定。疗效判定标准按国内 1979 年青島癲病会议标准执行。两组病例一般疗程在 4 个月以上，若服药 3 个月症状未减轻评为无效者必用其他药物。本组病例服药时间最短者为 8 个月，最长者 20 个月，平均 11.9 个月。对照组病例亦在确诊后每日给予鲁米那 3~6mg/kg，分 2~3 次口服，服药时间均超过 18 个月。结果：观察组显效 72 例 (72.0%)，有效 12 例 (12.0%)，效差 10 例 (10.0%)，无效 6 例 (6.0%)；对照组显效 29 例 (72.5%)，有效 8 例 (20.0%)，效差 2 例 (5.0%)，无效 1 例 (2.5%)。其中观察组获效的 84 例中，脑电图有不同程度改善者 15 例 (17.9%)；对照组在获效的 37 例中，脑电图有不同程度改善者 5 例 (13.5%)。

资料来源：陈德明等，抗癲片治疗儿童癲病的临床观察，中医杂志，1989；(12)：731。

⑤抗癲灵

组成：郁金、橘红各 20g，枳实 15g，半夏、龙齿、远志、菖蒲、制南星各 12g，全蝎 10g，海浮石、山楂、茯苓各 30g，炙甘草 6g。

适应症：癫痫。

用法用量：上药研末，制成散剂，装入胶囊，每粒重 0.4g，每次服用 2g，每日 3 次（小儿酌减）。20 天为 1 疗程。

临床应用：治疗癫痫 65 例中，男性 37 人，女性 28 人；年龄 8~20 岁 21 例，21~30 岁者 29 例，31~40 岁者 11 例，40 岁以上者 4 例；病程在 1 个月以内者 5 例，1 个月至半年者 16 例，半年至 1 年者 25 例，1 年以上者 19 例。大发作者 48 例，占 74%；小发作者 17 例，占 26%。按 1978 年第二届全国神经精神科学学术会议制定的癫痫病诊断标准。结果：大发作者 48 例，痊愈 17 例，显效 20 例，有效 7 例，无效 3 例；小发作者 17 例，痊愈 5 例，显效 9 例，有效 2 例，无效 1 例；总有效率为 93.8%。最短有效时间为半个月，最长有效时间为 1 年。

资料来源：王海州等，抗痫灵治疗癫痫 65 例疗效观察，浙江中医杂志，1990；(2)：66。

⑦抗痫胶囊

组成：太子参、茯苓、石菖蒲、胆星、半夏、橘红、枳壳、沉香、青果、天麻等。

适应症：小儿癫痫植物性发作。

用法用量：上药制成散剂，分装胶囊，每粒含生药 4.5g，1~3 岁 4 粒，4~6 岁 5 粒，7~10 岁 8 粒，10 岁以上 10 粒。均为日服 3 次，发作频繁时，将胶囊改为汤剂，根据辨证酌情化裁，日服 1 剂，服药期间忌荤腥辛辣之物。

临床应用：本组治疗小儿癫痫植物性发作 39 例中，男性 14 例，女性 25 例；其中 1~5 岁 12 例，6~10 岁 19 例，11~15 岁 8 例；病程最短者 1 个月，最长者 10 年。结果：疗效评定标准参照 1979 年青岛会议全国试行草案。显效 21 例，占 53.85%；有效 14 例，占 35.89%；效差 2 例，占 5.13%；无效 2 例，占 5.13%，总有效率为 89.74%。

资料来源：向阳，抗痛胶囊为主治疗小儿癲癇植物性发作 39 例，中国医药学报；1992，7（2）：32。

⑤抗癲散

组成：薄荷 0.2g，防风 0.3g，黄连 0.3g，荆芥 0.3g，胆南星 0.3g，清半夏 0.3g，金银花 0.7g，巴豆 2 粒（去壳去油）。

适应症：原发性癲癇。

用法用量：上药共研细末，再和面粉 400g，芝麻 120g，烙成焦饼，每日早、中、晚 3 次服完。不愈者续服。

临床应用：治疗原发性癲癇 40 例中，男 28 例，女 12 例，年龄 10~60 岁；病程半年至 25 年。结果：症状消失，观察 2 年以上未复发为痊愈，共 25 例，发作间隔期延长，观察 1 年未复发为显效，共 13 例；无效 2 例。

资料来源：焦源，抗痛散治疗原发性癲癇大发作 40 例，湖北中医杂志，1985；（1）：16。

⑥灵芝镇癲散

组成：紫贝齿、生龙齿、生牡蛎、生地、玳瑁、石决明各 50g，灵芝 40g，蚤休、郁金、天麻、天竺黄各 25g，石菖蒲、僵蚕各 15g。

适应症：癲癇。

用法用量：以上诸药共为细末，装瓶备用，每次 5g，每日 2 次，7 天为 1 疗程。

临床应用：本组治疗癲癇 92 例，结果：治愈率达 89.21%。

资料来源：李志文，灵芝镇癲散治癲癇，时珍国药研究，1992；3（1）：36。

⑦青黛加味片

组成：青黛、山药各 12g，硼砂 10g，明矾 4g，木香、地榆各 8g。

适应症：癲癇。

用法用量：上药研细末后，制成片剂，每片 0.3g。每次 4 片，每日 3 次，口服，1 个月为 1 个疗程。

临床应用：应用本方治疗癫痫 65 例，结果：痊愈 7 例，显效 18 例，有效 25 例，总有效率为 76.92%。

资料来源：陈良等，青黛加味片治疗癫痫临床疗效观察，中医杂志，1984；(12)：31。

⑥河南囊虫丸 2 号

组成：皂刺 62g，蛇床子 6g，蜈蚣 7 条，胆星 45g，僵蚕 62g，朱砂 9g，青礞石 93g。

适应症：癫痫。

用法用量：上药共为细面，蜜为丸，每丸重 2.5g（含生药、蜂蜜各 1.25g）。成人每次 1 丸，1 日 3 次口服；儿童酌减。

临床应用：本组患者均经临床和脑电图等确诊为癫痫患者，其中男性 131 例，女性 49 例；平均年龄 38.5 岁；癫痫类型：大发作 145 例，局限性发作 1 例，小发作 1 例，精神运动性发作 12 例，混合型 17 例，其他 4 例；原发性癫痫 21 例，继发性癫痫 159 例。发作频率不等，均为 1 年内发作 3 次以上者。有效病例治疗 3~6 个月以上。除 99 例脑囊虫病癫痫型患者住院治疗病因外，余均在门诊治疗。疗效标准：根据 1979 年 10 月在青岛召开的癫痫学术座谈会所制定的癫痫疗效评定标准，经治疗后停药 1 年以上，癫痫未再发作或发作频率减少 75% 以上者为显效；发作频率减少 50%~75% 者为有效；减少 25%~50% 者为效差；减少 25% 以下者为无效；发作频率增加为加重。经 1~6 年随访观察，结果：显效 104 例（57.78%），有效 46 例（25.55%），效差 21 例（11.67%），无效 8 例（4.45%），加重 1 例（0.55%），总有效率为 83.33%。单用本药治疗的 30 例，有效率为 82.04%，初诊和非初诊病例无明显差别。脑电图改变：原脑电图异常者 105 例，于治疗稳定后复查 24 例转为正常，46 例

明显好转，35例变化不明显。脑电图改善与临床疗效之间多数是一致的。但也有2例脑电图由明显痫样放电恢复正常，临床症状却未完全控制；6例临床显效，而脑电图无明显改善。

资料来源：刘玲等，河南囊虫丸2号治疗癫痫180例疗效观察，中西医结合杂志，1987；7（2）：107。

⑥治痫灵

组成：炙马前子粉2.5g，钩藤10g，骨粉200g，樟脑8.5g，苯巴比妥50g，溴化钠134g。

适应症：癫痫。

用法用量：上药共制成1000片，每片0.4g。1日3次饭后服用，每次1~2片（小儿按儿童剂量计算）。服药不间断，服药期间不再服其他抗癫痫药。

临床应用：治疗癫痫150例中，男94例，女56例；年龄20岁以下78例，20~30岁51例，31岁以上21例；病程5年以内56例，6~11年57例，11年以上37例。病例根据：①有典型癫痫发作症状；②神经系统检查无定位体征；③脑电图有癫痫波形者（亦有病史典型而脑电图正常者）；④眼底检查正常；⑤排除其他疾病引起的继发性癫痫。原发性癫痫大发作138例，继发性癫痫大发作12例。结果：显效（在服药期间控制发作，坚持服药2年后停药，1年内不再发作，可以参加工作或学习）94例，有效（服药期发作次数减少，间隔时间延长）54例，无效（服药3月病情无任何变化者）2例。

资料来源：刘素琴等，“治痫灵”治疗癫痫150例临床分析，实用中医内科杂志，1987；1（2）：80。

⑦定痫丸

组成：生熟锦纹各60g，黑白丑各120g（微炒去皮），生地黄42g，熟地黄18g，巴豆仁30g（去油取霜），朱砂30g，甘草30g。

用法用量：将上方配 7 天的剂量，浓煎成 500ml 糖浆合剂，每次内服 20ml，每日 3 次。同时服蝎蜈片（全蝎、蜈蚣等 4 份，每片 0.3g）或星蜈片（生南星 1 份，蜈蚣 3 份，每片 0.3g），每次 4~5 片，每日 2 次。

临床应用：治疗癫痫 30 例中，男性 16 例，女性 14 例；年龄最小 3 岁，最大 62 岁。20 例做过脑电图检查，阳性发现者 16 例。结果：显效（各类痫性发作已完全控制，停止发作 4 个月以上）12 例（40%）；有效（发作次数明显减少，大小发作和多种发作中，一种发作控制，另一种发作虽尚未完全控制，但次数减少）8 例（26.7%）；无效（发作频度无明显改善）10 例（33.3%）；总有效率 66.7%。

资料来源：沈毓鸣等，“定痫镇痛合剂”治疗癫痫 30 例临床分析，上海中医药杂志，1980；（4）：29。

⑥甘麦大枣汤

组成：甘草 9g，小麦 9~15g，大枣 10 枚。

适应症：癫痫。

临床应用：应用本方加贝母、制南星、陈皮、法夏、茯神、炙远志、竹茹各 10g，钩藤 15g，生铁落 100g（小麦重用至 100g），枳壳 8g，水煎服。治疗癫狂病 12 例。结果：痊愈 8 例，显效 2 例，有效 1 例，无效 1 例^[1]。又用本方的提取剂治疗，用药量为 0.15~0.25g/kg·日，分 2 次服，连服 3~22 个月。治疗小儿癫痫 16 例，其中情绪惊厥 0~5 岁 8 例，多动不安等情绪性难治者 0~13 岁 6 例，混合性热性痉挛 3~6 岁 2 例。结果：情绪性惊厥患儿单服本方的 8 例中，4 例显效，4 例有效；余 8 例（1 例并用了抗癫痫药），显效 2 例，有效 4 例，无效 2 例，而且显效中有 1 例是曾用过各种抗癫痫药无效的难治病例^[2]。

药理研究：

1. 镇静催眠抗惊厥等作用 将本方制成浸膏。用蒸馏水配

成所需浓度进行以下实验：①对中枢神经系统的影响（对小鼠电激怒的影响；对小鼠格斗的影响；对小鼠自发活动的影响；对回苏灵诱发小鼠惊厥的影响；对土的宁诱发小鼠惊厥的影响；对小鼠电惊厥的影响；对戊巴比妥钠诱导小鼠睡眠时间的影响；对小鼠转棒的影响）；②对家兔血压、呼吸和心率的影响；③对雄性小鼠性腺的影响（对小鼠子宫重量的影响；对去卵巢小鼠阴道角化细胞的影响）。结果：本方能明显提高激怒小鼠的电压阈值；延长小鼠的格斗发生率；抑制小鼠自发活动；减少回苏灵和土的宁诱发的小鼠惊厥发生率；延长戊巴比妥钠诱导的小鼠睡眠时间，表明具有中枢镇静、催眠和抗惊厥作用。本方对幼鼠子宫重量、去卵巢小鼠阴道上皮细胞无明显影响，无雌激素样作用。此外，本方对家兔血压、呼吸、心率、心电图均无明显影响^[3]。

2. 对神经系统及平滑肌的作用 实验取大鼠对本方进行神经药理学的筛选和观察其对大鼠自发运动的影响。取豚鼠进行对离体平滑肌收缩作用影响的观察。结果：在神经药理学筛选中，未见显著的效果，对环己烯巴比妥的睡眠时间稍有延长作用。对大鼠自发运动量在口饲第3~4日后观察到运动量减少。对于离体平滑肌的作用，其提取物以 $5 \times 10^{-3} \text{g/ml}$ （水箱中浓度）能够抑制组胺、乙酰胆碱所致的豚鼠回肠收缩。对于大鼠子宫的收缩作用以 $2 \times 10^{-3} \text{g/ml}$ 的浓度则能完全抑制^[4]。

3. 毒性研究

①急性毒性试验：将小鼠分为3组，每组20只。室温18~23℃下1次灌胃给药（浓缩液0.6ml/只），7天后观察死亡数。

②长期毒性试验：大鼠120只，随机分为4组，即生理盐水对照组，甘麦大枣汤10、20、30g/kg组，灌胃给药，每日1次。给药前给药1.5个月和给药3个月后，各检查1次肝功能（SGPT）、肾功能（BUN）、血红蛋白、白细胞总数和分类计数，并对大鼠进食、外观、活动、粪便等一般情况进行观察。给药3个

产生癫痫的原因或家族史，使用抗癫痫药物有良好的效果者。经治疗后，每周定期复查 1 次，结果：2 年未复发者为治愈，共 354 例，占 60.4%；发病间期延长，持续时间短，症状减轻，药量减少，发作前有先兆，能预防为有效，共 211 例，占 36%；无效 21 例，占 3.6%。

资料来源：张继德，牵牛子散治疗癫痫 586 例临床观察，湖南中医杂志，1993；9（1）：14。

⑧消栓再造丸

组成：川芎、丹参、广三七、广血竭、天麻、白花蛇、安息香、苏合香、八参、沉香等。

适应症：外伤性癫痫。

用法用量：口服 1 次（1~2 丸），1 日 2 次，小儿逐减，温开水及黄酒送服。1 个月为 1 疗程，症状减轻，可继续服用第 2 个疗程至症状全部控制，若无效可必用其他药物。

临床应用：治疗外伤性癫痫 5 例中，控制 2 例，显效 2 例，无效 1 例。分析疗效与各种因素的关系中发现，年龄小、病程短者效果较好，年龄大、病程长者次之。5 例治疗后脑电图检查：除 1 例无变化外，其余 4 例均有不同程度的改善。服药的 5 例病中未发现不良反应。

资料来源：李治方，消栓再造丸治疗外伤性癫痫 5 例，云南医药，1987；8（4）：242。

⑨雄黄瘴痢丸

组成：明雄黄 25g，钩藤 25g，琥珀 19g，炒乳香 25g，天竺黄 19g，明天麻 19g，芥穗 13g，朱砂 5g，明矾 13g，全蝎 19g，胆南星 19g，郁金 19g，黄连 19g，珍珠 2g，木香 19g，甘草 13g，冰片 2g，绿豆 200 粒。

适应症：癫痫。

用法用量：上药除明雄黄、朱砂外，其他药物均为细末，制

上 10 例，最长 23 年。结果：服药后停止发作 2 年以上，脑电图检查恢复正常为完全控制，共 19 例，占 41.3%；发作频率减少 80% 以上，症状明显减轻为显效，共 11 例，占 23.9%；发作频率减少 50% 左右，症状略有改善为有效，共 7 例，占 15.2%；发作频率与症状基本无改善为无效，共 9 例，占 19.6%；总有效率为 80.4%。

资料来源：吴耀升，痫可定治疗癫痫 46 例，江苏中医杂志，1985；(9)：18。

⑦新加保和丸

组成：神曲、山楂、葛根各 60g，茯苓、党参、黄芪各 35g，莱菔子、甘草各 12g，山药、地龙、僵蚕、生南星各 20g，陈皮、法半夏各 10g，蜈蚣 15 条，全蝎 14g，紫河车 45g。

适应症：癫痫。

用法用量：上药焙干，研末炼蜜为丸，每丸 1g，每次 4～8g，每日 3 次，6 个月为 1 疗程，服药期间停药其他抗癫痫药。

临床应用：治疗癫痫 41 例中，男 25 例，女 16 例。另设对照组 35 例，服苯妥英钠 0.1g，安定 5mg，每日 3 次。两组在年龄、病因及病程等方面均无显著差异。疗效标准：发作频率减少 75% 以上者或基本被控制者为显效；减少 33%～75% 者为有效；减少在 33% 以下者为无效。结果：显效占 51.22%；有效占 39.02%；无效占 9.76%。与对照组疗效比较，两组间有极显著差异。

资料来源：汤正才等，新加保和丸治疗难治性癫痫 41 例报告，四川中医，1992；(12)：26。

⑧熄风定痫丸 1 号

组成：胆南星、天麻、法半夏、地龙、青木香、藿香、陈皮、天竺黄、沉香、川贝母、生大黄、青礞石、白矾、二丑、全蝎、钩藤、石菖蒲、茯神、丹参、海浮石、冰片、姜汁。

适应症：癲癇。

用法用量：上药研末，炼蜜为丸，每丸重 6g。早晚各 1～3 丸，小儿酌减。2 个月为 1 疗程，3 个疗程后判定疗效。

临床应用：治疗癲癇 52 例，辨证属阳病。疗效评定：根据 1979 年 10 月青岛会议对癲癇疗效的评定标准。结果：显效率占 71.2%，有效率占 28.8%，总有效率为 100%。

资料来源：高永汉等，熄风定痫丸治疗癲癇 120 例总结，北京中医学院学报，1991；14（4）：17。

㉓熄风定痫丸 2 号

组成：胆南星、天麻、法半夏、地龙、青木香、藿香、陈皮、天竺黄、沉香、川贝母、青礞石、白矾、全蝎、钩藤、石菖蒲、茯神、丹参、海浮石、生大黄、琥珀粉、姜汁、黄芪、当归、紫河车、鹿茸、黄精、降香、檀香、乌梢蛇、川乌头。

适应症：癲癇。

用法用量：上药研末，炼蜜为丸，每丸重 6g。早晚各服 1～3 丸，小儿酌减。2 个月为 1 疗程，3 个疗程后判定疗效。

临床应用：治疗癲癇 35 例，辨证属阴病。疗效评定：依据 1979 年 11 月青岛会议对癲癇疗效的评定标准。结果：显效率占 45.7%，有效率占 48.6%，无效率占 5.7%，总有效率为 94.3%。

资料来源：高永汉等，熄风定痫丸治疗癲癇 120 例总结，北京中医学院学报，1991；14（4）：17。

㉔熄风定痫丸 3 号

组成：胆南星、天麻、法半夏、地龙、青木香、藿香、陈皮、天竺黄、沉香、川贝母、生大黄、青礞石、二丑、全蝎、钩藤、石菖蒲、茯神、丹参、海浮石、琥珀粉、姜汁、川芎、红花、鸡血藤、牛膝。

适应症：癲癇。

用法用量：上药研末，炼蜜为丸，每丸重 6g。早晚各服 1～3 丸，小儿酌减。2 个月为 1 疗程，3 个疗程后判定疗效。

临床应用：治疗癫痫 33 例，辨证属痰痫。疗效评定：根据 1979 年 10 月青岛会议对癫痫疗效的评定标准。结果：显效率占 69.7%，有效率占 27.3%，无效率占 3.0%，总有效率为 97%。

资料来源：高永汉等，熄风定痛丸治疗癫痫 120 例总结，北京中医学院学报，1991；14（4）：17。

⑤熄痫汤

组成：石菖蒲（后下煎 15 分钟）50g，白胡椒 10g，丹参 60g，僵蚕 20g。

适应症：癫痫。

用法用量：每日 1 剂，水煎服，小儿酌减。

临床应用：治疗癫痫 33 例，男 18 例，女 15 例；年龄 2～61 岁；对照组类同于治疗组。对照组口服苯妥英钠、癫建安、卡马西平，小发作时口服苯巴比妥、安定，常规治疗量。疗效标准：服药 3 天后，2 日内尚未发作，神志意识正常为近控；服药 3 天后，发作减少 75%，症状减轻显著，神志及体力恢复亦快为显效；发作减少 50%，但发作时间及症状同治疗前无异为有效；服药 3 天发作症状及时间同前为无效。结果：近控 11 例，显效 9 例，有效 6 例，无效 7 例，总有效率为 78.8%。

资料来源：王瑜华，熄痫汤控制癫痫发作 33 例临床观察，陕西中医，1990；11（7）：295。

⑥镇痫灵

组成：桃花蕊、黄花败酱、缬草丹参、水牛角浓缩粉、珍珠层粉、羚羊角粉、地龙、紫河车、冰片等。

适应症：癫痫。

用法用量：将上药提取物浓缩烘干，加粘合剂压片。每片重量 0.45g，口服 1 日 2 次，每次 1～3 片，小儿量酌减，用量可

学院学报, 1984; 7 (3): 36。

⑦⑧ 癫痫汤

组成: 黄芪 30g, 泽泻 20g, 白术 20g, 甘草 10g, 木香 10g, 白芍 20g, 车前子 10g (单包), 枸杞子 20g, 破故纸 10g, 益智仁 15g, 半夏 10g, 核桃 1 个。

适应症: 癫痫。

用法用量: 每日 1 剂, 小儿酌减, 20 剂为 1 疗程。

临床应用: 治疗癫痫 1323 例, 男 721 例, 女 602 例; 年龄 11 个月至 50 岁; 病程 4 个月至 30 年。结果: 完全控制 759 例, 占 57.3%; 显效 425 例, 占 32.2%; 好转 136 例占 10.2%; 无效 3 例, 占 0.3%; 总有效率 99.7%。

药理研究: 将健康大白鼠分 2 组, 1 组以癫痫汤灌胃, 另 1 组灌生理盐水, 1 小时后注射 50mg/kg 戊四氮记录惊厥发作潜伏时间。实验表明服癫痫汤潜伏时间延长, 说明该方有抗戊及氮惊厥作用, 有抗癫痫作用。

资料来源: 王富龙等, 癫痫汤治疗癫痫的临床, 现代中医, 1992; 5 (2): 53。

⑦⑨ 癫痫散

组成: 朱砂、郁金、雄黄、巴豆霜。

适应症: 癫痫。

用法用量: 上药共研细末, 混匀。0.1~0.5g/次, 2~3 次/日, 口服。

临床应用: 治疗癫痫 30 例, 显效 7 例, 有效 12 例, 改善 8 例, 总有效率达 87%。

资料来源: 杨秀婷, 癫痫散治疗癫痫 30 例观察, 中医药信息, 1989; (2): 29。

⑧⑩ 癫痫散

组成: 陈皮、法半夏各 15g, 茯苓、胆南星、郁金、全蝎各

12g, 枳实、石菖蒲、生远志各 10g, 沉香、朱砂各 6g, 蜈蚣 3 条, 海浮石、青礞石各 30g。

适应症：癲病。

用法用量：诸药共为细末，装瓶备用。成人每次服 6~10g，每日 3 次；小儿酌减。2 个月为 1 疗程。若发作频繁者，可改汤剂或加大剂量，每次服 10g，每 6 小时 1 次。

临床应用：治疗癲病 38 例中，男性 15 例，女性 23 例；年龄最大 20 岁，最小 3 岁，其中 3~8 岁 15 例，9~14 岁 10 例，15~20 岁 7 例，21~26 岁 6 例；病程 1~4 年 15 例，5~10 年 10 例，9~12 年 13 例；发作持续时间最长者 1 个多小时，最短者为 2~3 分钟；原发性 28 例，继发性 10 例。结果：痊愈 34 例（症状消失，脑电图复查正常，随访 3 年未再复发）；好转 3 例（次数明显减少，间歇时间延长，发作持续时间明显缩短，症状减轻，脑电图复查有明显好转）；无效 1 例（服药 3 个疗程，各症状无明显改善，脑电图复查无明显改变）。

资料来源：高国祥，自拟癲病散治疗癲病 38 例疗效观察，浙江中医药杂志，1992；(10)：444。

⑧通脉愈病丸

组成：赤芍、桃仁、红花、川芎各 30g，丹参 90g，法半夏、生南星、煅礞石各 45g，石菖蒲 20g，肉桂 15g，当归、紫河车、黄芪、党参各 60g，天麻 50g。

适应症：癲病。

用法用量：上药共研极细末，炼蜜为丸，每丸重 10g。成人每日早、午、晚各 1 丸，姜汤送服。儿童酌减。1 个月为 1 疗程。

临床应用：治疗 43 例中男 31 例，女 12 例；年龄 4~39 岁；病程 1~12 年。疗效标准：痊愈：治疗后经随访 2 年以上未见复发者。显效：发作次数和每次发作时间各减少 75% 以上者。好

转：发作次数和每次发作时间各减少 25% 以上者。无效：连续服药 12 个疗程，病情无变化者。结果：痊愈 32 例，显效 3 例，好转 4 例，无效 4 例，总有效率为 90.7%。

资料来源：曹俊辉等，自拟通脉愈痫丸治疗脑外伤继发性癫痫 43 例疗效观察，新中医，1987；(6)：35。

②续气丸

组成：生黄芪、当归、白芍、巴戟天各 150g，白糖参、朱茯苓、白术、山萸肉、桑螵蛸各 100g，砂仁、补骨脂各 30g，山药、芡实、柴胡、远志各 15g，熟地 350g。

适应症：癫痫。

用法用量：上药共研末以蜜为丸，每丸重 9g。1 天 2 次，每次 1 丸，1 个月 1 疗程，一般 3~6 个疗程。

临床应用：治疗癫痫 41 例，男 5 例，女 36 例；年龄 3~30 岁；病程 3 个月至 25 年。属中医气虚型者 30 例，气虚痰阻型 9 例，气虚痰阻血瘀型 2 例。结果：癫痫发作及伴随症状均消失，1 年以内未复发者为临床治愈，共 25 例；癫痫发作消失，或显著减少，伴随症状明显好转为显效，共 13 例；癫痫发作次数减少，伴随症状减轻为有效，共 3 例；有效为 100%。

资料来源：吕相，中药治疗癫痫 41 例，陕西中医，1993；14 (8)：346。

三、单方验方

(一) 地龙 3~6g，煎服。用于外伤性、局灶性癫痫。(朱文政，河北医药，1983；(3)：48)

(二) 脐血粉 0.4g，1 日 2 次吞服。用于癫痫非发作期。(新中医，1978；(6)：33)

(三) 青阳参 9g，煎服。有明显抗惊厥作用，作用持久，用于顽固性癫痫大发作。

(四) 石菖蒲 15~30g, 煎服。用于各类癲癇。

(五) 防风、瓜蒂各 6g, 藜芦 3g, 各为粗末, 混匀, 置于杯中, 加温水 250ml, 搅拌成混悬液。先服半量, 停片刻, 待有恶心感后用筷子探吐, 吐出食物、痰涎后, 再服剩下之半量, 令再吐之, 以吐出大量痰涎为佳。用于癲癇之痰涎壅塞证, 体虚者慎用。(以上三方选自: 吴大真等, 难治病的良方妙法, 中国医药科技出版社, 1991)

(六) 抗癲癇片 青黛 5000g, 硼砂 15000g, 山药 30000g。磨粉制片, 每片 0.5g; 每服 4~8 片, 1 日 3 次。

(七) 癲癇散 郁金 400g, 全蝎 (焙)、蜈蚣各 140g, 巴豆 (醋煮) 50g, 香附 (醋炒) 250g。共研细末, 每服 3g, 空腹温开水送服。服后半日不可进食。

(八) 海参肠、青果、生牡蛎、郁李仁各等分, 煎服或制成丸剂; 每服 6g, 1 日 3 次, 用于癲癇。(以上三方选自山东省立医院, 实用药物手册, 山东科学技术出版社, 1986)

四、中成药

礞石滚痰丸

来源:《养生主论》

组成: 大黄 (酒蒸)、片黄芩 (酒洗净) 各 250g, 沉香 15g, 礞石 30g (捶碎, 焰硝 30g, 入小砂罐内, 及稍盖之, 铁线练定, 盐泥固济, 晒干, 火煅红, 候冷取出), 一方加朱砂 60 研细末为衣。

功效: 降火逐痰。

主治: 实热老痰, 发为癲狂惊悸, 或怔忡昏迷, 或咳喘痰稠, 或痰闭子宫不孕, 大便秘结。舌苔黄厚而腻, 脉弦或滑数有力。现用于精神病、癲癇身体壮实者。

用法用量: 研细末制成梧桐子大水丸, 每服 10g (40~50

丸)、临卧用茶或温水送下,量虚实加減服。

临床应用:临床多配合辨证方药用之,或用于病初,或用于痢频神痴,也可用于长期应用抗痢西药导致智能障碍者。

方义解释:本方以礞石镇坠老痰、顽痰;大黄、黄芩清热降火;礞石配大黄则使顽痰从大肠而去;沉香降气,俾气降火降、气降痰降,免扰清窍;朱砂镇痢宁神。综合使用正合癫痫之病机,俾痰去热除,风熄神安。

六、饮食疗法

(一) 饮食宜忌

癫痫患者的饮食癫痫宜清淡,易消化,忌食辛辣肥甘厚味,勿过饥过饱,食量宜适中,禁止饮用酒、茶、咖啡等兴奋性饮料。

(二) 药膳食疗

1. 酒烧鸡蛋 取鸡蛋2只,食用酒精(酒)100ml,同放搪瓷盆内,燃酒烧蛋,不时用筷子翻蛋,使蛋熟匀,酒干后去蛋壳,每晨空腹吃,连用50天为1疗程。

2. 红蓖麻根煮鸡蛋 取红蓖麻根60g,鸡蛋2只,先将红蓖麻煮汁去渣,约200ml,趁热打荷包蛋,加黑醋10ml,每日1次,连服10天为1疗程。(以上选自:吴大真,难治病的良方妙药,中国医药科技出版社,1991)

3. 泥鳅7条、黄叶槐条1段、雄黄3g。将泥鳅用槐条串口贯腹,在炭火中炙熟,不加盐、醋,先食泥鳅,再冲服雄黄末,1次吃尽,每日1次。(郑启明,民间饮食疗法,广西人民出版社,1981)

4. 地龙煮黄豆 地龙煮黄豆熟后,吃豆粒,每日30g左右。

5. 羊胎一具 煮熟后烘干研末,每服10g,1日2次。

6. 狗脑一具 煮熟吃,2~3日1次,常用。(以上三方选

自：叶橘泉，食物中药与便方，江苏科技出版社，1980年)

六、医案医话

(一) 赵心波医案——痰热内伏、复受惊恐癲病案

王某，男，11岁。患儿8年前患癲病，至今未愈。现每年发作1~3次，多在晚间发作，发作时口吐痰沫，牙关紧闭，不省人事。近日发作较勤，抽搐时间较前为长，服苯妥英钠或注射镇静剂后方解，发作后感觉头痛、睡眠不安，时有烦急。曾在各医院治疗不效，故来就诊，诊为痰癲。为平素痰热内伏，复受惊恐，扰及厥阴所致。

立法：清热化痰，镇惊定搐，活血息风。生侧柏10g，天竺黄6g，胆星6g，地龙6g，青礞石10g，橘红6g，磁石10g，红花3g，桃仁5g，钩藤5g，全蝎3g，焦楂10g。化风锭1丸，日2次。

上方加减共进36剂，症状平稳，唯痰多，纳差，舌无苔，脉弦缓，再拟前法化裁。钩藤5g，青礞石12g，法半夏5g，桃仁5g，红花6g，磁石10g，全蝎3g，地龙10g，化橘红3g，胆草6g，神曲10g，炒麦芽10g。化风锭1丸，每日2次。

上药又进16剂，合化风锭20丸后，3周来未再发作抽搐，继续治疗4个月后，且礞石滚痰丸和医痫无双丸交替服用，巩固疗效。1年后来门诊抽搐基本痊愈。

[附]定搐化风锭方：全蝎20只，桔梗10g，黄连10g，蝉蜕15g，甘草10g，防风15g，羌活15g，大黄15g，僵蚕15g，法半夏15g，麻黄3g。轧细末后每300g兑入朱砂30g，牛黄5g，麝香5g，冰片10g，共研匀蜜为丸，重3g/丸，每服1~2丸，日2服。(摘自《赵心波儿科临床经验选编》)

(二) 刘渡舟医案——太阳膀胱蓄水“水病”案

王某，男，18岁。主诉：患癲病，虽屡用苯妥英钠等抗癲

痫药物，不能控制发作。自诉发病前感觉有一般气从下往上冲逆，至胃则呕，至心胸则烦闷不堪，上至头则晕厥，不省人事。少顷，气下行则苏醒，小便少而频数。其脉沉，舌淡嫩，苔白润滑。

辨证：太阳膀胱蓄水，水气上逆，冒蔽清阳之“水病”。

治法：利水下气，通阳消阴。

处方：茯苓 30g，泽泻 12g，猪苓 10g，白术 10g，桂枝 10g，肉桂 3g。

服药 3 次，病发次数见减，小便通利；继服药 6 付，病除。（董建华，中国现代名中医医案精华，北京出版社，1990：1764。）

七、现代报道

（一）中西医结合防治癫痫的临床疗效是肯定的。西药抗痫治疗本病虽有一定的疗效，但仍有 20%~30% 患者服用后症状不能控制。且这些药物都是对症治疗之品，长期服用副作用明显。中药虽然收效较慢，但立足整体调理，作用持久，副作用较少，近年来由中药中提取的抗痫成分（如 α -细辛醚、缬草提取物癫痫安及胡椒提取物癫痫灵等）的临床疗效也并不逊色。同时，中西医结合治疗，可以扬长避短，协同增效。据报告，曾经使用过多种抗惊厥药物（西药）长期治疗而未获满意疗效的癫痫大发作患者，在加用青阳参（中药）2~9 个月后，癫痫发作次数减少 80% 以上者达 60%，提示中西医结合治疗本病有明显的优越性。（匡培根，北京中医杂志，1984；（3）：23）

（二）癫痫有发作期和间歇期的区别。一般而言，发作期短暂，瞬息即过，除癫痫持续状态外，通常不需特殊处理，只要加强防护，可免意外（如从高处跌下或溺水等）。而且，大多数患者应诊时，均处于间歇期。因此，加强间歇期的中西医结合防治

研究，特别是注意充分发挥中医药的优势和特长，具有十分重要的意义。(王庆其，中医杂志，1982；(6)：75)

(三) 癲病是一种动态进行的疾病，每次发作均会增加病变的程度和脑细胞死亡的数目，从而成为另一次发作的潜在病因。其发病时存在脑部微循环障碍，脑细胞缺氧、死亡，脑水肿，甚至产生颅内高压，活血化瘀药对改善此类病变有一定帮助；癲病时常发作，对智力的影响是显著的，并会导致人格改变，新生儿期和婴儿期发病者预后更差，其出现智力发育不全和神经机能欠缺的机率达70%~80%，这方面也应予以足够的重视。近年来部分学者观察到中药补虚药和息风药、豁痰药同用，除抗癲作用明显外，对患者智力的改善，具有一定作用，有待更深入研究。(张汤敏，癲病新疗法，化学工业出版社，1991)

八、主要参考资料

1. 吴大真等，难治病的良方妙法，北京：中国医药科技出版社，1991
2. 王庆其，中医杂志，1982；(6)：75
3. 胡建华，中医杂志，1988；(2)：87
4. 匡培根，北京中医杂志，1984；(3)：23
5. 沈但，江苏中医，1986；(12)：554
6. 张凯，北京中医杂志，1986；(6)：48~49
7. 傅景华等，古代验方大全，中医古籍出版社，1990
8. 萧佐桃等，中医杂病集成，湖南科学技术出版社，1991
9. 黄泰康等，中药方剂现代研究大典，科学出版社，1996

精神分裂症

精神分裂症是以基本个性改变，思维、情感和意志行为分裂，精神活动与外界环境不协调为主要特征的一类最常见的精神疾病。本病的病因尚未阐明，多在青壮年时期发病，病程迁延，不少患者呈慢性进行性过程，若不能及时诊治，往往导致精神衰退，故又有“早发性痴呆”之称。

本病的总患病率，据 1982 年国内的一次调查表明为 5.69%，居精神病的首位，一般占精神病住院病人的 60%～70%；西医主要应用氯丙嗪、氟哌定醇、氯氮平、泰尔登等药物及电休克、胰岛素休克等治疗，有一定的副作用，且复发率较高。根据国内资料，出院两年以上的病人复发率为 24.9%～51.7%，同时发现，随访时间越长，复发率越高，具有不断发展，逐渐加重趋势。目前国内外治疗该病的效果皆不能令人满意，因而精神分裂症成为医学上重要难题之一。

中医学中无精神分裂症一词，根据本病临床表现，属于“癫狂”病范畴，癫、狂均为精神失常的疾患。《千金要方》云：“诸百邪之病，源起多深，其有种种形相，示表癫邪之端而见其病，……或复多言而漫说，……或吟或笑，……或嗔骂无度，或是蜚虫精灵……”。癫证以沉默痴呆，语无伦次，静而多喜，抑郁少动为特征；狂证以喧扰不宁，妄行骂詈，毁物伤人，躁动多怒为特征。中医药治疗精神分裂症已积累了一些经验。

一、病因病机

中医学认为，精神分裂症的发生与脏腑功能失调和阴阳失于平秘有关，兼夹顽痰、瘀血，气血阴阳亏虚，并常由气郁化火所诱发。

(一) 脏腑失调 精神分裂症有遗传倾向，素禀脏腑失衡之质，多为肝郁之体或个性不良之辈，遇有扰动，阴阳、气血每易失衡，致肝郁化火或顽痰、瘀血内扰神明，则为病矣。此为发病内因之一。

(二) 顽痰作祟 精神分裂症多由痰邪作祟而然。痰邪结于心胸，随郁火内扰神明。痰之为病，可随气升降，无处不及，变化多端。痰湿阻结，耗伤阳气；痰火互结，上扰元神；痰邪夹瘀，则使本病迁延难愈，且病情深重。

(三) 气血失调 素有肝郁之质或精神脆弱，遇事烦扰，七情过激，致使肝郁不伸，脾失健运，痰邪内生；或郁火内炽，炼津为痰，灼血成瘀；致气滞、肝火、痰、瘀相互为患，扰乱神明，发为本病。王清任云：“癫狂一症，哭笑不休，詈骂歌唱，不避亲疏，许多恶态，乃气血凝滞脑气，与脏腑气不接，如同作梦一样。”此之谓也。

(四) 阴阳亏损 病情久延，反复发作，阴阳气血为之耗损，呈现一片虚损之态；而正亏之际，脑气失养，精神分裂症更易发生。阳虚者多为心脾两虚，气血不足，神失所养，导致思维贫乏，行为退缩，精神衰退；阴虚火旺者，则多为心肾不足，兴奋多语，骂詈不休，但有形瘦颧红，五心烦热，不眠寐少，口干而燥，舌红少苔等。

二、辨证施治

(三) 治法方药

1. 分型治疗

(1) 痰湿内阴型 疏肝开郁，涤痰除湿。方选逍遥散合涤痰汤出入：柴胡 12g，香附 15g，郁金 30g，白术芍各 12g，胆南星 10g，姜竹茹 10g，石菖蒲 15g，枳实 15g，姜半夏 10g，青陈皮各 6g，茯苓 30g，白矾 10g。

(2) 痰火上扰型 清热化痰，镇心开窍。方用黄连温胆汤增删：黄连 5g，生大黄 6~10g（后下），芒硝 10~20g（分冲），全瓜蒌 30g，胆南星 10g，姜半夏 10g，陈皮 6g，竹茹 6g，天竺黄 12g，磁石 30g，珍珠母 30g，枳实 10g。痰盛神驰、愚昧者，重用石菖蒲，可用 15~45g，另远志 12g，茯神 30g，化痰醒神。

(3) 气滞血瘀型 活血化瘀，行气解郁。方选癫狂梦醒汤加减：桃仁 20g，赤芍 30g，郁金 30g，蒲黄 15g，丹参 15g，红花 10g，柴胡 10g，香附 10g，青陈皮各 10g，桑白皮 12g，苏子 12g，黄芩 6g。兼寒加附子 6g，干姜 3g，温阳散寒。

(4) 阴虚火旺型 滋阴降火，安神定志。方用二阴煎出入：生地 15g，麦冬 12g，玄参 15g，黄连 5g，木通 6g，竹叶 10g，白薇 12g，地骨皮 12g，茯神 30g，炒枣仁 30g，甘草 6g。烦躁不眠，汗出者，可加小麦 30~60g，大枣 6 枚，养心除烦。

(5) 阳亏虚损型 益气温阳，养血安神。方选养心汤加减：人参 6g，黄芪 15g，甘草 10g，当归 10g，川芎 12g，鸡血藤 30g，酸枣仁 30g，柏子仁 12g，巴戟天 12g，仙灵脾 15g，肉苁蓉 15g。

2. 方药选介

① 加味四逆汤

组成：附子 60g，干姜 15g，甘草 10g，肉桂 10g，仙茅 15g，仙灵脾 15g。

适应症：精神分裂症阴型。精神萎靡，行止懒散，瞬视息

缓，音低语简，动作迟缓，兴趣索然，脉象与舌苔有时呈虚寒之象，有时则变化不大。

用法用量：水煎服。每日1剂，60剂为1疗程。

临床应用：上海市精神病防治总院周康主任医师认为癫狂并非皆痰迷，探求治法需审阴阳。指出单纯以化痰之品治疗癫狂（精神分裂症），效果并不佳，从“火”论治的效果也不理想。认为癫狂病机符合《难经·十二难》：“重阴者癫，重阳者狂”。临床将精神分裂症分为阴型和阳型施治，效果满意，为中医药治疗精神疾病另辟一新途。

使用注意：火旺者忌用。

药理研究：助阳药具有兴奋中枢神经系统机能的共性，故本方对精神分裂症情感淡漠、行为退缩、生活疏懒、呆滞嗜卧、思维贫乏、意志欠缺、语言蹇涩，孤独不群及自知毫无等有改善作用。

资料来源：周康验方，史文字等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：3。

②加減柴胡龍骨牡蠣湯

组成：柴胡30g，龙骨60g，牡蛎60g，大黄30g，赤芍30g，莪术100g。

适应症：精神分裂症阳型。兴奋紊乱，躁动不宁，幻觉妄想，卧起不安，或可见阳亢之象，或变化不大。

用法用量：水煎服。每日1剂，60剂为1疗程。

临床应用：见前方。

使用注意：虚寒证者慎用。

资料来源：周康验方，史广宇等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：4。

③达营汤

组成：莪术100g，大黄30g，赤芍30g。

适应症：周期性精神病。多为未婚女青年，每遇月经前后发生兴奋、躁闹、哭笑无常、思维散漫，数日后自缓。可无明显血瘀指征。

用法用量：每日1剂，煎服。或将其浓煎制成合剂服用。

临床应用：周康按“热入血室”古训及参照王清任“癫狂由于气血凝滞”的学说，采用中药活血化瘀、凉血达营的治则，药味由14味精简为3味，组成“达营汤”。经多年临床观察，有效率达90.9%。

资料来源：周康验方，史宇广等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：5。

④梁氏导痰汤

组成：法半夏、陈皮、茯苓、甘草、胆星、枳实、木香、石菖蒲、香附子、生姜、大枣。

适应症：癫病属心气不扬、痰浊内蒙者。或歌或哭，如醉如痴，表情淡漠，不饥不渴，甚至秽洁不知，神形不守，脉必弦滑。

用法用量：水煎服，每日1剂，2次分服。

临床应用：郁火偏旺者，可加用黄连3g，黄芩6g，龙胆草10g；痰气交阻者，加用礞石30g（打），沉香6g，枳壳6g。

资料来源：梁剑波验方，史宇广等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：15。

⑤二阳煎

组成：黄连、礞石、大黄、龙胆草、栀子、青黛、风化硝（冲）、胆南星、地龙、石菖蒲、远志、石决明。

适应症：狂证属阳明胃实者，多由郁怒悲愤、伤肝化火、干扰包络。性情躁动，头痛失眠，病起急骤，两目怒视，面红睛赤，妄言妄行，甚则弃衣而走，歌笑高呼，并能数日不食，不知饥饿，脉多弦大滑数。

临床应用：胃热重者加生石膏、知母；相火亢旺者加黄柏、知母、栀子；痰气交阻者，加沉香、姜半夏、矾水郁金。

使用注意：本方用于体实者。

资料来源：梁剑波验方，史宇广等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：17。

⑥豁痰定狂汤

组成：生龙齿 30g，生牡蛎 30g，生石决明 30g，生珍珠母 30g，龙胆草 10g，天竺黄 10g，九节菖蒲 10g，矾郁金 10g，旋覆花 10g，代赭石 10～30g，金礞石 30g，沉香 3g，黄芩 10g，大黄 6g。

适应症：狂证。猖狂刚暴，骂詈不避亲疏，甚则登高而歌，弃衣而走，逾垣上屋，非力所能，或与人语所未尝见之事，如有邪所依。

用法用量：水煎成 300ml，分 2 次服。另加甘遂 1.5g，朱砂 1.5g（共研细末），每晨空腹 1 次随汤药送下。

临床应用：兼见阴虚者，宜加生地、麦冬、石斛；兼见脾气虚者酌加太子参、炒白术。

使用注意：对体虚者宜注意只可暂用，中病即止。

资料来源：王季儒验方，史宇广等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：21。

⑦狂躁期方

组成：大黄 15～30g（后下），黄连 9g，芒硝 10～15g，白芍 30g，枳实 10～30g，栀子 9g，淡豆豉 9g，胆南星 10g，石菖蒲 10g，厚朴 9g，生甘草 5g。

适应症：精神分裂症狂躁期。精神亢奋，狂躁刚暴，喧扰不宁，力大过人，或毁物打骂；或登高而歌，或逾垣上屋，或狂奔乱舞，脉弦劲有力，或舌红，苔黄厚，脉弦滑洪数。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：本方为乔保钧经验方。乔氏将精神分裂症分为狂躁期、相对平衡期和恢复期，各列专方施治，多有效验。本方融大承气汤、黄连泻心汤、栀子豉汤、涤痰汤于一炉，用药量大势猛，以促其峻泻，顿挫邪之锐气。认为不宜缩手缩脚，迟疑久拖，此乃成败之关键。

使用注意：体质虚弱者慎用。

资料来源：史宇广等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：52。

⑧相对平衡期方

组成：柴胡 9g，当归 15g，茯苓 30g，栀子 9g，淡豆豉 10g，白芍 20g，枳实 9g，菖蒲 10g，炒枣仁 20g，琥珀 3g，生龙骨 15g，生牡蛎 15g，夜交藤 30g。

适应症：精神分裂症相对平衡期，由狂躁期经积极治疗或未经治疗、但患者由于连续发作体力日渐消耗转来。精神疲惫，时而躁狂，烦躁不眠，多言乱语。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：胃纳不健者，可酌加砂仁、姜夏、陈皮；体虚甚者可稍佐太子参、石斛之属。

使用注意：本期虽气阴两伤，但余热尚存，痰邪久恋，治疗上不宜过分强调补气、养阴，否则可使病情加重。

资料来源：乔保钧验方，史宇广等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：53。

⑨恢复期方

组成：党参 12g，麦冬 15g，五味子 9g，当归 15g，柴胡 9g，白芍 20g，天麻 15g，白术 10g，半夏 9g，陈皮 9g，茯苓 30g，丹参 15g，川芎 9g，炙甘草 5g。

适应症：精神分裂症恢复期。乏力神疲，少言懒动，胸胁胀满或刺痛，脘痞纳呆，心烦口渴，头晕头痛，舌红紫暗，少苔，

脉沉细无力。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：脘痞纳呆甚者，可以太子参、党参，加山药以缓养胃气；心烦口渴甚者，加山栀、豆豉清热除烦；舌质紫暗者，可加桃仁、红花活血化瘀。

资料来源：乔保钧验方，史宇广等，当代名医临证精华·癫狂痫专辑，北京：中医古籍出版社，1992：53。

⑩分裂症青春1号

组成：珍珠母24g，龙胆草6g，炒山栀6g，黄芩6g，黄连3g，细生地15g，杭白芍12g，丹参10g，玄参10g，炒枣仁18g，远志10g，菖蒲6g，合欢皮10g，天竺黄10g，琥珀末1.5g（分冲）。

适应症：精神分裂症青春型属抑郁不伸、怒不得泄、肝郁化火、扰乱神明者。语言内容离奇，不可理解，甚至言语思维破裂，情感喜怒无常，行为幼稚愚蠢，可有片断的幻觉和妄想，动作和情感改变多受幻觉和妄想支配、伴有冲动行为。

临床应用：本方为陈家扬经验方。陈氏长期从事中西医精神病学的研究、教学和临床工作，应用本方治疗青春型精分症多有效验。

使用注意：胃纳差者，服本方一周，可停用1~2天再服。

资料来源：陈家扬，实用中医精神病学，北京出版社，1985：276。

⑪分裂症青春2号

组成：珍珠母30g，龙胆草8g，炒山栀8g，黄芩8g，黄连3g，丹参10g，元参10g，远志10g，菖蒲6g，知母10g，黄柏8g，炒枣仁15g，琥珀末1.8g（分冲），朱砂末1.8g（分冲），川军3g，胆星10g。

适应症：精神分裂症青春型，属龙雷上僭，引动心火，邪扰

神明。语言内容离奇，言语思维破裂，行为幼稚愚蠢，有片断的幻觉和妄想，动作和情感改变，受幻觉和妄想支配。伴有食欲、性欲亢进。冲动行为多。俗称“花痴”。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：本方为陈家扬经验方，有较好疗效。有的患者服药10剂，即恢复正常。

使用注意：宜中病即止，不宜过用。

资料来源：陈家扬，实用中医精神病学，北京出版社，1985：276。

⑫十味温胆汤

组成：法半夏、枳实、陈皮各6g，茯苓5g，炒酸枣仁、远志、五味子、熟地、人参各3g，炙甘草5g，生姜5片，红枣1枚。

适应症：心胆虚怯，触事易惊，四肢浮肿，饮食无味，心悸烦闷，坐卧不宁。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：陈家扬以本方为主加减治疗精神分裂症属妄想型者。妄想型是精神分裂症中较多见的一型，十味温胆汤对此有一定的疗效。

使用注意：本方仅适用于气郁不舒、痰结不化为癫者。

资料来源：《证治准绳》

⑬清心汤

组成：栀子仁9g，连翘9g，薄荷9g，黄芩9g，大黄15g（另煎），芒硝6g（冲化），黄连9g，麦冬9g，甘草9g。

适应症：心经蓄热证。精神恍惚，言语错乱，喜怒无常或狂躁不宁，情绪高涨，言语滔滔，好歌好舞，心烦失眠，鼻眼觉热，面红口渴或吐血衄血，便秘溲赤，舌红苔黄，脉数有力。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：本方清心荡腑，使邪热从肠腑而去，大黄只宜煎1~2分钟，否则不导致通下作用。以畅泻为要。

使用注意：脾胃虚弱者慎用。

药理研究：黄连、黄芩、栀子皆有镇静作用，动物实验表明，能抑制小白鼠的自发活动，呈现闭目、低头、肌肉松弛。

资料来源：《证治准绳》

⑭荡痰汤

组成：生赭石 60g，大黄 30g（后下），朴硝 18g（溶化），清半夏 9g，郁金 9g。

适应症：火盛痰结证。急躁狂暴，言语错乱，忿怒狂歌，骂詈叫号，伤人毁物，心中烦闷，夜不能寐，便秘溲赤。舌质红苔黄腻，脉滑实。

用法用量：水煎服。每日1剂，分早、晚2次温服。

临床应用：借硝、黄之走泄通下，俾痰火从大肠而去，火去痰消，自然诸多怪戾之症均可消减。

使用注意：脾胃虚弱者慎用。

资料来源：《医学衷中参西录》

⑮服蛭煎

组成：生地 6g，麦冬 6g，乌药 6g，石菖蒲 6g，石斛 6g，丹皮 6g，茯神 6g，陈皮 3g，木通 5g，知母 5g。

适应症：阴虚火扰证。精神疲惫，时而兴奋烦躁，情绪焦虑紧张，多言善惊，或精神恍惚，语无伦次，身瘦面赤。舌红少苔，脉细数。

用法用量：水煎服。每日1剂，分早、晚2次温服。

临床应用：心火偏旺者，宜加川连、连翘、寒水石；肝火偏旺者，可加龙胆草、山栀子；相火亢旺者，加黄柏，并加重知母剂量。

药理研究：地黄、知母能对抗外源性糖皮质激素对垂体及肾

上腺皮质的抑制，使肾上腺皮质不萎缩；地黄有增强肾上腺皮质轴功能的作用，使衰弱症状得以改善。

资料来源：《景岳全书》

⑩癫狂梦醒汤

组成：桃仁 24g，柴胡 9g，香附 6g，木通 9g，赤芍 9g，半夏 6g，大腹皮 9g，青皮 6g，陈皮 6g，桑白皮 9g，苏子 12g（研），甘草 15g。

适应症：气血凝滞证。情绪不稳，时而高涨时而低落，哭笑不休，詈骂歌唱，不避亲疏，许多恶态，思慕异性，如醉如痴，或妄见、妄闻，妄想离奇多端，或呆滞忧郁，可兼见面色晦滞，胸胁满闷，妇人痛经，血紫有块。舌质紫暗或有瘀斑，脉弦涩或弦细、沉涩。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：国内不少学者通过临床发现精神分裂症许多患者不同程度地存在血瘀体征，如舌质紫暗或舌面、舌尖有瘀点瘀斑，青纹青筋和舌下静脉怒张等。据吴彩云等报告，通过血液流变学测定发现，精神分裂症患者血液流变学 7 项指标均高于正常人，异常项目在各证型中均存在，以血瘀型为最高，他们以活血化瘀为主的中药加西药治疗与单纯用西药治疗进行对照观察，其疗效明显高于后者（ $P < 0.005$ ），且可缩短疗程（ $P < 0.01$ ），为临床上以活血化瘀法治疗精神分裂症提供了依据（尚炽昌，疑难病证名验方辑要，北京：华龄出版社，1990：593）。

使用注意：有出血倾向者慎用。

药理研究：桃仁、赤芍等活血化瘀药能减低血液粘滞度，改善血液循环。

资料来源：《医林改错》

⑪养心汤

组成：人参 6g，黄芪 12g，茯苓 12g，川芎 10g，当归 12g，

药理研究：地黄饮子悬浊液灌胃，观察对大白鼠的影响。发现灌胃 1~2 周，肾上腺有明显的增殖，类固醇激素有明显释放，并且此作用是地黄饮子明显促进下丘脑正中隆突与垂体门脉直接有关的血循环后发生的。说明地黄饮子的治疗作用，可能是通过其滋肾补阳、即激发了下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的功能，改善了机体神经内分泌调节而取得（葛子，等，中医杂志，1991；9：560）。

资料来源：《宣明论方》

⑩逐呆汤

组成：人参 9g，白芥子 10g，白术 15g，茯神 20g，半夏 9g，菟丝子 15g，附子 3g，白薇 9g，朱砂 1.5g（研末调服）。

适应症：癡呆证，精神分裂症后期精神衰退。目瞪口呆，沉默少语，情感淡漠，生活懒散，秽洁不知。舌淡，苔白腻，脉沉滑。

用法用量：水煎服。每日 1 剂，2 次分服。

临床应用：肾阳虚明显者，宜酌加仙灵脾、巴戟天、锁阳；肾精不足加制首乌、熟地、枸杞子；纳差脘胀加砂仁、焦三仙。

使用注意：阴虚火旺者忌用本方。

药理研究：人参、菟丝子、附子均能兴奋和改善下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴功能，从而能改善全身衰弱症状。人参还能调节大脑兴奋-抑制过程，增加思维灵敏与准确性，有增强脑力和体力作用。

资料来源：《石室秘录》

⑪精分 1 号方

组成：生石膏、生大黄、生铁落、青礞石、黄芩、黄柏、青黛、芒硝、郁金、龙骨。

适应症：精神分裂症肝郁火旺型。躁动易怒，通宵不眠，打人毁物，动作增多，发狂无时，披发大叫，有时裸体，跳水冷浴

缩，对周围事漠不关心，面色无华，双目无神呆直，对答不切题。舌质淡，舌尖红，苔薄黄或黄腻，脉沉细数或脉细弦。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：见“精分1号方”。

使用注意：同“精分1号方”项。

资料来源：乔玉川，上海中医药杂志，1984；(10)：13。

②精分3号方

组成：当归、黄芩、黄柏、芦荟、木香、生石膏、生大黄、龙胆草、厚朴、枳壳、青皮。

适应症：精神分裂症阳明实热型。烦躁不安，通宵不眠，口干渴，大量饮冷水，大叫头痛，阵性发狂，外出乱跑，或来回走动踱步不停，有时大哭大闹，口中不停地自言自语，幻觉，面赤唇焦，大便干燥、秘结。舌尖红，苔黄厚裂或灰黑少津，脉洪数。

用法用量：水煎服。每日1剂，2次分服。

临床应用：见“精分1号方”。

使用注意：同“精分1号方”。

资料来源：乔玉川，上海中医药杂志，1984；(10)：13。

③金蒲丹

组成：郁金、石菖蒲、丹参各40g，香附20g。

适应症：精神分裂症。

用法用量：上方量，研末，制成50片，每片含生药2.8g。每次15~25片，1日2次，温开水送下。

临床应用：杨春林等以本方治疗精神分裂症204例，同时选用1种西药：氯丙嗪（ $<300\text{mg/d}$ ）、或三氟拉嗪（ $<20\text{mg/d}$ ）、或舒必利（ $<500\text{mg/d}$ ）、或氟奋乃静（ $<20\text{mg/d}$ ）。西药组100例，单用西药品种同上，选1种，用量折算成氯丙嗪，平均每日585mg。均以6周为1疗程，其后即评定疗效。结果，本方为主

组与单用西药组分别治愈 64 例、44 例，显著进步 70 例、24 例，进步 49 例、25 例，无效 21 例、7 例，显效率分别为 65.7%、68%，比较无显著性差异 ($P > 0.05$)。但本方为主组副作用较西药组显著减少。

使用注意：月经量多者宜减量服用。

药理研究：郁金、丹参可改善精神分裂症血液流变学方面的异常——高粘滞血症。

资料来源：杨春林等，中西医结合杂志，1987；7（9）：529～531。

②桃黄片

组成：桃仁 20g，大黄、赤芍各 40g。

适应症：精神分裂症实证。

用法用量：上方量制成浸膏糖衣片 50 片。初用每次 10～15 片，于上午 9:00 和下午 15:00 各服 1 次。可逐渐加重至每次 25～30 片。

临床应用：杨春林等以本方为主，同时加用小剂量西药如氯丙嗪、氟哌定醇、氯氮平等，以 6 周为 1 疗程，治疗精神分裂症 186 例（病程 3 个月～12 年）。结果，痊愈 73 例（占 39.2%），显著进步 55 例（占 29.5%），进步 42 例（占 22.6%），无效 6 例（占 8.6%）。与单用大剂量西药组的疗效无显著性差异 ($P > 0.05$)，但与文献报道单用小剂量西药治疗的效果比较则有显著提高。以本法治疗的副反应轻，减轻了西药引起的锥体外系等副作用，用总体印象量表评定，由于本组的副反应分低，使疗效指数分显著高于西药组。观察到本法对便秘、不寐、喜怒无常、妄见妄闻、狂躁、行为怪异等狂症症状疗效较好，对呆滞、妄言妄语则疗效较差。

使用注意：对虚证慎用。

药理研究：桃仁、大黄、赤芍均为活血化瘀（偏凉血性质）

间, 表明具有中枢镇静、催眠和抗惊厥作用。本方对幼鼠子宫重量、去卵巢小鼠阴道上皮细胞无明显影响, 无雌激素样作用。此外, 本方对家兔血压、呼吸、心率、心电图均无明显影响^[4]。

2. 对神经系统及平滑肌的作用 实验取大鼠对本方进行神经药理学的筛选和观察其对大鼠自发运动的影响。取豚鼠进行对离体平滑肌收缩作用影响的观察。结果: 在神经药理学筛选中, 未见显著的效果, 对环己烯巴比妥的睡眠时间稍有延长作用。对大鼠自发运动量在口饲第3~4日后观察到运动量减少。对于离体平滑肌的作用, 其提取物以 5×10^{-3} g/ml (水箱中浓度) 能够抑制组织胺、乙酰胆碱所致的豚鼠回肠收缩。对于大鼠子宫的收缩作用以 2×10^{-3} g/ml 的浓度则能完全抑制^[5]。

毒性研究:

①急性毒性试验: 将小鼠分为3组, 每组20只。室温18~23℃下1次灌胃给药(浓缩液0.6ml/只), 7天后观察死亡数;
②长期毒性试验: 大鼠120只, 随机分为4组, 即生理盐水对照组, 甘麦大枣汤10、20、30g/kg组, 灌胃给药, 每日1次。给药前、给药1.5个月和给药3个月后各检查1次肝功能(SGPT)、肾功能(BUN)、血红蛋白、白细胞总数和分类计数, 并对大鼠进食、外观、活动、粪便等一般情况进行观察。给药3个月后, 每组取10只大鼠, 放血处死后作大体病理检查及心、肝、肺、肾、脾和胃的病理切片检查。

急性毒性试验结果: 小鼠甘麦大枣汤灌胃给药 $LD_{50} > 80$ g/kg。长期毒性试验: 从第1和第2周起: 雌性大鼠10和20g/kg组和雄性大鼠10、20、30g/kg组体重增加值均明显高于对照组同期的体重增值, 增重趋势维持了3个月之久, 雄性比雌性更明显。血清GPT和BUN, 血红蛋白、白细胞总数和分类计数值与生理盐水对照组比较均无明显改变, 给药后1.5月和3个月检查统计, 均属正常范围。给药期间, 大鼠活动自如, 饮食、粪便正

常规则，无耸毛等不良反应。给药3个月后的心、肺、肝、肾、脾和胃，肉眼检查和切片检查均无明显改变^[4]。

资料来源：

[1] 周建芳，甘麦大枣汤治疗歇斯底里精神性发作35例，中医杂志，1960；(2)：105

[2] 周长发，用程门雪老师的经验治疗146例“精分症”临床报告，上海中医药杂志，1982，(9)：12

[3] 周长发，甘麦大枣汤加龙骨牡蛎治疗精神分裂症79例，浙江中医杂志，1982；(6)：273

[4] 谢强敏等，甘麦大枣汤的药理作用，中药药理与临床，1992；8(6)：6

[5] 保田和美，甘麦大枣汤的药理学研究，国外医学中医中药分册，1983；5(3)：181

⑦ 加减温胆汤

组成：半夏、茯苓、竹茹、陈皮、枳壳、太子参、枣仁、远志、菖蒲、甘草。

适应症：各类神经官能症，精神分裂症，情感性精神病。更年期综合征，植物神经功能紊乱，冠心病，癫痫及其精神障碍，高血压等。

用法用量：水煎服，每日1剂，30天为1疗程。

临床应用：治疗各类精神障碍患者132例，男103例，女29例；年龄15~73岁。其中神经官能症54例，更年期综合征38例，精神分裂症24例，脑动脉硬化性精神障碍16例。疗效判断：痊愈：病人自觉症状消失或明显减轻，稳定达3个月以上者；好转：病人自觉症状减轻，稳定达1个月以上者，不大于3个月；无效：病情无改变；复发：痊愈或好转病人，疗效不巩固，自觉症状复发者。结果：痊愈41例(31.1%)；好转74例(56.1%)；无效17例(12.8%)；复发22例，复发率为

19.1%；总有效率为 87.2%。

资料来源：陈发熙，加減温胆汤在精神医学中应用的体会——附 132 例分析，中级医刊，1987；22（12）：45。

⑳金蒲丹片

组成：郁金 40g，石菖蒲 40g，丹参 40g，香附 20g。

适应症：精神分裂症。

用法用量：上药共制成 50 片，每片含生药 2.8g，每次 15～25 片，每日 2 次。

临床应用：所治精神分裂症 304 例患者均符合 1985 年中华医学会精神分裂症临床工作诊断标准，并经“简明精神症状评量表（BPRS-CR）”加自知力共 19 项因子，评分在 35 分以上者，中医诊断属癫证血瘀痰阻型。将患者随机分为两组：①金蒲丹片合并小剂量抗精神病药治疗组（简称中西结合组）204 例。②抗精神病药治疗组（下称西药组）100 例。两组患者的性别、年龄、病程等大致相等。中西结合组每次服金蒲丹片 15～25 片，每日 2 次。同时选用一种西药：氯丙嗪（＜300mg/日）或三氟拉嗪（＜20mg/日）或舒必利（＜500mg/日）或氟奋乃静（＜20mg/日）。西药组所用西药品种与中西结合组基本一致，选其 1 种，用药剂量折算成氯丙嗪，平均为 585mg/日，2 组均以 6 周为 1 疗程，1 疗程结束后评定疗效。结果：①两组疗效比较：中西结合组显效率为 65.7%，与西药相比无显著性差异（ $P > 0.05$ ）；②中西结合组副作用较西药组显著减轻；③中西结合组中有 44 例作了治疗前后甲皱微循环观察，发现治疗前甲皱微循环严重异常，治疗后部分指标有显著差异。

资料来源：杨春林等，金蒲丹片为主治疗精神分裂症临床观察，中西医结合杂志，1987；7（9）：529。

㉑复方地龙汤

组成：活地龙 50 条，酒洗川大黄 60g，生韭菜汁 250g。

适应症：精神分裂症。

用法用量：将地龙纱布包裹煮沸 2 小时，加入大黄再煮 5 分钟，滤液与韭菜法混合顿服，1 天 1 次，或隔日 1 次，共 10 次。

临床应用：所治精神分裂症 40 例中，男 22 例，女 18 例；年龄最小 15 岁，大者 41 岁以上；病程最短 2 个月，最长 10 年。全部患者均无严重躯体疾病，并均系经冬眠灵治疗 2 月以上无效者。结果：精神症状全部消失，自知力与原有工作能力全部恢复，适应环境很好者为痊愈，共 19 例；精神症状基本消失，自知力大部恢复，能料理自己的生活，适应环境无困难，但对原工作不能充分胜任者为显效，共 11 例；精神症状减轻，自知力未恢复，适应环境差者为好转，共 9 例；症状如旧者为无效，共 1 例；总有效率为 97.5%。

资料来源：曹典永，复方地龙汤治疗精神分裂症 40 例的初步观察，安徽中医学院学报，1983；2（1）29。

⑩复方金蒲丹

组成：郁金 30g，菖蒲 25g，丹参 15g。

适应症：精神分裂症。

用法用量：上药提取有效成分后浓缩成浸膏，加入舒必利 0.5g，混合压成 20 片，每片含生药 3.5g，舒必利 0.025g。饭后服用复方金蒲丹 6~10 片，日 2 次。以 6 周为 1 疗程。

临床应用：治疗精神分裂症 24 例，均为男性；平均年龄为 30 岁；病程平均为 5 个月，以偏执型为多，未定型次之。结果：治愈 11 例，显著进行 5 例，进步 5 例，无效 3 例；总有效率为 87.5%。

资料来源：杨春林等，复方金蒲丹治疗精神分裂症的临床观察，中国医药学报，1992；7（2）：30。

⑪桃黄片

组成：桃仁 20g，大黄 40g，赤芍 40g。

适应症：精神分裂症。

用法用量：上药提取制成浸膏糖衣片 50 片。初用每次 10～15 片；若无腹泻，病情又未见好转，可逐渐加量至 25～30 片，日 2 次，在上午 9 时、下午 3 时服用。同时配合小量西药，多用氯丙嗪（ $< 300\text{mg/d}$ ）、氟哌啶醇（ $< 20\text{mg/d}$ ）、氯氮平（ $< 250\text{mg/d}$ ）。

临床应用：本组 186 例，男性 142 例，女性 44 例；年龄 16～25 岁 84 例，26～40 岁 68 例，41～55 岁 34 例；初次住院 76 例，2 次以上住院 110 例；病程最短 3 个月，最长 12 年，3 年以内者最多，计 128 例，占 68.8%。均据 1985 年中华医学会精神分裂症临床工作会议所订诊断标准，并经“简明精神症状评定定量表（BPRS- CR ）”（加自知力，共 19 项）评分在 35 分以上者。另随机取 100 例单用大剂量氯丙嗪、氟哌啶醇、氯氮平治疗。桃黄片组和西药组病例均以治疗 6 周为 1 疗程。1 疗程结束后评定疗效。疗效标准：治愈：精神症状消失，自知力恢复；显著进步：精神症状基本消失，自知力大部分恢复；进步：精神症状有改善；无效：精神症状无改善或反增剧者。结果：桃黄片组治愈 73 例（39.2%），显著进步 55 例（29.5%），进步 42 例（22.6%），无效 16 例（8.6%），显效率为 68.7%；西药组治愈 42 例（42%），显著进步 25 例（25%），进步 42 例（22.6%），无效 16 例（8.6%），显效率为 68.7%；西药组治愈 42 例（42%），显著进步 25 例（25%），进步 27 例（27%），无效 6 例（6%），显效率为 67%。2 组无显著差异（ $P > 0.05$ ），但与文献报道的单用小剂量西药治疗的显效率 40.0% 比较，桃黄片组有显著提高。

资料来源：杨春林等，桃黄片为主治疗精神分裂症的临床与实验观察，中医杂志，1986；27（9）：71。

⑫柴胡加龙骨牡蛎汤

组成：柴胡 12g，龙骨、黄芩、生姜、铅丹、人参、桂枝（去皮）、茯苓各 4.5g，半夏 6g（洗），大黄 6g（切），牡蛎 4.5g（熬），大枣（擘）6 枚。

适应症：精神分裂症。

用法用量：上药 12 味，除大黄外，以水 800ml，煮取 400ml，再纳大黄，更煮一二沸，去滓，每次温服 100ml。

临床应用：应用本方加减：柴胡、炒黄芩、姜半夏、茯苓各 9g，桂枝 6g，丹参、龙骨、生牡蛎各 15g，党参 12g，生大黄 6~9g，生姜 6g，红枣 15g。将患者分为 3 组：A 组 15 例，属少阳证者用柴胡龙牡汤治疗，有睡眠障碍可服安定或利眠宁，不给其他西药；B 组 31 例，属少阳证者以柴胡龙牡汤为主，合用氯丙嗪或泰尔登，日服量小于 200ml；C 组 21 例，属少阳病兼有气滞血瘀者用柴胡龙牡汤之衍化方为主，合用氯丙嗪或泰尔登，日服量小于 200mg。柴胡龙牡汤衍化方：柴胡、炒黄芩、当归、赤芍、桃仁、红花各 9g，生大黄 6~9g，川芎 6g，生龙牡各 15g，生姜 6g，红枣 15g。以上每日 1 剂，30 剂为 1 疗程，无效者可继服 2 个疗程。治疗精神分裂症 67 例，男 21 例，女 46 例；年龄 16~57 岁，20~40 岁者占 73.13%；病程 3 个月至 1 年者 24 例，2~3 年者 12 例，4~5 年者 6 例，6~23 年者 25 例。诊断标准和分型依 E. Bleuler 的基本（原发生）症状如联想障碍、情感淡漠、孤独性及矛盾症作为本病的诊断依据，而将幻觉、妄想及现实解体等作为附加（或继发）症状。其中偏执型 37 例，紧张型 1 例，青春型 1 例，未定型 28 例。中医辨证：少阳证 46 例，少阳证兼有气滞血瘀 21 例。疗效评定依据 1978 年 7 月于南京召开的第二届全国神经精神科学学术会议所制定的标准，分为痊愈、显效、进步及无效。结果：痊愈 1 例，显效 35 例，进步 15 例，有效率为 76.1%。

资料来源：葛萍等，柴胡龙牡汤治疗精神分裂症 62 例临床观察，中西医结合杂志；1986；6（12）：753。

③柴胡加龙骨牡蛎汤

组成：软柴胡 12g，生龙骨 20g（先煎），生牡蛎 20g（先煎），路党参 15g，制半夏 12g，生大黄 10g，云茯苓 12g，淡黄芩 12g，川桂枝 6g（去心），紫丹参 15g，生姜 3 片，大枣 6 枚。

适应症：精神分裂症。

用法用量：每日 1 剂，每剂 2 煎，上、下午各服 1 煎，30 剂 1 疗程，有效者可继服 1 疗程。

资料来源：王明祥，实用中西医结合杂志，1998；（2）：170。

④宁神解郁汤

组成：五味子 15g，酸枣仁 30g，夜交藤 20g，石菖蒲 20g，当归 20g，郁金 15g，柴胡 15g，甘草 10g。

适应症：精神分裂症。

用法用量：每日 1 剂，水煎成 300ml 顿服，重者每日 2 剂早晚分服。

临床应用：痰火内扰型加胆南星、山栀子、生石膏；痰湿内阻型加竹茹、半夏、胆南星；气滞血瘀型加桃仁、红花、鸡血藤；阴虚火旺型加麦冬、沙参。

配合西药治疗，可视病情服用小剂量抗精神病药物。

资料来源：刘立芬等，吉林中医药，1997；17（1）：24。

⑤甘遂辰砂丸（方名为编者拟）

组成：甘遂末 10g，辰砂末 12g，代赭石末 12g，连血猪心 1 个。

猪心一个剖开，取 3 管血，将甘遂末、代赭石末和猪心血拌匀，纳入猪心内，线缚好，外用牛皮纸湿裹，慢火煨熟，勿焦为度，而后将药取出与朱砂和匀分作 8 丸。

适应症：癫狂症。

用法用量：每日清晨空腹服 1 丸，开水送服，重症者每日早晚各服 1 丸。

资料来源：沈骥等，吉林中医药，1997；17（1）：12。

三、单方验方

（一）郁金 210g，明矾 90，加薄荷 30g，研末为丸。每服 10g，每日 2 次，温开水送下。（《程氏简易方论》）

（二）桃花 250g。挤汁，加入香附 3g，藕 15g，桔梗 3g，同煎，吃藕和药汁。（《外台秘要》）

（三）铁锈 120g。敲碎，加水煎，服其液。（《医学三字经》）

（四）青盐 15g。炒红，加水适量。服下，以羽毛或押舌板刺激其咽部，引吐，以呕吐痰涎为妙。不效再用。（《千金方》）

（五）天南星（生用）300g，琥珀（研）30g，朱砂（水飞）60g。为细末，姜汁打面糊为丸，如绿豆大，每服 40 丸，用人参、石菖蒲煎送下，淡姜汤亦得。（《严氏济生方》）

（六）巴戟天 90g，半夏 9g，煎服。（《辨证录》）

（七）麻仁 72g，煎服。（《医方考》）

（八）好生犀角 120g。锉末，每用 30g，加淡竹叶 120g 煎汁内服。（《先醒斋医学广笔记》）

（九）苦参，煎服或为丸服。（《千金方》）

（十）莨菪子 60g。以酒 300ml 浸之，出暴干，再渍尽酒止捣。服 6g，日三，勿多服。（《外台秘要》）

四、中成药

本病只有少数几种中成药，其中礞石滚痰丸较为常用。

来源：《惠直堂经验方》卷一

组成：大黄 60g（九蒸），礞石 60g（煨、乳淬），沉香 30g，

半夏 60g (姜、矾制), 陈皮 60g, 黄芩 60g (酒制)。

主治: 中痰, 并一切痰证。可用于精神分裂证痰火较甚者, 妄见妄闻、歌舞不休、不知廉耻、喃喃自语等。

用法用量: 上药为末, 陈米糊为丸, 如绿豆大。每服 9g, 一日 2 次。

临床应用: 痰火甚者以生石膏 100g, 煎汤送服; 气虚已显者用人参 6g, 煎汤送服; 肾虚者可与六味地黄丸间隔使用。

使用注意: 以每日腹泻 2~3 次为宜, 神志复常后停用。

方义解释: 本方为实热老痰而设。实热老痰, 久积不去, 变化多端, 发则出现种种怪戾之症。若兼大便秘结, 苔黄厚腻, 脉滑数有力, 即可用本方降火逐痰, 使痰积恶物, 自肠道而下。方中主药礞石驱逐顽痰, 力甚峻猛; 辅以大黄苦寒, 荡涤实积, 开下行之路; 黄芩苦寒, 泻上焦之火, 消除生痰之源, 大黄、黄芩二味同用有正本清源之意。沉香调达气机, 为诸药开导。四药配合, 确是治疗痰火之有力方剂。

五、饮食疗法

饮食宜以清淡, 忌食油腻辛辣之品, 另忌公鸡、鲤鱼、猪头肉及烧鹅等动风发物。药膳方如下:

(一) 猪胃 1 只 (剖, 洗净) 包金箔 10 枚, 缝合后加水煮烂。食猪胃, 并饮汤汁, 常用之。(《活人一术初编》)

(二) 锈铁 1 块 (约 250g), 煎水, 以其水煮小麦 120g 成麦粥, 食之。(奇效良方)

(三) 刀豆粉、米粉各 20g, 蝮蛇 (烧存性, 研) 6g。每服 3g, 每日白天服 2 次, 夜间服 1 次, 以有嗜睡感为佳。此方即古方“白龙散”。(《李氏经验广集良方》)

以上适用于精神分裂证实证。

(四) 莲子 60g, 大枣 30g, 水煎煮, 食之。适用于精神分裂

症虚证。(《神仙济世良方》)

(五) 黄花菜(金针菜) 20~40 根, 与荸荠或黑木耳同炒当菜吃或煮汤喝。可改善精神分裂症抑郁症状。(《活人一术初编》)

六、医案医话

(一) 陈家杨医案——龙雷上僭, 扰动神明案

刘某, 女性, 20 岁, 技校学生。初诊日期为 1981 年 3 月 10 日。患者姐弟三人, 患者居长。父母及外祖父非常疼爱女孩。自幼年一切生活琐事均需家人照料, 对一切事物自己也不肯独立思考, 凡事皆需家长给予安排, 性格懦弱。高中毕业后未能考取大学, 于 1979 年考入专科技校学习。患者虽对本专业不十分喜爱, 但学习成绩尚好。4 个月前家长发现其精神异常, 经常对着镜子笑, 继之声称学校某男生爱慕自己, 自认为该男生的一切举动言行都是暗示对她的爱慕之情, 从此学习精神不能集中, 后就医休病假。一日自己打扮好说是与某男生约好在某处会面, 其母陪同前往, 并未见到有人等她。随后家长去学校访问班主任, 班主任从未发现她与某男生有过接触; 于是又找某男生了解情况, 该生否认和她有过联系。至此, 家长始意识到她的病情的严重。经某某精神病院诊断为精神分裂症青春型。经治两月余无效, 逐渐发展到常将衣服脱掉, 裸体在房中行走而大笑不止; 食欲增加, 不断要东西吃。精神恍惚, 神态似 16、17 岁少年。唇红, 舌质红, 边尖起红刺, 苔黄, 脉滑数。龙雷上僭, 引动心火, 邪扰神明。泻相火, 益心阴, 镇静安神。方用分裂症青春 2 号。珍珠母 30g, 龙胆草 8g, 炒山栀 8g, 黄芩 8g, 黄连 3g, 丹参 10g, 元参 10g, 远志 10g, 菖蒲 6g, 知母 10g, 黄柏 8g, 炒枣仁 15g, 琥珀末 1.8g (分冲), 朱砂末 1.8g (分冲), 川军 3g, 胆星 10g。5 剂。

按前方加减服药 15 剂, 愚蠢动作消失, 幻听已无, 睡眠也

好，精神接近正常，对病中的思想有批判能力，承认与某男生从没有交谈过。4月13日停服汤剂，为了巩固疗效，配制丸剂缓服。已参加学习。珍珠母 120g，龙胆草 30g，炒山栀 30g，黄芩 30g，黄连 12g，生地 60g，丹参 40g，玄参 40g，远志 30g，菖蒲 24g，知母 30g，黄柏 30g，炒枣仁 60g，胆星 30g，川军 10g，琥珀末 6g，朱砂末 6g。

以上共研细末，炼蜜为丸，每丸 10g，每服 1 丸，早晚服。

虽因病停止学习 3 个多月，但暑期考试成绩尚好。本年寒假期末考试，成绩优良，被评为优秀学生。1982 年毕业后分配在某厂工作，专业技术熟练，无任何精神症状。（陈家扬，实用中医精神病学，北京：北京出版社，1985：277～278）

（二）周康医案——脾肾阳虚，脑失所养，发为癫证案

某男，38 岁，已婚。3 年来每年发病 1 次，此次于入院前 10 天，开始沉默寡言，哭泣，欲自杀，以往有阳痿病史。精神检查，仪态不整，注意迟钝，动作言语均显著减少，情感淡漠，有捞食大便行为，迫害妄想及听幻觉均较明显，智能未减退，自知力不全，诊断为精神分裂症。先予氯丙嗪合并利血平治疗，1 个月后情况显著进步。但再经半月后，病又恶化，萎靡懒散，终日嗜睡；再予胰岛素治疗，嗜睡更甚，常诉“怕冷”，且有腹泻、纳呆现象，应用止泻及助消化剂无效，经胰岛素治疗 16 次后，上述情况更严重，乃停胰岛素及各种西药，改为中药治疗。此时患者整日欲寐，倦怠无神，言低语简，兴趣索然，食欲不振，五更泄泻，舌淡无苔，脉细弱。整个病情属于脏腑虚寒，太阴少阴为病，以往虽有幻觉妄想等有余之症，但至此已变为不足之象，再结合畏寒及阳痿病史，属阳虚寒证无疑。先予补中祛寒，温扶中下，壮命门火，益不足之真元。用壮阳汤去熟地、龟板，药用：附子 9g，干姜 9g，肉桂 6g，巴戟天 9g，仙灵脾 9g，仙茅 9g，党参 9g，黄芪 9g，陈皮 9g，炙甘草 6g。服药 3 剂后，腹泻

肝。”《证治准绳·杂病》“内火致眩”。《丹溪心法》谓“无痰不作眩”。《景岳全书》“无虚不作眩”。《医学从众录·眩晕》谓：“盖风非外来之风，指厥阴风木而言，与少阳相火同居，厥阴气逆则风生火发，故河间以风火立论。风生必夹木势而克土，土病则聚液而成痰，故仲景以痰饮立论。丹溪以痰火立论也。究之肾为肝母，肾藏精，精虚则脑海空而头重，故《内经》以肾虚及髓海不足立论也。其言虚者，言其病根；实者，言其病象，理本一贯。”真是至理名言。

同前所述病因一样，临床中耳眩晕症多与心肾肝脾四脏有关，肾阳不足，寒水上泛，停聚耳窍；肝肾阴虚，肝阳上亢，肝风内动，上扰清窍；心神过劳，脾气亏虚，血虚不能上荣于脑；脾虚生湿，痰浊阻滞，清阳不升，浊阴不降等皆可导致耳眩晕。此外亦有脓耳变症之误治失治，邪毒蚀膜腐骨所导致眩晕，非本篇讨论的范围。

二、辨证施治

（一）辨证要点

耳眩晕初起，多为风火痰浊实邪引起，属实证。临床见突发眩晕，视物旋转。自身旋转，静卧闭目片刻可稍减轻。伴耳鸣耳聋，恶心呕吐，汗出，倾倒及眼球震颤。发作时间长短不一，有的数分钟，有的数小时或更长时间，结合其他见症可分为肝阳上扰及痰浊中阻两型论治。耳眩晕久发或反复发作则为虚症。其表现为眩晕反复发作，突发眩晕而无先兆，呈旋转性，自觉头眩眼花或幻觉自身旋转或天旋地转，不能张目站立，头不愿转，双眼紧闭，兼有耳鸣耳聋，自发眼震，甚则恶心呕吐，面色苍白，出汗肢冷等症，每次发作可持续数分钟、数小时或数日之久，发作后症状消失，听力恢复或下降，多次反复发作听力下降明显，结合病因和发作时其他见症，可作为髓海不足论，并按偏阴虚或偏

阳虚来辨证施治。

(二) 辨证分型

1. 肝阳上扰型

眩晕遇心情不舒或运动时发作，恶心，头闷脑胀，心烦易怒，喜静恶躁，兼见头痛，面红目赤，口苦咽干，少寐多梦。舌红苔黄，脉弦数。

2. 痰浊中阻型

眩晕，甚则摇摇欲倒，不能视物及坐起，动则恶心呕吐，耳鸣耳聋，头胀身重，胸闷不适，纳呆多寐，痰多心悸。舌苔白腻，脉濡滑或濡缓。

3. 髓海不足型

肾阴虚为主者，见眩晕耳鸣常发，每于发作时耳鸣加重，听力减退，兼见腰膝酸软，心烦失眠多梦，记忆力差，手足心热。舌质红，苔少，脉弦细数。

肾阳虚为主者，眩晕而伴心下悸动，腰痛背冷，手足不温，阳痿滑泄，夜尿频而清长。舌质淡苔薄白，脉沉细尺脉尤弱。

(三) 治法方药

1. 分型治疗

(1) 肝阳上扰型 平肝息风，滋阴潜阳。方宗天麻钩藤饮加减，以天麻、钩藤、石决明平肝潜阳息风为主；兼以牛膝、杜仲、桑寄生益肾滋阴、治其根本。黄芩、山梔子可以清肝火，使风火不得相并有害。偏于风盛者加龙骨、牡蛎镇肝息风；偏火盛者加龙胆草、丹皮以清肝泄热。

(2) 痰浊中阻型 健脾燥湿，涤痰息风，方用半夏白术天麻汤。以二陈汤（半夏、陈皮、茯苓、甘草）燥湿除痰，加白术以健脾，入天麻以息风，湿重者倍用半夏加泽泻。

(3) 髓海不足型 偏阴虚者，滋阴补肾，填精益髓。方用杞菊地黄汤加石决明、牡蛎、白芍、首乌等。方中以六味地黄汤滋

肾，壮水之主，以水涵木。加杞子、菊花、白芍、首乌养肝益血，石决明、牡蛎滋阴潜阳。偏阳虚者，温壮肾阳、散寒利水、方用真武汤加减。以附子辛热，温壮肾阳；生姜散寒；白术、茯苓健脾利水，共奏温壮肾阳、散寒利水之功。

2. 方药选介

①干祖望验方（方名系编者加）

组成：山药 10g，当归 10g，五味子 10g，酸枣仁 10g，龙眼肉 5 枚。

适应症：适应症广，除舌苔厚腻者其他各型耳眩晕均可用。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，或制成膏剂经常服用。

临床应用：使用方便，适应症较广；药味可口，久用不伤脾胃；此方发作时有治疗作用，间歇期有预防作用。

使用注意：耳眩晕之舌苔厚腻者不可用。

资料来源：严道南，干祖望治疗美尼尔病的方法，长江医话，江苏科学技术出版社，1992；473。

②岳美中验方

组成：酸枣仁 15g，怀山药 15g，桂圆肉 15g，当归 15g，五味子 9g。

适应症：内耳眩晕症，以情绪激动加剧，舌红无苔者。

用法用量：水煎服，每日 1 剂，分两次口服。

使用注意：注意舌苔变化，本方适应于舌红无苔者。

资料来源：《岳美中医案集》

③龙地汤

组成：龙眼肉 120g，熟地黄 120g，陈皮 15g，白糖 120g。

适应症：耳眩晕之虚症。

用法用量：加水 5 倍共煮沸，每日隔水蒸 1 次，频频代茶饮。

作用注意：本方对耳眩晕属实证不可用。

资料来源：黄寿人验方，疑难病名验方辑要，华龄出版社。

④甘麦大枣汤加味方

组成：炙甘草 9g，淮小麦 30g，大枣 7 枚，熟附片 12g（先煎），磁石 30g，龙骨 30g，桂枝 6g，生白芍 9g，钩藤 15g（后下），合欢皮 15g。

适应症：耳源性眩晕及神经衰弱所致的怔忡眩晕，健忘失眠等。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

资料来源：徐仲才方，疑难病症名验方辑要，华龄出版社。

⑤复方泽泻汤

组成：泽泻 20g，生白术 15g，钩藤 15g，真珠母 15g，菊花 10g，牛膝 10g，磁石 25g（先煎）。

适应症：耳眩晕症。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：恶心呕吐加半夏，代赭石；出汗多加山萸肉、煅牡蛎；兼发热烦渴加生石膏，麦冬、白芍；心悸失眠加茯神、酸枣仁；头痛者加白蒺藜；食欲不振加山楂、内金；腰痛加杜仲，寄生；气虚加党参、黄芪；眼花耳鸣加枸杞子、女贞子。作者用本方治疗 102 例病人痊愈 90 例，显著好转 17 例，复发 5 例。

资料来源：欧阳可钧，复方泽泻汤治疗耳源性眩晕症 102 例临床观察，江西中医药，1982；(2)：25。

⑥止眩除晕汤

组成：半夏 18g，桂枝 15g，泽兰 15g，陈皮 15g，川牛膝 15g，生姜 15g，车前子 30g，牡蛎 30g，白术 24g，茯苓 24g，琥珀 6g（冲）。

适应症：美尼尔病。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：用本方治疗 64 例美尼尔病，其中 49 例系 2 次发

作，服药 2~10 剂后，全部临床治愈。随访 5 年有 5 例复发，但均服原方而愈。

资料来源：王忠民，止眩除晕汤治疗美尼尔病 42 例，陕西中医，1986；7（12）：540。

⑦定眩汤

组成：白术 15g，石菖蒲 15g，钩藤 15g，泽泻 20g，茯苓 20g，半夏 10g，桑叶 10g，天麻 10g，荷叶 10~15g。

适应症：美尼尔病。

用法用量：日 1 剂，水煎，分 3 次服。

临床应用：气虚加黄芪、党参；肾阴不足加旱连草、女贞子、何首乌；虚火上炎加知母、黄柏、牛膝；肝火明显加龙胆草、黄芩；血压偏高，肝阳上亢者加代赭石、生龙牡；失眠加炒枣仁、夜交藤；恶心呕吐加炒竹茹。

作者治疗本病 42 例，服药 5~14 剂，痊愈 39 例，好转 2 例，无效 1 例，总有效率 98%。

资料来源：张昇平，定眩汤治疗美尼尔病 42 例，山东中医，1992；11（3）：22。

⑧加减葛根汤 I 号方

组成：葛根 45g，黄芪 30g，珍珠母 30g，磁石 30g，柴胡 8g，蝉蜕 10g，煅龙齿 10g，桂枝 10g，白芍 10g，当归 15g，苦丁茶 5g。

适应症：内耳眩晕之肝旺肾虚者。

用法用量：水煎，日 1 剂，分两次服。

资料来源：赵养生，加减葛根汤治疗内耳眩晕病，江苏中医，1984；5（3）：7。

⑨加减葛根汤 II 号方

组成：加减葛根汤 I 号方去桂枝，加丹参 20g，钩藤 15g，决明子 15g。

适应症：内耳眩晕之肝郁血虚者。

用法用量：水煎服，每日1剂，分两次服。

使用注意：孕妇慎用或忌用。

资料来源：同加减葛根汤I号方。

⑩五味子合剂

组成：酸枣仁10g，淮山药10g，当归10g，五味子10g，桂圆肉10g。

适应症：内耳眩晕病。

用法用量：水煎服，每日1剂。

临床应用：兼实证痰延壅盛者加天竺黄，姜半夏；兼气虚，舌淡脉细者加党参、黄芪；兼血虚，爪甲不荣者加熟地、丹参；血压高者加罗布麻片、夏枯草、羚羊角粉（吞服）。作者用本方治疗内耳眩晕42例，用药8~105剂，临床治15例（症状消失，3个月不发），有效24例（症状基本消失，发作较前减少），无效3例，总有效率93%。

资料来源：潘珈琰，五味子合剂治疗内耳眩晕病42例，陕西中医，1989；10（12）：535。

⑪定眩饮子

组成：法夏15g，陈皮12g，防己12g，茯苓20g，黄芪15~30g，谷精草8~18g，甘草8g，生姜1片。

适应症：内耳眩晕病。

用法用是：水煎服，每日1剂。

临床应用：痰湿重加胆南星；气血虚加潞党参、当归；郁热加栀子、龙胆草；津亏加沙参、麦冬、五味子；耳鸣或重听加蝉蜕、响铃草。

资料来源：王继仙，定眩饮子治疗内耳眩晕病临床观察，云南中医，1989；10（6）：12~13。

⑫平眩汤

组成：泽泻 40g，天麻 15g，丹参 30g，磁石 30g，白术 30g，代赭石 30g。

适应症：耳源性眩晕。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：肝阳上亢加钩藤；气血亏虚加黄芪、党参；肾阴不足加五味子；自汗多者加龙骨、牡蛎；热甚加龙胆草；失眠加酸枣仁；耳鸣耳聋甚者加石菖蒲；呕吐者加半夏。

使用注意：治疗期低盐饮食；禁油腻及辛辣刺激物；孕妇慎用。

资料来源：李贯彻，平眩汤治疗耳源性眩晕 100 例临床小结，新中医，1991；23（3）：31。

⑬加味当归芍药汤

组成：川芎 30g，泽泻 30g，当归 15g，白芍 15g，白术 15g，茯苓 15g，丹参 15g，白茅根 15g。

适应症：美尼尔病。

用法用量：轻者日 1 剂，重者日 2 剂，水煎频频饮服。

临床应用：耳鸣甚者加山萸肉；汗出，面眇色白加党参、黄芪；口干舌质红加生地、女贞子、天冬、麦冬；四肢末端不温，脉沉滑者加菟丝子、熟附片、巴戟天；头痛重者加菊花、蔓荆子；呕吐频繁加代赭石、旋覆花；口中粘腻，舌质红苔黄腻，脉滑数加黄芩、竹茹、陈胆星；颈项活动不便加葛根、郁金、丝瓜络；心慌失眠，脉细加炒枣仁、夜交藤；月经不调，经前乳胀痛加柴胡、香附、佛手。用本方治疗美尼尔病 110 例，服药 17～20 日后，愈 88 例，显效 11 例，有效 2 例，无效 9 例，总有效率 91.82%。

使用注意：孕妇慎用。

资料来源：程运文，（题为编者加）加味当归芍药汤治疗美

尼尔氏病 110 例，国医论坛，1991；(1)：9。

⑭王智贤验方

组成：白蒺藜 20g，菊花 20g，天麻 10g，珍珠母 20g，陈皮 10g，半夏 10g，胆南星 10g，代赭石 30g，泽泻 30g，云苓 20g，白术 10g，甘草 3g。

适应症：美尼尔病。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

资料来源：王智贤，三十种病治验录，山西科学教育出版社，1987；36。

⑮泽泻汤

组成：泽泻 12g，白术 12g。

适应症：耳眩晕症之膜迷路积水者。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

资料来源：《金匱要略》

⑯草乌头、细辛茶芽方（方名自拟）

组成：草乌头、细辛、茶芽各等分。

适应症：但晕而不眩，发则伏地昏昏，食顷乃苏。

用法用量：上为末，每服 15g，水 500ml，煎至 250ml，去滓缓缓服尽。

资料来源：全《生指迷方》

⑰川芎散

组成：川芎 15g，山药 15g，茯神 15g，甘菊花（野菊不用）15g，人参 15g，山萸肉 30g。

适应症：风眩头晕。

用法用量：上为细末，酒调 6g，每日 3 服。

资料来源：《妇人大全良方》

⑱止晕汤

组成：野菊（或甘菊）12g，黄芩 10g，生地 15g，生石膏

12~30g, 云苓 12~25g, 桂枝 10g, 白术 12~20g, 泽泻 15~30g, 陈皮 10g, 半夏 10g, 生龙骨 25g, 生牡蛎 25g, 甘草 6g。

适应症：耳源性眩晕。

用法用量：水煎，日服 1 剂，10 天为 1 疗程。

临床应用：所治耳源性眩晕 30 例中，男 11 例，女 19 例，年龄 30~70 岁，以 40~50 岁发病多。病程 3 天至 20 年。治疗标准：治愈：首发病人，眩晕控制至来年同期不再发者；每年发病 1~2 次，观察 2 年以上不再犯病者；数日发病 1 次，药后 1 年内未再犯者。有效：发病 3 天内投药，药后晕止者，或药后眩晕停止较自愈期提前（如不用药 7 天停止，用药 5 天即止）；或药后症状明显改善者，无效：用药 7 天无改善者。结果：有效者 28 例，无效者 2 例；总有效率为 93%。

资料来源：许继昭，耳源性眩晕 30 例报告，山东中医杂志，1984；(6)：22。

⑩化痰通窍汤

组成：半夏 20g, 白术 12g, 生南星 1.2g, 泽泻 12g, 石菖蒲 20g, 桂枝 10g, 菊花 15g。

适应症：耳源性眩晕。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。头痛甚者加蔓荆子，肝火甚者加龙胆草、丹皮，气虚者加黄芪、党参，呕吐甚者加生姜、赭石，耳鸣重听者加郁金、葱白，脘闷不食者加砂仁。

临床应用：所治耳源性眩晕 114 例中，男 51 例，女 63 例，年龄 23~50 岁。结果：临床症状消失，随访 1 年内未复发者为痊愈，共 103 例，占 93.35%；服药后症状消失，1 年内复发者为有效，共 11 例，占 9.65%。

资料来源：刘志军，化痰通窍汤治疗耳源性眩晕 114 例，湖南中医杂志，1989；(5)：36。

②平眩汤

组成：泽泻 40g，天麻 15g，丹参、磁石、白术、代赭石各 30g。

适应症：耳源性眩晕症。

用法用量：每日 1 剂，水煎 2 次，兑后分 2 次服。

临床应用：治疗耳源性眩晕症 100 例中，男 55 例，女 45 例；年龄 6~64 岁；发病时间 2 天至 3.5 年。疗效标准：治愈，眩晕、呕吐消失，耳鸣、听力复常，1 年内未复发；有效，眩晕、呕吐消失，耳鸣、听力未完全恢复，半年内未复发。结果：临床治愈 93 例，有效 7 例。

资料来源：李贯彻，平眩汤治疗耳源性眩晕症 100 例临床小结，新中医，1991；(3)：31。

②加味血府逐瘀汤

组成：桃仁、红花、川芎各 10g，熟地 15g，京赤芍 10g，柴胡 5g，桔梗 10g，牛膝、当归各 15g，枳壳 10g，全蝎尾 5g，蜈蚣 3 条，僵蚕 10g，黄芪 15g。

适应症：耳源性眩晕。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：治疗耳源性眩晕 40 例中，女 26 例，男 14 例；年龄 25~35 岁 14 例，<45 岁 19 例，<55 岁 7 例；病程最长 6 年，最短 2 年。均有典型临床表现，体征均有中耳病变的眼球规律性水平震颤，前庭功能试验不正常。结果：接受治疗前发作时间最短 2 天，最长 2 周。经服药 6~21 剂后，症状全部缓解，随访 2 年未再复发 32 例；1 年后复发，但发作次数减少，持续时间较前明显缩短 5 例；效果不甚明显 3 例。

资料来源：方英杰等，加味血府逐瘀汤治耳源性眩晕 40 例，辽宁中医杂志，1989；(1)：45。

其中 21~30 岁 7 例, 31~40 岁 12 例, 41~50 岁 24 例, 51~60 岁 19 例, 60 岁以上 5 例。结果: 临床治愈 49 例, 好转 15 例, 无效 3 例; 总有效率为 95.45%。

资料来源: 白墨, 眩晕汤治疗耳源性眩晕 67 例, 河南中医, 1987; (4): 25。

④安眩汤

组成: 熟地 20g, 牛膝 15g, 泽泻 20g, 茯苓 15g, 天麻 15g, 钩藤 15g, 丹参 15g。

适应症: 内耳眩晕病。

用法用量: 每日 1 剂, 水煎 2 次, 早晚分服。

临床应用: 肾阳不足症见形寒肢冷, 舌淡嫩者加附子、桂枝; 肾阴不足, 虚火内生症见五心烦热, 口干, 舌嫩红少苔, 加龟板、五味子、黄柏; 肝阳上亢症见头胀痛, 心烦易怒者, 加生龙牡、栀子、黄芩; 痰浊中阻症见头重如裹, 舌苔白腻脉滑者, 重用泽泻, 加白术; 气血亏虚症见面色少华, 少气懒言者, 加党参、黄芪; 呕吐剧烈者, 加半夏、竹茹; 耳鸣重听较重者加石菖蒲; 失眠者加酸枣仁。在本病症状缓解后, 继服六味地黄丸, 每次 6g, 每日 3 次, 连服 1~2 个月。

资料来源: 严雪玲, 福建中医药, 1997; 28 (6): 25。

⑤通窍活血汤

组成: 川芎 20g, 赤芍 15g, 桃仁 10g, 红花 10g, 生姜 3 片, 大枣 5 枚, 老葱白 3 根。

适应症: 内耳眩晕急性发作期、发作时间持续 24 小时以上、瘀血症明显者。

用法用量: 每日 1 剂, 水煎 400ml, 早晚 2 次分服。6 天为 1 疗程。

临床应用: 瘀血症甚者加丹参、郁金, 呕吐较重加代赭石、半夏、竹茹, 血压偏高加石决明, 失眠加生龙骨、生牡蛎、炒酸

枣仁、夜交藤，痰湿内蕴加白术、泽泻。

资料来源：李宗华等，山东中医杂志，1997；16（8）：359。

⑥泽牡天麻六君汤

组成：泽泻 50～120g，生牡蛎 30～60g，天麻 10g（另煎兑服），党参 15g，白术 20g，茯苓 15g，陈皮 10g，炙甘草 4g，半夏 12g，石菖蒲 5g，钩藤 20g（后下）。

适应症：内耳性眩晕。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：若胸闷呕恶甚，加枳实 10g，赭石 25g，竹茹 15g；若兼血压升高，加夏枯草 20g，草决明 20g，益母草 30g；若兼失眠多梦，加炒枣仁 10g，夜交藤 20g，合欢皮 15g；若兼痰湿较励，加苍术 10g，制南星 10g；兼耳鸣甚，加磁石 30g。6 剂为 1 疗程，可连服 1～3 个疗程。服药期间忌辛辣油腻刺激物，保持情绪平稳。

资料来源：邹世光等，甘肃中医，1997；10（4）：25。

⑦苓桂术甘汤

组成：茯苓 30g，泽泻 20g，白术 20g，炙甘草 10g，桂枝 10g，姜半夏 10g，天麻 5g。

适应症：内耳眩晕症。

用法用量：水煎服，每日 1 剂。

临床应用：呕吐明显者，加生姜 5g；有热象表现者，去桂枝，加黄芩 15g；肝阳上亢明显者，加天麻至 10g，杭菊花 15g；兼头痛者，加白芍 20g，川芎 10g；有瘀血表现者，加红花 5g；气虚明显者，加党参 15g，黄芪 20g；腹胀中满者，去炙甘草，加麦芽 10g，山楂 15g。

资料来源：梁开荣，山西中医，1997；13（4）：19。

林书局，香港)

四、中成药

半夏白术天麻汤

来源：《医学心悟》

组成：半夏 12g，天麻 12g，茯苓 12g，白术 12g，橘红 9g，甘草 6g，生姜 3 片，大枣 3 枚。

功效：补脾燥湿，化痰息风。

主治：风痰上逆之眩晕头痛，呕吐恶心，舌苔白腻，脉弦滑。

用法用量：水煎温服。

临床应用：大塚敬节氏报告用半夏白术天麻汤治疗美尼尔病 1 例。患者 57 岁，女性，半年眩晕病史，发时晕吐，每隔 7~10 日发作 1 次，需卧床 2~3 日方止，服本方 2 个月后发作消失。本方用于耳眩晕，亦可用于神经衰弱的头晕头痛而见脾胃虚阴症状者；本方适用于痰湿中阻的耳眩晕，其他病机引起者不宜。

方义解释：本方以二陈汤化痰燥湿，理气和中，善治痰症之眩晕；白术运脾化湿以绝痰源；天麻平息内风以治头晕，对于风痰眩晕症确有疗效。《脾胃论》说“足太阴痰厥头痛非半夏不能疗；眼黑头眩，虚风内作，非天麻不能除”。由此见半夏、天麻相配，善于祛痰息风。诸药合用，方简力宏，标本兼治，化痰息风，补脾燥湿之功颇著；生姜、大枣和脾胃，促进吸收。

药理研究：天麻具镇痛镇静作用，薛洁华用合成天麻素治美尼尔病等有效率达 95.5%。实验研究证实天麻可阻断刺激家兔中脑网状结构及咖啡因所致反应。白术有强壮利尿扩张血管作用。半夏有抑制腺体分泌；茯苓具有镇静作用；陈皮具抗过敏，防止毛细微血管出血；甘草具有皮质激素样作用。

五、饮食疗法

(一) 饮食宜忌

1. 实证眩晕 饮食宜清淡，除米面、豆类主食外，多吃新鲜蔬菜、水果等。少食煎炒、炙烤、油脂、肥厚的食物，如肥肉、羊肉，不吃辛辣刺激品，如酒、葱、蒜、韭菜、洋葱、辣椒等，以免生痰火。

2. 虚症眩晕 饮食宜多样化，以适合胃口，多进饮食，以瘦肉、鸡蛋，鸡汤清补为宜，忌食生冷。

3. 少吸烟、饮酒。

(二) 食疗验方

1. 陈皮茶 陈皮 10g，茶叶 5g。煎水代茶频饮，适用于肝阳上扰之眩晕。

2. 玉米须煎 玉米须 30g，水 300ml 煎至 150ml，空心服下，连服 3 次。适用于痰饮上扰之眩晕。

3. 白木耳炖肉 白木耳 15g，瘦猪肉 50g，红枣 10 枚，加水同炖，熟后饮服。(白木耳先浸泡 1 夜，泡后发用)。用于虚症眩晕。

4. 枸杞肉丝 精猪肉 500g，枸杞 100g，熟青笋 100g，猪油 100g，盐 12g，白糖 6g，味精 3g，黄酒 3g，麻油 15g，水生粉 30g，酱油 10g。制法：①猪肉洗净，去筋膜，切成 6cm 长肉丝，青笋切成 6cm 长的细丝，枸杞洗净待用。②烧热锅，用冷油滑锅倒出，再放猪油，将肉丝，笋丝同时下锅划散，烹黄酒，加白糖，酱油，盐，味精搅匀，再放枸杞翻炒几下，淋上麻油，推匀起锅适用于虚症眩晕。(以上见：中华食物疗法大全，江苏科技出版社，1990)

六、医案医话

(一) 张赞臣医案——肾亏肝旺验案

许某，女，30岁。初诊。1956年患眩晕症，其后发作次数渐频，辄与月经来潮或思虑过多有关。西医谓耳源性眩晕。最近眩晕更甚，不能乘车与看电影，两目不敢展视，左耳常如蝉鸣，记忆力减退，思维迟钝，情绪易于激动，夜不安寐，神疲腰酸，胸胁右侧隐痛，脉象左弦细，右缓弱，尺部力不足。症由肾水不足，不能涵养肝木，以致虚阳上越而成。拟益阴平肝潜阳为法。方药：生白芍 9g，沙苑子 9g，天麻 3g，绿豆衣 6g，枸杞子 4.5g，山萸肉 4.5g，何首乌 9g，川断 6g，制狗脊 9g，补骨脂（盐水炒）9g，熟女贞 9g，广郁金 4.5g。取 5 剂后，病情如故，再服 5 剂。

三诊：9月21日。头昏耳鸣已减，饮食渐增，睡眠亦酣，惟右肋尚有气滞刺痛之感，脉两手趋于平衡，惟略带弦意。舌苔薄净，症情已有转机，再拟柔肝益肾为主。方药：生白芍 4.5g，沙苑子 9g，枸杞子 4.5g，绿豆衣 6g，何首乌 9g，广郁金 4.5g，焦白术 9g，采芸曲 9g（包）。服 5 剂后，症情又减，再服 10 剂。

五诊：10月5日。临经 5 日，食香眠酣，胸闷滞痛已减，脉转和缓。惟头昏减而未除、或跳痛。精神尚感疲惫。乃本元不足，气血两亏，再拟肝肾并调。方药：生白芍 4.5g，丹参 9g，孩儿参 9g，焦白术 9g，潼沙苑 9g，绿豆衣 9g，何首乌 9g，制狗脊 9g，川断 9g，制香附 4.5g，采芸曲（包）9g。5 剂。

六诊：10月6日。易感疲乏，右肋时隐痛不舒，别无所苦，舌脉亦趋正常。为巩固计，以散剂调理。山参 24g，枸杞子（焙燥）24g，生野于术 18g。共研细末，日服 3 次，每次 8g，用开水送下。（《上海老中医经验选编》）

(二) 陈玉峰医话

几十年来余对东垣指出的“足太阴痰厥头痛非半夏不能疗；眼黑头旋，虚风内作，非天麻不除”，体会较深。遵其所论，屡

用皆效，其作用优于决明、菊花。《本草从新》谓：“天麻入肝经，通血脉，疏痰气，治闭风眩掉，头眩眼黑。”“半夏体滑性燥，能走能散，治咳逆头眩，痰厥头痛。”临症则再根据不同原因辨证加减。若有心烦，呕逆者加竹茹、枳壳，清热降逆止呕。若手足震颤，筋惕肉瞤者加龙骨、牡蛎、珍珠母；镇痉息风效果不显，可用羚羊角。若眩晕呕吐，频作不止加代赭石、柿蒂、吴茱萸镇逆止呕，亦可重用茯苓、泽泻、车前子、白术、生姜等化气利水和胃降逆，使水不能上泛而由小便出、吐眩则止。胸不适者加砂仁、白蔻开胃化浊，耳鸣耳聋加菖蒲、莼肉、葱白通阳开窍。血压偏高见于阳亢者加牛膝、黄芩、茺蔚子、夏枯草。（阎瑞曾，陈玉峰医话《浅谈眩晕治疗》；见刘强选辑，名老中医医话，科技文献出版社重庆分社，1985）

七、现代报道

张爱玲报道：用晕平汤（桑叶 10g，焦栀子 10g，路路通 10g，白菊花 6g，防风 6g，白芷 5g，白术 5g，丹皮 5g，炙甘草 5g，车前子 12g，钩藤 12g，泽泻 25g，丹参 20g，治疗耳眩晕之美尼尔氏病 90 例，并设立西药对照组（烟酸 100mg，晕海宁 50mg，安定 2.5mg，654-2 10mg 及维生素 C、维生素 B₁、维生素 B₆ 等）81 例。两组分别痊愈 38 例，33 例；好转 49 例；无效 3 例，14 例。总有效率分别为 96%，82.5%。两组疗效对比有非常显著差异（ $P < 0.01$ ）。（张爱玲，晕平汤治疗美尼尔氏病临床观察，中国医药学报，1992；7（4）：30～31）

八、主要参考资料

1. 成都中医学院，中药学，上海人民出版社，1977
2. 当代中国名医验方 1000 首，中国中医药出版社
3. 傅景华等，古代验方大全，中医古籍出版社，1990

流行性乙型脑炎

流行性乙型脑炎，简称乙脑，是由乙脑病毒引起的流行于夏秋季节的中枢神经系统急性传染病。其以高热、嗜睡、头痛、惊厥、昏迷及脑膜刺激症为主要临床表现，多发生于10岁以下的小儿。蚊虫是乙脑的主要传播媒介，病毒经蚊虫叮咬进入人体血液后，可再通过血脑屏障进入中枢神经系统而引起大脑炎。该病发病急暴，预后凶险，并常常造成肢体瘫痪、痴呆、失语等严重后遗症。根据乙脑的发病季节与临床表现特点，其相当于祖国医学温病中的“暑温”范畴。

暑温是发生于夏暑季节的时行热病，暑为夏令之气，天暑下逼，地湿上蒸，人在其中，感之皆为暑病。暑温以发病急骤，变化迅速，易伤津耗气为特点，小儿肤薄神怯，脏腑嫩弱，不奈三气发泄，最易罹患，且易出现闭窍动风、气阴脱竭之危重证候。

“暑温”一名，为清代吴鞠通氏创立，首见于《温病条辨》。在此之前通称为暑病，有关暑病的最早记载当推《黄帝内经》。该书《素问·热论》云：“先夏至日者为病温，后夏至日者为病暑”，明确了该病的季节特异性。《素问·生气通天论》云：“因于暑、汗，烦则喘喝，静则多言，”首次描述了暑病的临床表现。而汉代张仲景则首次提出了具体的治疗方剂，《金匱要略》云：“太阳中热者，喝是也，其人汗出恶寒，身热而渴者，白虎加人参汤主之。”至清代吴鞠通则特立“小儿暑温”一条，认为小儿脏腑嫩薄，阴液不足，“一得暑温，不移时有过卫入营者”，指出

“小儿暑温，身热，卒然痉厥”，说明了小儿暑温的发病与传变特点。历代医家对该病均较为重视，并取得了丰富的治疗经验。特别是解放后，各地运用古人对暑温的认识，在防治暑温方面取得了较好成绩，同时也大大丰富与发展了祖国医学对该病的理论认识与临床实践。

一、病因病机

《温病条辨·解儿难》云：“小儿肤薄神怯，经络脏腑嫩小，不耐三气发泄，邪之来也，势如奔马，其传变也，急如掣电。”小儿肌肤嫩薄，脏腑柔弱，气阴不足，不耐暑邪是小儿易发暑温的内在因素，但本病的主要病因却是感受暑温邪毒之气。

暑温邪毒，病属温邪，传变迅速，且易耗津伤气，喜归心包，并有很强的季节性；其“惟暑月最多，而兼证最杂。”《幼科要略》云：“夏为热病，然夏至以前，时令未为大热，经以先夏至病温，后夏至病暑”。小儿神志怯弱，气血未充，脏腑未坚，不耐暑热熏蒸，阴液阳气易随汗泄，故尤易感受暑温邪毒。暑邪从口鼻或肌表而入，一般可按温病卫气营血的规律性变，但暑邪其性酷烈，易化燥化火、生风生痰，故常径入气分而发病，病初即见高热、烦渴、汗多等，所谓“暑者发自阳明，”甚或未见卫气征象面已出现神昏抽搐的营分征象或气营两燔，热陷心营之候。

暑温之病理关键在于风火痰惊交织为患。其主要病变在心、肝二脏，夹湿者常累及脾胃。盖暑为天地之热气，其性属阳，极易化火，热盛动风，火盛生痰，风火痰热相互交织，外炙肌肤，内灼脏腑，壅滞经络，蒙蔽清窍，故临床可见高热、神昏、抽风、痰鸣等风火痰惊四证；暑喜归心，故常见神昏谵语等邪陷心包之候；热盛动风，燔灼肝经，故常见抽搐、项强之候；暑易夹湿，且夏季雨湿较多，暑湿相合，内困中阻，蒙蔽清阳，则可见

发热、头痛、身重、胸闷、嗜睡、恶心、舌苔厚腻等暑热痰湿并重之证。病势严重者，邪毒久留，蕴结难除，津气耗劫，伤及脏腑，损伤经络，则留下种种后遗症状。

二、辨证施治

乙脑的辨证既要根据温病卫气营血的一般传变规律，又要结合该病自身病情急骤变化复杂的特点，论治时应对患儿发病特性、体质强弱、气候的燥湿、感邪的深浅等不同仔细辨别，综合分析，才能求得正确及时的治疗。

(一) 辨证要点

1. 辨卫气营血

本病传变迅速，层次虽不易分清，但仍有一定规律，要根据临床证候特点准确判定病在卫气、气营两燔或邪入营血，这对正确治疗与判定预后非常重要。

2. 辨清暑热与暑湿的偏胜

暑热偏胜者，以高热、烦渴、多汗、苔黄燥为主症；暑湿偏胜者，虽亦见高热，但口渴不甚、汗出不多，并可兼见胸闷痞满，舌苔滑腻等。

3. 辨明脏腑

该病常累及心肝脾胃等脏，病在心者见神昏谵语；病在肝者见惊风抽搐；病入脾胃见腹胀呕恶等。

4. 辨清病期

本病一般可分急性期、恢复期与后遗症期三个阶段，各期表现、治则与转归各异，不可不辨。急性期的特点是发病急、传变快，易化火、动风、生痰、发惊，其为本病之高峰与治疗重点。恢复期大都是在急性期危笃险证之后，邪毒损伤气阴，出现津亏气弱、筋脉失养、邪去正衰的征象。而后遗症期的标志是在经积极治疗6个月后病情未见痊愈或显著好转，表现出神呆、肢瘫、

失语耳聋等种种后遗症状。

5. 辨别邪正之盛衰：

因本病病势急骤，病情倏变，往往突然出现邪陷正衰之危候，故在各个阶段都应仔细辨别邪正相互消长的关系，确定邪正之盛衰，以便及时救治凶险变证。

(二) 辨证分型

1. 邪在卫气

突然发热，或微恶风寒，或但热不寒，全身灼热少汗或无汗，较大儿童自诉头痛项强，口渴烦躁，或嗜睡神糊。舌苔薄白或黄，质偏红，脉浮数或滑数。苦湿偏重者兼见恶心呕吐，胸闷便溏。

2. 邪在气营

持续高热，口渴欲饮，狂躁不宁或神昏谵语，四肢抽搐，痰鸣气粗，甚或呼吸不利，便秘溲赤。舌质红绛，苔黄糙，脉滑数或细弦而数。

3. 邪在营血

身热起伏，朝轻暮重，神识昏糊，常常两目上视，牙关紧闭，四肢厥冷，手足拘急，抽搐，胸腹灼热，二便失禁，见衄血，斑疹，唇紫绛焦干。舌质紫绛，或光滑少津，舌体僵缩，脉沉细。

4. 余热未清

低热颧红，夜热早凉，身体消瘦，虚烦不宁，偶有惊惕，小便短赤，口渴易汗。舌红少苔或苔光净，脉沉细数。

5. 痰蒙清窍

意识昏糊，或见痴呆，失语失聪，喉间痰鸣，吞咽困难，甚至见狂躁不宁，嚎叫哭闹等。舌质红绛，苔黄腻或无苔，脉滑。

6. 虚风内动

形疲颧红，手足瘛疔或拘挛，肢体强直或震颤。舌质红绛，

鸡子黄滋补肝肾，牡蛎平肝熄风，五味子、甘草酸甘化阴。

2. 方药选介

①银翘散

组成：银花 10g，连翘 10g，豆豉 10g，牛蒡子 6g，荆芥 6g，薄荷 5g，桔梗 6g，竹叶 6g，芦根 12g，甘草 3g。

适应症：暑温初起，邪在卫分。

用量用法：日 1 剂，水煎分 2 次服。

资料来源：《温病条辨》

②白虎汤

组成：石膏 20～30g，知母 9g，粳米 9g，甘草 3g。

适应症：暑温气分热盛，壮热烦渴。

用法用量：1 日 1 剂，水煎分 2 次服。

资料来源：《伤寒论》

③清营汤

组成：犀角 2g，生地 12g，玄参 9g，竹叶心 3g，麦冬 9g，丹参 6g，黄连 5g，银花 9g，连翘 9g。

适应症：暑温热邪初入营分。

用法用量：同上。

资料来源：《温病条辨》

④犀角地黄汤

组成：犀角 1.5～3g，生地黄 12～15g，芍药 12g，牡丹皮 9g。

适应症：暑温热入血分证。

用法用量：同上。

资料来源：《备急千金要方》

⑤清瘟败毒饮

组成：生石膏 20g，小生地 12g，犀角 2g，黄连 5g，栀子 5g，桔梗 5g，黄芩 6g，知母 9g，赤芍 9g，玄参 9g，连翘 9g，

丹皮 9g, 淡竹叶 6g, 甘草 3g。

适应症：暑温热毒炽盛，气血两燔。

用法用量：同上。

资料来源：《疫疹一得》

⑥青蒿鳖甲汤

组成：青蒿 6g, 鳖甲 15g, 生地 15g, 知母 6g, 丹皮 9g。

适应症：暑温恢复期余邪未清，阴虚内热证。

用法用量：同上。

资料：《温病条辨》

⑦大定风珠

组成：生白芍 9g, 阿胶 9g, 生龟板 12g, 干地黄 12g, 麻仁 6g, 五味子 6g, 生牡蛎 12g, 麦冬 9g, 生鸡子黄 2 枚, 炙甘草 6g, 鳖甲 12g。

适应症：暑温后期，热灼真阴，阴虚火旺，虚风内动证。

用法用量：1 日 1 剂，水煎去渣，再入鸡子黄搅匀，分 2 次温服。

临床应用：有人报道以此方加减治疗乙脑后遗症 15 例，均获得显著效果。（罗道揆，大定风珠加减治疗流脑后遗症，上海中医药杂志，1986；（9）：28。）

资料来源：《温病条辨》

⑧地黄饮子

组成：干地黄 12g, 巴戟 9g, 山茱萸 6g, 石斛 9g, 制附子 6g, 肉苁蓉 9g, 五味子 6g, 肉桂 3g, 白茯苓 9g, 麦冬 9g, 菖蒲 12g, 远志 9g。

适应症：暑温后遗症，肾之阴阳俱虚证，可见肢瘫、失语等症状。

用法用量：1 日 1 剂，水煎分 2 次服。

资料来源：刘河间《医学六书》

⑨安宫牛黄丸

组成：牛黄、郁金、犀角、黄芩、黄连、雄黄、山栀子、朱砂各 30g，梅片、麝香各 7.5g，珍珠 15g，箔衣。

适应症：暑温热甚，邪陷心包，神昏惊风者。

用法用量：上药共为极细末，炼蜜为丸，每丸 3 克，金箔为衣，每服半丸或 1 丸，不醒者再服 1 丸。

资料来源：《温病条辨》

⑩苏合香丸

组成：白术、青木香、乌犀屑、香附子、朱砂、诃子、白麝香、安息香、沉香、麝香、丁香、荜茇各 60g，龙脑、苏合香油、薰陆香各 30g。

适应症：暑温夹湿，痰浊内闭心窍，症见痰厥昏迷，牙关紧闭等。

用法用量：炼蜜制成药丸，（每丸重 3g），每服半丸或 1 丸，温开水送下。

资料来源：《太平惠民和剂局方》

⑪紫雪丹

组成：石膏、寒水石、磁石、滑石各 1500g，犀角屑、羚羊角屑、青木香、沉香、玄参、升麻各 500g，甘草 240g，朴硝 5000g，硝石 930g，麝香 38g，朱砂 90g，黄金 3000g，丁香 30g。

适应症：暑温极期，邪入心包，热极生风，出现神昏惊厥等症。

用法用量：制成散剂，每服 1～1.5g，每日 1～2 次，冷开水调下。

资料来源：《太平惠民和剂局方》

⑫清乙汤 I 号

组成：银花、板蓝根、黄芩、生石膏、生地、知母、葛根、菊花、钩藤、丹皮。

适应症：暑温病在卫气分。

⑬清乙汤Ⅱ号

组成：板蓝根、黄芩、石膏、知母、葛根、钩藤、生地、羚羊角、全虫、菖蒲、天竺黄、安宫牛黄丸。

适应症：暑温病在气、营分属危重者。

用法用量：每日1剂，水煎分2次服。

临床应用：针对病情适当配用输液、镇静、降温等对症疗法。以上2方共治45例小儿乙脑，结果痊愈40例，好转3例，死亡2例，疗效堪称满意。

资料来源：龚家林，以“清乙汤”为主治疗45例乙型脑炎的疗效观察，江西中医药，1989；(3)：17~18。

⑭脑炎方

组成：藿香9g，佩兰9g，野菊花10g，银花15g，连翘9g，生石膏16g，菖蒲9g，郁金9g，钩藤9g，全蝎9g，蜈蚣1条，竹沥水30ml。

适应症：乙脑出现高热、神昏、抽风等症。

制法：竹沥水为市售成药，余药加水浸泡，浓煎1次，去渣取清汁备用。

用法：每日服用3次，牙关紧闭不能吞咽者鼻饲之。

资料来源：裴学义，见杜怀棠主编，中国当代名医验方大全，石家庄：河北科技出版社，1990。

⑮乙脑合剂

组成：石膏100g，银花30g，连翘20g，大青叶30g，板蓝根30g，黄连10g，生地30g，石菖蒲15g，钩藤20g，大黄15g。

适应症：暑温邪闭心窍，热极生风证。

用法用量：上方诸药加水150ml，煎成500ml，1~5岁服50ml，5~10岁服100ml，每日2次。服时可加适量开水稀释。

临床应用：神昏者合安宫牛黄丸，痰厥甚加羚羊角粉或紫雪

丹、止痉散。共治 174 例，其中治愈 119 例，好转 34 例，死亡 2 例。治愈时间最短 2 天，最长 30 天，平均 8 天。

资料来源：刘向东，中西医结合治疗小儿乙脑 174 例疗效观察，江西中医药，1989；(5)：19～20。

⑮乙脑 I 号

组成：银花 15g，连翘、芦根、钩藤各 15g，薄荷 6g，生石膏、板蓝根各 30g，山栀子 8g，郁金、石菖蒲各 10g。

适应症：乙脑初期，邪在卫气阶段。

⑯乙脑 II 号

组成：银花、钩藤各 15g，藿香、黄连、生地、石菖蒲、郁金各 10g，板蓝根 40g，生石膏 60g，知母、地龙各 12g。

适应症：乙脑普通型中期，邪入气营阶段。

⑰乙脑 III 号

组成：生地、藿香、黄连各 12g，丹皮 10g，生石膏 100g，钩藤、地龙各 15g，全蝎 3g，板蓝根 50g，蜈蚣 1 条。

适应症：乙脑重型和极重型，属极期，邪陷营血阶段。

用法用量：上述 3 方均为每日 1 剂，煎水分 2 次服。

临床应用：痰多加天竺黄、胆南星、鲜竹沥等，重者加紫雪丹，高热不退、抽搐者加羚羊角粉 2g 冲服，并配合应用西药对症疗法。

资料来源：符宝第，中医治疗流行性乙型脑炎 19 例临床分析，新中医，1989；(10)：38～39。

⑱周氏乙脑 I 号方

组成：大青叶 15g，黄菊花 12g，冬桑叶 10g，芦根 12g，连翘 9g，银花 10g，薄荷 6g。

适应症：乙脑轻型及普通型发病之初。

⑲周氏乙脑 II 号方

组成：大青叶 30g，板蓝根 30g，生石膏 30g，知母 30g，连

翘 10g, 钩藤 10g, 甘草 5g。

适应症：乙脑重型、极重型。

用法用量：每日 1 剂，水煎分 2 次服，或煎成 100ml 装瓶备用，每次 50ml，日服 2 次。

临床应用：湿重苔厚腻者加藿香、佩兰；抽搐严重、频繁加地龙、蜈蚣或紫雪丹；神志昏迷者加安宫牛黄丸；痰多加川贝、天竺黄。共治 365 例乙脑，获得满意疗效，其中治愈 279 例，好转 66 例，死亡 20 例。

资料来源：周小祥、胡立鹏，中西医结合治疗乙脑 365 例观察，浙江中医学院学报，1988；(1)：18~19。

②袁氏乙脑方

组成：生石膏 90g, 龙胆草 10g, 紫花地丁 60g, 蒲公英 60g, 钩藤 15g, 制大黄 6g, 羚羊角粉 0.6g (分 2 次服)。

适应症：重症乙型脑炎。

用法用量：每日 1 剂，浓煎 150ml 左右，分 2~3 次由鼻饲管内注入。

临床应用：痰多者加服鲜竹沥，每次 15ml，每日 2 次；呕吐频繁可加紫苏叶 6g, 黄连 5g, 竹茹 10g, 橘皮 6g；便秘加元明粉 5g 冲服。以此方治疗 30 例乙脑，痊愈 24 例，好转 4 例，死亡 2 例。

资料来源：袁道生，治疗重症乙型脑炎 30 例临床小结，江苏中医杂志，1984；(3)：16~17。

②五虎追风散

组成：蝉衣 30g, 制南星 6g, 天麻 10g, 全蝎、僵蚕各 7 只。

适应症：乙脑恢复期出现四肢抽掣、震颤等症状。

用法用量：上方各药共研细末，开水冲服，每次 3~6g，每日 2~3 次，如加减不便可改为汤剂。

资料来源：胡良铭，谢国柱，五虎追风散加味在乙脑恢复期

中的应用，江西中医药，1982；(2)：36～37。

夏氏乙脑系列方

②乙脑一方

组成：石膏 60g，寒水石 60g，蝉衣 9g，大青叶 9g，芦根 60g，炙甘草 6g。

适应症：乙脑轻型初期，邪在卫分及邪在卫气阶段。

④乙脑二方

组成：鲜生地 60g，石膏 60g，丹皮 9g，赤芍 9g，银花 12g，连翘 12g，知母 9g，黄连 3g，黄芩 9g，龙胆草 9g，大青叶 9g，蝉衣 9g，芦茅根各 30g，益元散 15g，玉枢丹 3g。

适应症：乙脑普通型中期，邪在气分及邪入气营阶段。

⑤乙脑三方

组成：水牛角 60g，鲜生地 60g，丹皮 9g，赤芍 9g，石膏 60g，知母 12g，黄连 3g，龙胆草 9g，大青叶 12g，蝉衣 9g，石菖蒲 12g，淡竹叶 9g，竹沥 30g。

适应症：乙脑重型、重暴型，极期邪入营分或逆传心包。

⑥乙脑四方

组成：川连 9g，丹皮 9g，赤芍 6g，石膏 60g，知母 9g，天麻 9g，蝉衣 9g，象贝 9g，天竺黄 9g，鲜石菖蒲 15g，陈胆星 9g，远志 9g，竹沥 30g，牛黄抱龙丸 1 粒。

适应症：乙脑极期热退，但其它症状不减。

⑦乙脑五方

组成：炙黄芪 60g，当归 15g，红花 12g，桃仁 12g，赤芍 9g，地龙 9g，党参 9g，玄参 15g。

适应症：乙脑后期或出现后遗症。

用法用量：以上五方均为水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

临床应用：用上述五个方剂辨证施治小儿乙型脑炎 78 例，痊愈 67 例 (85.9%)，留有后遗症 7 例 (9%)，死亡 4 例

(5.1%)。

资料来源：夏翔，中医治疗小儿乙型脑炎 78 例临床分析，中医杂志，1987；(4)：34～35。

⑧大青龙汤加附子

组成：麻黄 6g，桂枝 6g，杏仁 10g，生石膏 60g，熟附片 10g，炙甘草 6g，红枣 6 枚，鲜生姜 3 片。

适应症：乙脑，属太阳与少阴并病。

用法用量：同上。

临床应用：使用本方当以壮热无汗，舌润苔白，脉浮或细弱，肢冷为指征。若见壮热汗多，烦渴引饮，苔干黄燥，舌绛，脉洪大者，则非本方所宜，当用白虎汤之属。作者以此方救治 30 例乙脑均获成功。

资料来源：翟冷仙，大青龙汤加附子治愈流行性乙型脑炎，江苏中医杂志，1981；(4)：20～21。

⑨黄芪赤风汤

组成：黄芪 30～60g，赤芍、防风各 6g，乌梢蛇 3～9g。

适应症：乙脑后遗症，以躯体感觉和运动障碍为主症。

用法用量：同上。

临床应用：软瘫加制马钱子粉 0.15～0.3g，每日分 2 次冲服；不自主运动加天麻、钩藤各 9g，蜈蚣 1 条研冲；肌肉萎缩加人参鹿茸粉，并配合按摩；筋肉挛缩加伸筋草、木瓜各 9g，鸡血藤 15g；上肢屈伸不利加桑枝 30g，桂枝 9g；下肢加桑寄生 15～30g，川断 15g，怀牛膝 9g；痴呆失语加河车大造丸或冲服紫河车粉 3～9g，并配合针灸；虚热加知母 9g。此法共治 18 例乙脑后遗症，痊愈 10 例，好转 4 例。

资料来源：刘昌海，张家驹，黄芪赤风汤为主治疗脑炎，脑膜炎后遗症 18 例，新中医，1990；(3)：22。

③地龙大黄合剂

组成：地龙、大黄、青蒿、石膏、板蓝根、牛膝、泽泻。

适应症：乙脑高热不退。

用法用量：以上方煎汤剂保留灌肠，3次/日，昏迷者可改用鼻饲给药。

临床应用：同时应服用大剂量安宫牛黄丸或紫雪丹，若痰盛者加鲜竹沥、竹茹，神昏加入参（另煎）。

资料来源：刘碧清等，乙型脑炎临床逆传情况的分析，中医杂志，1988；（6）：23。

④乙脑合剂

组成：生石膏 120g，知母 10g，生地 15g，赤芍 10g，丹皮 10g，钩藤 12g，僵蚕 15g，全蝎 3g，菖蒲 10g，大黄 10g（后下）。

适应症：乙脑高热、神昏、抽搐，难以口服药物者。

用法用量：将每剂浓煎成 500ml 装入灭菌空瓶内，加入 10ml 防腐剂冷藏备用，采用开放式输液法，将针头换成导尿管，每日 1 剂，分 2 次直肠点滴，每日间隔 6～8 小时，滴速：30～50 滴/分。

临床应用：以此法治疗 38 例乙脑患儿，结果痊愈 32 例（84.2%），好转 4 例（10.5%），且在退热、止痉天数上均明显短于单纯西药的对照组（ $P < 0.01$ ）。

资料来源：张三川等，直肠点滴法治疗乙型脑炎 38 例，中西医结合杂志，1989；（1）：45。

⑤牛黄醒脑注射液

组成：I 号：牛胆酸 3.25g，猪去氧胆酸 3.75g，水牛角 25g，海珠母 50g，黄芩素 5g，金银花提取物 5g，栀子 25g，板蓝根 200g。II 号：麝香皮 20g，郁金 100g，藿香 100g，石菖蒲 100g，冰片 1g，薄荷脑 0.75g，吐温-80 20ml。

久的退热作用外还有抑菌等各种药理作用。黄色结晶 C 为知母作为清热药的有效成分，该物质是呋喃衍生物——芒果甙。^[4]

2. 对家兔气分证模型的退热作用

应用本方：生石膏 20g，知母 9g，粳米 15g，甘草 3g。制成 100% (1g 生药/ml) 药液，高压灭菌备用。白虎汤组及对照组家兔由耳缘静脉注入内毒素液 1ml/kg，正常组注入同等剂量生理盐水。白虎汤组在注射内毒素前 2 小时及注射内毒素后，每只动物分别经腹腔注入白虎汤 5ml/kg。观察体温，症状及体征的变化。结果：白虎汤组的体温与对照组相比，有明显降低。提示白虎汤对内毒素所致的家兔温病气分证模型有退热作用。^[3]

3. 增强机体免疫功能作用

动物实验结果表明，本方能增强腹腔巨噬细胞的吞噬功能：吞噬率及吞噬指数在 1、3、6 小时均有显著提高；提高血清溶菌酶的含量；能促使淋巴细胞转化，其转化率为 14%，阳性对照为 34%，而阴性对照为 6%；能显著提高再次免疫抗体滴度：初次免疫后实验组抗体滴度与对照组无明显差别，而再次免疫后实验组抗体滴度显著高于对照组，表明本方对再次抗体形成有促进作用。^[4]

资料来源：

[1] 刘志明等，治疗 37 例流行性乙型脑炎的初步报告，中医杂志，1958；(4)：251。

[2] 王爱芳等，对白虎汤清热原理及知母退热成分的初步研究，上海中医药杂志，1981；(6)：43。

[3] 陈扬荣等，白虎汤降低家兔气分证体温的观察，安徽医学院学报，1993；12 (2)：49。

[4] 吴贺算等，白虎汤对免疫功能的影响，中成药研究，1984；(12)：43。

④益气清解汤

组成：生晒参 4～8g，麦冬、板蓝根、大青叶各 15～20g，金银花、连翘各 8～10g，生石膏 30～50g，丹皮、知母、竹叶各 6～10g，生地 10～20g，甘草 2～5g。

适应症：流行性乙型脑炎。

用法用量：每日 1 剂，内服或鼻饲。高热者生石膏易为 60g，加抗热牛黄散 1g，或紫雪散 2g，每日 2 次；神昏者加石菖蒲、郁金各 6～10g；抽搐惊厥加地龙 10～15g，钩藤、僵蚕各 6～10g，或用止痉粉 2～3g，鼻饲，每日 3 次；重者加用羚羊角粉 1g；鼻饲，每日 3 次；气阴欲脱者生晒参改用 5～10g；若虚阳外脱加附子 2～6g；痰浊盛加胆南星、法半夏各 4～6g；腹胀苔腻加藿香、厚朴、法半夏各 4～6g；便秘不通加生大黄、玄明粉各 3～6g。

临床应用：治疗流行性乙型脑炎 80 例中，男 45 例，女 35 例；年龄最小 2 岁，最大 12 岁；病程最短 10 小时，最长 4 天。本组 80 例中，72 例获临床治愈，5 例留有后遗症，3 例死亡。有效率为 96.25%，平均疗程约 8 天。

资料来源：陈恩树，益气清解汤治疗流行性乙型脑炎 80 例，安徽中医学院学报，1988；7（2）：31。

三、单方验方

（一）大青叶 30g，板蓝根 30g，紫草 10～15g，煎服。

（二）板蓝根 60～120g，煎服，连用 2 周。

（三）鲜积雪草、鲜鸭跖草、鲜狗肝菜各 60g，捣汁服或煎服。

以上 3 方均取自全国高等中医院校统编教材，中医儿科学，上海科技出版社，1979。

（四）麻黄、薄荷水煎加等量 95% 酒精趁温热（37～38.5℃）多

次擦浴，有退热之效。（赖济民等，中西医结合杂志，1988；（4）：244～245。）

（五）“燕子泥”外敷神厥穴退乙脑高热。（曾立昆，河南中医，1989；（6）：13。）

（六）青蒿 30g，薄荷、荆芥各 20g，打成粗末，用 45% 酒精 300ml 浸泡 5 天而成，擦洗患儿头、背、四肢、腋腋等处。（李建成，新中医，1991；（3）：32。）

（七）六神丸 10～15 粒/次，3 次/日，连服 2～3 天。（郭元仓，新中医，1989；（10）：39。）

（八）南通蛇药片 10 片/次，3 次/日，口服 7～10 天。（陈自安，中西医结合杂志，1988；（11）：689。）

（九）香蕉根 500ml，加冬蜜 30g，500～1000ml/d，鼻饲点滴，滴速：每分钟 5～10ml，均匀持续滴给，患儿出现稀便则可停药。（邓光国，新中医，1981；（5）：38。）

（十）大青叶全草 62g（鲜者用 93g），生大黄 18g，牛蒡子、大蓟各 15g，瓜子金 12g，共研细末，以低度黄酒调敷双足掌正中，固定，每日 1 次，一般用 4～5 天即可使体温正常。（顾铭康，四川中医，1988；（3）：16。）

四、中成药

局方至宝丹

来源：《和剂局方》

组成：麝香、冰片、雄黄、玳瑁、琥珀、安息香、牛黄、犀角、朱砂。

功效：清热解毒，化浊开窍。

主治：暑温痰热内闭，邪入心包所致神昏痰厥，惊风抽搐。

用法用量：蜜丸，每丸重 1.5g。口服，1 次半丸至 1 丸，1 日 1～2 次。脉弱体虚者人参汤化服，痰涎壅盛者可用生姜汁化

服。

使用注意：忌辛辣、生冷食物，慢惊风禁用。

方义解释：麝香、冰片、安息香芳香化浊，豁痰开窍，共为主药，辅以犀角、牛黄、玳瑁、雄黄清热解毒，朱砂、琥珀镇心安神共为佐使。共奏清热开窍，化浊解毒之功，是凉开法的代表方之一。

药理研究：牛黄能加强水合氯醛、巴比妥钠、乌拉坦对小鼠和大鼠的镇静作用，动物实验还表明：牛黄对盐酸可卡因和咖啡因等引起的惊厥有对抗作用。以牛黄为主药制成的注射液腹腔注射可调整动物脑内儿茶酚胺的活性，恢复脑干网状上行激活系统的功能，达到复苏作用。这些均为至宝丹治疗乙脑的高热、惊厥昏迷提供了现代科学依据。（吴荷杰，中草药药理学，北京：人民卫生出版社，1983）

五、饮食疗法

暑温的急性期膳食以流质、半流质为宜，并以清淡为原则，如藕粉、豆浆、白米粥、玉米面粥、绿豆粥。忌食油腻厚味食品。暑温极期热入心包，神志昏迷者更需以流质鼻饲；至后期余热羁留，仍宜饮食清淡适量，不可暴饮暴食，以防“食复”而使余热复燃。

（一）生芦根粥方 鲜芦根 30g，粳米 50g，以水 1500ml，煎芦根，取汁 1000ml，纳米于汁中，煮粥食之。（《食医心鉴》）

（二）石膏粥方 生石膏 120g，细米 50g，以水 2000ml，煮石膏 1000ml，去渣下米煮粥食之。（《食医心鉴》）

（三）生地黄粥 取生地黄汁 150ml，加入陈仓米粥内，搅拌均匀食之。（《食医心鉴》）

六、医案医话

(一) 裴学义医案——暑温热陷心包案

侯某，男，6岁。1987年9月20日入院。

高热5天，昏迷抽风1天。脑脊髓常规：细胞数126个，中性细胞65%，淋巴细胞35%，糖：150mg%，氯化物：765mg%，蛋白质：10mg%。西医诊断：乙型脑炎。入院后予西药抗感染、镇静止抽、降颅压、吸氧吸痰等治疗症状无缓解。两天后昏迷加重，吞咽反射消失，呼吸道分泌物增多，刺激后有阵阵抽搐，遂请会诊。

证见高热不降，面色晦垢，神志昏迷，痰声漉漉，频频抽搐，舌红苔黄厚腻，脉弦滑数。拟方如下：生石膏18g，佩兰、野菊花、连翘、菖蒲、僵蚕、郁金、钩藤各10g，鲜芦根30g，银花15g，全蝎2条，蜈蚣1条，竹沥水30ml，姜汁5滴兑入。局方至宝散1瓶分2次冲服。急煎1剂鼻饲灌入后，次日神志转清，呼之有应，痰量减少，面色转红，体温降至37.5℃，上方随证加减服药9剂，神志正常，回答问题清楚，能下地行走，带药出院调养善后。（裴学义，见杜怀棠主编，中国当代名医验方大全，石家庄：河北科技出版社，1990年。）

(二) 吴鞠通医案——暑温痰热内结案

乙丑6月11日，某女，15岁。暑温夹痰饮怒郁，故脉扎身热而胁痛，误用足六经表药，烦躁不宁，6日不解，至危之症。

生石膏4钱，杏仁、生香附、旋覆花（包）、连翘、藿香梗各3钱，广郁金2钱，薄荷1钱。煮两杯，分2次服。3时一帖，服2日大见效再商。

13日，于前方内加青橘皮2钱，鲜芦根5钱，鲜荷叶边1枚。（《吴鞠通医案·暑温》）

(三) 马景乐医案

卜某，女，10个月。1959年8月2日入院。

患儿3天来精神萎靡，不肯吮乳，今日突然高热

(T40.5℃)无汗,伴呕吐,腹泻,惊跳不宁。检查:舌苔薄白,指纹紫暗,瞳孔放大,颈项稍强,心肺正常,腹部稍膨。巴氏征(+),布氏征(+)。WBC $27.4 \times 10^9/L$, N0.70, L0.28, M0.02。脑脊液:无色透明,蛋白(+),细胞数 $633 \times 10^6/L$ 。诊断:流行性乙型脑炎。

中医辨证:患儿高热无汗,舌苔薄白,此邪在卫分之征;因邪有内陷之势,故呕吐腹泻,惊跳不宁。人小热盛,传变最速,昏迷抽搐即在目前。急以辛凉透表,驱邪外出。方用银翘散合白虎汤加减。处方:南苏荷 3g(后下),鲜竹叶 20片,粉葛根 6g,东银花 10g,净连翘 6g,生石膏 30g(先煎),肥知母 6g,淡黄芩 6g。1剂。

8月3日二诊:服药后2小时许遍体微汗,随之发热、呕吐、腹泻均减。T38.7℃,舌苔微黄,指纹犹紫。再以清凉退热为治。处方:东银花 6g,净连翘 6g,鲜竹茹 6g,鲜荷梗 6g,大麦冬 6g,生石膏 30g(先煎),肥知母 6g,淡黄芩 3g,川黄连 2g。2剂。

8月5日三诊:热退身凉,吐泻俱止,惊跳已平,惟胃纳不开,精神不振。予养阴益胃以善后。处方:南北沙参(各) 6g,大麦冬 6g,肥玉竹 6g,川石斛 6g,粉甘草 3g,冰糖 10g(分冲),2剂。

进上药后乳食已增,精神亦佳,二便如常,体检和化验室检查亦无异常,于8月7日痊愈出院。(周玲,马景乐治疗流行性乙型脑炎医案选按,江苏中医,1997;18(4):27。)

七、现代报道

(一)徐德先报道乙脑卫气型治宜辛凉透表,清热解毒,方用银翘散加减;气营型治宜清热解毒,清气凉营,方用白虎汤合清营汤加减;营血型治宜清热解毒,凉血开窍,方用清瘟败毒饮

加减；阴竭阳脱型治宜清心开窍，凉血息风，方用清营汤合羚羊钩藤汤加减。各型随证加减，治疗结果中西组/对照组（西药组）：痊愈病例 144/78，显效病例 3/6，有效病例 2/5，无效病例 6/13，总有效率为 96.1%/87.4%，且在退热、治愈时间、病死率、后遗症等方面中西医结合组均优于对照组。（中西医结合治疗流行性乙型脑炎 155 例的经验和体会，中西医结合杂志，1985；（7）：429~430。）

（二）汪雪芬等报道以自拟乙脑方（组成：生石膏 30g，大青叶、板蓝根、金银花各 10g，知母、玄参、丹皮、竹叶、生甘草各 8g。）治疗各型乙脑 84 例。兼表证者去玄参、丹皮，加豆豉、薄荷、牛子；里热炽盛津伤者加山梔、天花粉、麦冬、鲜石斛；偏于暑热者加青蒿、菊花、六一散；偏于暑湿者加藿香、佩兰；神识昏糊、嗜睡者加菖蒲、郁金或伍用牛黄清心丸；惊跳、轻度抽搐者加钩藤、僵蚕，结果痊愈 75 例，明显好转 6 例。（中西医结合治疗乙型脑炎 84 例小结，安徽中医学院学报，1984；（2）：36~37。）

（三）李瑞云报道以清热泻火，釜底抽薪法治疗乙脑邪热鸱张者，基本方：大黄 10g，生石膏 30~45g，竹叶 15g，银花 15g，钩藤 12g，知母 12g，麦冬 15g，甘草 5g，用水 500ml 浓煎至 150ml，1 次口服或分 2 次鼻饲。一般服 1~2 剂，大便通畅排出污黑粪便后体温则开始下降。若病情重笃，热深厥深可加服安宫牛黄丸，抽搐频繁加地龙、蝉蜕、石菖蒲。（运用下法治疗乙型脑炎，新中医，1981；（5）：36~37。）

（四）胡启兴报道以清热解毒汤治疗 105 例乙型脑炎。方剂组成：银花 15~20g，连翘 10~15g，黄芩、山梔各 8~12g，石膏 30~60g，板蓝根 20~30g，菊花 8~10g，蚤休 12~15g，甘草 3~5g。每日 1~2 剂，煎汤鼻饲，经过 8~37 个月的治疗，痊愈 96 例，治愈率达 91.43%。（清热解毒汤为主治疗 105 例乙

型脑炎疗效观察，江苏中医，1990；(8)：6～7。)。

(五) 刘万朝报道以该院自制的安宫牛黄冰栓（每粒含生药3g，存放冰箱备用），治疗乙脑高热不退，神昏惊厥等症。1～2粒/次，6～12小时可重复使用1次。使用方法：将冰栓置患儿肛门内2～6cm处，深眠或深昏迷需用手指堵住肛门10～15分钟，以防药水外溢，同时配合物理降温 and 冬眠Ⅱ号，共治疗180例，治愈160例，总有效率达90.6%。（安宫牛黄冰栓和冬眠Ⅱ号为主治疗流行性乙型脑炎180例，中西医结合杂志，1988；(11)：689。）

八、主要参考资料

1. 王伯岳、江育仁，中医儿科学，北京：人民卫生出版社，1984
2. 凌一揆，中药学，上海：上海科技出版社，1984
3. 吴鞠通，温病条辨，上海：上海科技出版社，1962
4. 广州中医学院主编，方剂学，上海：上海科学技术出版社，1979
5. 冷方南，中国基本中成药，北京：人民卫生出版社，1988
6. 唐·孙思邈食医心鉴，北京：人民卫生出版社，1960
7. 黄泰康等，中药方剂现代研究大典，北京：科学技术出版社，1996

